TaichiNOW

BẢN DỊCH TOÀN VĂN 183 TRANG · KÈM TOÀN BỘ ĐỒ HÌNH NGUYÊN BẢN

Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền Trung Hoa

《Essence of Traditional Chinese Medicine》 — Asiapac Editorial · World Scientific

Bản dịch tiếng Việt trung thực từng trang của ấn bản *Essence of Traditional Chinese Medicine* (Asiapac / World Scientific), do Chu Văn Quân, Lâm Nguyên và Trịnh Tâm Kim hiệu đính, Phó Xuân Giang minh họa. Toàn bộ 361 đồ hình, tranh minh họa, sơ đồ kinh lạc và ảnh dược liệu của bản gốc được cắt trực tiếp từ bản scan và chèn đúng vị trí như trong sách.

192 trang đã dịch · 361 hình · p001–p192

TRANG SÁCH -8 · SCAN P001

Essence of Traditional Chinese Medicine

Essence of Traditional Chinese Medicine

Bìa trước. Nhan đề *Essence of TRADITIONAL CHINESE MEDICINE* in bằng chữ hoa màu cam, kẹp giữa hai đường kẻ mảnh màu vàng. Bên dưới nhan đề là một huy hiệu nhỏ hình con dấu phong cảnh màu vàng, kèm theo hai chữ Hán 中医 (Y học Trung Hoa). Ở giữa là một huy hiệu tròn lớn màu cam mang chữ Hán 药 (thuốc) màu trắng, được bao quanh bởi những nét vẽ mảnh các loài cây thuốc — rễ sâm, cành hoa, lá, quả mọng và củ. Nơi chân bìa là logo của nhà xuất bản: Asiapac Books (亚太图书) bên trái và World Scientific bên phải.

TRANG SÁCH -7 · SCAN P002

Essence of Traditional Chinese Medicine

Essence of Traditional Chinese Medicine

Trang nhan đề. Nhan đề được lặp lại bằng chữ hoa màu đen dưới cùng hai đường kẻ mảnh, cùng con dấu phong cảnh nhỏ màu vàng với hai chữ 中医; huy hiệu tròn màu cam mang chữ 药 được in lại bằng màu xám phía trên phần thông tin xuất bản.

Biên soạn: Ban biên tập Asiapac

Cố vấn biên tập

BS. Zhu Wenjun

Học viện Y học Trung Hoa truyền thống Singapore, Singapore

BS. Lin Yuan

BS. Cheng Sim Kim

Minh họa

Fu Chunjiang

Dịch

Y N Han

Nơi chân trang là logo của Asiapac Books (亚太图书) và World Scientific.

TRANG SÁCH -6 · SCAN P003

Trang -6

Xuất bản và phát hành bởi

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

5 Toh Tuck Link, Singapore 596224

Văn phòng Hoa Kỳ: 27 Warren Street, Suite 401-402, Hackensack, NJ 07601

Văn phòng Anh: 57 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9HE

Dữ liệu Biên mục Xuất bản của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

Names: Zhu, Wenjun (Expert in Chinese traditional medicine), editor. | Lin, Yuan (Expert in Chinese traditional medicine), editor. | Cheng, Sim Kim, editor. | Fu, Chunjiang, 1974– illustrator.

Title: Essence of traditional Chinese medicine / edited by Wenjun Zhu, Yuan Lin, Sim Kim Cheng ; illustrated by Chunjiang Fu ; translated by Y.N. Han.

Other titles: Zhonghua yi yao jing cui. English

Description: New Jersey : World Scientific, 2018. | Reprint of: Essence of traditional Chinese medicine / compiled by Asiapac editorial ; illustrated by Fu Chunjiang ; translated by Y.N. Han. 2003.

Identifiers: LCCN 2018008793 | ISBN 9789813239180 (hardcover : alk. paper)

Subjects: | MESH: Medicine, Chinese Traditional | Graphic Novels

Classification: LCC R602 | NLM WB 17 | DDC 615.8/80951--dc23

LC record available at https://lccn.loc.gov/2018008793

Dữ liệu Biên mục Xuất bản của Thư viện Anh

Một bản ghi biên mục cho cuốn sách này hiện có tại Thư viện Anh.

Essence of Traditional Chinese Medicine. Xuất bản theo thỏa thuận với Asiapac Books Pte Ltd.

Bản quyền © 2003, 2018 thuộc Asiapac Books Pte Ltd, Singapore

Bảo lưu mọi quyền. Cuốn sách này, hoặc bất kỳ phần nào của nó, không được sao chép dưới bất kỳ hình thức hay bằng bất kỳ phương tiện nào, dù điện tử hay cơ học, kể cả sao chụp, ghi âm hay bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào hiện đã biết hoặc sẽ được phát minh sau này, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.

Đối với việc sao chụp tài liệu trong tập này, vui lòng trả phí sao chụp qua Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA. Trong trường hợp này, không cần xin phép nhà xuất bản để sao chụp.

Để biết bất kỳ tài liệu bổ sung nào hiện có, vui lòng truy cập

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10962#t=suppl

Dàn trang bởi Stallion Press

Email: enquiries@stallionpress.com

In tại Singapore

TRANG SÁCH -5 · SCAN P004

Các tựa sách liên quan khác của World Scientific

Các tựa sách liên quan khác của World Scientific

- - ***Essential Chinese Medicine*** **(Bộ 4 tập)**
- - Tập 1: Restoring Balance
- - Tập 2: Health Tonics
- - Tập 3: Improving Blood Circulation
- - Tập 4: Relieving Wind
- - của Bao Chun Zhang và Yu Ting Chen
- - ISBN: 978-981-3239-06-7 (Tập 1)
- - ISBN: 978-981-3239-09-8 (Tập 2)
- - ISBN: 978-981-3239-12-8 (Tập 3)
- - ISBN: 978-981-3239-15-9 (Tập 4)
- - ***Anecdotes of Traditional Chinese Medicine***
- - của Lifang Qu
- - biên tập: Mary Garvey
- - ISBN: 978-1-938134-99-9
- - ISBN: 978-1-945552-02-1 (bìa mềm)
- - ***Tu Youyou's Journey in the Search for Artemisinin***
- - của Wenhu Zhang, Yiran Shao, Dan Li và Manyuan Wang
- - dịch: Junxian Yu
- - ISBN: 978-981-3207-63-9
- - ISBN: 978-981-3207-64-6 (bìa mềm)
- - ***Cancer Management with Chinese Medicine: Prevention and Complementary Treatments*****, bản sửa đổi**
- - của Rencun Yu và Hong Hai
- - ISBN: 978-981-3203-88-4

- - ISBN: 978-981-3231-85-6 (bìa mềm)
- - ***Ginseng and Ginseng Products 101: What are You Buying?***
- - của Hwee Ling Koh, Hai Ning Wee và Chay Hoon Tan
- - ISBN: 978-981-4667-30-2
- - ISBN: 978-981-4667-31-9 (bìa mềm)

TRANG SÁCH -4 · SCAN P005

Lời Nhà xuất bản

Lời Nhà xuất bản

Y học Trung Hoa truyền thống có lịch sử lâu đời và nổi tiếng khắp thế giới nhờ những phương pháp chẩn đoán và điều trị độc đáo. Một số khái niệm nền tảng của y học Trung Hoa truyền thống đã trở thành thói quen ăn sâu trong chúng ta. Vào những tháng hè nóng bức, chúng ta uống trà thảo mộc để giải nhiệt; khi trời trở lạnh, chúng ta dùng thuốc bổ; khi thấy nóng bừng và khô miệng, chúng ta ăn những món có tính mát; còn khi môi và móng tay nhợt nhạt — dấu hiệu của thiếu máu — chúng ta ăn những thực phẩm bổ huyết....

Chúng tôi mong muốn đưa thế giới y học Trung Hoa truyền thống đến gần tất cả mọi người. Cuốn sách trình bày những lý luận nền tảng của y học Trung Hoa truyền thống bằng các sơ đồ dễ hiểu, đề cập đến những phương pháp chẩn đoán và điều trị, đồng thời giới thiệu các danh y trong lịch sử đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền y học này.

Cuốn sách này là kết quả nỗ lực hợp tác của đội ngũ biên tập Asiapac trong việc nghiên cứu và biên soạn tài liệu, có tham khảo ý kiến của các chuyên gia về y học Trung Hoa truyền thống. Xin chân thành cảm ơn ông Zhu Wenjun, bác sĩ Lin Yuan và bác sĩ Cheng Sim Kim vì những đóng góp quý báu.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Fu Chunjiang vì những minh họa sống động, bà Y N Han vì phần dịch thuật và ông Zhu Wenjun vì đã viết lời tựa. Đồng thời, xin cảm ơn ông Huang Ruide vì sự hỗ trợ, bà Wong Wan Ling vì công tác biên tập và bà Wu Li Bin vì đã cung cấp thông tin về các tổ chức y học Trung Hoa tại Singapore. Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn ê-kíp sản xuất vì sự chăm chỉ đã giúp ấn phẩm này ra đời.

Các tựa sách sức khỏe của Asiapac

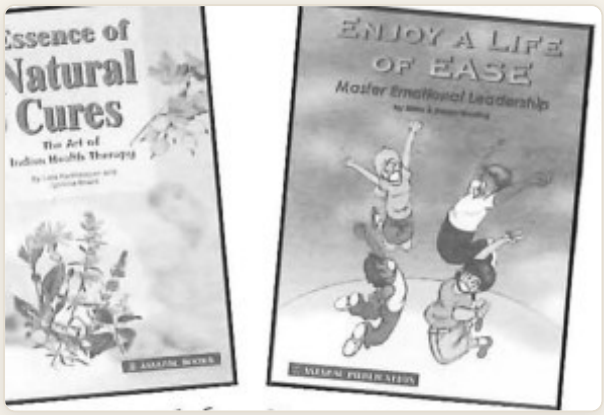
Essence of Natural Cures: Khám phá các hệ thống trị liệu tự nhiên có nguồn gốc từ Ấn Độ, bao gồm ayurveda, siddha, unani, yoga, vi lượng đồng căn (homeopathy) và naturopathy.

ISBN 978-981-220-476-6

***Enjoy a Life of Ease*:** Trao cho thanh thiếu niên khả năng xây dựng lòng tự trọng, bày tỏ nhu cầu, tạo ra và truyền đạt những thay đổi, cũng như quản lý cảm xúc của mình.

ISBN 978-981-229-421-0

HÌNH 1



Hai ảnh bìa sách cỡ nhỏ đặt cạnh nhau: bên trái là bìa cuốn Essence of Natural Cures, với những nét vẽ cây cỏ và lá thuốc; bên phải là bìa cuốn Enjoy a Life of Ease, với hình các nhân vật hoạt hình đang chuyển động trên nền sáng.

TRANG SÁCH -3 · SCAN P006

Lời tựa

Lời tựa

Y học Trung Hoa truyền thống là báu vật của nền văn minh Trung Hoa và là một phương diện độc đáo của khoa học — kỹ thuật Trung Hoa, với lịch sử hàng nghìn năm. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của tổ tiên, nó đã phát triển thành một nhánh y học độc đáo. Tuy khởi nguồn từ Trung Hoa, y học Trung Hoa truyền thống là tài sản chung của loài người. Để mang lại lợi ích cho nhiều người nhất, nó phải vươn ra toàn cầu.

Nó theo chân những người Hoa di cư đầu tiên đến Singapore, nhưng khi ấy chỉ là sự du nhập tự phát. Cùng với sự phát triển của y học Trung Hoa và sự quan tâm của chính phủ đối với việc đào tạo, phát triển y học Trung Hoa truyền thống trong thập niên 80 và 90, sự quan tâm và niềm tin vào nền y học này ngày càng tăng. Trong khi một số người chọn ra nước ngoài học tập, những người khác ở lại trong nước để theo học nhánh y học này. Cuốn sách được xuất bản nhằm giúp người Singapore hiểu biết về y học Trung Hoa. Đồng thời, nó cũng phù hợp với xu hướng 'trở về với thiên nhiên' đang thịnh hành.

Essence of Traditional Chinese Medicine trình bày một cách toàn diện và sâu sắc về y học Trung Hoa truyền thống. Các chủ đề từ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, dược liệu truyền thống đến công nghệ hiện đại tạo nền tảng tốt để hiểu về nền y học này. Sơ đồ và minh họa giúp người đọc hiểu rõ hơn nội dung. Khía cạnh thực hành được trình bày thiết thực và dễ áp dụng; những câu chuyện về các danh y được kể lại một cách sinh động. Tất cả những điều đó khiến cuốn sách trở thành một ấn phẩm dễ đọc và giàu thông tin.

Cuốn sách không chỉ dành cho người mới bắt đầu hay những ai muốn có một cẩm nang chung về y học Trung Hoa truyền thống. Nó còn là người bạn đồng hành tốt cho các gia đình, với những mẹo đơn giản và hiệu quả để giữ gìn sức khỏe, nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống lành mạnh, việc phòng ngừa lão hóa sớm và sống lâu.

Zhu Wenjun

Viện trưởng

TCM College (S) Pte Ltd

Tháng 5 năm 2003

Zhu Wenjun có bằng Thạc sĩ của Đại học Dược Trung Quốc và từng giảng dạy tại Đại học Y học Trung Hoa truyền thống Nam Kinh.

TRANG SÁCH -2 · SCAN P007

Mục lục

Mục lục

- - **Lý luận và học thuyết đằng sau Y học Trung Hoa** — 1
- - • Âm và Dương — 2
- - • Ngũ hành — 6
- - • Nền tảng của y học Trung Hoa — 10
- - • Bát cương — 11
- - • Tạng phủ (các cơ quan nội tạng — ngũ tạng lục phủ) — 12
- - • Khí (sinh lực), huyết và tân dịch — 14
- - • Kinh lạc, huyệt đạo — 15
- - • Nhân tố nội sinh và ngoại sinh — 18
- - • Cách phòng bệnh — 23
- - **Các phương pháp chẩn đoán trong Y học Trung Hoa truyền thống** — 27
- - • Tứ chẩn — 28
- - - Chẩn đoán bằng quan sát (vọng chẩn) — 29

- - Chẩn đoán bằng nghe và ngửi (văn chẩn) — 33
- - Chẩn đoán bằng hỏi bệnh (vấn chẩn) — 35
- - Chẩn đoán bằng bắt mạch và xúc chẩn (thiết chẩn) — 41
- • Chẩn đoán bằng xúc chẩn — 46
- • Chẩn đoán qua phân tích chất bài tiết — 47
- **Các phương pháp điều trị trong Y học Trung Hoa truyền thống** — 49
- • Phương pháp một — Dược liệu Trung Hoa — 50
- • Phương pháp hai — Châm cứu và cứu ngải — 87
- • Phương pháp ba — Xoa bóp trị liệu — 99
- • Phương pháp bốn — Liệu pháp ăn uống — 104
- • Phương pháp năm — Liệu pháp tâm lý — 114
- • Phương pháp sáu — *Khí công* — 126
- • Các phương pháp điều trị đặc biệt — 131

TRANG SÁCH -1 · SCAN P008

Trang -1

- **Các danh y** — 139
- • Y đức — 140
- • Bian Que — 141
- • Hua Tuo — 146
- • Zhang Zhongjing — 151
- • Sun Simiao — 156
- • Zhu Danxi — 161
- • Li Shizhen — 166
- • Các nữ y sĩ thời cổ — 171
- **Hiện đại hóa y học Trung Hoa** — 173
- Phụ lục — 179
- Nguồn tư liệu về y học Trung Hoa — 182

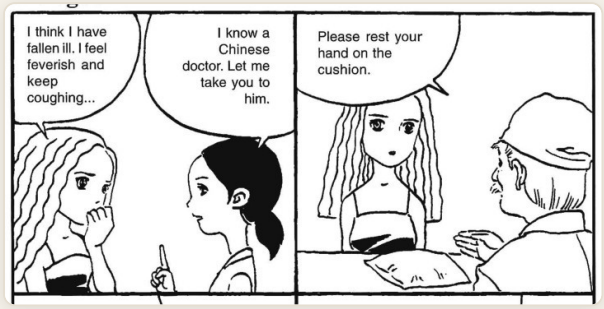
HÌNH 2

Hình minh họa nét vẽ ở chân trang mục lục. Bên trái là một thầy thuốc Trung Hoa thời cổ đội mũ văn sĩ, mặc áo dài thướt tha, tay cầm cuộn giấy, đứng cạnh những bó thẻ tre và một tủ hay bình phong khắc chữ Hán. Đối diện ông là một thầy thuốc thời hiện đại mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe quanh cổ. Phía dưới, ở tiền cảnh, là một chiếc bát nông cùng một dụng cụ cắt, và một máy vi tính để bàn gồm màn hình, bàn phím và chuột. Một vòng cung nét cọ đen lớn quét phía sau vị thầy thuốc hiện đại, nối liền cái cũ với cái mới.

Mở đầu

Mở đầu

HÌNH 3



Hàng trên của truyện tranh, gồm ba khung. Một cô gái tóc xoăn, vẻ mặt mệt mỏi, nói với bạn rằng mình thấy như đã ốm; bạn cô đáp rằng cô biết một thầy thuốc Trung Hoa và sẽ đưa cô đến đó; ở khung thứ ba, cô gái ngồi đối diện vị thầy thuốc già nơi bàn, ông bảo cô đặt tay lên đệm.

"Tôi nghĩ mình ốm mất rồi. Tôi thấy nóng sốt và cứ ho mãi..."

"Tôi biết một thầy thuốc Trung Hoa. Để tôi đưa cậu đến gặp ông ấy."

"Cháu hãy đặt tay lên đệm."

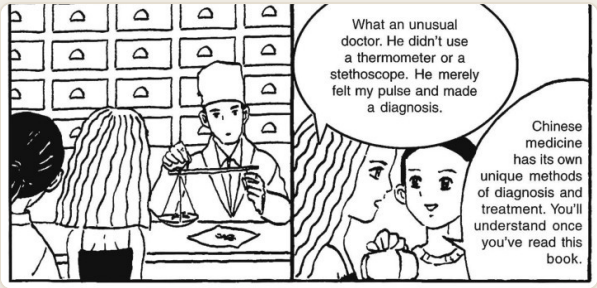
HÌNH 4

Hàng giữa, gồm hai khung. Vị thầy thuốc nắm cổ tay cô gái để bắt mạch và hỏi cô có hay ho không; sau đó ông bảo cô chỉ bị cảm nhẹ và viết đơn thuốc cho cô.

"Cháu có hay ho không?"

"Cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi. Ta sẽ viết cho cháu một đơn thuốc. Cháu có thể ra ngoài lấy thuốc."

HÌNH 5



Hàng dưới, gồm hai khung. Sau quầy của một hiệu thuốc truyền thống, người bốc thuốc đang cân dược liệu trên chiếc cân trước bức tường đầy ngăn kéo đựng thuốc; hai cô gái trò chuyện về buổi khám.

"Ông thầy thuốc thật lạ. Ông ấy không dùng nhiệt kế hay ống nghe. Ông chỉ bắt mạch rồi đưa ra chẩn đoán."

"Y học Trung Hoa có những phương pháp chẩn đoán và điều trị độc đáo riêng. Cậu sẽ hiểu ra khi đọc cuốn sách này."

TRANG SÁCH 1 · SCAN P010

Lý luận và học thuyết đằng sau Y học Trung Hoa

Lý luận và học thuyết đằng sau Y học Trung Hoa

Nghệ thuật y học Trung Hoa có lịch sử hàng nghìn năm. Nó kết hợp các khái niệm âm dương, ngũ hành và sự hợp nhất giữa con người với tự nhiên trong triết học Trung Hoa thành một lý luận và hệ thống độc đáo, đứng riêng một cõi trong thế giới y học. Hiệu quả trị liệu vượt trội của nó cũng đã được công nhận rộng rãi.

TRANG SÁCH 2 · SCAN P011

Âm và Dương

Âm và Dương

Vạn vật trong vũ trụ được phân thành âm (tinh chất sống) và dương (sinh khí). Ví dụ, trong hệ thiên thể, mặt trăng là âm còn mặt trời là dương. Trong hệ con người, nữ là âm còn nam là dương. Sự tương tác giữa âm và dương sinh ra biến hóa và khiến sự sống trên trái đất sinh sôi. Âm và dương bổ sung cho nhau. Cùng nhau, chúng khơi nguồn biến hóa trong vũ trụ và làm nảy sinh muôn loài.

Lửa và nước là hai biểu tượng của âm dương, phản ánh những đặc tính cơ bản của chúng. Nước thì lạnh, có tính hạn chế và tương đối tĩnh. Nước mang bản chất âm. Lửa thì nóng, kích thích và nuôi dưỡng, và tương đối động. Lửa thuộc phạm trù dương.

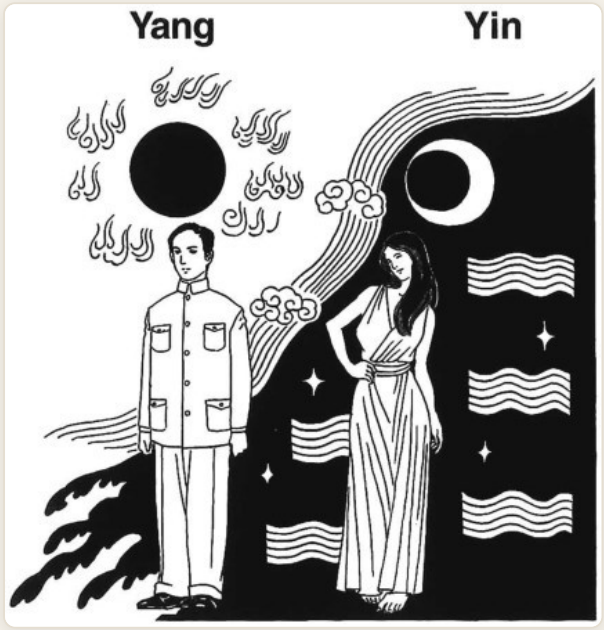
Những đặc tính cơ bản của âm dương:

Âm: Thụ động, giáng xuống, ở trong, có hình thể, lạnh, tối, ức chế, nhu nhược.

Dương: Chủ động, thăng lên, ở ngoài, không hình thể, ấm, sáng, kích thích, cương mãnh.

Âm và dương không thể đứng một mình, cũng không thể tồn tại ở trạng thái không cân bằng. Ví dụ, có bên phải thì phải có bên trái. Trái và phải phải cùng tồn tại. Đó là một mối quan hệ vừa bổ sung vừa hạn chế lẫn nhau. Chúng hài hòa và cân bằng lẫn nhau.

HÌNH 6



Sự đối lập giữa Dương và Âm, được vẽ thành hai nửa của cùng một trang. Bên trái, mang tiêu đề Yang (Dương), một người đàn ông mặc áo cài khuy đứng trên nền trắng dưới một mặt trời đen đặc quấn quanh những ngọn lửa — đó là nguyên lý nóng, sáng, chủ động, thuộc nam. Bên phải, mang tiêu đề Yin (Âm), một người phụ nữ mặc váy dài xếp ly đứng trên nền đen bên cạnh vầng trăng lưỡi liềm trắng, phía trên những làn sóng nước cách điệu và các ngôi sao — đó là nguyên lý lạnh, tối, thụ nhận, thuộc nữ. Một dải mây cuộn chia đôi hai nửa ở chính giữa.

Ứng dụng trong y học Trung Hoa

Ứng dụng trong y học Trung Hoa

- - Khi âm và dương của một người ở trạng thái cân bằng thì người đó khỏe mạnh.
- - Khi âm và dương mất cân bằng thì sinh ra bệnh tật.
- - Khi âm và dương rời khỏi cơ thể thì cái chết đến.

Cấu tạo cơ thể con người cũng được phân thành âm và dương:

- - Phần trên cơ thể là dương; phần dưới cơ thể là âm.
- - Bên ngoài là dương; bên trong là âm.
- - Lưng là dương; ngực và bụng là âm.
- - Tim, gan, tỳ (lá lách), phổi và thận là dương; dạ dày, túi mật, ruột và bàng quang là âm.

TRANG SÁCH 4 · SCAN P013

Bệnh tật cũng có thể được phân thành âm và dương:

Bệnh tật cũng có thể được phân thành âm và dương:

	Hội chứng âm	Hội chứng dương
Nguyên nhân	Do ảnh hưởng của âm quá mức.	Do ảnh hưởng của dương quá mức.
Triệu chứng	Da nhợt nhạt, sợ lạnh, sờ vào thấy lạnh, mệt mỏi, không khát, thích uống nước ấm, tiểu nhiều và nước tiểu trong, phân lỏng.	Mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu, sờ vào thấy nóng, miệng khô, thích uống nước lạnh, nước tiểu vàng, phân khô và cứng.

HÌNH 7

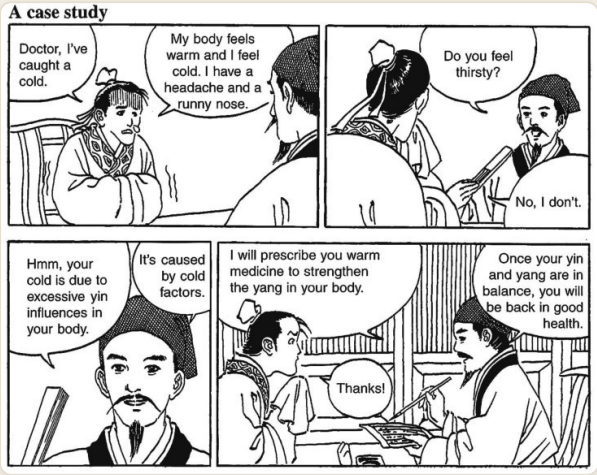
Dải tiêu đề in nền xám của bảng: hai ô xám ghi chữ Yin Syndrome (Hội chứng âm) bên trái và Yang Syndrome (Hội chứng dương) bên phải, ngăn cách bằng một đường kẻ dọc màu đen.

HÌNH 8

Hai hình vẽ nét nằm trong các ô Symptoms (Triệu chứng) của bảng. Bên trái là một người phụ nữ búi tóc cao, cổ áo có hoa văn, hai tay thu vào trong ống tay áo, vai so lại và run rẩy — đó là hội chứng âm, thuộc hàn. Bên phải là một người đàn ông hói đầu, búi tóc trên đỉnh, mặc áo không tay, hai tay ôm chặt một cái bát, mặt cau có, mồ hôi vã ra và hơi nóng bốc lên quanh đầu — đó là hội chứng dương, thuộc nhiệt.

Một ca bệnh điển hình

HÌNH 9



Một dải truyện tranh bốn khung dưới dòng chú thích A case study (Một ca bệnh điển hình). Khung trên bên trái: một thiếu nữ quấn áo dày, tóc búi, nói với thầy thuốc rằng mình đã bị cảm. Khung trên giữa: thầy thuốc nhìn từ phía sau, đáp rằng người cô thấy nóng mà cô lại thấy lạnh, cô bị đau đầu và chảy nước mũi. Khung trên bên phải: thầy thuốc hỏi cô có thấy khát không, cô đáp là không. Khung dưới bên trái: thầy thuốc đội mũ Nho sinh, để râu mảnh, tay cầm sách, giải thích rằng chứng cảm của cô do âm quá thịnh và do các nhân tố hàn gây ra. Khung dưới giữa: ông ngồi bàn viết đơn, kê thuốc ấm để bồi bổ dương khí trong cơ thể cô, còn cô thì cảm ơn. Khung dưới bên phải: ông nói với cô rằng khi âm và dương trong người đã cân bằng thì cô sẽ khỏe trở lại.

Trang 5

- - Thầy thuốc: "Bệnh nhân tiếp theo!"
- - Bệnh nhân: "Thưa thầy thuốc, con đang bị cảm và sốt cao. Đầu con đau và con đang vã mồ hôi."
- - Thầy thuốc: "Mũi con có chảy nước hay con thấy khát không?"
- - Bệnh nhân: "Con không chảy nước mũi. Nhưng hầu như lúc nào con cũng thấy khát."
- - Thầy thuốc: "Được rồi, ta sẽ viết đơn thuốc cho con."
- - Bệnh nhân thứ hai: "Thưa thầy thuốc, con thấy một bệnh nhân khác cũng bị cảm đang nhận đơn thuốc."
- - Bệnh nhân thứ hai: "Sao đơn thuốc của anh ấy lại khác đơn của con?"
- - Thầy thuốc: "Tuy cả hai người đều bị cảm, nhưng tình trạng bệnh không giống nhau."
- - Thầy thuốc: "Chứng cảm của con là do nhiệt, nên ta kê cho con một đơn thuốc mát để hạ nhiệt."
- - Thầy thuốc: "Khi âm khí trong cơ thể con được bồi bổ và âm dương đạt tới cân bằng, con sẽ khỏi cảm."
- - Thầy thuốc: "Chứng cảm của bệnh nhân kia là do âm quá thịnh, cho nên đơn thuốc mới khác như vậy."
- - Bệnh nhân: "À, con hiểu rồi."

HÌNH 10

Toàn bộ trang là một dải truyện tranh gồm bốn hàng, lấy bối cảnh phòng khám của một thầy thuốc, phía sau có mành tre và vườn lá chuối. Hàng thứ nhất: vị thầy thuốc gầy gò trong chiếc áo dài gọi bệnh nhân tiếp theo, rồi hỏi han một người đàn ông hói đầu, búi tóc trên đỉnh, đang kêu bị cảm, sốt cao, đau đầu và vã mồ hôi; sau đó ông hứa sẽ kê đơn. Hàng thứ hai: bệnh nhân đầu tiên cầm đơn thuốc trên tay, kể lại việc thấy một người bệnh cảm khác và hỏi vì sao đơn thuốc của hai người lại khác nhau, còn thầy thuốc thì giơ tay lên giải thích. Hàng thứ ba: thầy thuốc đội mũ Nho sinh, để râu, vừa chỉ tay vừa giải thích về đơn thuốc mát và việc cần bồi bổ âm khí. Hàng thứ tư: ông kết luận rằng chứng cảm của bệnh nhân kia là do âm quá thịnh, và người bệnh gãi đầu như đã hiểu ra. Trang này không có tiêu đề hay chú thích in kèm.

Ngũ hành

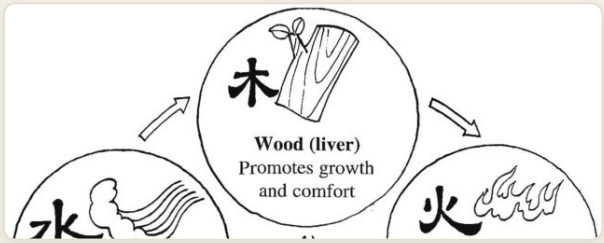
Ngũ hành

Ngũ hành chỉ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người xưa tin rằng thế giới vật chất được tạo thành từ năm hành này. Năm hành vừa tương sinh vừa tương khắc lẫn nhau, nhờ đó duy trì được sự cân bằng của hệ sinh thái.

Y học Trung Hoa cũng dùng ngũ hành để giải thích cơ thể con người:

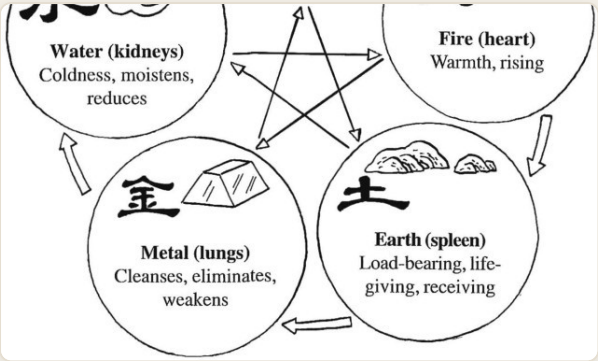
Ngũ hành	Tạng	Đặc tính
Mộc (木)	gan	Thúc đẩy sinh trưởng và dễ chịu
Hỏa (火)	tâm (tim)	Ấm nóng, đi lên
Thổ (土)	tỳ (lá lách)	Nâng đỡ, nuôi dưỡng sự sống, tiếp nhận
Kim (金)	phế (phổi)	Thanh lọc, đào thải, làm suy yếu
Thủy (水)	thận	Tính lạnh, làm ẩm, làm giảm

HÌNH 11



Nửa trên của đồ hình vòng tròn Ngũ hành. Ở trên cùng, vòng tròn của Mộc mang chữ 木 bên cạnh một tấm gỗ có mầm cây nhú lên, kèm dòng chữ Wood (liver) — Promotes growth and comfort (Mộc – gan – thúc đẩy sinh trưởng và dễ chịu). Bên dưới, bị cắt mất một phần, là vòng tròn của Thủy với dòng nước uốn lượn ở bên trái và vòng tròn của Hỏa với những ngọn lửa bốc lên ở bên phải. Những mũi tên viền đậm uốn cong nối các vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

HÌNH 12

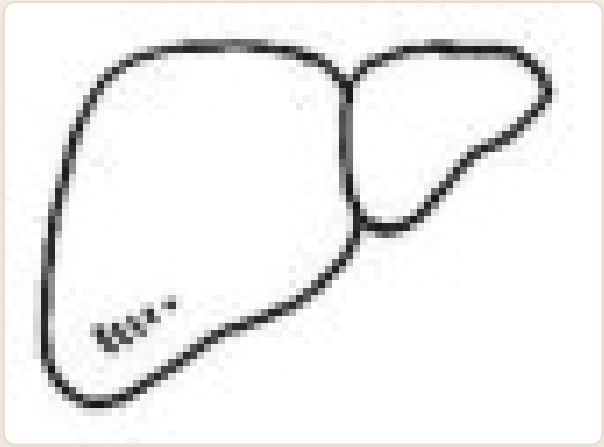


Nửa dưới của cùng đồ hình vòng tròn đó. Đồ hình gồm vòng tròn của Thủy (水) với dòng nước chảy, vòng tròn của Kim (金) với một thỏi kim loại, vòng tròn của Thổ (土) với hai ngọn núi tròn và vòng tròn của Hỏa (火) với ngọn lửa. Mỗi vòng đều ghi tên tạng và đặc tính: Water (kidneys) — Coldness, moistens, reduces (Thủy – thận – tính lạnh, làm ẩm, làm giảm); Metal (lungs) — Cleanses, eliminates, weakens (Kim – phổi – thanh lọc, đào thải, làm suy yếu); Earth (spleen) — Load-bearing, life-giving, receiving (Thổ – tỳ – nâng đỡ, nuôi dưỡng sự sống, tiếp nhận); Fire (heart) — Warmth, rising (Hỏa – tâm – ấm nóng, đi lên). Một ngôi sao năm cánh bằng nét mảnh cắt ngang chính giữa, biểu thị quan hệ tương khắc, còn những mũi tên viền chạy theo chiều kim đồng hồ ở phía ngoài biểu thị quan hệ tương sinh.

Quan hệ tương sinh và tương khắc giữa Ngũ tạng, tức các tạng phủ quan trọng.

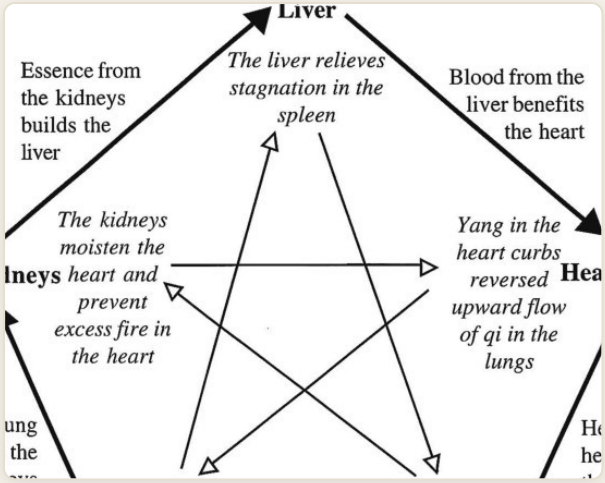
Quan hệ tương sinh và tương khắc giữa Ngũ tạng, tức các tạng phủ quan trọng.

HÌNH 13



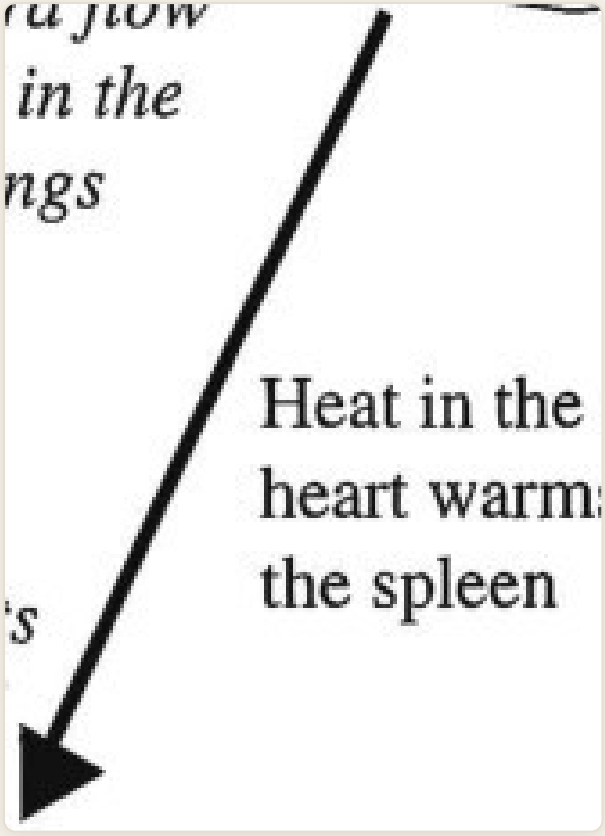
Một hình vẽ nét nhỏ về lá gan, là tạng được ghi là Liver (gan) ở phía trên đồ hình.

HÌNH 14



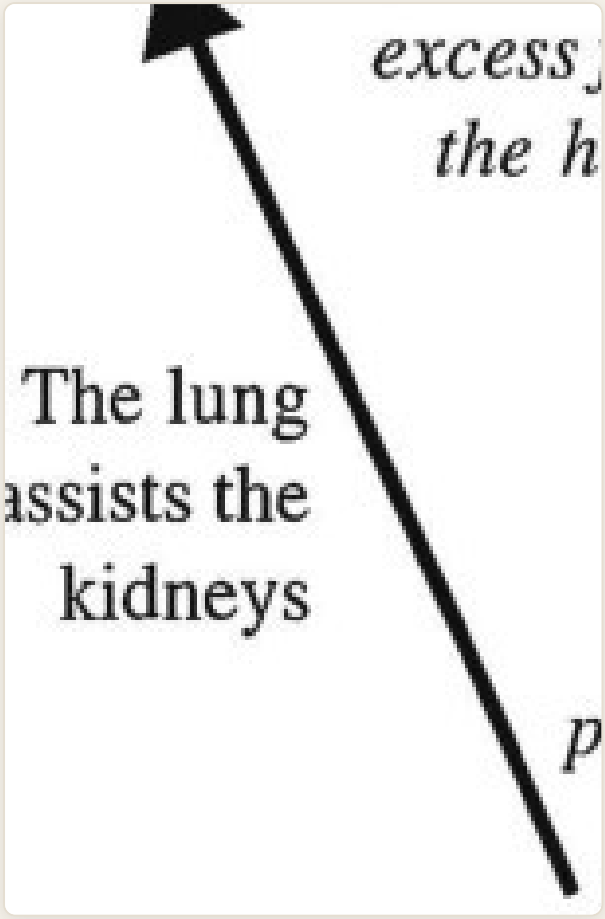
Phần chính giữa của đồ hình: chữ Liver (gan) ở trên cùng, Kidneys (thận) bên trái và Heart (tâm) bên phải, được nối với nhau bằng những mũi tên đậm và bị một ngôi sao năm cánh bằng nét mảnh cắt ngang. Dọc theo các mũi tên có ghi: Essence from the kidneys builds the liver (tinh của thận bồi đắp cho gan), Blood from the liver benefits the heart (huyết từ gan nuôi dưỡng tim), The liver relieves stagnation in the spleen (gan làm thông suốt sự ứ trệ ở tỳ), The kidneys moisten the heart and prevent excess fire in the heart (thận làm ẩm tâm và ngăn hỏa quá thịnh ở tâm) và Yang in the heart curbs reversed upward flow of qi in the lungs (dương khí ở tâm kiềm chế dòng khí nghịch lên ở phế).

HÌNH 15



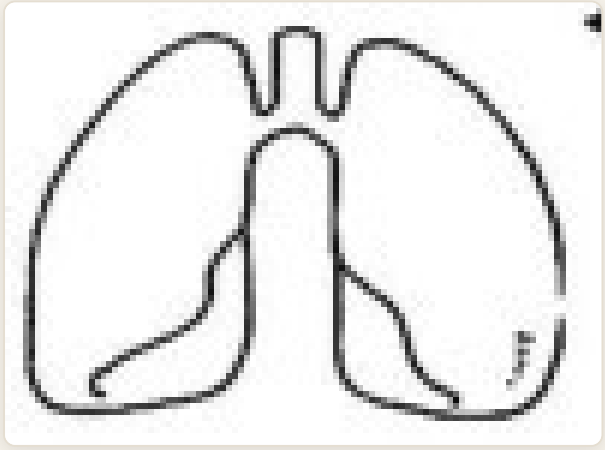
Một chi tiết ở phía dưới bên phải đồ hình: một mũi tên đậm chạy xuống và sang trái, ghi Heat in the heart warms the spleen (nhiệt ở tâm làm ấm tỳ), phía trên bên trái còn thấy phần đuôi của dòng chữ ...upward flow of qi in the lungs.

HÌNH 16



Một chi tiết ở phía dưới bên trái đồ hình: một mũi tên đậm chạy lên và sang phải, ghi The lung assists the kidneys (phế hỗ trợ thận), phía trên bên phải còn thấy phần đầu của dòng chữ excess....

HÌNH 17



Một hình vẽ nét nhỏ về hai lá phổi, là tạng được ghi là Lungs (phế) ở phía dưới bên trái đồ hình.

- - Đường liền — quan hệ tương sinh
- - Đường mảnh — quan hệ tương khắc

TRANG SÁCH 8 · SCAN P017

Ngũ tạng tương trợ và tương khắc lẫn nhau

Ngũ tạng tương trợ và tương khắc lẫn nhau

Nếu một tạng bị bệnh hoặc bị tổn thương bên trong, bệnh tật sẽ phát sinh. Nếu không được chữa trị, bệnh sẽ ảnh hưởng sang các tạng khác. Đó là quan hệ tương khắc: Giận dữ sẽ ảnh hưởng và làm tổn thương gan. Gan thuộc hành mộc. Mộc khắc thổ. Vì thế một lá gan bị kích động mạnh sẽ làm mất cân bằng chức năng tiêu hóa của tỳ (lá lách). Đến lượt mình, gan lại ảnh hưởng tới thận (thổ và thủy cân bằng lẫn nhau), tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Nếu một tạng hoạt động không bình thường, việc tăng cường chức năng của những tạng liên quan sẽ giúp tạng bị bệnh trở lại bình thường. Đó là quan hệ tương sinh. Ví dụ: việc chữa bệnh ở phổi có thể bắt đầu bằng một đơn thuốc bổ cho tỳ (lá lách). Phổi thuộc hành kim còn tỳ thuộc hành thổ; do đó một tỳ khỏe sẽ có lợi cho phổi, vì thổ sinh kim.

TRANG SÁCH 9 · SCAN P018

Phân loại sự vật và hiện tượng theo Ngũ hành

Phân loại sự vật và hiện tượng theo Ngũ hành

	Mộc	Hỏa	Thổ	Kim	Thủy
Tự nhiên					
Mùa	Xuân	Hạ	Trưởng Hạ	Thu	Đông
Phương hướng	Đông	Nam	Trung tâm	Tây	Bắc
Khí hậu	Gió	Ẩm ướt mùa hè	Ẩm thấp	Khô	Lạnh
Biến hóa	Nảy mầm	Sinh trưởng	Chuyển hóa	Thu hoạch	Tàng trữ
Màu sắc	Xanh lục	Đỏ	Vàng	Trắng	Đen

Vị	Chua	Đắng	Ngọt	Cay	Mặn
Âm (ngũ âm)	Giốc	Chủy	Cung	Thương	Vũ
Thân thể con người					
Ngũ giác quan	Mắt	Lưỡi	Miệng	Mũi	Tai
Tạng phủ	Gan	Tim	Lá lách	Phổi	Thận
	Túi mật	Ruột non	Dạ dày	Ruột già	Bàng quang
Tổ chức	Gân	Mạch	Cơ	Da, lông	Xương
Cảm xúc	Giận	Vui	Suy nghĩ	Buồn rầu	Sợ hãi
Âm thanh	Hét	Cười	Hát	Khóc	Than khóc

Tiền đề của Đông y

Tiền đề của Đông y

Cơ thể người là một hệ thống thống nhất

Đông y xem cơ thể người là tổng thể của nhiều bộ phận gắn kết với nhau. Mọi tạng phủ, kinh lạc, dòng chảy của khí và huyết đều không hoạt động độc lập, mà nương tựa vào nhau. Vì vậy, khi một bộ phận thay đổi thì các bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng theo. Trong chẩn đoán bệnh, cơ thể được xem như một chỉnh thể: quan sát bên ngoài sẽ hỗ trợ việc chẩn đoán bệnh bên trong. Phương pháp điều trị sau đó phải cân nhắc các mối liên hệ tương hỗ trước khi được đưa ra.

HÌNH 18

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rộng và quần dài sẫm màu đứng giơ hai tay lên, đối diện với một vòng tròn lớn vẽ bằng nét cọ. Bên trong vòng tròn, một con rồng cuộn mình bên trái và một con hổ bên phải. Những chòm sao lấm tấm trên nền trời quanh ông, còn dưới chân là núi đồi nhấp nhô và dòng nước chảy.

Mối quan hệ mật thiết giữa con người và môi trường

Các yếu tố tự nhiên như thay đổi khí hậu, thời điểm trong ngày, vị trí địa lý... đều ảnh hưởng ở một mức độ nhất định đến hoạt động sinh học của con người, những biến đổi của cơ thể cũng như việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Vì thế, tự nhiên được xem là một phần cấu thành nên con người. Giữa con người và tự nhiên có mối liên hệ gắn bó với nhau.

TRANG SÁCH 11 · SCAN P020

Bát cương

Bát cương

Trong Đông y, bệnh tật có thể được quy thành "Bát cương": Âm–Dương, Biểu–Lý, Hàn–Nhiệt và Hư–Thực.

Âm – Dương

Đây là cương lĩnh chủ đạo trong Bát cương. Biểu, Nhiệt và Thực thuộc Dương; Lý, Hàn và Hư thuộc Âm. (Âm–Dương sẽ được giải thích kỹ hơn ở những trang sau).

HÌNH 19

Một người phụ nữ mặc áo có hoa văn cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực, vẻ trầm tĩnh — trạng thái âm, hướng vào trong — bên cạnh là một người đàn ông lực lưỡng đang ôm bát, mặt cau có giận dữ và bốc khói từ đầu — trạng thái dương, hướng ra ngoài.

Biểu – Lý

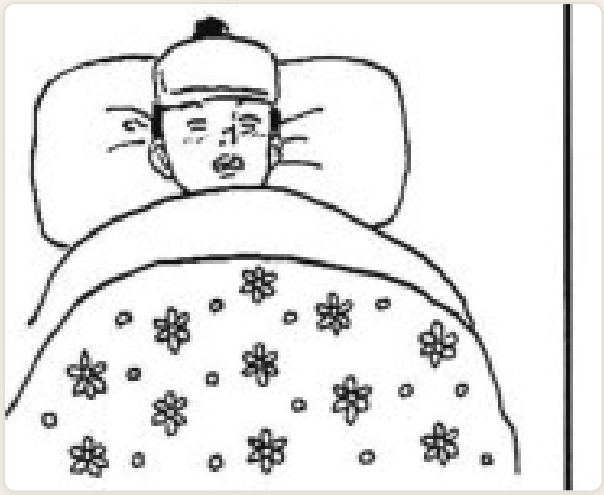
Một số bệnh đi từ bề mặt vào bên trong. Bệnh còn ở giai đoạn biểu thì nhẹ và dễ chữa.

Khi bệnh đã xâm nhập vào lý (bên trong), nghĩa là bệnh đã trở nên nặng.

HÌNH 20

Một người phụ nữ mặc áo dài cúi mặt, hai tay khoanh trước ngực, minh họa cho bệnh còn đang ở giai đoạn biểu.

HÌNH 21



Một người đàn ông nằm trên giường, đắp chiếc chăn dày có họa tiết hoa tuyết, đầu kê gối với vẻ mặt đau đớn, minh họa cho bệnh đã xâm nhập vào lý.

Hàn – Nhiệt

Các triệu chứng của hàn là tay chân lạnh, nước tiểu trong và da xanh nhợt. Các chứng của nhiệt gồm mặt đỏ bừng, người nóng, bứt rứt dữ dội và táo bón.

HÌNH 22

Hình vẽ gồm hai khung. Khung trên: một người phụ nữ ôm lấy thân mình run rẩy, bên cạnh là một người đàn ông đang quạt lấy mình với những ngọn lửa bốc lên quanh người — hàn và nhiệt. Khung dưới: một người phụ nữ choáng váng với vòng xoay lấp lánh trên đầu, và một người đàn ông mập mạp gập người, hai tay ôm chặt ngực — hư và thực.

Hư – Thực

Hư được đặc trưng bởi sự suy thiếu khí và huyết, thể trạng yếu ớt, sụt cân, chóng mặt... Thực được đặc trưng bởi các triệu chứng như thở nhanh, bứt rứt và táo bón.

TRANG SÁCH 12 · SCAN P021

Tạng phủ (các cơ quan nội tạng — ngũ tạng và lục phủ)

Tạng phủ (các cơ quan nội tạng — ngũ tạng và lục phủ)

Tạng phủ là các cơ quan nội tạng trong cơ thể người. Chúng được chia thành năm tạng và sáu phủ:

Ngũ tạng (năm tạng) gồm: tim, gan, lá lách, phổi và thận.

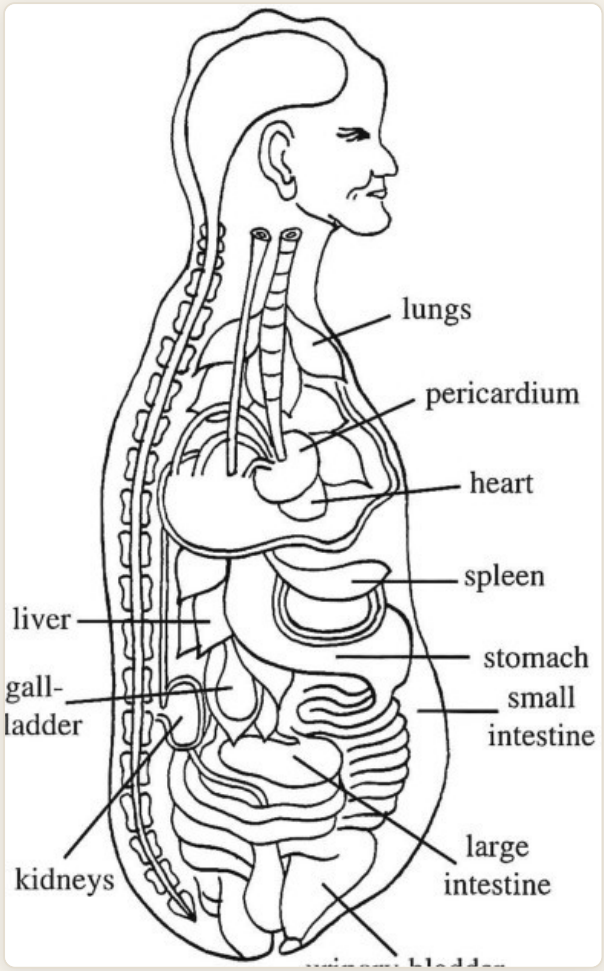
Lục phủ (sáu phủ) gồm: dạ dày, ruột non, ruột già, túi mật, bàng quang và Tam tiêu.

Ngũ tạng sinh dưỡng sự sống, là nơi tàng chứa năng lượng sống và tinh hoa của sự sống.

Lục phủ tiếp nhận những chất dư thừa, chuyển hóa nước và chất dinh dưỡng mà không tích trữ lại.

Ngũ tạng và lục phủ (tạng phủ) hợp thành một hệ thống với sự cân bằng âm dương tương ứng.

HÌNH 23



Sơ đồ giải phẫu cổ, vẽ các cơ quan trong cơ thể bên trong đường viền một hình người. Các đường chỉ dẫn lần lượt chỉ vào phổi, màng ngoài tim, tim, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, gan, túi mật, thận và bàng quang, cùng một chuỗi đốt sống chạy dọc theo cột sống. Sơ đồ này có đôi chỗ khác với các sơ đồ giải phẫu hiện đại.

Ngũ tạng (Âm) — Lục phủ (Dương)

Ngũ tạng (Âm)	Lục phủ (Dương)
Tim	Ruột non
Gan	Túi mật

Lá lách	Dạ dày
Phổi	Ruột già
Thận	Bàng quang
*Màng ngoài tim cùng các mạch máu	Tam tiêu

*Màng ngoài tim cùng các mạch máu: còn gọi là *shan zhong*, chỉ lớp màng (màng ngoài tim) bao quanh tim. Lớp màng này có tác dụng bảo vệ tim.

TRANG SÁCH 13 · SCAN P022

Trang 13

Tim

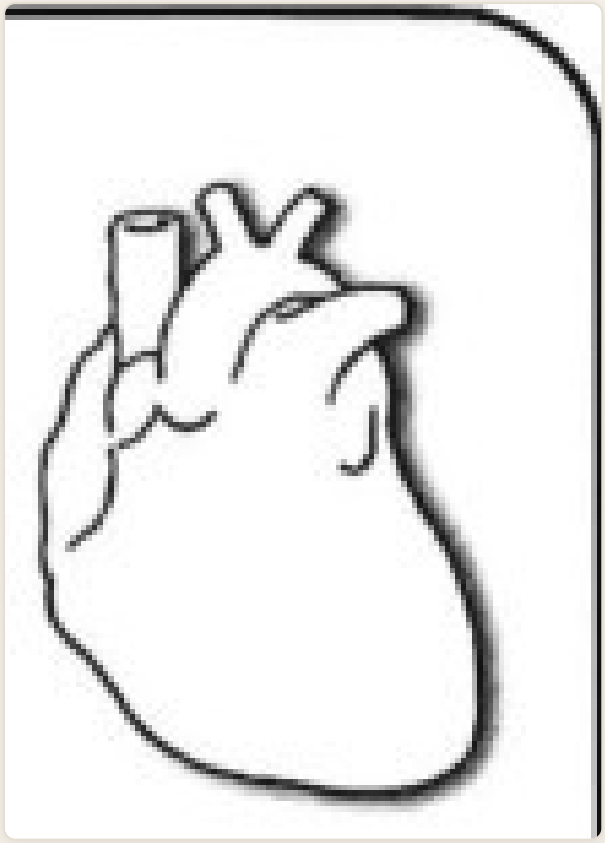
Kiểm soát hoạt động và chức năng của các tạng phủ.

Vận hành khí và huyết trong cơ thể, đưa chất dinh dưỡng đến các bộ phận khác của cơ thể.

Mồ hôi được gọi là dịch của tim.

Khi tim hoạt động tốt, khí huyết và tân dịch đầy đủ thì hai gò má hồng hào; khi huyết và tân dịch hư suy thì gương mặt trở nên nhợt nhạt.

HÌNH 24



Hình vẽ nét một quả tim người, phía trên là động mạch chủ và các mạch máu lớn.

Gan

Dự trữ và điều hoà lượng huyết trong cơ thể.

Điều hoà sự vận hành của khí, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc.

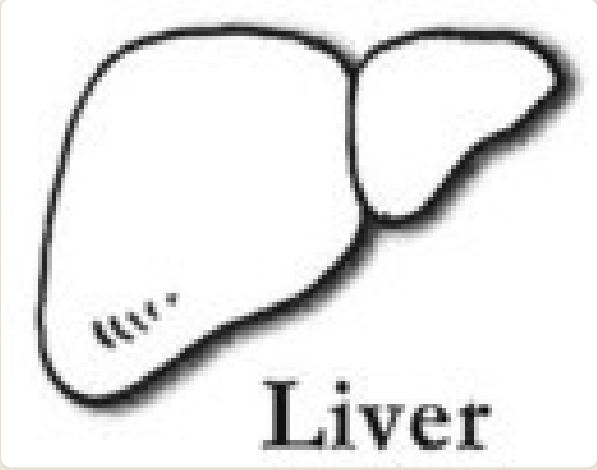
Hồn (魂) và thần (神) lấy huyết làm nền tảng.

Vì gan dự trữ huyết nên gan cũng dự trữ hồn.

Can âm và can huyết hư, hoặc can dương thịnh, sẽ khiến người ta dễ cáu gắt.

Gan đủ huyết thì móng tay chắc khoẻ, hồng hào; gan thiếu huyết thì móng tay mỏng, mềm và nhợt nhạt.

HÌNH 25



Hình vẽ nét một lá gan, với thuỳ phải lớn và thuỳ trái nhỏ hơn.

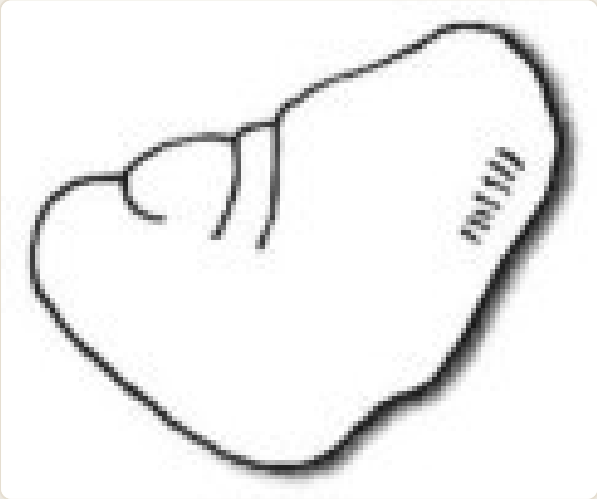
Lách

Kiểm soát tiêu hoá và vận chuyển: Giúp tiêu hoá và hấp thu chất dinh dưỡng để phân phối đi khắp cơ thể. Đồng thời vận chuyển tân dịch và duy trì sự cân bằng dịch thể.

Điều hoà dòng chảy của huyết trong mạch máu: Giúp nuôi dưỡng tay chân và cơ bắp. Lách khoẻ thì tay chân và cơ bắp cũng khoẻ mạnh. Kiểm soát dòng chảy của huyết trong động mạch và tĩnh mạch. Ngăn ngừa chảy máu.

Khí huyết đầy đủ thì môi đỏ và bóng mượt; lách thiếu huyết thì môi nhợt nhạt.

HÌNH 26



Hình vẽ nét một lá lách, dạng hạt đậu lớn với một vết khía ở bờ trong.

Phổi

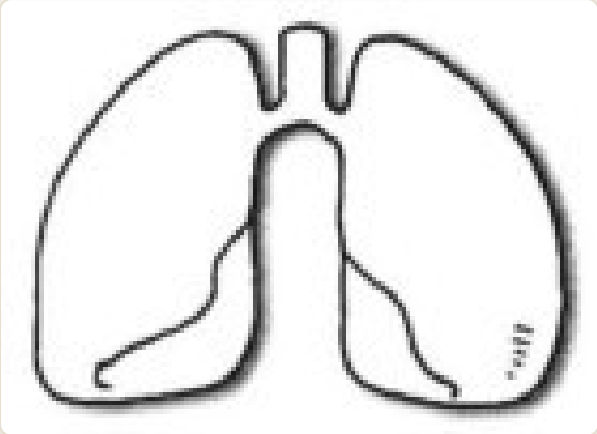
Chủ về khí. Hít vào không khí trong lành, thải ra khí carbonic và các loại khí khác để duy trì quá trình trao đổi chất.

Điều hoà sự vận động của tân dịch và khí trong cơ thể; sự giáng xuống dẫn khí đi xuống thận và bàng quang để duy trì sự lưu thông và bài xuất bình thường của tân dịch.

Mọi huyết trong cơ thể đều chảy qua phổi để trao đổi khí tươi mới và khí cũ trước khi đi đến các bộ phận khác.

Da khoẻ phản ánh chức năng phổi tốt và sức đề kháng với tà khí cao hơn.

HÌNH 27



Hình vẽ nét một đôi phổi nằm hai bên khí quản, khí quản chia thành hai phế quản.

Thận

Dự trữ tinh của ngũ tạng lục phủ. Đây là nền tảng của sự sống, duy trì mọi hoạt động sống.

Điều hoà sự chuyển hoá nước, kiểm soát sự phân phối và bài xuất nước, duy trì sự chuyển hoá nước trong cơ thể.

Tóc dày và bóng mượt phản ánh thận trẻ trung, khoẻ mạnh; còn tóc rụng phản ánh thận suy yếu, già nua.

Khí (Sinh Khí), Huyết và Tân Dịch

Khí (Sinh Khí), Huyết và Tân Dịch

Khí, huyết và tân dịch là những thành phần chính tạo nên và duy trì cơ thể con người. Chúng là nền tảng cho hoạt động bình thường của mọi cơ quan trong cơ thể.

Khí

Sinh khí là nguyên tố cơ bản của sự sống trong cơ thể con người. Sinh khí của chúng ta không ngừng lưu thông, thăng lên, giáng xuống, bị tán ra và được hấp thu vào. Những vận động ấy được gọi là "khí cơ". "Khí cơ" chỉ sự tăng, giảm và vận động của khí, tức là tác dụng sinh lý của khí. Khí cơ cân bằng thì các hoạt động sinh lý diễn ra bình thường. Khi khí mất cân bằng — chẳng hạn khi khí bị tắc trệ khiến mức khí tăng vọt và khí bị ứ đọng — thì sẽ sinh bệnh.

HÌNH 28

Hình vẽ nét một vị tiên nhân râu dài, áo choàng bay bổng, đứng chắp tay trong tay áo, hai bên là những đám mây khí cuộn lên.

Huyết và Tân Dịch

Sự tuần hoàn của huyết trong mạch có tác dụng cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho các tạng phủ, nhờ đó duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Nước da tươi sáng, tóc bóng mượt và cơ bắp săn chắc cho thấy huyết tuần hoàn tốt. Ngược lại sẽ xuất hiện những triệu chứng như chóng mặt, da xanh xao, tóc khô, da khô, hay quên và mất ý thức.

HÌNH 29

Hình vẽ nét một người mặc áo choàng ngồi co mình dưới một chiếc lá khổng lồ duy nhất, chiếc lá cong lên che chở như một tán cây.

Tân dịch bao gồm dịch từ các tạng phủ khác nhau và những chất tiết bình thường của cơ thể. Những dịch này giữ ẩm cho các tạng phủ bên trong và cũng có thể chuyển hoá thành huyết. Vì vậy, hao tổn tân dịch quá mức sẽ dẫn đến khí huyết suy yếu. Một số tình trạng như nôn, tiêu chảy và ra mồ hôi nhiều cũng làm cạn kiệt tân dịch. Đồng thời có thể xuất hiện các biểu hiện như khí đoản, sắc mặt nhợt nhạt và chứng ợ nóng.

HÌNH 30

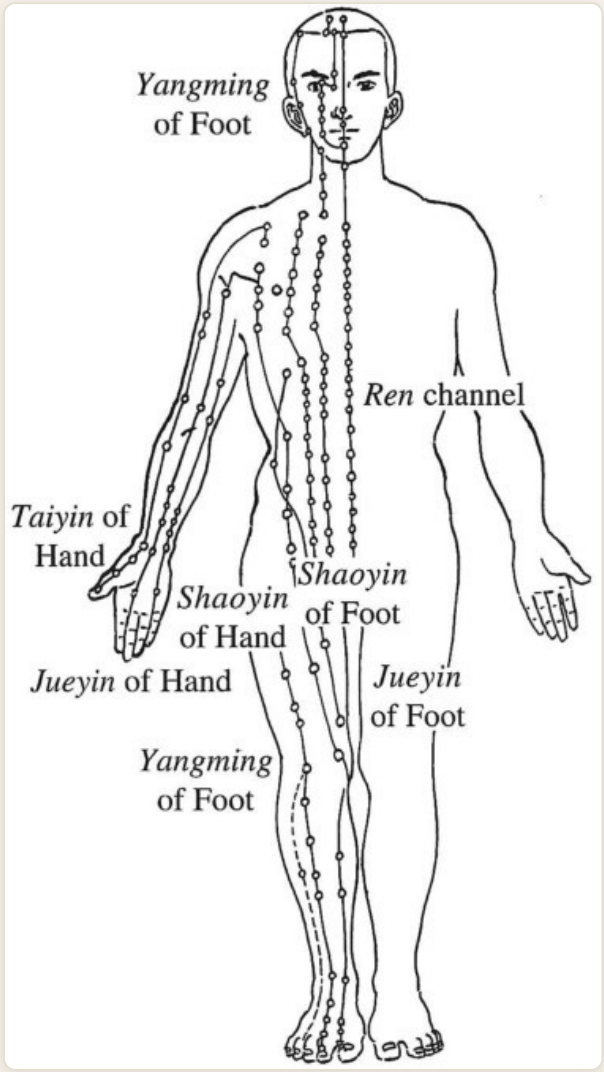
Hình vẽ nét một người mặc áo choàng nằm trên mặt đất, chống một cùi chỏ, đầu tựa vào bàn tay.

Kinh Mạch và Lạc Mạch, Huyệt Đạo

Kinh Mạch và Lạc Mạch, Huyệt Đạo

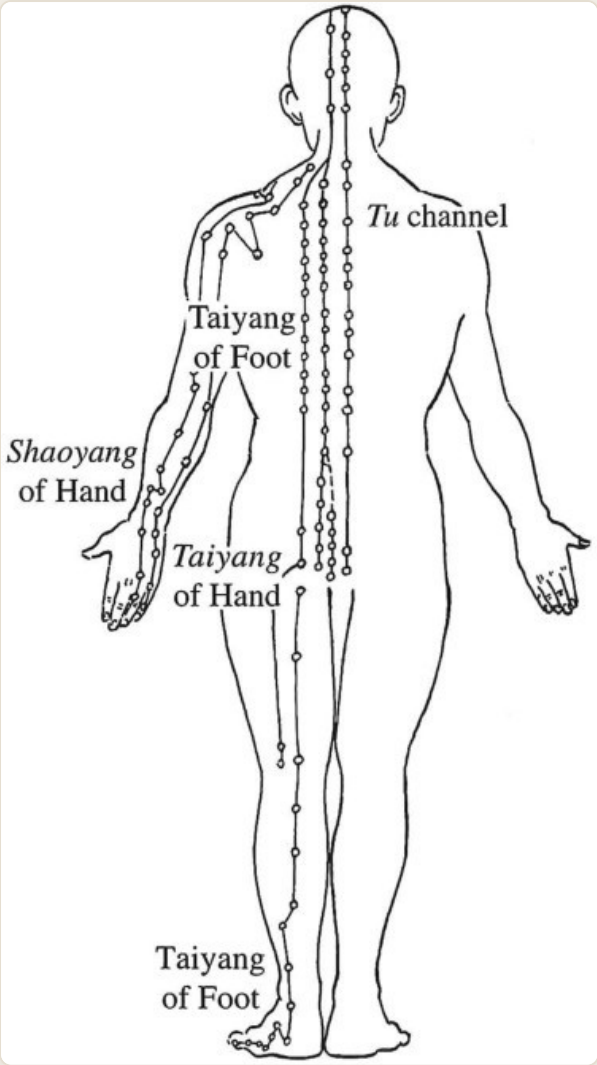
Kinh mạch và lạc mạch vận chuyển khí huyết, kết nối các tạng phủ, tay chân và khớp xương, đồng thời là nơi giao tiếp giữa biểu và lý. Kinh mạch và lạc mạch có trình tự nhất định và gắn với những tạng phủ tương ứng. Chúng có thể phản ánh mọi bệnh tật liên quan đến tạng phủ ấy.

HÌNH 31



Hình vẽ mặt trước của một người nam, hai tay hơi dang ra khỏi thân, cho thấy các đường kinh mạch và những hàng huyệt đạo chạy dọc mặt, ngực, bụng và tay chân. Các đường kinh được ghi tên: Dương Minh của Chân, Thái Âm của Tay, Quyết Âm của Tay, Thiếu Âm của Tay, Thiếu Âm của Chân, Quyết Âm của Chân, Dương Minh của Chân, mạch Nhâm và mạch Đốc.

HÌNH 32



Hình vẽ mặt sau của cùng người nam ấy, cho thấy các đường kinh mạch và huyệt đạo chạy dọc gáy, cột sống, vai, tay và chân. Các đường kinh được ghi tên: mạch Đốc, Thái Dương của Chân, Thiếu Dương của Tay, Thái Dương của Tay và Thái Dương của Chân.

TRANG SÁCH 16 · SCAN P025

Tóm Tắt về Kinh Mạch và Lạc Mạch

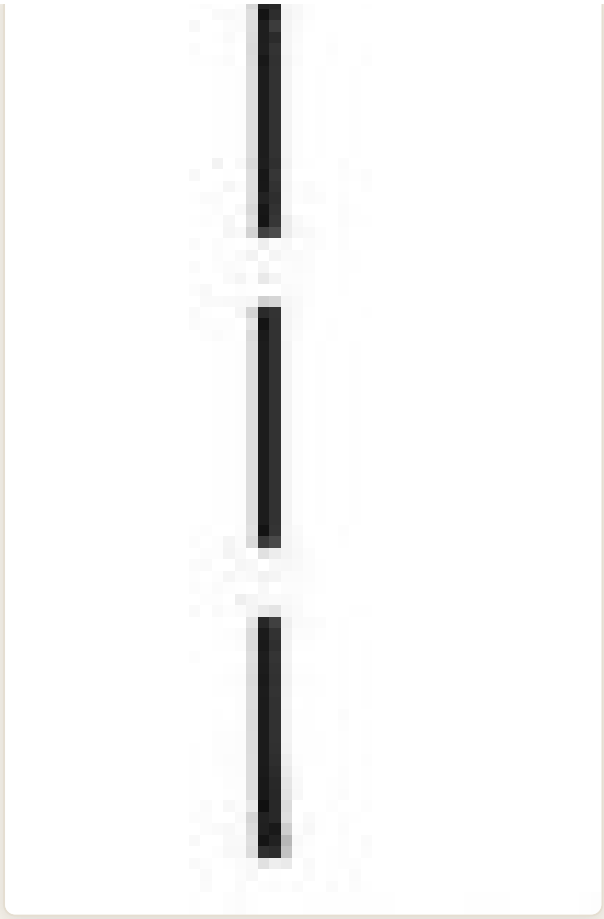
Tóm Tắt về Kinh Mạch và Lạc Mạch

- **- Kinh mạch và lạc mạch**
- **- Kinh mạch (đường kinh)**
- **- Mười hai đường kinh**
- **- Ba đường kinh âm ở tay**

- - Kinh Phế của tay *Thái Âm*
- - Kinh Tâm bào của tay *Quyết Âm*
- - Kinh Tâm của tay *Thiếu Âm*
- - **Ba đường kinh dương ở tay**
- - Kinh Đại trường của tay *Dương Minh*
- - Kinh Tam tiêu của tay *Thiếu Dương*
- - Kinh Tiểu trường của tay *Thái Dương*
- - **Ba đường kinh âm ở chân**
- - Kinh Tỳ của chân *Thái Âm*
- - Kinh Thận của chân *Thiếu Âm*
- - Kinh Can của chân *Quyết Âm*
- - **Ba đường kinh dương ở chân**
- - Kinh Vị của chân *Dương Minh*
- - Kinh Đởm của chân *Thiếu Dương*
- - Kinh Bàng quang của chân *Thái Dương*
- - **Các nhánh của mười hai đường kinh** — những nhánh lớn nhất tách ra từ mười hai đường kinh
- - **Tám mạch kỳ kinh** — Mạch Đốc, Mạch Nhâm, Mạch Xung, Mạch Đới, Mạch Âm kiều, Mạch Dương kiều, Mạch Âm duy và Mạch Dương duy
- - **Lạc mạch**
- - **Mười lăm lạc mạch chính** — *Lique, Tongli, Neiguan, Zhizheng, Pianli, Waiguan, Feiyang, Guangming, Fenglong, Gongsun, Dazhong, Ligou, Changqiang, Jiuwei và Dabao*
- - **Phù lạc** — những nhánh nhỏ được chia tiếp ra từ đường kinh hoặc từ mao mạch
- - **Tôn lạc** — những lạc mạch nằm ngay dưới bề mặt da

HÌNH 33

Twelve
Meridians



Nhãn ngoặc dọc lấy từ mép trái của sơ đồ, ghi dòng chữ "Twelve Meridians" (Mười hai đường kinh), bên cạnh là một đường nét đứt chạy dọc xuống.

Mười hai đường kinh: Còn gọi là mười hai chính kinh; mỗi đường kinh tương ứng với một tạng hoặc một phủ.

Tám mạch kỳ kinh: Không liên hệ trực tiếp với các tạng phủ. Chúng bổ trợ cho mười hai chính kinh.

Mười lăm lạc mạch chính: Những lạc mạch lớn hơn trong cơ thể.

Các nhánh của mười hai đường kinh: Đường đi bổ sung cho mười hai chính kinh để khí lưu thông trong kinh mạch.

TRANG SÁCH 17 · SCAN P026

Kinh lạc và huyệt đạo

Kinh lạc và huyệt đạo

Kinh mạch và lạc mạch vận chuyển khí và huyết, liên kết các tạng phủ, tay chân và khớp xương, đồng thời là nơi giao tiếp giữa biểu và lý trong khắp cơ thể. Kinh mạch và lạc mạch có thứ tự vận

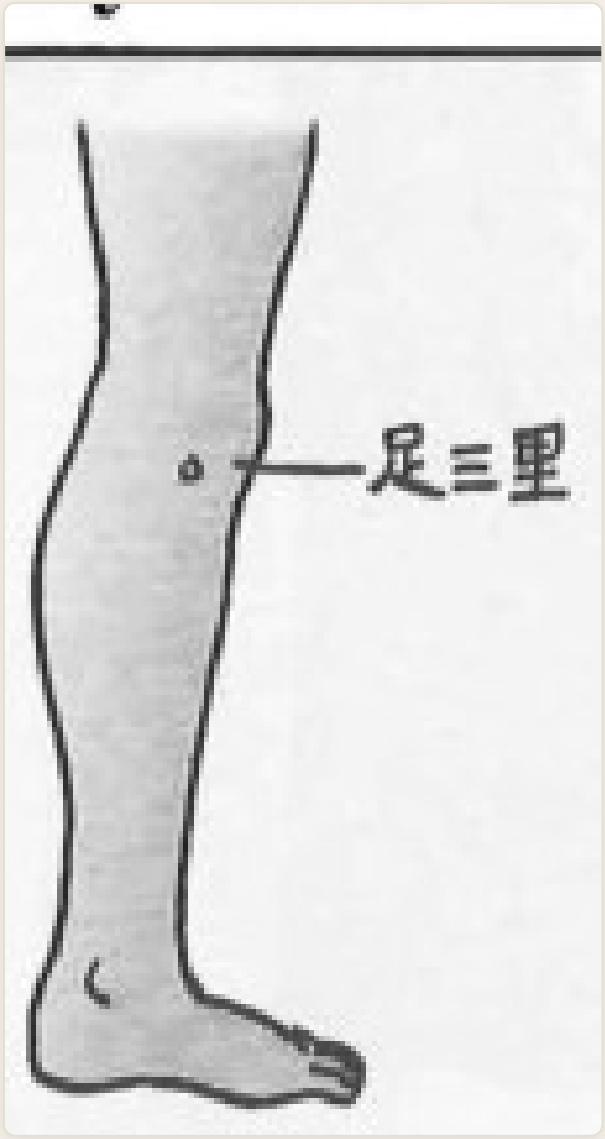
hành riêng và gắn với những tạng phủ nhất định. Chúng có thể phản ánh mọi chứng bệnh liên quan đến các tạng phủ ấy.

Huyệt đạo là một điểm nút nơi các bó mô thần kinh giao nhau. Cơ thể người có 720 huyệt đạo, trong đó 108 huyệt là yếu huyệt. Một số chứng bệnh có thể được chữa trị bằng cách kích thích các huyệt đạo.

Các huyệt đạo thường dùng

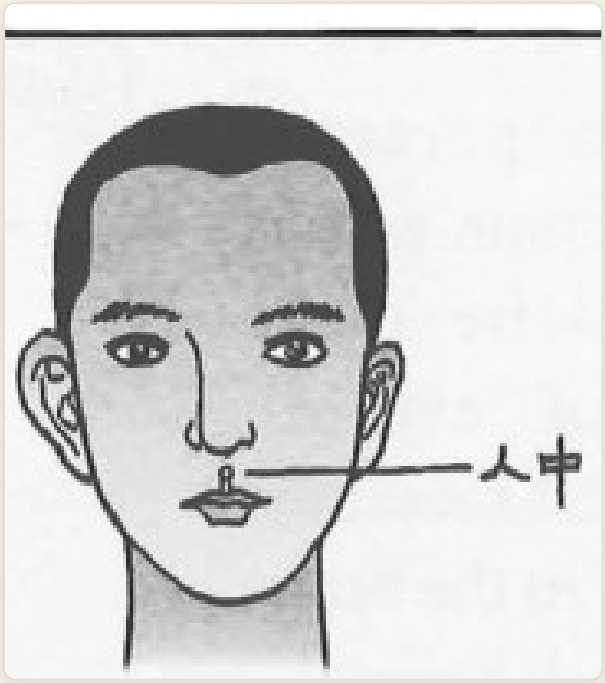
Huyệt đạo	Trị
Huyệt Túc Tam Lý (Zusanli)	Khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, các bệnh về dạ dày và cao huyết áp.
Huyệt Nhân Trung (Renzhong)	Hôn mê/mất ý thức. Ngoài ra còn trị mặt sưng phù và đau lưng.
Huyệt Hợp Cốc (Hegu)	Các bệnh ở mặt. Huyệt này còn làm giảm đau đầu, đau răng, đau họng, cảm lạnh, sốt, v.v.
Huyệt Dũng Tuyền (Tongquan)	Đau đầu, sốc, liệt một phần, trúng nắng, ù tai, viêm thận, các bệnh phụ nữ và bệnh của hệ sinh sản.
Huyệt Mệnh Môn (Mingmen)	Liệt dương, tinh trùng ít, tay chân yếu, thận dương hư, đau lưng, bệnh về tai, v.v.
Huyệt Bách Hội (Baihui)	Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn thần kinh, trúng phong và mất tiếng, huyết áp thấp, v.v.

HÌNH 34



Hình vẽ nét một cẳng chân và bàn chân để trần nhìn nghiêng. Một chấm nhỏ đánh dấu huyệt ở phía ngoài xương ống chân, dưới đầu gối, có một đường ngắn dẫn tới nhãn chữ Hán 足三里 (Túc Tam Lý) viết dọc.

HÌNH 35



Hình vẽ nét khuôn mặt một người đàn ông nhìn thẳng. Một chấm đánh dấu rãnh giữa mũi và môi trên, nối bằng một đường kẻ tới nhãn chữ Hán 人中 (Nhân Trung).

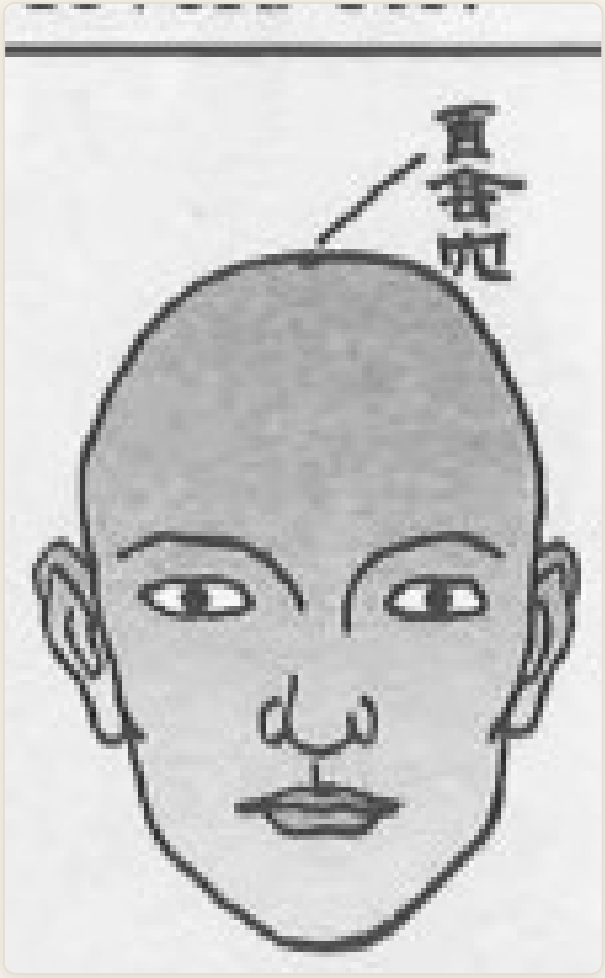
HÌNH 36

Hình vẽ nét mu bàn tay phải xoè các ngón. Một chấm đánh dấu khe giữa ngón cái và ngón trỏ, bên cạnh nhãn chữ Hán 合谷 (Hợp Cốc).

HÌNH 37

Hình vẽ nét lòng bàn chân, có một chấm ở khoảng một phần ba phía trên, bên cạnh nhãn chữ Hán 涌泉穴 (Dũng Tuyền) viết dọc.

HÌNH 38

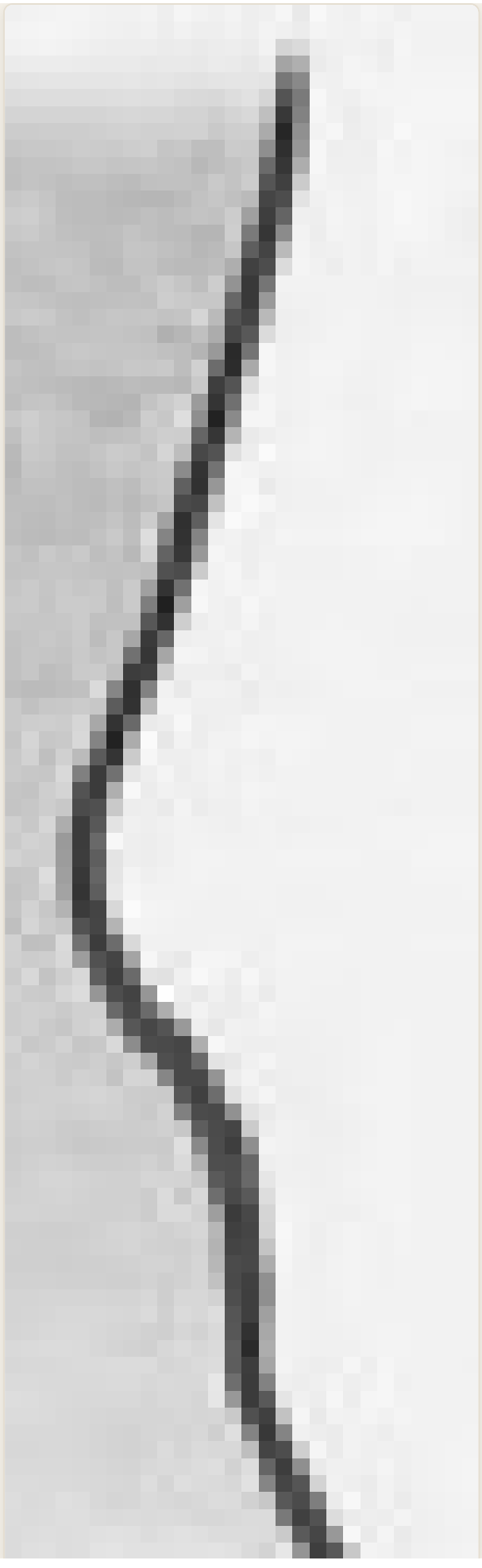


Hình vẽ nét đầu một người đàn ông hói nhìn thẳng, nhãn chữ Hán 百會穴 đặt phía trên đỉnh đầu và một đường ngắn chỉ xuống đỉnh đầu (huyệt Bách Hội).

HÌNH 39

Mảnh cắt của hình vẽ nét vùng eo – bụng dùng cho huyệt Mệnh Môn: đường viền cong dài bên trái của thân người, từ ngực xuống hông.

HÌNH 40



Mảnh cắt còn lại của cùng hình vẽ đó: đường viền cong bên phải của thân người, với chỗ lõm của vùng eo.

TRANG SÁCH 18 · SCAN P027

Nhân tố nội sinh và ngoại sinh

Nhân tố nội sinh và ngoại sinh

Nhân tố nội sinh

Nhân tố nội sinh là những biến đổi cảm xúc quá mức. Y học Trung Hoa cổ truyền ghi nhận bảy loại cảm xúc, và sẽ trình bày chúng ở một chương sau.

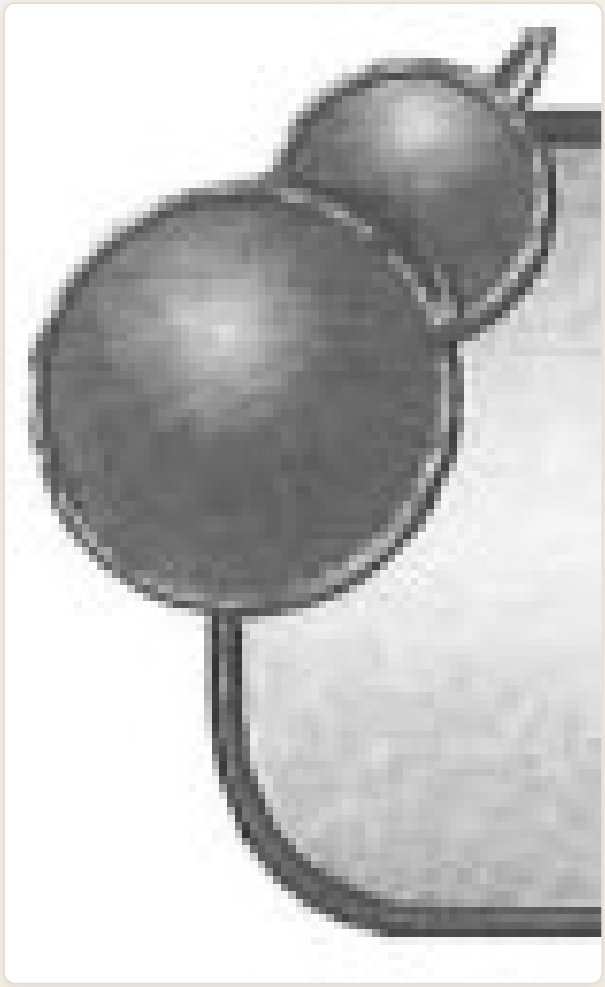
Sức khỏe chịu ảnh hưởng từ trạng thái cảm xúc của mỗi người. Vì vậy, người có tinh thần bất an sẽ càng dễ bị 'tà khí' xâm hại. Đó là lý do y học Trung Hoa cho rằng: "Trong cơ thể có chính khí thì tà khí không thể gây hại".

Nhân tố ngoại sinh

Nhân tố ngoại sinh là những tác động của môi trường như thời tiết và khí hậu thay đổi. Có sáu loại khí hậu được ghi nhận: phong, hàn, thử (nắng hè), thấp, táo và hỏa. Sáu loại khí hậu này mang nét riêng của từng mùa.

Thời tiết thay đổi đột ngột sẽ khiến sáu loại khí hậu mất đi sự hài hòa, chẳng hạn khi trời bỗng trở lạnh vào mùa xuân hay ấm lên vào mùa đông. Vì cơ thể người không thích ứng kịp với sự thay đổi thời tiết đột ngột ấy, đủ thứ bệnh tật sẽ phát sinh.

HÌNH 41



Hình trang trí hình quả bầu ở đầu bên trái dải tiêu đề xám của chương: hai múi tròn nối nhau ở eo, phía trên có một cuống ngắn, múi nhỏ nằm sau và cao hơn múi lớn.

HÌNH 42

Hình vẽ nét một người đàn ông mặc áo choàng dài, búi tóc, cúi gằm đầu và so vai lại. Hai đám hơi cuộn khói lượn quanh ông — một trước mặt, một sau lưng — cả hai đều mang dòng chữ evil qi (tà khí).

HÌNH 43

Hình vẽ nét một người đàn ông mặc áo tay rộng, búi tóc, đứng giữa cơn mưa xiên và những chiếc lá khô đang rơi. Ông quay nghiêng người, hắt hơi thật mạnh, miệng há ra và nước bắn khỏi mũi, bên cạnh mặt là dòng chữ Achoo! (Hắt xì!).

TRANG SÁCH 19 · SCAN P028

Trang 19

Phong (gió) chủ yếu xuất hiện vào mùa xuân, dù cả bốn mùa đều có những đợt gió. Phong là thủ phạm chính gây ra nhiều chứng bệnh. Vì phong có tính di động, các loại tà khí như hàn, táo, thấp và nhiệt sẽ theo đó xâm nhập vào cơ thể, gây ra những vấn đề như cảm lạnh và phong thấp.

Hàn (lạnh) xuất hiện vào mùa đông khi nhiệt độ không khí giảm xuống. Hàn là âm tà, có thể làm tổn hại dương khí. Khi cơ thể bị hàn xâm nhập, sẽ xuất hiện những triệu chứng như sốt, không ra mồ hôi và đau đầu.

Thử (nắng hè) vào mùa hè nóng bức có thể gây chóng mặt, mồ hôi lạnh, tay chân lạnh. Đó là những triệu chứng của trúng nắng.

Thấp do độ ẩm trong không khí tăng lên. Vào mùa mưa, mặt đất trở nên ẩm ướt. Người ta dễ mắc bệnh.

Táo (khô) xuất hiện vào mùa thu khi độ ẩm thấp. Táo gây khô họng và khô miệng, cùng nhiều chứng bệnh khác.

Hỏa (lửa) do nhiệt sinh ra. Phong, hàn, thử và táo đều có thể dẫn đến hỏa. Các triệu chứng gồm sốt cao, mặt đỏ bừng, tinh thần bất an, khát nước, v.v.

TRANG SÁCH 20 · SCAN P029

Không nội sinh cũng không ngoại sinh

Không nội sinh cũng không ngoại sinh

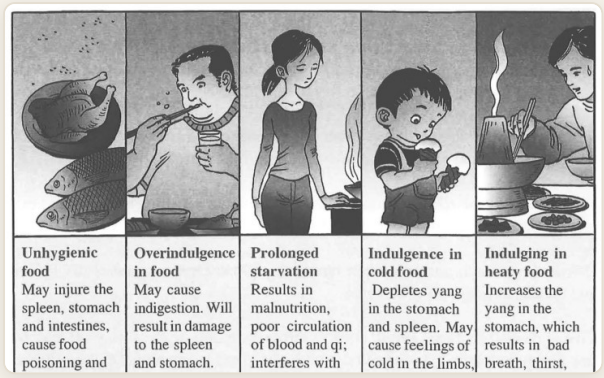
Người xưa có câu: "Chúng ta chính là những gì chúng ta ăn". Chế độ ăn uống cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều chứng bệnh.

	Thực phẩm không hợp vệ sinh	Ăn quá độ	Nhịn đói kéo dài	Ăn nhiều đồ lạnh	Ăn nhiều đồ nóng
	Có thể làm tổn thương tỳ, vị và ruột, gây ngộ độc thực phẩm và để ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.	Có thể gây khó tiêu. Sẽ dẫn đến tổn thương tỳ và vị.	Dẫn đến suy dinh dưỡng, khí huyết lưu thông kém; cản trở sự phát triển ở tuổi dậy thì.	Làm hao tổn dương khí ở vị và tỳ. Có thể gây cảm giác lạnh ở tay chân, tiêu chảy và đau bụng.	Làm tăng dương khí ở vị, dẫn đến hôi miệng, khát nước, táo bón, v.v.

Hoạt động và nghỉ ngơi của cơ thể có liên quan mật thiết đến trạng thái sức khỏe của chúng ta.

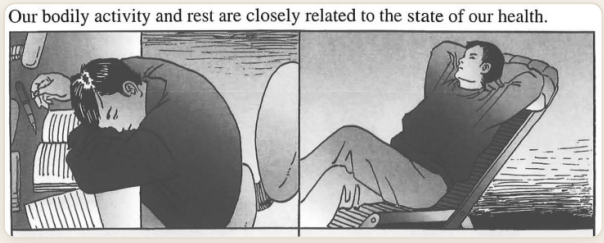
Mệt nhọc quá độ	Nhàn rỗi quá độ
Sự gắng sức quá mức về thể chất lẫn tinh thần sẽ gây ra những chứng bệnh như suy nhược tinh thần, hay quên, sút cân, mất ngủ và hồi hộp tim.	Lối sống nhàn rỗi, ngồi nhiều sẽ dẫn đến một số chứng bệnh như uể oải, kém ăn, sức bền kém và tăng cân.

HÌNH 44



Dải năm khung minh họa các cách ăn uống. Khung thứ nhất: một con gà đã nấu chín và hai con cá nằm trên đĩa, ruồi bay lởn vởn phía trên. Khung thứ hai: một người đàn ông bụng phệ ngồi ăn, một tay cầm đũa, tay kia cầm bát cơm. Khung thứ ba: một phụ nữ trẻ gầy gò đứng bên bếp, hơi nước bốc lên từ nồi, một tay đặt trên mặt bàn. Khung thứ tư: một cậu bé mặc áo sọc đang cắn que kem. Khung thứ năm: một người đàn ông ngồi cầm đũa trên nồi lẩu nghi ngút khói, xung quanh bày la liệt đĩa thức ăn.

HÌNH 45



Dải hai khung. Bên trái: một người đàn ông gục mặt ngủ trên bàn, tay vẫn cầm bút chì, bên cạnh là cuốn vở đang mở, một cốc nước và chiếc điện thoại di động. Bên phải: một người đàn ông nằm ngả trên ghế xếp, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm, chân bắt chéo, sau lưng là đường chân trời được phác bằng nét gạch.

TRANG SÁCH 21 · SCAN P030

Bệnh đã vào tới chỗ hiểm yếu

Bệnh đã vào tới chỗ hiểm yếu

Câu ngạn ngữ "bệnh đã vào tới chỗ hiểm yếu" (*bệnh nhập cao hoang*) dùng để chỉ một tình trạng y khoa vô phương cứu chữa.

Vậy rốt cuộc "chỗ hiểm yếu" là chỗ nào? Câu chuyện sau đây sẽ cho bạn một hình dung.

Vào thời Xuân Thu, vua Tấn Cảnh Công nước Tấn lâm bệnh rất nặng.

Hãy triệu danh y Hoãn đến.

Trước khi Hoãn đến, vua Tấn Cảnh Công nằm mơ...

Hì... hì...

Chỗ này thích quá! Ta không đi đâu.

HÌNH 46

Trang truyện tranh toàn trang. Khung lớn ở góc trên bên trái mang tiêu đề The Disease Has Entered the Vitals (Bệnh đã vào tới chỗ hiểm yếu), phía dưới là hai đứa trẻ mặc áo hoa, tóc búi hai bên, đang bay lơ lửng trên một người nằm ngủ mà khuôn mặt nhô lên ở mép dưới khung. Khung trên bên phải: một con rồng xanh nói qua hai bong bóng thoại, trước hết giải thích câu ngạn ngữ, rồi hứa rằng câu chuyện sẽ cho thấy "chỗ hiểm yếu" là gì. Khung giữa: một người hầu quỳ trên sàn bên cạnh án nhỏ dâng thuốc cho nhà vua nằm trên giường phủ chăn hoa văn cuộn xoáy; bong bóng thoại phía trên ra lệnh triệu danh y Hoãn. Khung dưới bên trái: cận cảnh gương mặt vua Tấn Cảnh Công đang ngủ, kèm ô chú thích kể rằng trước khi Hoãn đến, nhà vua nằm mơ. Khung dưới bên phải: hai đứa trẻ trong giấc mơ cười khúc khích và nói rằng chỗ này dễ chịu quá nên chúng không chịu rời đi.

Trang 22

Hoãn là một thầy thuốc giỏi. Ta sợ ông ấy sẽ làm hại chúng ta.

Chúng ta sẽ trốn phía trên 'hoang' (khoảng giữa tim và cơ hoành) và 'cao' (lớp mỡ quanh tim). Xem ông ấy làm gì được chúng ta nào!

Đi thôi!

Đó có phải là Hoãn không? Bệnh của ta có chữa được không?

Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự thẳng thắn của thần. Bệnh đã nhập cao hoang*.

Châm cứu không có tác dụng trong trường hợp này. Thuốc thang cũng vậy. Bệnh đã vượt quá khả năng chữa trị.

Ngươi quả xứng với danh tiếng thầy thuốc giỏi! Chẩn đoán của ngươi đúng hệt như điều ta đã mơ thấy.

'Cao' chỉ lớp mỡ quanh tim; 'hoang' chỉ vùng giữa tim và cơ hoành. Vì vậy *cao hoang* chỉ vùng nằm dưới tim và trên cơ hoành.

* *bệnh nhập cao hoang*

HÌNH 47

Trang truyện tranh toàn trang, tiếp diễn câu chuyện. Hàng khung trên cùng là hai đứa trẻ trong giấc mơ: khung thứ nhất, một đứa cảnh báo rằng Hoãn là thầy thuốc giỏi nên có thể làm hại chúng; khung thứ hai, đứa kia giơ ngón tay chỉ lên và nói chúng sẽ trốn phía trên 'hoang' — khoảng giữa tim và cơ hoành — và 'cao', lớp mỡ quanh tim, để xem ông ấy làm gì được; khung thứ ba, cả hai vọt đi với tiếng "Đi thôi!", bên dưới là gương mặt nhà vua đang toát mồ hôi lo lắng. Khung lớn ở giữa: Hoãn trong áo Nho sinh quỳ bên giường vua, tay chống cằm; vua hỏi liệu bệnh của mình có chữa được không, Hoãn đáp rằng bệnh đã nhập cao hoang nên châm cứu lẫn thuốc thang đều vô hiệu, bệnh đã vượt quá khả năng chữa trị. Khung dưới bên trái: nhà vua tựa gối khen Hoãn quả xứng với danh tiếng thầy thuốc giỏi và nói chẩn đoán ấy đúng hệt như điều mình đã mơ thấy, trong khi Hoãn cúi lạy trước vua. Khung dưới bên phải: con rồng dùng que chỉ vào hình vẽ phẫu diện thân người với tim, phổi, dạ dày, gan và ruột, rồi giải thích rằng 'cao' là lớp mỡ quanh tim còn 'hoang' là khoảng giữa tim và cơ hoành, vì thế cao hoang chỉ vùng nằm dưới tim và trên cơ hoành.

Làm thế nào để phòng bệnh

Làm thế nào để phòng bệnh

Bệnh tật do tà khí gây ra. Mắc bệnh cũng giống như một trận chiến giữa chính và tà. Vì vậy, để phòng bệnh, chúng ta cần bồi đắp chính khí trong cơ thể nhằm ngăn chặn tà khí xâm nhập.

Bồi dưỡng chính khí

Chính khí suy yếu là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh. Bồi dưỡng chính khí sẽ làm thể chất vững vàng, nâng cao sức đề kháng, duy trì sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ. Vậy bồi dưỡng chính khí bằng cách nào? Dưới đây là một vài cách:

1. **Thuận theo quy luật tự nhiên:** Cơ thể người và tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, nên cơ thể cần hài hòa với tự nhiên. "Dương khí hưng thịnh vào mùa xuân và mùa hè; âm khí được bồi đắp vào mùa thu và mùa đông". Hiểu được điều này thì bệnh tật sẽ khó xâm nhập chúng ta.

2. **Coi trọng sức khỏe tinh thần:** Giữ tâm trạng vui vẻ, hoan hỷ. Thân thể ta chịu ảnh hưởng từ sức khỏe tinh thần. Sống vui vẻ sẽ giúp ta khỏe mạnh.

3. **Chú ý đến ăn uống và nếp sống:** Một chế độ ăn cân bằng cùng nếp sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi và vận động hợp lý sẽ cho ta nguồn năng lượng dồi dào và một cơ thể khỏe mạnh.

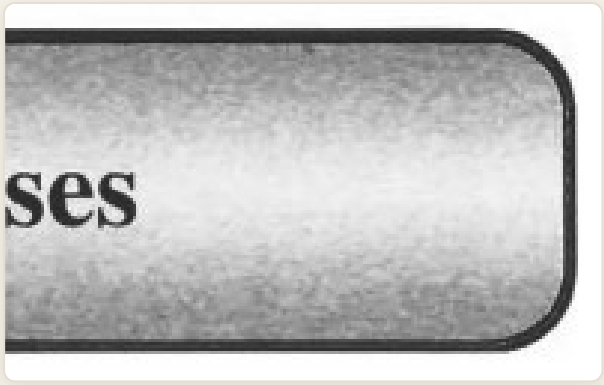
4. **Rèn luyện thể chất:** Những bài tập như *khí công*, *thái cực quyền* và *võ thuật* là cách thúc đẩy tuần hoàn máu, làm bền cơ và xương, đồng thời tăng cường sức lực.

5. **Các biện pháp phòng bệnh hỗ trợ:** Tiêm chủng và dùng điều độ vitamin cùng các vị thuốc bổ cũng giúp xây dựng miễn dịch và tăng sức đề kháng với mầm bệnh.

HÌNH 48

Phần đầu dải tiêu đề xám của chương: hình trang trí quả bầu hai múi ở mép trái, cùng đoạn đầu của khung chữ nhật mang dòng chữ How To Prevent Diseases (Làm thế nào để phòng bệnh).

HÌNH 49



Phần còn lại của cùng khung tiêu đề xám, mang những chữ cái cuối "...ses" của từ Diseases và góc phải bo tròn của khung.

HÌNH 50

Dải dọc gồm năm hình tròn chạy xuống theo mép trái của danh sách: một cậu bé đứng bên mép nước nhìn mặt trời hoặc mặt trăng thấp trên mặt biển; một người đàn ông mặc sơ mi giơ một tay lên với vẻ mặt hài lòng; một phụ nữ ngồi bên bàn xếp hình; một người đứng ở thế võ, một tay duỗi ra, tay kia chống hông; và một người cầm cốc nước để uống thuốc.

TRANG SÁCH 24 · SCAN P033

Chống lại tà khí

Chống lại tà khí

Khi tà khí xâm nhập cơ thể, người ta mắc bệnh. Tránh xa tà khí sẽ làm giảm sự xuất hiện của bệnh tật.

Dưới đây là những cách phòng ngừa hoặc khống chế bệnh tật:

1. **Dùng thuốc để tiêu diệt tác nhân gây bệnh:** Bôi kem trị bệnh, làm sạch và sát trùng vùng bị nhiễm, uống thuốc để tiêu diệt nguyên nhân gây bệnh.

2. **Vệ sinh cá nhân:** Mầm bệnh thường ẩn náu quanh ta. Vệ sinh thực phẩm, nguồn nước sạch và môi trường xung quanh sạch sẽ sẽ ngăn vi-rút và vi khuẩn sinh sôi.

3. **Tránh nguồn lây nhiễm:** Tránh tiếp xúc trực tiếp với người đang mắc bệnh truyền nhiễm để bệnh không lây lan.

4. **Phòng tránh tai nạn và thương tích:** Sức miễn dịch sẽ giảm khi bị thương, vì thế khả năng mắc bệnh sẽ tăng lên.

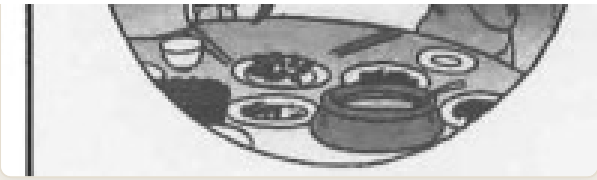
5. **Chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách:** Chúng ta chính là những gì chúng ta ăn. Ăn uống là việc diễn ra hằng ngày. Thực phẩm cung cấp cho cơ thể năng lượng để thực hiện các

hoạt động thường nhật. Nhưng nếu thực phẩm không được chế biến hoặc bảo quản đúng cách, nó có thể gây bệnh.

HÌNH 51

Hình tròn minh họa cho mục thứ nhất: một người đàn ông mặc áo khoác để mở, một tay cầm cốc nước, tay kia sờ vào cổ họng; bên cạnh là một lọ thuốc, một vỉ thuốc con nhộng và một viên thuốc rời.

HÌNH 52



Dải dọc gồm bốn hình tròn chạy xuống theo mép trái của danh sách: một phụ nữ đang rửa cốc bên bồn nước; một người đàn ông mặc áo bông đứng ngoài cửa sổ vẫy tay chào người đang nằm bệnh trong nhà; một người đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy; và hai người ngồi ăn bên bàn, một người vươn đũa gắp thức ăn mời.

TRANG SÁCH 25 · SCAN P034

Y học cổ truyền Trung Quốc (Thuật Kỳ Hoàng)

Y học cổ truyền Trung Quốc (Thuật Kỳ Hoàng)

Y học cổ truyền Trung Quốc còn được gọi là Thuật Kỳ Hoàng (岐黃之術). Kỳ và Hoàng chỉ hai con người — Hoàng Đế (Vua Sắc Vàng) và Kỳ Bá. Hoàng Đế là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa. Tương truyền chính ông đã sáng lập ra y học cổ truyền Trung Quốc. Kỳ Bá, một người uyên bác về y học, là bề tôi của Hoàng Đế. Vì hai người là những người đầu tiên đề xướng các học thuyết y học Trung Hoa, đặt nền móng cho nền y học Trung Quốc, nên người ta bắt đầu dùng chữ "Kỳ Hoàng" để chỉ y học Trung Quốc.

HÌNH 53

Chú rồng linh vật nhỏ của sách thò đầu qua góc trên bên trái của khung trang: chỉ có đầu, mào và một chân trước có vuốt nhô lên trên đường viền, bên má có vài giọt mồ hôi.

HÌNH 54

Tranh vẽ nét toàn chiều ngang: hai người đàn ông ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn đá thấp. Người bên trái đội mũ trùm sát đầu, tay cầm một túi thuốc gấp lại; người bên phải để tóc dài, đội mũ miện của bậc vương giả, phía sau có giá treo mũ miện có tua rủ xuống, và đang nâng một nhánh thảo dược. Trên bàn có một chiếc bình, hai chiếc chén và một bó thảo dược; bên phải là một chiếc sọt đan đựng lá cây, còn phía trước bên trái là những hòn đá và bụi cây.

TRANG SÁCH 26 · SCAN P035

Bảo vật của y học Trung Quốc — *Hoàng Đế Nội Kinh*

Bảo vật của y học Trung Quốc — *Hoàng Đế Nội Kinh*

Bàn về y học Trung Quốc, không thể không nhắc đến *Hoàng Đế Nội Kinh*.

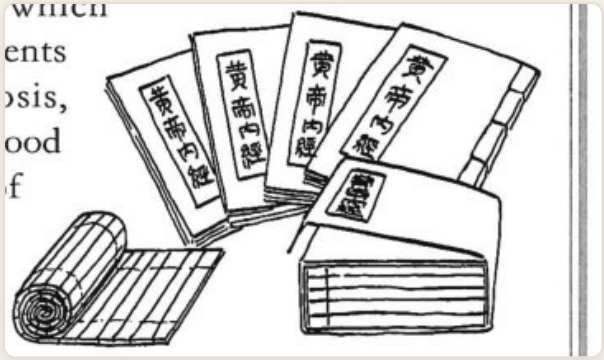
Được biên soạn vào thời Chiến Quốc, tác phẩm này tập hợp những giai thoại và học thuyết y học của nhiều danh y thời cổ. *Hoàng Đế Nội Kinh* nổi tiếng là bộ sách sớm nhất giải thích sinh lý con người, bệnh tật và cách chữa trị, chẩn đoán, phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe qua sự hiểu biết về âm dương và ngũ hành. Bộ sách đã đặt nền móng cho y học cổ truyền Trung Quốc, làm cơ sở cho các học thuyết về sau.

Hoàng Đế Nội Kinh gồm hai phần — *Tố Vấn* và *Linh Khu* (Kinh Châm Cứu). Tất cả có 18 quyển và 162 chương.

Tố Vấn khảo sát sự phát triển của con người, mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, các nguyên tắc và phương pháp giữ gìn sức khỏe, bốn phương pháp chẩn đoán cùng việc phòng và chữa bệnh.

Linh Khu giới thiệu các đường kinh chính và lạc mạch cùng các huyệt đạo trên cơ thể người, mối liên hệ giữa tinh thần và bệnh tật thể xác, tìm hiểu phần ngoài cơ thể người và các tạng phủ bên trong, các thể chất và trạng thái sức khỏe khác nhau, châm cứu, v.v.

HÌNH 55

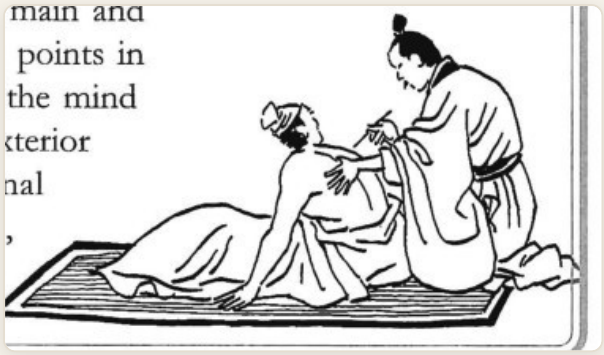


Một chồng sách đóng gáy kiểu truyền thống xòe ra như quạt, mặt bìa hướng về phía người xem, mỗi bìa đều ghi nhan đề 黃帝內經; bên cạnh là một cuộn thẻ tre cuộn tròn và một quyển sách khác nằm ngửa, để lộ mép trang.

HÌNH 56

Một người đàn ông có râu, mặc áo rộng, ngồi xếp bằng trên nền đất dưới một gốc cây cổ thụ xù xì, hai tay giơ cao quá đầu, lòng bàn tay mở ra, trong tư thế luyện tập dưỡng sinh; quanh ông là cỏ thấp và rễ cây.

HÌNH 57



Hai người trên một tấm chiếu đan: người bệnh nằm nghiêng, còn thầy thuốc quỳ phía sau, đang đưa mũi kim nhỏ vào lưng người bệnh.

TRANG SÁCH 27 · SCAN P036

Các phương pháp chẩn đoán trong y học cổ truyền Trung Quốc

Các phương pháp chẩn đoán trong y học cổ truyền Trung Quốc

Y học cổ truyền Trung Quốc có những phương pháp chẩn đoán độc đáo riêng. Nghề y Trung Quốc không dùng ống nghe, máy X-quang hay các thiết bị chẩn đoán nào khác. Thay vào đó, người ta dùng vọng (quan sát), văn (nghe và ngửi), vấn (hỏi) và thiết (bắt mạch) để chẩn đoán bệnh.

HÌNH 58

Một thầy thuốc đội mũ nho sĩ, mặc áo dài, ngồi trên ghế bên chiếc bàn nhỏ, đang bắt mạch cho người bệnh quỳ trên chiếc ghế đẩu thấp đối diện; giữa hai người, trên bàn, có một hộp dụng cụ nhỏ. Phía sau họ treo một tấm biển dọc cao, trên đó viết bốn chữ 妙手回春.

TRANG SÁCH 28 · SCAN P037

Tứ chẩn

Tứ chẩn

Vọng chẩn (quan sát)

Xem xét tình trạng sức khỏe chung của người bệnh, màu sắc nước da, v.v.

HÌNH 59

Thầy thuốc, một cụ ông đội mũ mềm, đeo kính, ngồi chống cằm lên tay, chăm chú quan sát người bệnh.

HÌNH 60

Người bệnh, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi có cổ, được vẽ nghiêng mặt về phía thầy thuốc, miệng khép, im lặng chờ đợi.

Văn chẩn (nghe và ngửi)

Giọng nói, nhịp thở và hơi thở của người bệnh được phân tích.

HÌNH 61

Cũng chàng trai trẻ ấy, vẽ nghiêng mặt, lúc này miệng đang mở như đang nói hoặc thở ra.

HÌNH 62

Thầy thuốc vẽ nghiêng mặt, đầu nghiêng và quay về phía người bệnh để lắng nghe.

Vấn chẩn (hỏi)

Hỏi người bệnh về bệnh tình, các triệu chứng và cảm giác mà họ trải qua, v.v.

HÌNH 63

Thầy thuốc cúi đầu, người chồm tới trước để hỏi bệnh người bệnh.

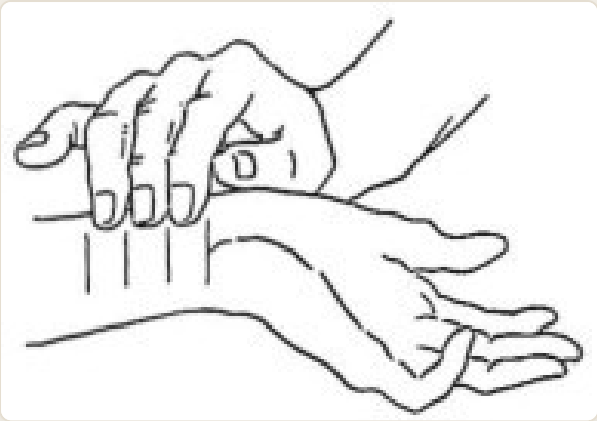
HÌNH 64

Lại là chàng trai trẻ vẽ nghiêng mặt, đối diện và trả lời thầy thuốc.

Thiết chẩn (bắt mạch)

Những thay đổi trong mạch của người bệnh được dùng để xác định sự lưu thông khí huyết của họ.

HÌNH 65



Cận cảnh những ngón tay của thầy thuốc đặt trên cổ tay người bệnh để bắt mạch, bàn tay người bệnh ngửa lên.

TRANG SÁCH 29 · SCAN P038

Chẩn đoán qua quan sát

Chẩn đoán qua quan sát

Sắc mặt và các tạng phủ của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mọi thay đổi trong sự lưu thông khí huyết nơi tạng phủ đều thể hiện ra bên ngoài hình hài của người đó, trong đó có việc quan sát mức sinh lực và màu sắc gương mặt, lưỡi của họ.

Quan sát mức sinh lực của người bệnh

Quan sát sức sống, thần thái trong mắt, nét mặt của người bệnh, v.v. Sinh lực của một người có thể được phân thành các loại sau:

Có thần (sinh lực dồi dào):

Mắt sáng linh hoạt, gương mặt rạng rỡ, v.v. Những biểu hiện này cho thấy bệnh còn nhẹ, sinh lực chưa bị tổn hại. Đó là dấu hiệu hồi phục nhanh.

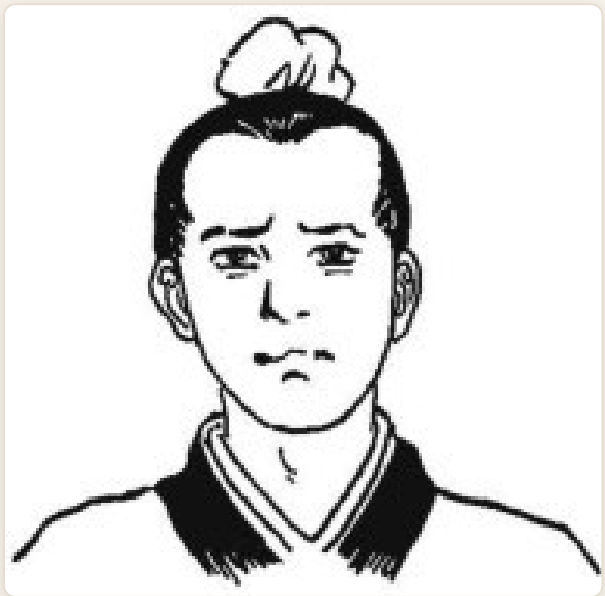
Vô thần (mất sinh lực):

Uể oải, lờ đờ, mắt đờ đẫn, tinh thần lơ đãng, phản ứng chậm chạp, v.v. Người bệnh bị khí hư và đang bệnh nặng.

HÌNH 66

Một chàng trai trẻ búi tóc thành búi trên đỉnh đầu, vẽ từ ngực trở lên: mắt sáng, trán thư thái và một nụ cười nhẹ nhướng lên nơi khóe miệng.

HÌNH 67



Cũng chàng trai trẻ ấy với vẻ mặt bơ phờ: chân mày nhíu lại, mắt đờ đẫn và cụp xuống, khóe miệng trễ xuống.

Quan sát sắc mặt của người bệnh

Khi một người mắc bệnh, sắc mặt họ sẽ mang một màu lạ. Đây được gọi là bệnh sắc của sắc mặt. Tất cả có năm màu.

Xanh	Do phong và hàn gây ra, biểu hiện bằng cảm giác đau.
Vàng	Do thấp gây ra, biểu hiện bằng khí hư và sức đề kháng của cơ thể suy giảm.
Đỏ	Do nhiệt gây ra.
Trắng	Do khí hư và khí huyết lưu thông kém.
Đen	Do hàn, đau, ứ đọng dịch thể và huyết ứ (cục máu đông).

TRANG SÁCH 30 · SCAN P039

Quan sát lưỡi

Quan sát lưỡi

Lưỡi có thể được chia thành các phần, mỗi phần tương ứng với một trong ngũ tạng. Vì vậy, mọi thay đổi trong diện mạo của lưỡi đều phản ánh sự thay đổi trạng thái của tạng tương ứng.

Màu sắc và diện mạo của rêu lưỡi trên bề mặt lưỡi cho biết những thay đổi trong tình trạng của người bệnh:

Màu rêu lưỡi:

Trắng → Vàng → Xám → Đen

Diện mạo rêu lưỡi:

Ẩm → Khô → Khô và đen → Khô và có gai

Mỏng → Dày

Có → Không

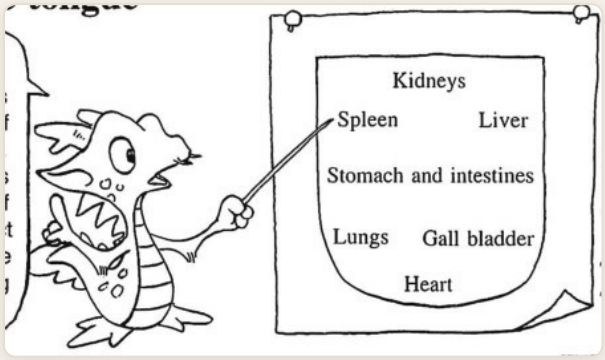
Chiều từ trái sang phải biểu thị bệnh tình của người bệnh đang xấu đi, và ngược lại.

Màu sắc, độ to bè và độ mềm mại của lưỡi cũng quan trọng. Dưới đây là một số trạng thái và ý nghĩa của chúng.

Lưỡi trắng nhạt	Cho thấy khí huyết hư.
Lưỡi đỏ thẫm	Cho thấy có nhiệt.
Lưỡi to bè	Thường liên quan đến sự hiện diện của đàm, thấp, nhiệt và độc.

Lưỡi mỏng và teo lại	Thường gợi ý khí huyết hư, hoặc nội nhiệt.
Lưỡi cứng	Thường gặp trong các bệnh ngoại cảm, có thể báo hiệu nguy cơ trúng phong.
Lưỡi mềm và co rúm	Thường gợi ý khí huyết hư.

HÌNH 68



Chú rồng linh vật của sách dùng một cây gậy dài chỉ vào tấm bảng được ghim lên như một cuộn giấy: đó là hình vẽ phác đường viền chiếc lưỡi, ghi tên các tạng phủ tương ứng với từng phần — Thận, Tỳ, Can, Dạ dày và ruột, Phế, Đởm và Tâm.

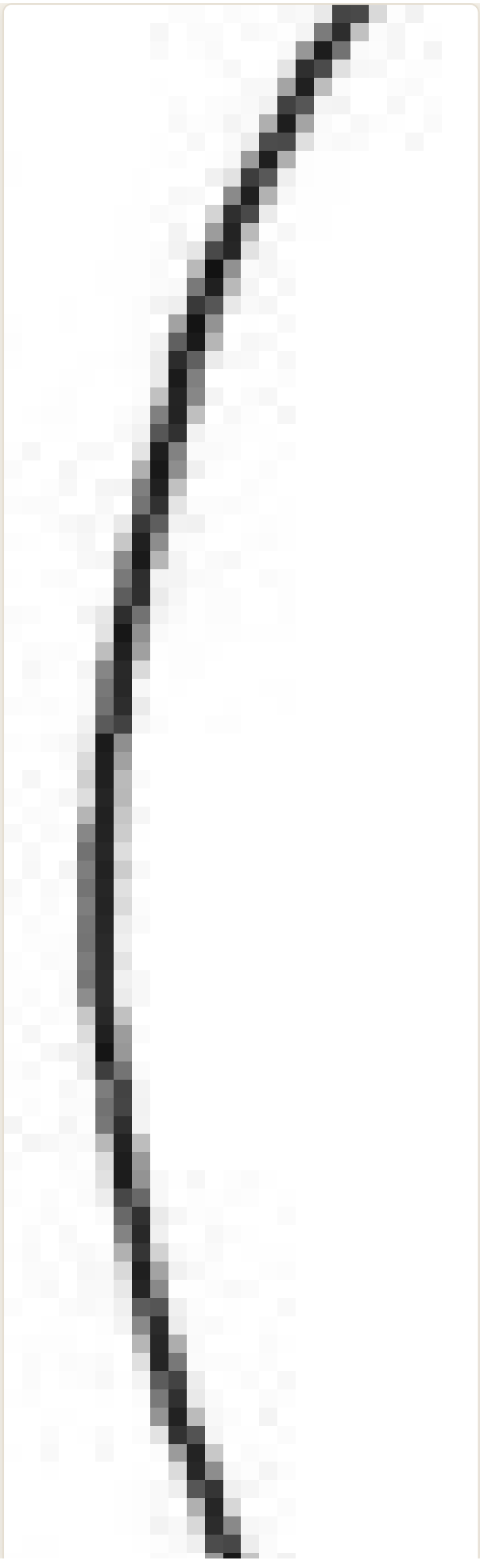
HÌNH 69

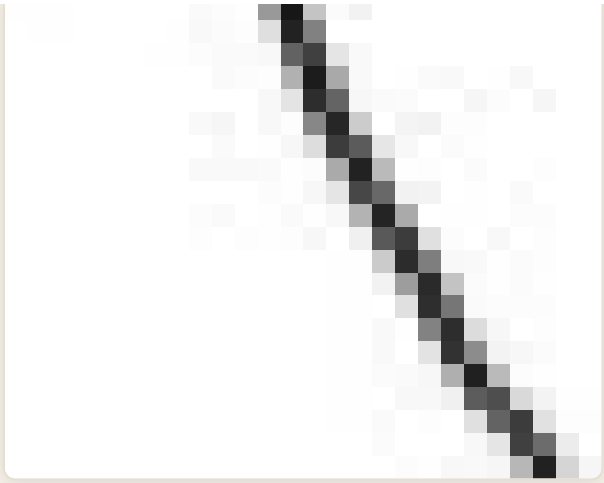
Một khuôn miệng há ra với lưỡi thè, nằm trong một vòng tròn, bên cạnh là chú rồng linh vật đang giơ một chiếc gương cầm tay nhỏ.

HÌNH 70

Một đoạn ngắn của đường cong, thuộc phần trang trí khung của các hình minh họa trên trang.

HÌNH 71





Một đoạn cong dọc ngắn, thuộc phần trang trí khung của các hình minh họa trên trang.

TRANG SÁCH 31 · SCAN P040

Quan sát ngũ quan và tóc

Quan sát ngũ quan và tóc

Tình trạng tai, mắt, môi, mũi, tóc và da của một người cũng phản ánh trạng thái sức khỏe của cơ thể. Dưới đây là một số ví dụ:

Mắt sưng phù	Thường do ứ đọng nước (thủy thấp).
Mắt khô	Thường do can huyết hư.
Mắt sưng và đỏ	Thường do phong nhiệt.
Nghẹt mũi, nước mũi trong	Thường do phong hàn.
Nghẹt mũi, nước mũi đặc và vàng	Thường do phong nhiệt.
Vành tai khô và mỏng	Thận hư (suy nhược, mất sức lực bất thường).
Môi đỏ thẫm	Do hàn tà gây ra, thường thấy ở người phế hư (phổi yếu).
Môi nhợt nhạt	Thường do huyết hư.
Môi đỏ thẫm và khô	Thường do nhiệt tà gây ra, đặc trưng bởi sốt cao.
Môi khô, nứt nẻ	Tân dịch không đủ.
Da khô	Tân dịch không đủ; tinh và huyết bên trong hao kiệt.

Da khô và sần	Thường do phế nuy (phổi suy nhược).
Tóc đen, dày và bóng mượt	Thận khỏe, khí huyết đầy đủ.
Tóc nâu, thưa và khô	Tinh huyết hư, thường thấy sau một trận bệnh nặng.
Tóc khô và giòn	Huyết nhiệt và âm hư.
Tóc xoăn và nhờn	Thường do huyết nhiệt.
Tóc bạc sớm ở người trẻ	Do lo lắng và ưu phiền; nhiệt tà tích tụ trong huyết.
Tóc thưa ở người trẻ	Thận hư hoặc nhiệt tà trong huyết.
Tóc mọc chậm, mỏng và nâu	Thường do yếu tố di truyền và thể chất yếu.

HÌNH 72

Một cô gái lớn hơn, tóc búi thành búi, cúi người chải và vuốt mái tóc đen dài cho một cô gái nhỏ đang ngồi phía trước.

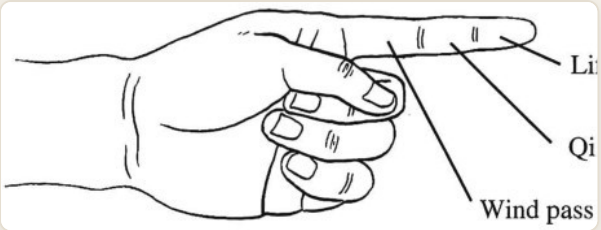
TRANG SÁCH 32 · SCAN P041

Quan sát ngón trỏ của trẻ (khán chỉ vân)

Quan sát ngón trỏ của trẻ (khán chỉ vân)

Cách chẩn đoán này thích hợp cho trẻ dưới ba tuổi. Người ta xem các đường kinh và lạc mạch ở mặt trong ngón trỏ của trẻ. Việc chẩn đoán dựa trên quan sát hiện tượng kinh mạch và màu sắc.

HÌNH 73



Hình vẽ bàn tay một đứa trẻ với các ngón co lại và ngón trỏ duỗi ra: dọc theo ngón tay có ba đoạn ngắn được đánh dấu bằng những vạch ngang mảnh, và ba đường dẫn nối từ đó tới các nhãn Life pass, Qi pass và Wind pass.

Khi xem vân ngón tay, trẻ cần được bế đến chỗ đủ ánh sáng; thầy thuốc dùng tay trái giữ cố định đầu ngón trỏ của trẻ. Tay phải ông xoa ngón trỏ của trẻ từ đầu ngón hướng về phía lòng bàn tay vài lần cho đến khi các nhánh kinh mạch hiện rõ để quan sát.

HÌNH 74

Thầy thuốc, một người đàn ông có râu mặc áo cổ cao, ngồi với một đứa trẻ nhỏ trên đùi và nhẹ nhàng nâng bàn tay của trẻ lên để xem ngón trỏ.

Lạc mạch hiện ở vùng phong quan	Bệnh còn ở trong lạc mạch; tình trạng không nghiêm trọng.

Lạc mạch hiện ở vùng khí quan.	Bệnh đã phạm vào kinh; tình trạng khá nghiêm trọng.
Lạc mạch hiện rõ ở cả ba quan.	Bệnh đã phạm vào tạng phủ; tình trạng nghiêm trọng.
Lạc mạch hiện vượt quá đầu ngón tay.	Tình hình rất nguy kịch.
Lạc mạch hiện rõ.	Bệnh thuộc ngoại cảm, phạm vào phần biểu của cơ thể.
Lạc mạch không rõ.	Bệnh thuộc nội thương, phạm vào tạng phủ.
Lạc mạch hơi đỏ.	Thường do hàn tà.
Lạc mạch tím.	Thường do nhiệt tà.
Lạc mạch xanh.	Do phong, hàn hoặc đau.
Lạc mạch nhợt và mỏng.	Thường do hàn tà.
Lạc mạch đục và dày.	Chứng thực.

TRANG SÁCH 33 · SCAN P042

Văn chẩn (nghe và ngửi)

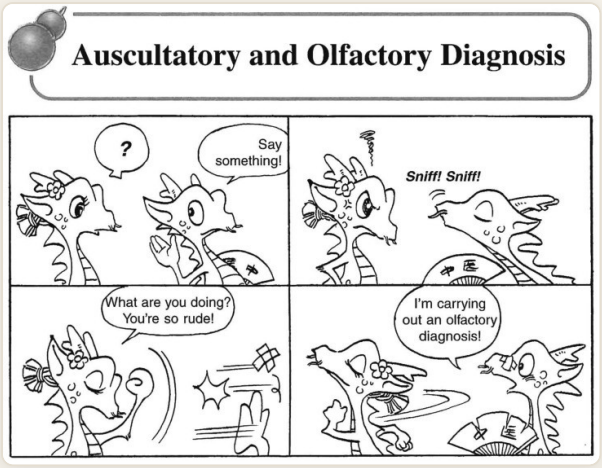
Văn chẩn (nghe và ngửi)

Chẩn đoán bằng văn chẩn bao gồm việc lắng nghe giọng nói, cách thở của người bệnh và ngửi hơi thở của họ. Những bảng dưới đây trình bày một số tình trạng có thể gặp và ý nghĩa của chúng.

Nghe giọng nói của người bệnh

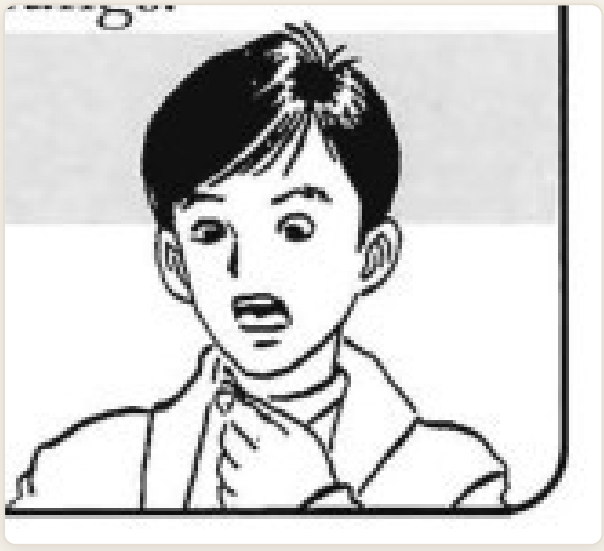
- - **Giọng mạnh, to** — Dương thịnh, nhiệt.
- - **Giọng yếu, đứt quãng** — Âm thịnh, hàn. Biểu hiện là khí hư và sức đề kháng giảm.
- - **Khản tiếng hoặc mất tiếng do bệnh mới mắc** — Do tà nhiệt gây nên, thường là hậu quả của cảm lạnh và sốt từ bên ngoài xâm nhập.
- - **Khản tiếng hoặc mất tiếng do bệnh kéo dài** — Thiếu khí, sức đề kháng giảm; phế và thận hư yếu.
- - **Ho sâu, đàm trong** — Phong hàn đã xâm phạm phế.
- - **Ho đột ngột, đàm đặc và vàng** — Nhiệt thịnh ở phế.
- - **Ho có đàm** — Có đàm.

HÌNH 75



Một dải truyện tranh bốn khung với hai nhân vật rồng của sách. Khung một: một con rồng nói "Nói gì đi!", con rồng kia trợn tròn mắt nhìn lại, trên đầu hiện dấu hỏi. Khung hai: con rồng thứ hai ghé sát và hít ngửi "Hít! Hít!", con rồng thứ nhất né người lại. Khung ba: con rồng bị ngửi phản đối "Anh làm gì vậy? Thô lỗ quá!". Khung bốn: con rồng đi ngửi đáp "Tôi đang thực hiện khứu chẩn đấy!"

HÌNH 76



Hình vẽ nét nhỏ nằm ở góc dưới bên phải của bảng: một người đàn ông trẻ mặc áo khoác, miệng hơi há và một tay đưa lên cổ áo.

Trang 34

Nghe nhịp thở của người bệnh

- - **Thở mạnh và nặng nhọc** — Do tà nhiệt gây nên, nội nhiệt thịnh do tà khí.
- - **Hơi thở yếu, ngắn** — Do chức năng của phế hư suy.
- - **Khó thở, có tiếng khò khè** — Hen suyễn.
- - **Hơi thở không đều hoặc thở dài nặng nhọc** — Tình trạng nặng, tinh khí bị tổn thương hoặc bị ngộ độc.
- - **Thở to kèm tiếng ngáy** — Người bệnh đột quỵ và người bệnh hôn mê mắc bệnh gan và tiểu đường.
- - **Thở nhanh, thở ra thấy dễ chịu hơn** — Thường gặp trong viêm phổi hoặc đàm trệ.
- - **Tiếng thở nhỏ, hít vào thấy dễ chịu hơn** — Chức năng của thận suy giảm.

Khám bằng mùi (khứu chẩn)

- - **Hơi thở hôi** — Tiêu hóa kém, nhiệt ở vị hoặc vệ sinh răng miệng kém.
- - **Hơi thở chua** — Thức ăn chưa tiêu còn đọng trong cơ thể.
- - **Hơi thở ươn thối** — Loét dạ dày và các vết loét.
- - **Mùi cơ thể** — Do thấp nhiệt tà khí gây nên.
- - **Mũi có mùi, chảy nước mũi** — Nhiệt ở phế hoặc thấp nhiệt tà khí tích tụ ở tỳ và vị.

HÌNH 77

Một mảnh cắt rất mỏng lấy từ hình minh họa ở chân trang, cho thấy một phần bàn tay và tay áo của một nhân vật trong truyện tranh.

HÌNH 78

Hình minh họa ở chân trang: một người đàn ông há to miệng, những làn sóng khí bốc lên từ miệng thể hiện hơi thở hôi, bên cạnh là chú rồng linh vật đang ghé vào ngửi. Bong bóng hội thoại bên cạnh chú rồng ghi: "Bác sĩ, tôi nghĩ mình bị hôi miệng. Xin kiểm tra giúp tôi."

TRANG SÁCH 35 · SCAN P044

Vấn chẩn (chẩn đoán bằng cách hỏi)

Vấn chẩn (chẩn đoán bằng cách hỏi)

Phương pháp này là hỏi người bệnh về bệnh tình, các triệu chứng và cảm giác của họ. Qua câu trả lời của người bệnh mà đưa ra chẩn đoán. Vì vậy đây là một phần rất quan trọng của việc chẩn đoán.

> *"Trước tiên, hỏi về ớn lạnh và sốt.*

> *Tiếp theo, hỏi về mồ hôi.*

> *Thứ ba, hỏi về các cơn đau toàn thân và đau đầu.*

> *Thứ tư, hỏi về tiểu tiện và đại tiện.*

> *Thứ năm, hỏi về ăn uống.*

> *Kế đó, hỏi về cảm giác ở ngực và bụng.*

Câu hỏi thứ bảy liên quan đến thính giác và thị giác.

Câu hỏi thứ tám đề cập đến giấc ngủ.

Câu hỏi thứ chín kiểm tra tiền sử bệnh và câu thứ mười hỏi về nguyên nhân của căn bệnh mới.

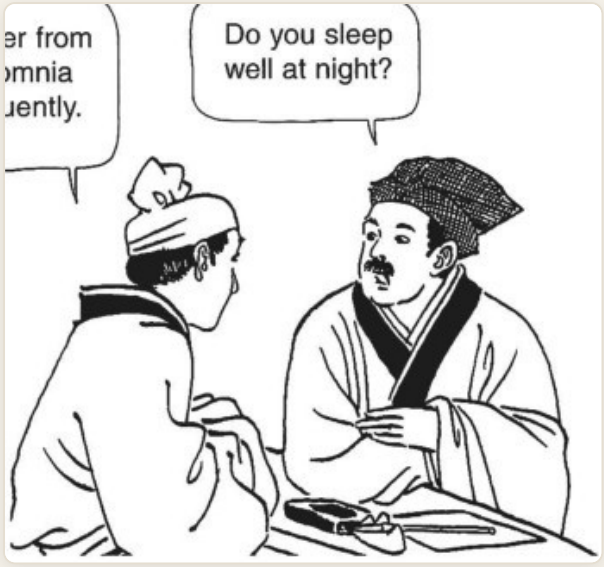
Với người bệnh nữ đã trưởng thành, hỏi về chu kỳ kinh nguyệt.

Với người bệnh nhỏ tuổi, đó là bệnh sởi."

HÌNH 79

Chú rồng linh vật đứng ở bên trái trang, kèm bong bóng hội thoại: "Chẩn đoán bằng cách hỏi rất toàn diện. Người ta còn đặt thành một bài vè liệt kê 10 câu hỏi thường gặp."

HÌNH 80



Tranh minh họa ở chân trang: một thầy thuốc lớn tuổi ngồi sau bàn hỏi "Đêm ngủ có ngon không?", còn người đàn ông trẻ ngồi đối diện, hơi chồm tới, hai tay đan vào nhau, đáp "Tôi hay bị mất ngủ."

TRANG SÁCH 36 · SCAN P045

Trang 36

Bảng trình bày một số tình trạng có thể gặp và ý nghĩa của chúng:

Ớn lạnh và sốt

- - **Sốt về buổi sáng** — Đởm khí hư.
- - **Sốt về buổi chiều** — Âm hư, thấp nhiệt.
- - **Sốt mà không thấy lạnh** — Dương thịnh, thường gặp trong bệnh cấp tính.
- - **Thấy lạnh mà không sốt** — Dương hư, thường gặp trong bệnh mạn tính.
- - **Tay chân lạnh** — Dương hư.
- - **Nóng ở bụng và ngực** — Nội nhiệt tích tụ.
- - **Toàn thân nóng sốt và sợ lạnh** — Thường do tà nhiệt gây nên.

Mồ hôi

- - **Ra mồ hôi trước khi ngủ, ngừng lại khi thức dậy (đạo hãn – mồ hôi trộm)** — Thường chỉ âm hư.
- - **Dễ ra mồ hôi ban ngày (tự hãn)** — Thường chỉ dương hư.

- - **Sợ lạnh, ra mồ hôi, tay chân lạnh (lãnh hãn – mồ hôi lạnh)** — Thường chỉ dương hư.
- - **Ra mồ hôi rồi rùng mình** — Cơ thể đang chống lại bệnh truyền nhiễm.
- - **Chỉ ra mồ hôi ở trán (Trẻ nhỏ thường ra mồ hôi trán khi ngủ. Nếu không kèm triệu chứng nào khác thì đây không phải dấu hiệu bệnh.)** — Thường chỉ nhiệt ở bụng và thấp nhiệt tà khí.
- - **Chỉ nửa người ra mồ hôi** — Đờm khí và huyết hư. Dấu hiệu của liệt nửa người.
- - **Ra mồ hôi ở ngực** — Tâm âm hư.
- - **Ra mồ hôi ở tay và chân** — Âm hư dương thịnh.
- - **Ra mồ hôi ở lòng bàn tay** — Thường do lo lắng và căng thẳng thần kinh.

HÌNH 81

Một người phụ nữ búi tóc, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu và co vai, nằm ở phía bên phải bảng "Ớn lạnh và sốt". Những đường lượn sóng bên cạnh gợi tả cơn rét run.

TRANG SÁCH 37 · SCAN P046

Trang 37

Ăn uống

- - **Thích uống nước lạnh khi khát** — Nội nhiệt.

- - **Thích uống nước ấm khi khát** — Nội hàn.
- - **Uống rất ít nước dù đang khát** — Thấp nhiệt tà khí ở tỳ và vị.
- - **Vị giác kém (ăn nhạt miệng)** — Tỳ vị hư nhược.
- - **Miệng đắng** — Can đởm nhiệt.
- - **Miệng chua** — Thức ăn chưa tiêu còn đọng ở vị và tràng.
- - **Miệng ngọt** — Thấp nhiệt tà khí ở tỳ và vị.
- - **Ăn lệch, chỉ ăn được một vài món** — Thường do có ký sinh trùng.
- - **Dễ thấy đói** — Vị nhiệt hoặc tiêu hóa không hoàn toàn.
- - **Đầy bụng sau khi ăn** — Tỳ hư và đởm khí bế tắc.
- - **Ăn kém, bụng đầy hơi, hơi thở chua** — Thức ăn chưa tiêu đọng ở vị và tràng, tiêu hóa kém.
- - **Tiểu nhiều lần, uống nước liên tục, khát** — Tiêu khát (đái tháo đường).

Tai và mắt

- - **Ù tai** — Can và thận hư.
- - **Đau tai** — Viêm tai trong.
- - **Điếc tai** — Thận hư, bệnh truyền nhiễm gây sốt.
- - **Tai có tiếng vang** — Thận hư hoặc phong tà.
- - **Nhìn mờ, quáng gà** — Can hư.
- - **Mắt sưng đỏ** — Can nhiệt.

HÌNH 82

Một người đàn ông ngồi ở bàn ăn: một tay gắp thức ăn đưa lên miệng bằng đũa, tay kia cầm chén nhỏ, trước mặt bày một bát và một đĩa thức ăn.

TRANG SÁCH 38 · SCAN P047

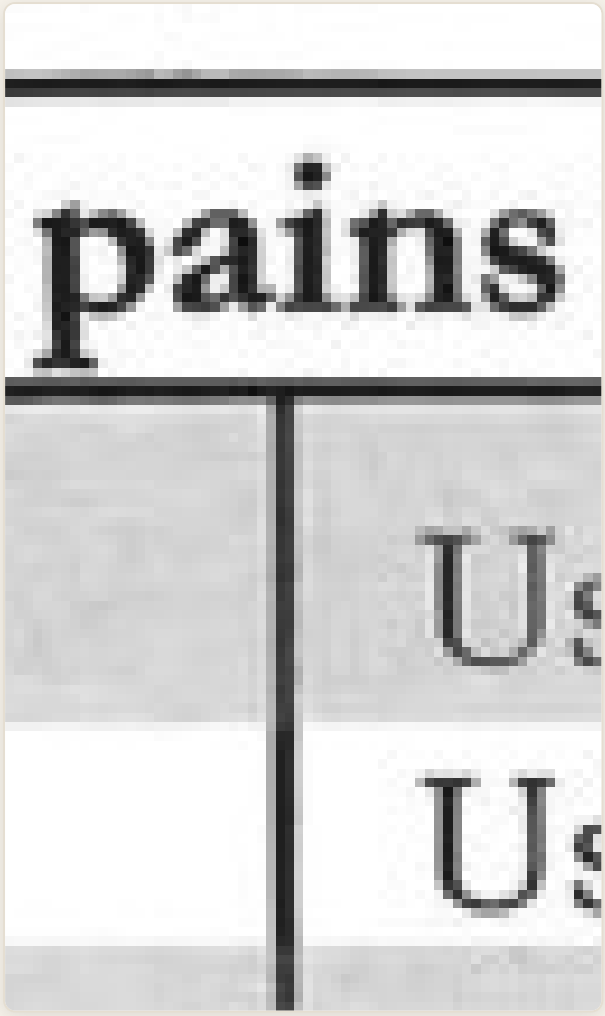
Trang 38

Đau nhức toàn thân và đau đầu

- - **Đau đầu âm i** — Thường do nhiệt từ bên ngoài gây nên.
- - **Đau đầu từng cơn rải rác** — Thường do nội thương.
- - **Đau đầu buổi sáng** — Thường là khí hư.
- - **Đau đầu buổi chiều** — Thường là huyết hư.
- - **Đau đầu ban ngày** — Dương hư.
- - **Đau đầu buổi tối** — Âm hư.
- - **Người nóng sốt và đau nhức** — Nội nhiệt.
- - **Đau lưng** — Thận hư.
- - **Đau nhói ở lưng** — Khí trệ và huyết ứ.
- - **Ngực tức, khó thở, uể oải** — Khí hư.
- - **Ngực tức, thở dài** — Khí trệ.
- - **Đau hai bên mạng sườn** — Can khí trệ.

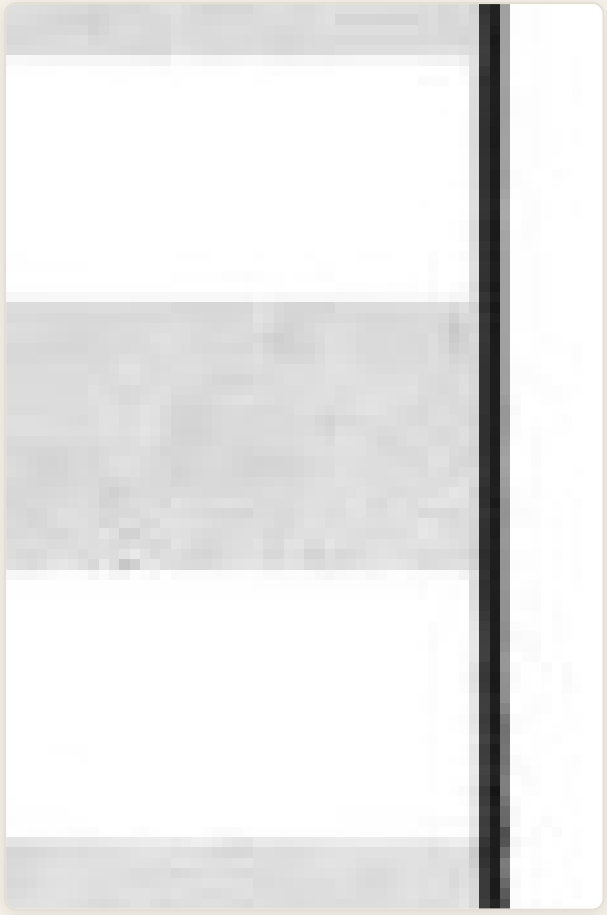
- - **Đau bụng; sợ chạm vào, thích uống nước lạnh, đau bụng nhói sau khi ăn** — Nhiệt thịnh.
- - **Đau bụng; xoa bóp thấy dễ chịu, phân lỏng** — Tỳ vị dương hư.
- - **Khớp đau vào những ngày mưa** — Do thấp hàn gây nên.
- - **Sưng và đau** — Uất ức, thức ăn đình trệ ở vị, đường hô hấp bị tắc nghẽn.
- - **Đau nhói** — Huyết ứ, khí trệ.
- - **Đau thắt ngực** — Huyết ứ, ký sinh trùng, sỏi mật.
- - **Đau âm ỉ, đau mơ hồ** — Khí huyết lưu thông kém; nội hàn và âm thịnh.
- - **Đau nhức** — Thấp khí ở khớp; khí huyết lưu thông kém.
- - **Sợ lạnh; đau dữ dội** — Thường do hàn tà gây nên.
- - **Sợ nóng; đỏ và sưng** — Thường do nhiệt tà gây nên.
- - **Đau đột ngột** — Chứng thực do ngoại tà.
- - **Đau kéo dài** — Âm hư.

HÌNH 83



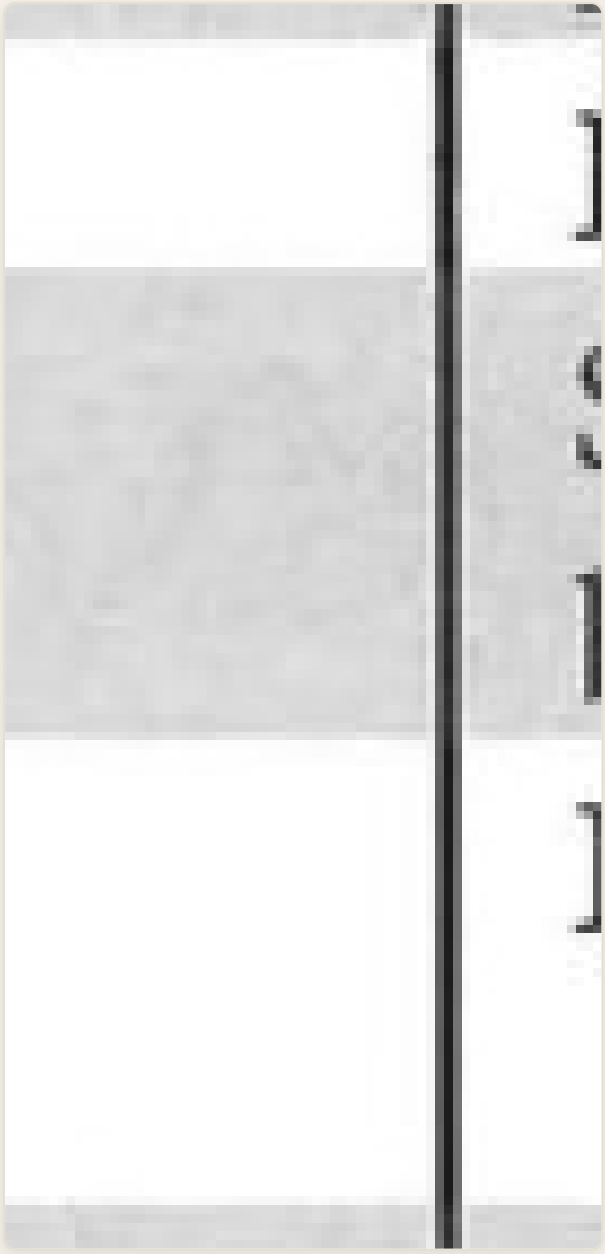
Một mảnh cắt nhỏ của tiêu đề bảng, cho thấy chữ "pains" in trong tiêu đề "General pains and headaches".

HÌNH 84



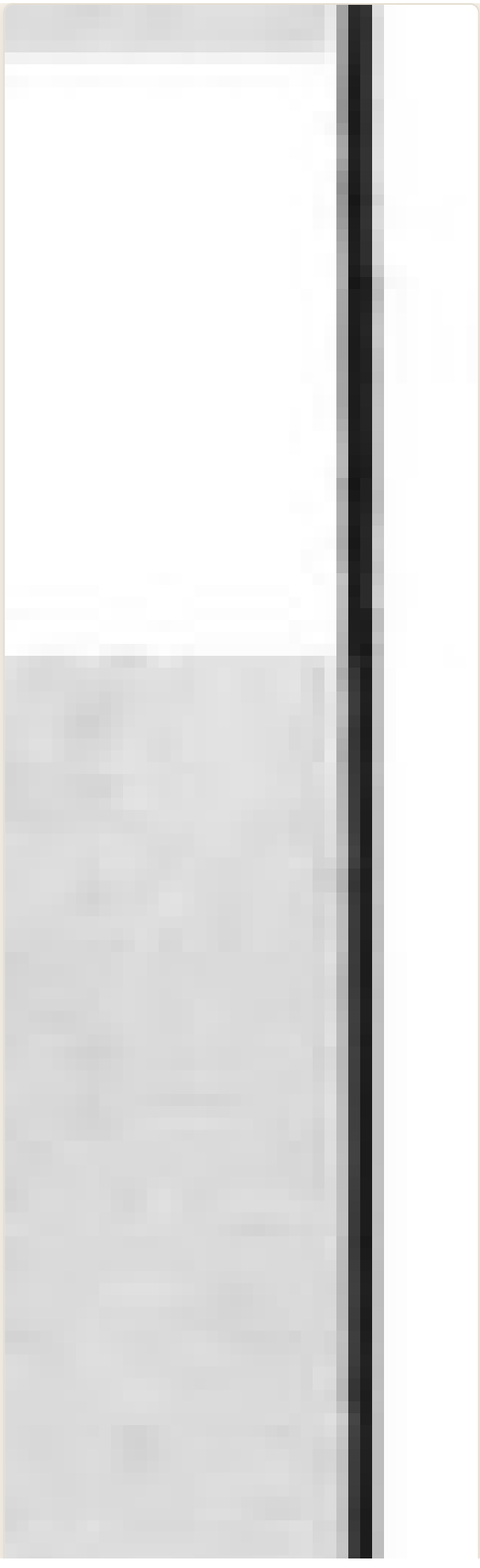
Một mảnh cắt dọc hẹp của bảng, cho thấy các hàng có nền xám và hàng trắng nằm giữa các đường kẻ.

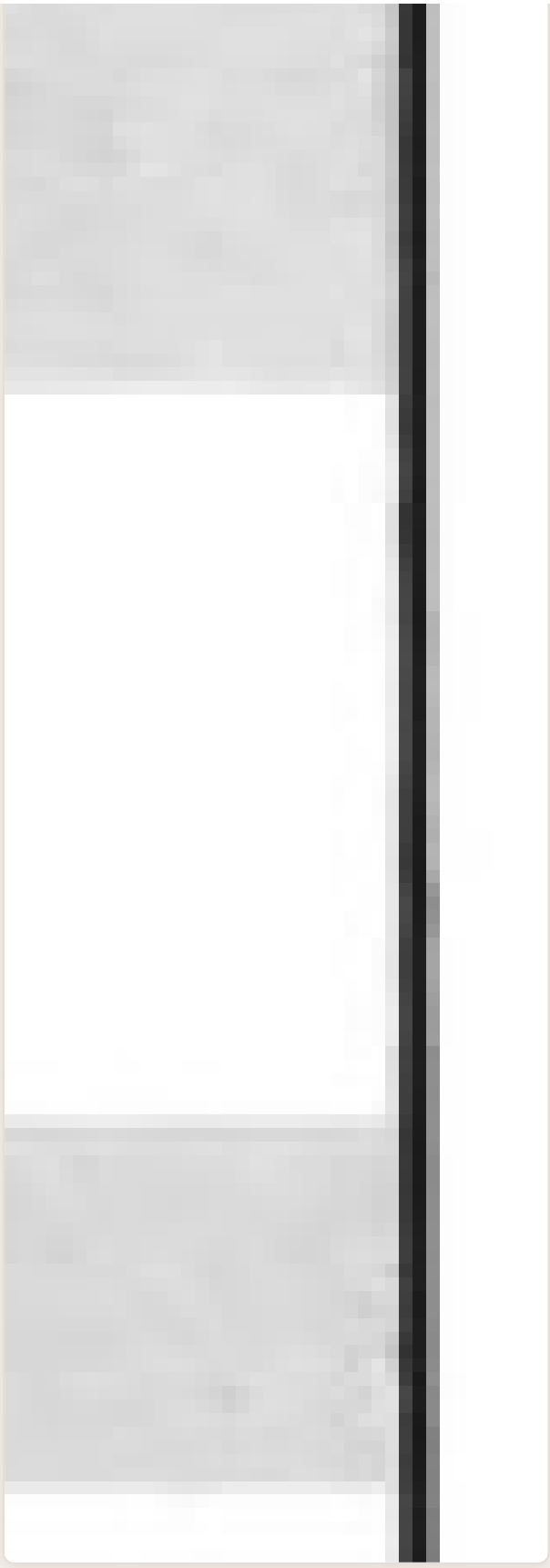
HÌNH 85



Một mảnh cắt nhỏ của bảng, cho thấy một đường kẻ dọc và mép của một hàng có nền xám.

HÌNH 86





Một dải dọc hẹp lấy từ mép phải của bảng, gồm đường kẻ dọc và các hàng nền xám.

HÌNH 87

Một dải ngang ngắn của một hàng có nền xám trong bảng.

HÌNH 88

Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, tóc búi cao có khăn thắt hình nơ, cúi đầu, một tay đưa lên cằm còn tay kia đặt ở eo, nằm ở góc dưới bên phải của bảng.

TRANG SÁCH 39 · SCAN P048

Trang 39

Tiểu tiện và đại tiện

- - **Táo bón** — Nhiệt, khí trệ hoặc huyết hư kiệt.
- - **Phân cứng** — Trung tiêu khí hư hoặc chức năng gan kém.

- - **Phân trắng nhạt** — Hoàng đản hoặc hàn hư ở đại tràng.
- - **Phân đen** — Xuất huyết bên trong.
- - **Phân đỏ** — Có máu trong phân hoặc lỵ.
- - **Nước tiểu trong** — Do hàn tà gây nên.
- - **Nước tiểu vàng sậm** — Do nhiệt tà gây nên.
- - **Đau khi tiểu tiện** — Do chứng lâm (co thắt niệu đạo và bàng quang).
- - **Nước tiểu đục (vẩn đục)** — Bệnh truyền nhiễm gây sốt do thấp và nhiệt.
- - **Tiểu tiện không tự chủ** — Khí hư và đột quỵ.
- - **Tiểu tiện khó** — Do thấp nhiệt gây tổn hại hoặc làm tổn thương tân dịch.

Kinh nguyệt (Phụ khoa)

- - **Kỳ kinh đến sớm, lượng nhiều, máu đỏ tươi** — Huyết nhiệt.
- - **Kỳ kinh đến muộn, lượng ít, màu nhạt, đau bụng dưới** — Nội hàn.
- - **Kinh nguyệt không đều** — Can khí trệ hoặc tỳ thận hư nhược, hoặc bế tắc do huyết khối.
- - **Vô kinh (không có kinh nguyệt)** — Khí hư và lượng máu ít; khí trệ và huyết ứ.
- - **Xuất huyết tử cung (băng huyết)** — Huyết nhiệt, Khí hư.

HÌNH 89

Một nhân vật nhìn nghiêng, ngồi co đầu gối, hai tay đặt trên gối, mặc áo và quần đơn giản, mắt nhắm và đầu hơi cúi, nằm ở phía bên trái bảng "Tiểu tiện và đại tiện".

HÌNH 90

Một mảnh cắt nhỏ của tiêu đề in trong bảng, cho thấy chữ "(Gynaecology)".

HÌNH 91

Một thiếu nữ tóc dài sẫm màu cúi nhìn xuống với vẻ mặt trầm lặng, một tay đưa lên ngực, nằm ở phía bên phải bảng "Kinh nguyệt".

TRANG SÁCH 40 · SCAN P049

Trang 40

Giấc ngủ

- - **Mất ngủ** — Lo nghĩ quá nhiều, tâm tỳ hư.
- - **Không ngủ được kèm khát nước và cảm giác bực bội khó chịu** — Thường chỉ tâm âm hư.
- - **Không ngủ được kèm cảm giác hoảng sợ** — Thường chỉ đởm khí hư.
- - **Không ngủ được kèm chóng mặt và hoảng sợ** — Thường chỉ tâm tỳ huyết hư.
- - **Không ngủ được kèm chóng mặt và đầu nặng** — Thường chỉ can dương thịnh.
- - **Không ngủ được kèm đầy bụng** — Thường do tỳ mất điều hòa, dẫn đến buồn nôn và nôn.
- - **Dễ thức giấc** — Thường chỉ tâm đởm khí hư, tâm nhiệt thịnh.
- - **Thức dậy sớm** — Thường chỉ khí hư.
- - **Không thể chợp mắt** — Lo lắng, khí bất túc.
- - **Giấc ngủ bị nhiều giấc mơ quấy rầy** — Can thận âm hư, âm dương mất cân bằng.
- - **Buồn ngủ liên tục, uể oải** — Thường chỉ tỳ hư hoặc thấp khí tích tụ.

HÌNH 92

Một người nằm ngửa đang ngủ, đầu gối trên gối, mắt nhắm và một tay co đặt ngang trên người, được vẽ ở phần dưới bên phải của bảng.

TRANG SÁCH 41 · SCAN P050

Chẩn đoán bằng bắt mạch và xúc chẩn

Chẩn đoán bằng bắt mạch và xúc chẩn

Những thay đổi nơi mạch của một người được dùng để xác định mức độ khí và huyết trong cơ thể người đó.

Cổ tay con người có thể chia thành ba đoạn: thốn, quan và xích. Mỗi đoạn tương ứng với những tạng phủ khác nhau.

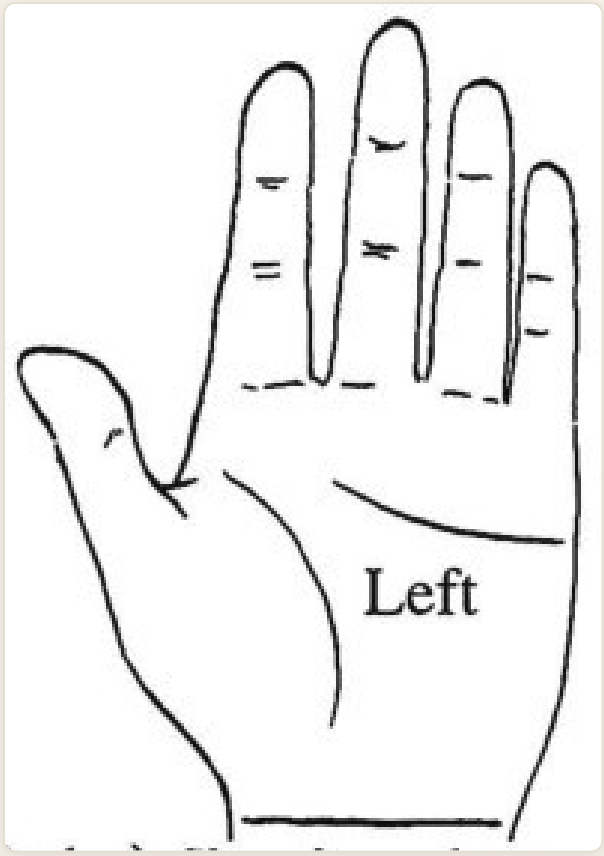
Nói chung, y học cổ truyền Trung Quốc dùng vị trí bước vào của mạch, tức đoạn thốn. Vì đây là nơi kinh Thủ Thái Âm Phế đi qua, mà phế là bộ phận tạng phủ tàng trữ khí, huyết và chất dinh dưỡng, lại giữ vai trò then chốt đối với tứ chi và xương cốt, nên đoạn này sẽ bộc lộ trạng thái của tạng phủ, kinh lạc, khí và huyết, v.v.

Khi một người khỏe mạnh, mạch chậm rãi, đều đặn, có nhịp điệu và vững mạnh. Mạch nhanh hoặc quá chậm là dấu hiệu có bệnh.

Nếu người bệnh rất nặng mà mạch vẫn bình tĩnh và vững mạnh, đó là dấu hiệu có cơ hội hồi phục. Nhưng nếu mạch nhỏ và yếu ớt, gần như không thể nhận ra, thì đó là điềm báo hậu quả nghiêm trọng.

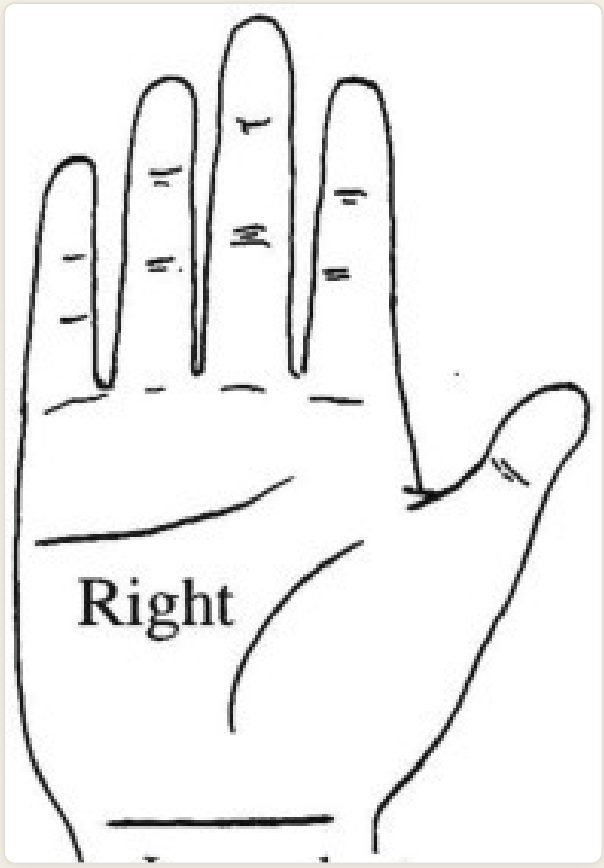
Có nhiều loại mạch, như mạch phù, mạch trầm, mạch hồng, mạch tế, mạch nhược, mạch thực và nhiều loại khác. Sự khác biệt rất tinh tế. Vì vậy, chẩn đoán bằng bắt mạch không dễ nắm vững.

HÌNH 93



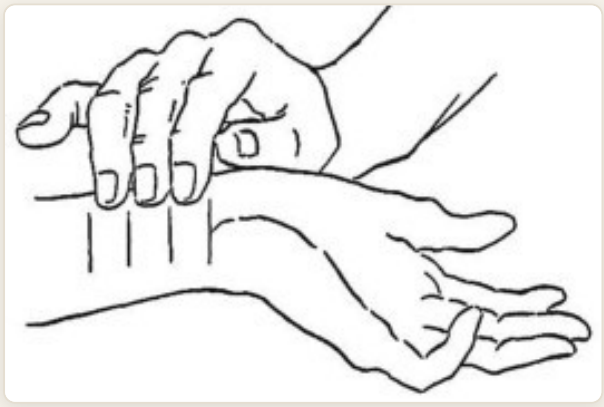
Hình vẽ nét một bàn tay trái mở, có ghi chữ "Left", cổ tay chia thành ba đoạn, bên cạnh mỗi đoạn ghi các tạng phủ mà nó phản ánh.

HÌNH 94



Hình vẽ nét một bàn tay phải mở, có ghi chữ "Right", cho thấy ba đoạn mạch trên cổ tay đó cùng những tạng phủ tương ứng.

HÌNH 95



Hình vẽ nét một bàn tay đặt ba ngón dọc theo cổ tay của bàn tay kia để bắt mạch.

Tổng quan về các loại mạch

Tổng quan về các loại mạch

Loại mạch	Mô tả
Mạch phù	Có thể cảm nhận bằng cách đặt tay nhẹ. Mạch yếu dần khi ấn mạnh, có thể ví như khúc gỗ nổi. Thường gặp ở giai đoạn đầu của bệnh do ngoại tà gây ra.
Mạch trầm	Chỉ có thể cảm nhận khi ấn xuống. Thường gặp trong nhiều bệnh mạn tính khác nhau. Cho thấy bệnh đã xâm phạm vào tạng phủ.
Mạch sác	Đập nhanh. Thường chỉ sự hiện diện của nhiệt.
Mạch trì	Nhịp mạch chậm. Chỉ các bệnh có tính hàn.
Mạch nhược	Mạch cảm thấy yếu ớt, mờ nhạt. Chỉ chính khí hư.
Mạch thực	Mạch mạnh mẽ và đầy lực. Chỉ chứng thực.
Mạch hồng	Mạch đập như sóng, dâng lên mạnh rồi xuống dần. Chỉ sự hiện diện của nhiệt tà quá thịnh.
Mạch tế	Mạch nhỏ, mảnh. Mờ nhạt nhưng luôn cảm nhận được. Chỉ âm và huyết hư.
Mạch huyền	Mạch dài và đầy lực, cảm giác như dây đàn. Thường gặp trong bệnh can, các cơn đau dữ dội và đàm tích tụ.
Mạch khẩn	Mạch nhanh và mạnh, cảm giác như sợi dây căng chặt. Chỉ sự hiện diện của hàn hoặc đau.
Mạch kết	Mạch ngừng lại quãng không đều. Thường gặp trong các trường hợp khí hoặc huyết trệ, đàm do hàn.
Mạch đại	Mạch chậm và yếu, ngừng lại quãng đều. Chỉ tạng phủ suy nhược nặng, khí và huyết hư, chấn thương nặng hoặc hoảng sợ.
Mạch xúc	Mạch nhanh, ngừng quãng không đều. Thường gặp trong các trường hợp nhiệt quá thịnh, khí và huyết trệ, đàm tích tụ hoặc khó tiêu.

Mạch hoạt	Mạch trơn nhẵn như hạt ngọc lăn trên đĩa. Thường gặp trong các trường hợp đàm tích tụ.
Mạch sáp	Mạch không đều. Thường do mất hoặc trệ khí và huyết.

TRANG SÁCH 43 · SCAN P052

Trang 43

"Chị không cần kể cho tôi nghe về bệnh tình của chị. Chỉ cần đưa tay cho tôi là tôi có thể chẩn đoán được."

"Tôi chỉ cần bắt mạch của chị là sẽ biết chị đang mắc bệnh gì."

"... ..."

"Mạch của chị đâu rồi? Tôi không sờ thấy gì cả!"

Nói rằng chỉ cần sờ mạch là có thể biết người bệnh đang mắc bệnh gì thì quả là cường điệu. Không thể chỉ dựa vào việc bắt mạch để chẩn đoán. Bốn phương pháp chẩn đoán không tách rời nhau. Trong một lần khám bệnh, phải vận dụng cả bốn phương pháp chẩn đoán mới có thể đưa ra một chẩn đoán toàn diện và chính xác.

Vương Thúc Hòa và cuốn *Kinh Mạch*

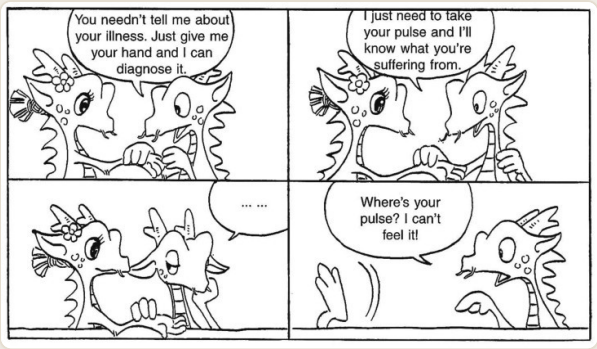
Vương Thúc Hòa (180–270 SCN) là danh y thời Tây Tấn. Ông nghiên cứu mạch học. *Ông đã tập hợp các văn liệu về mạch học của nhiều thế hệ trước cùng kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực y học này thành một cuốn sách mang tên *Kinh Mạch*.*

Kinh Mạch phân loại các trạng thái mạch thành 24 loại. Cho đến nay, chúng vẫn là nền tảng cho các phương pháp chẩn đoán của y học cổ truyền Trung Quốc. Cuốn sách đã thiết lập việc nghiên cứu vị trí bước vào của mạch và xác định rõ ràng ba đoạn thốn, quan, xích.

Kinh Mạch là tác phẩm mạch học sớm nhất của Trung Quốc và được các thầy thuốc đời sau đánh giá rất cao. Ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực y học rất rộng, về sau lan sang Trung Quốc, Triều Tiên, thế giới Ả Rập và châu Âu.

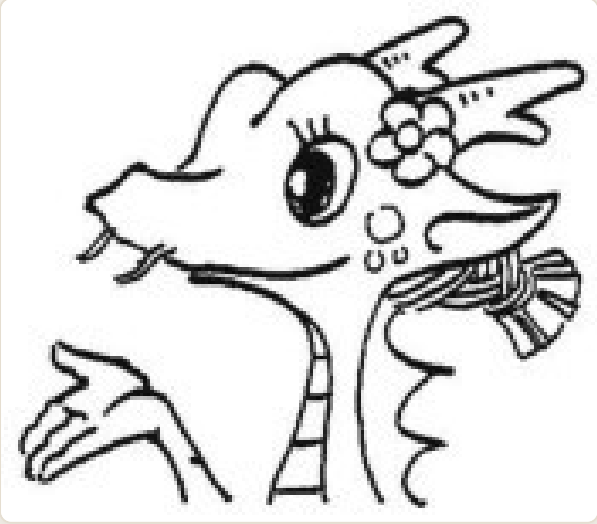
- * Ngành nghiên cứu về mạch.

HÌNH 96



Một dải truyện tranh bốn khung. Khung trên bên trái: một chú rồng đeo hoa bảo người bạn đồng hành rằng chị không cần kể bệnh tình, chỉ cần đưa tay ra. Khung trên bên phải: rồng nói tiếp rằng nó chỉ cần bắt mạch là biết chị đang mắc bệnh gì. Khung dưới bên trái: chú rồng kia im lặng, bong bóng thoại chỉ có một hàng dấu chấm. Khung dưới bên phải: chú rồng bối rối vẫy tay và kêu lên rằng không sờ thấy mạch gì cả.

HÌNH 97



Chú rồng linh vật đeo hoa và nơ, nhìn sang trái, một tay giơ lên, đuôi bong bóng thoại ở bên cạnh.

Quách Ngọc và chuyện chẩn đoán bằng bắt mạch

Quách Ngọc và chuyện chẩn đoán bằng bắt mạch

"Ái khanh Lý, trẫm nghe nói khanh ốm nặng. Ai đã chữa khỏi bệnh cho khanh?"

"Bẩm Bệ hạ, chính là Quách Ngọc. Ông ấy là một thầy thuốc tài giỏi. Ông thường chữa bệnh cho các phi tần và quan lại trong triều."

"Quách Ngọc quả là thần y!"

"Ông ấy chỉ sờ mạch của tôi mà có thể nói ra tôi đang mắc bệnh gì."

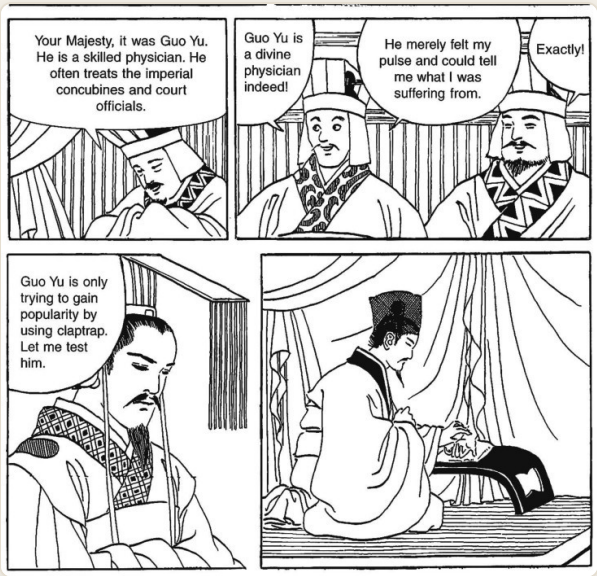
"Đúng là vậy!"

"Quách Ngọc chỉ đang muốn nổi tiếng bằng trò ba hoa mà thôi. Để ta thử ông ta xem sao."

HÌNH 98

Hàng đầu của truyện tranh. Khung bên trái mang tiêu đề câu chuyện Guo Yu and Diagnosis Through Pulse Taking (Quách Ngọc và chuyện chẩn đoán bằng bắt mạch), phía dưới là một thầy thuốc đội mũ cánh chuồn cao đang khám bệnh cho một người bệnh sau tấm rèm buông. Khung bên phải: nhà vua ngồi trên bệ ngai có họa tiết rồng, kèm dòng chú thích bên dưới "Han Dynasty, Emperor He's reign." (Thời Hán, dưới triều Hán Hòa Đế), hỏi vị quan vừa khỏi bệnh rằng ai đã chữa khỏi bệnh cho ông.

HÌNH 99



Hai hàng giữa và dưới của truyện tranh. Một vị quan tâu với nhà vua rằng chính Quách Ngọc, một thầy thuốc tài giỏi thường chữa bệnh cho các phi tần và quan lại trong triều; một vị quan khác khen Quách Ngọc quả là thần y; và người bệnh xác nhận rằng Quách Ngọc chỉ sờ mạch mà đã nói ra được ông đang mắc bệnh gì, nhà vua cũng đồng tình. Khung dưới bên trái: một vị quan đầy nghi ngờ nói rằng Quách Ngọc chỉ muốn nổi tiếng bằng trò ba hoa và xin thử ông ta; khung dưới bên phải: Quách Ngọc quỳ trước một chiếc giường có rèm, đang bắt mạch.

TRANG SÁCH 45 · SCAN P054

Trang 45

"Xin đưa bàn tay phải cho tôi."

"... ..."

"Quách thầy thuốc, ái phi của trẫm thế nào rồi?"

"À thì..."

"Bẩm Bệ hạ, mạch của Nương nương rất lạ thường. Tay trái của người mang tính dương, còn tay phải mang tính âm."

"Người mang cả mạch nam lẫn mạch nữ. Thật là khó hiểu."

"Ha ha ha!"

"Xem đây!"

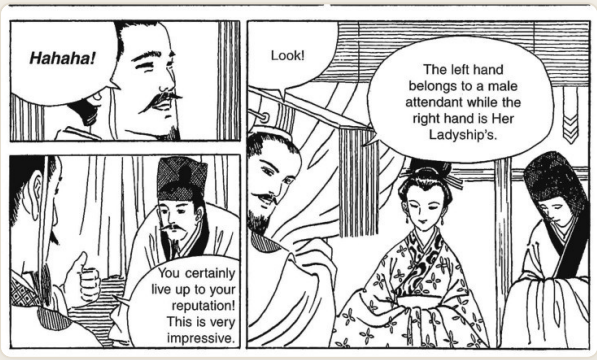
"Tay trái là của một người hầu nam, còn tay phải mới là của Nương nương."

"Ngươi quả nhiên danh bất hư truyền! Thật đáng khâm phục."

HÌNH 100

Các khung phía trên của truyện tranh. Hàng đầu: Quách Ngọc bảo người bệnh đưa bàn tay phải, một bàn tay sờ mạch sau tấm rèm, và Quách Ngọc cau mày bên bong bóng thoại chỉ có dấu chấm. Hàng thứ hai: nhà vua hỏi ái phi của mình thế nào; Quách Ngọc ngập ngừng, rồi tâu rằng mạch của Nương nương rất lạ thường — tay trái mang tính dương, tay phải mang tính âm — và cúi rạp người kết luận rằng người mang cả mạch nam lẫn mạch nữ, thật là khó hiểu.

HÌNH 101



Các khung phía dưới của truyện tranh. Nhà vua phá lên cười và gọi "Xem đây!", trong khi Quách Ngọc tuyên bố rằng tay trái là của một người hầu nam còn tay phải mới là của Nương nương; ở cuối trang, nhà vua nói với Quách Ngọc rằng ông quả nhiên danh bất hư truyền và điều này thật đáng khâm phục.

Chẩn đoán bằng xúc chẩn

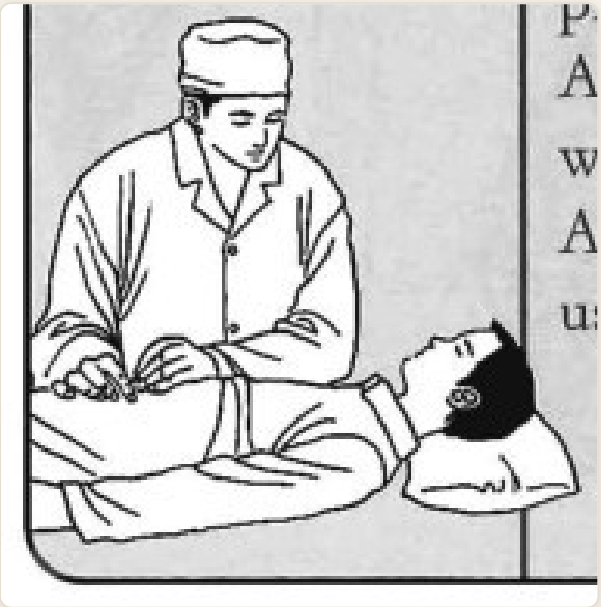
Chẩn đoán bằng xúc chẩn

Xúc chẩn là dùng tay ấn lên cơ thể người bệnh. Đây là một phần của việc chẩn đoán bằng bắt mạch và xúc chẩn.

Vị trí ấn	Dấu hiệu nhận biết
Ấn lên da	Da ấm chỉ sự hiện diện của nhiệt tà quá thịnh.
	Da lạnh chỉ dương và khí hư.
	Da khô chỉ tân dịch hư.
	Nếu da sờ thấy ram ráp, thường là dấu hiệu âm bị tổn thương hoặc huyết ứ bên trong.
	Nếu da lúc đầu sờ thấy ấm rồi sau đó lạnh đi, thì nhiệt ở bên ngoài.
	Da ấm lên dần chỉ nội nhiệt.
Ấn lên chỗ sưng	Khi chỗ sưng vẫn còn lõm xuống sau khi ấn, đó là dấu hiệu phù thũng.
	Khi chỗ sưng bật trở lại sau khi ấn, đó là dấu hiệu có khí.
Ấn lên tay chân	Tay chân lạnh chỉ âm và hàn quá thịnh.
	Tay chân ấm thường chỉ dương và nhiệt quá thịnh.
	Mu bàn tay ấm thường chỉ ngoại nhiệt.
	Lòng bàn tay ấm trong khi các phần khác của cơ thể vẫn tương đối lạnh thường chỉ âm bị tổn thương.
	Khi cơ thể trẻ ấm nhưng đầu ngón tay lạnh, hãy coi chừng khả năng lên cơn co giật.
Ấn lên bụng	Bụng đau và sưng gợi ý nguyên nhân ngoại tà.
	Bụng sưng nhưng mềm và không đau chỉ chứng hư.
	Bụng sưng căng lên khi ấn và phát ra âm thanh rỗng chỉ có quá nhiều khí.

	Bụng sưng có những chuyển động như sóng khi ấn vào hai bên chỉ có quá nhiều dịch.
	Một khối cứng trong bụng không di chuyển và đau khi ấn thường chỉ huyết ứ.
	Một khối sưng không có hình dạng, không đau và di chuyển lung tung thường chỉ khí trệ.

HÌNH 102



Hình vẽ nét nằm ở phần dưới bên trái của bảng: một thầy thuốc mặc áo blouse trắng dùng hai tay ấn lên bụng một người bệnh nằm ngửa, đầu gối trên gối.

TRANG SÁCH 47 · SCAN P056

Chẩn đoán qua phân tích chất bài tiết

Chẩn đoán qua phân tích chất bài tiết

Phân và nước tiểu là những chất thải của cơ thể con người. Chúng cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về tình trạng sức khỏe của một người. Nói chung, phân có màu vàng nâu. Nhưng nếu lưu lại trong ruột quá lâu, phân sẽ sẫm màu hơn và khô hơn. Khi tiêu chảy, phân vàng hơn vì chỉ lưu lại trong ruột một thời gian ngắn.

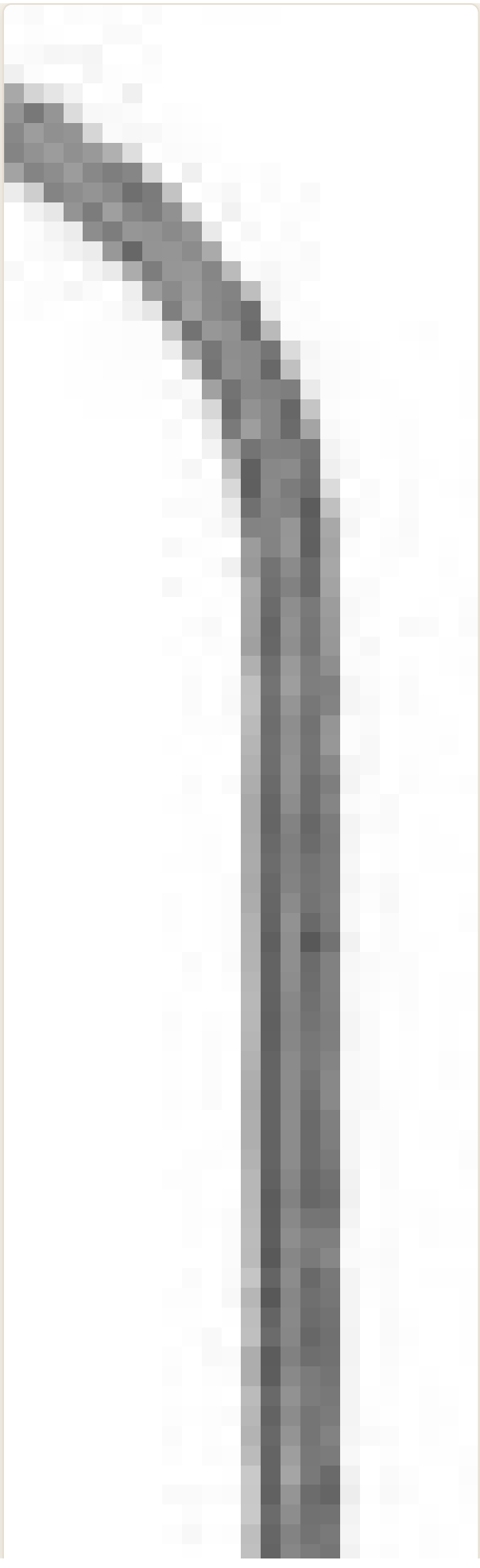
Việc xét nghiệm phân và nước tiểu thường được tiến hành trong các đợt khám sức khỏe ở bệnh viện. Chúng cung cấp cơ sở để chẩn đoán. Xét nghiệm phân và nước tiểu bao gồm việc quan sát hình dáng bên ngoài, độ đặc, màu sắc, mức độ tiêu hóa, v.v.

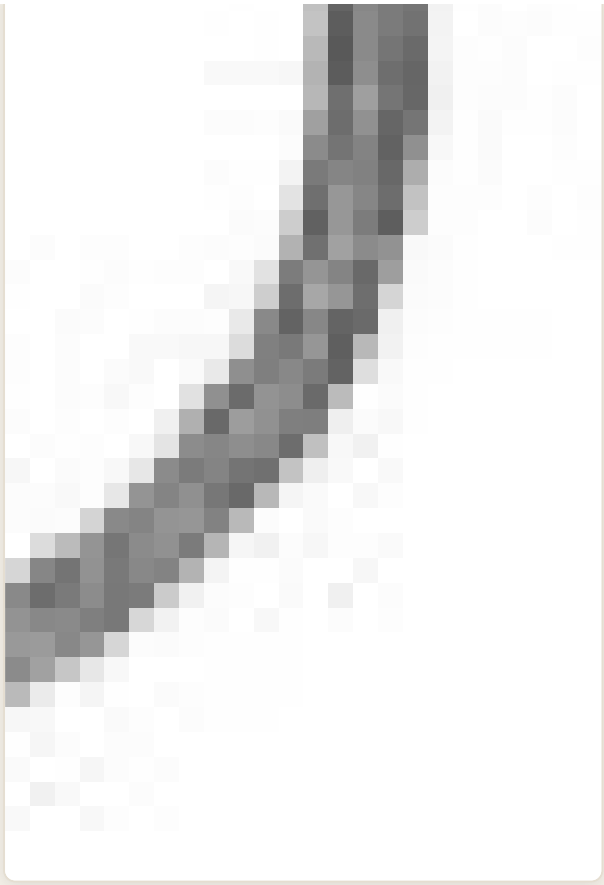
Xét nghiệm phân không hẳn là một phần của y học cổ truyền Trung Quốc. Nhưng ở Trung Quốc đã từng có ghi chép về việc nếm phân để chẩn đoán người bệnh. Người ta nói rằng phân đắng là dấu hiệu hồi phục, còn phân ngọt là tin xấu. Điều này chính xác và đúng thực đến đâu? Thôi thì đọc cho vui cũng chẳng hại gì.

Vua nước Việt nếm phân

Vào thời Xuân Hạ, khi hai nước Việt và Ngô đang giao chiến, nước Việt thua trận và vua nước Việt bị bắt làm tù binh. Vua nước Việt coi nỗi nhục ấy nhẹ như không. Để giành được lòng tin của vua nước Ngô, ông đã nếm phân của vua Ngô khi vua này lâm bệnh và đoán rằng nhà vua sẽ hồi phục hoàn toàn. Quả nhiên, vua nước Ngô khỏi bệnh và thả vua nước Việt. Vua nước Việt sau đó trở về gây dựng lại đất nước và cuối cùng đánh bại nước Ngô.

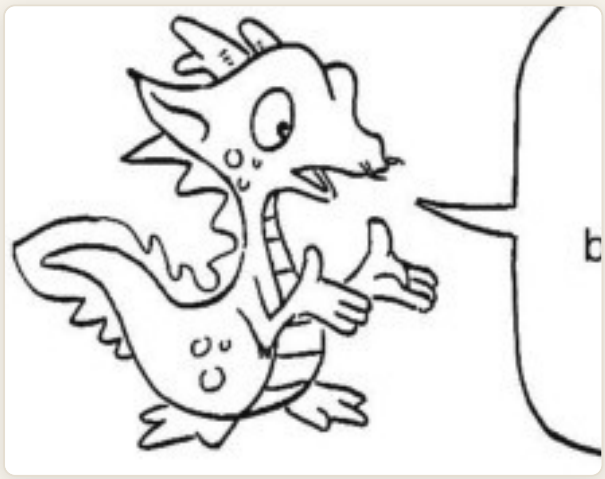
HÌNH 103





Một mảnh cắt hẹp chỉ cho thấy một đoạn của đường viền trang trí uốn cong bao quanh ô câu chuyện.

HÌNH 104



Chú rồng linh vật, với bong bóng thoại chứa đoạn văn phía trên, đứng dựng một chân trước và há miệng như đang nói, đuôi bong bóng thoại kéo dài về bên phải.

HÌNH 105

Hình vẽ nét gồm hai phần: phía trên, một người hầu đứng cạnh một chiếc bô đặt trên giá thấp và một người cúi xuống bên cạnh trong căn phòng có rèm; phía dưới, một tấm chăn hoa văn rối rắm, bên dưới là một người đàn ông để râu đang ốm nằm trên giường.

TRANG SÁCH 48 · SCAN P057

Người con hiếu thảo nếm phân của cha

Người con hiếu thảo nếm phân của cha

Vào thời Nam Tề, có một cậu bé tên là Dữu Kiềm Lâu (Yu Qianlou). Khi cha cậu lâm bệnh, cậu đã mời thầy thuốc đến chữa,

"Nếu phân có vị đắng, thì bệnh của cha cậu không nghiêm trọng."

"Nhưng nếu nó có vị ngọt, ta e rằng đó là tin xấu."

"Nó ngọt! Con phải làm sao đây?"

"Ta e rằng bệnh của ông ấy không thể chữa khỏi."

"Con nguyện rút ngắn tuổi thọ của mình để đổi lấy sự hồi phục của cha."

Có lẽ lòng hiếu thảo của Dữu Kiềm Lâu đã cảm động tới Trời. Cha cậu dần dần khỏi bệnh. Câu chuyện này được ghi lại trong sách *Nhị Thập Tứ Hiếu*.

HÌNH 106

Toàn bộ trang là một dải truyện tranh. Khung trên bên trái mang tiêu đề A Filial Son Tastes His Father's Stool (Người con hiếu thảo nếm phân của cha), phía dưới là Dữu Kiềm Lâu đang đứng suy nghĩ; khung trên bên phải có ô chú thích giới thiệu Dữu Kiềm Lâu thời Nam Tề, người đã mời thầy thuốc khi cha lâm bệnh, với hình ảnh cậu bé và thầy thuốc bên giường người bệnh. Khung giữa bên trái: thầy thuốc giải thích rằng phân có vị đắng nghĩa là bệnh không nghiêm trọng, còn vị ngọt là tin xấu; khung giữa bên phải: Dữu Kiềm Lâu sau khi nếm thấy phân ngọt và lo rằng bệnh của cha không thể chữa khỏi. Khung dưới bên trái: cậu quỳ cầu nguyện trước một lư hương, xin rút ngắn tuổi thọ của mình để đổi lấy sự hồi phục của cha; khung dưới bên phải có ô chú thích kể rằng lòng hiếu thảo của cậu có lẽ đã cảm động tới Trời, cha cậu dần khỏi bệnh, và câu chuyện được ghi lại trong sách Nhị Thập Tứ Hiếu, với hình ảnh Dữu Kiềm Lâu chăm sóc người cha đã khỏi bệnh.

Các phương pháp trị liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc

Các phương pháp trị liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc

Các phương pháp trị liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc rất nhiều và đa dạng. Những phương pháp thường gặp là dùng thuốc Đông y, châm cứu và cứu ngải, xoa bóp, trị liệu bằng ăn uống, khí công và trị liệu bằng cảm xúc; ngoài ra còn có những liệu pháp ít phổ biến hơn như giác hơi, cạo gió và trích máu. Phương pháp trị liệu được dùng thay đổi tùy theo bệnh trạng và thể chất của mỗi người bệnh.

TRANG SÁCH 50 · SCAN P059

Phương pháp thứ nhất — Dùng thuốc Đông y

Phương pháp thứ nhất — Dùng thuốc Đông y

Sự phát hiện ra các dược thảo

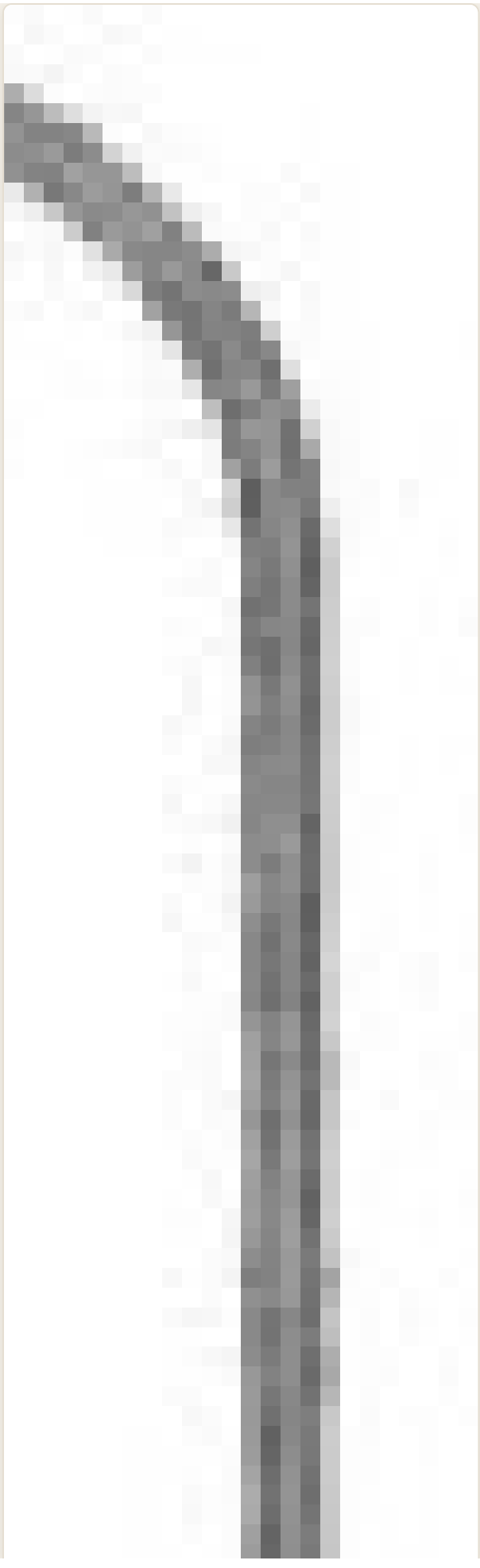
Một câu nói cổ truyền kể rằng: "Thần Nông nếm trăm loại cây cỏ để chữa bệnh cho dân." Trong cuộc mưu sinh, tổ tiên của người Trung Hoa đã nếm vô số loại quả dại, hạt và cây cỏ. Dần dần, họ học được cách phân biệt cây độc với cây không độc và phát hiện ra những loại cây có tác dụng chữa bệnh. Nhờ vậy, họ tích lũy được kiến thức về các cây thuốc.

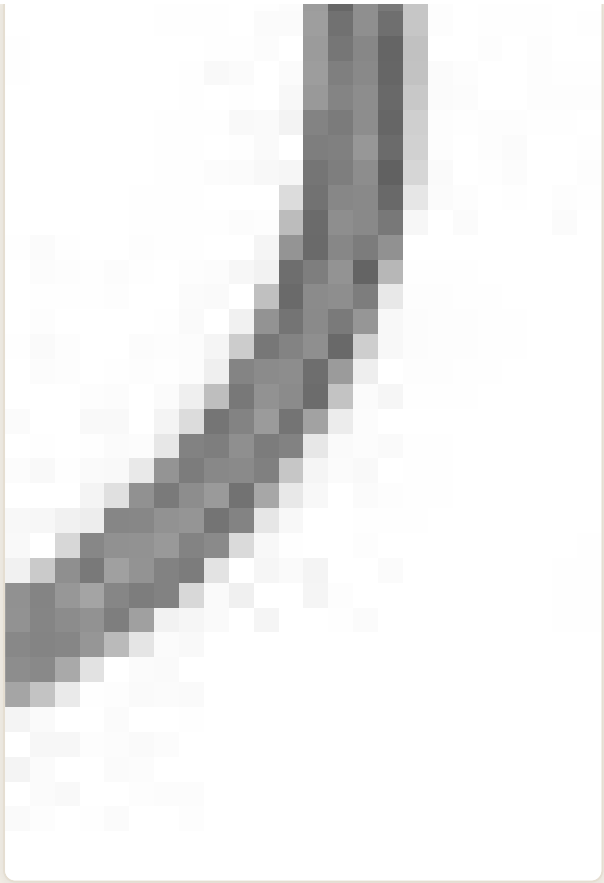
Chính trong những chuyến đi săn, họ phát hiện ra rằng một số loài động vật cũng có tác dụng chữa bệnh và làm thuốc. Với sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, người Trung Hoa đã xây dựng nên một kho tàng kiến thức đồ sộ mà ngày nay được biết đến với tên gọi y học cổ truyền Trung Quốc.

Thần Nông (còn gọi là Shennong hay Yandi)

Thuở xa xưa, dược thảo, ngũ cốc, cỏ dại và hoa mọc lẫn với nhau. Để tìm ra loại nào trong số đó có thể dùng làm thuốc hay làm thức ăn, Thần Nông trong truyền thuyết đã tự mình nếm thử các loài cây, nhận ra nhiều loại dược thảo và cây ăn được. Thế nhưng một ngày nọ, sau khi nếm phải một loài cây chết người, ông đã trúng độc mà qua đời.

HÌNH 107



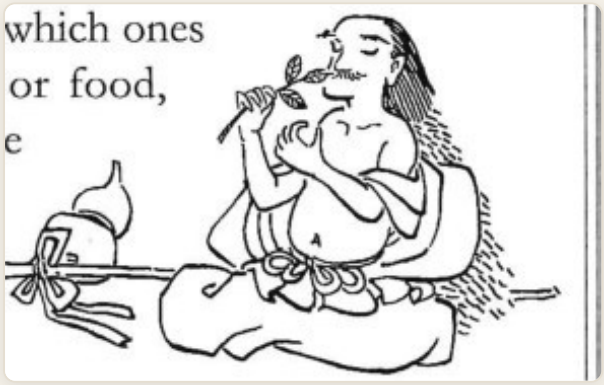


Một đoạn viền cong trang trí: góc bo tròn bên trái của dải tiêu đề, là họa tiết đường viền chứ không phải hình minh họa.

HÌNH 108

Tranh vẽ nét một khung cảnh rừng: ba nhân vật cổ Trung Hoa giữa rừng — một người cầm giáo, một người cúi xuống hái cây, một người vác bó dược thảo — cùng một con hươu, một con vật nhỏ, nấm và cỏ cây xung quanh. Hai ô nhỏ ở góc dưới bên phải vẽ một con chim và một củ rễ chạc ba.

HÌNH 109



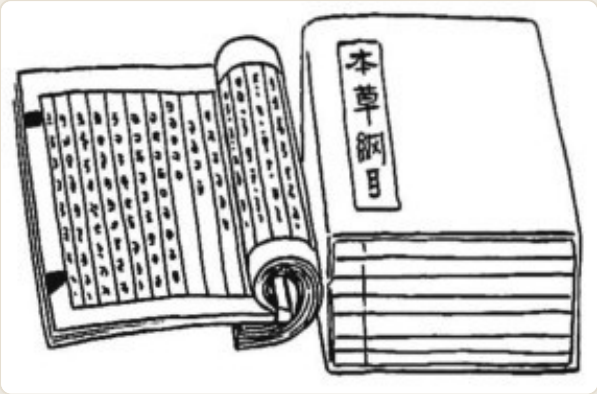
Thần Nông ngồi xếp bằng, nếm một chiếc lá đưa lên miệng, bên cạnh là một quả bầu đựng thuốc và một bọc dược thảo.

Các loại thuốc Đông y

Các loại thuốc Đông y

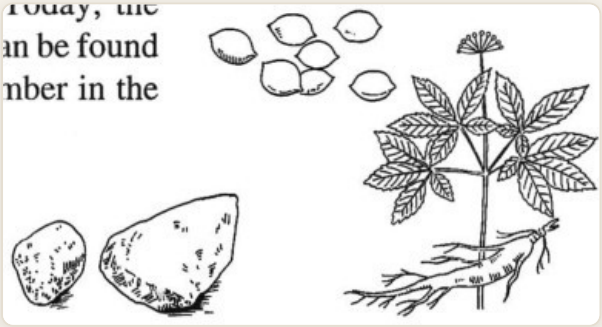
Ngoài những dược thảo quen thuộc, thuốc Đông y còn bao gồm khoáng vật và các bộ phận của động vật. Trung Quốc với diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng và nhiều vùng khí hậu khác nhau là quê hương của rất nhiều loài thực vật, động vật và khoáng vật. Bộ sách kinh điển về thuốc Đông y, cuốn *Bản thảo cương mục*, ghi lại 1.892 loại thuốc. Ngày nay, số loại thuốc có thể tìm thấy từ nguồn tài nguyên phong phú ấy dễ dàng lên tới hàng nghìn.

HÌNH 110



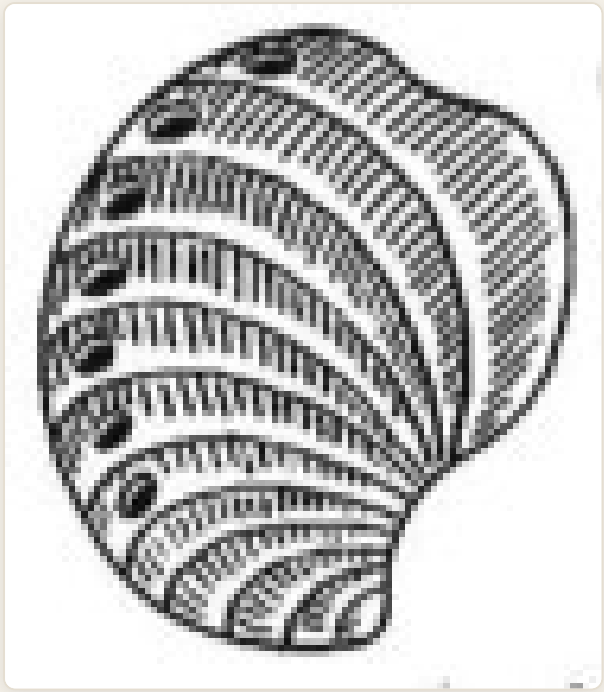
Hình vẽ cuốn Bản thảo cương mục: một cuốn sách in mộc bản đang mở, bên cạnh là chồng sách đã đóng gáy.

HÌNH 111



Một nhóm dược liệu: những hạt dẹt hình bầu dục rải rác, hai hòn đá khoáng thô ráp, và một cây có lá kép, một tán hoa nhỏ cùng rễ mảnh.

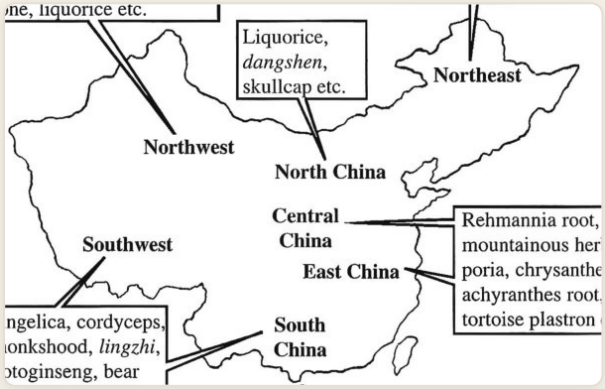
HÌNH 112



Một chiếc vỏ sò hình quạt có gờ — một vị thuốc có nguồn gốc động vật.

Nơi tìm thấy các dược thảo

HÌNH 113



Bản đồ Trung Quốc có ghi tên các vùng — Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Trung Nguyên (Hoa Trung), Hoa Đông, Tây Nam và Hoa Nam — mỗi vùng kèm một ô liệt kê các dược thảo và vị thuốc sản xuất tại đó.

HÌNH 114

Một mảnh nhỏ của bản đồ: một đoạn đường viền cùng đường chỉ dẫn nối tới một trong các ô tên vùng.

TRANG SÁCH 52 · SCAN P061

Dược thảo

Dược thảo

Những bộ phận của dược thảo được dùng gồm rễ, vỏ, lá, hoa, quả và hạt, thân đốt và nhiều bộ phận khác nữa.

Rễ

Rễ là bộ phận của cây hút chất dinh dưỡng và nước từ đất và không khí.

Thân

Thân vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ rễ lên. Thân còn có tác dụng nâng đỡ cây.

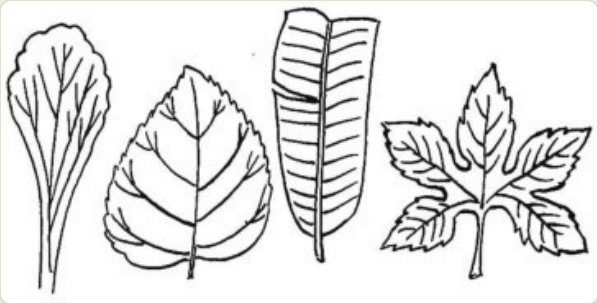
TRANG SÁCH 53 · SCAN P062

Trang 53

Lá

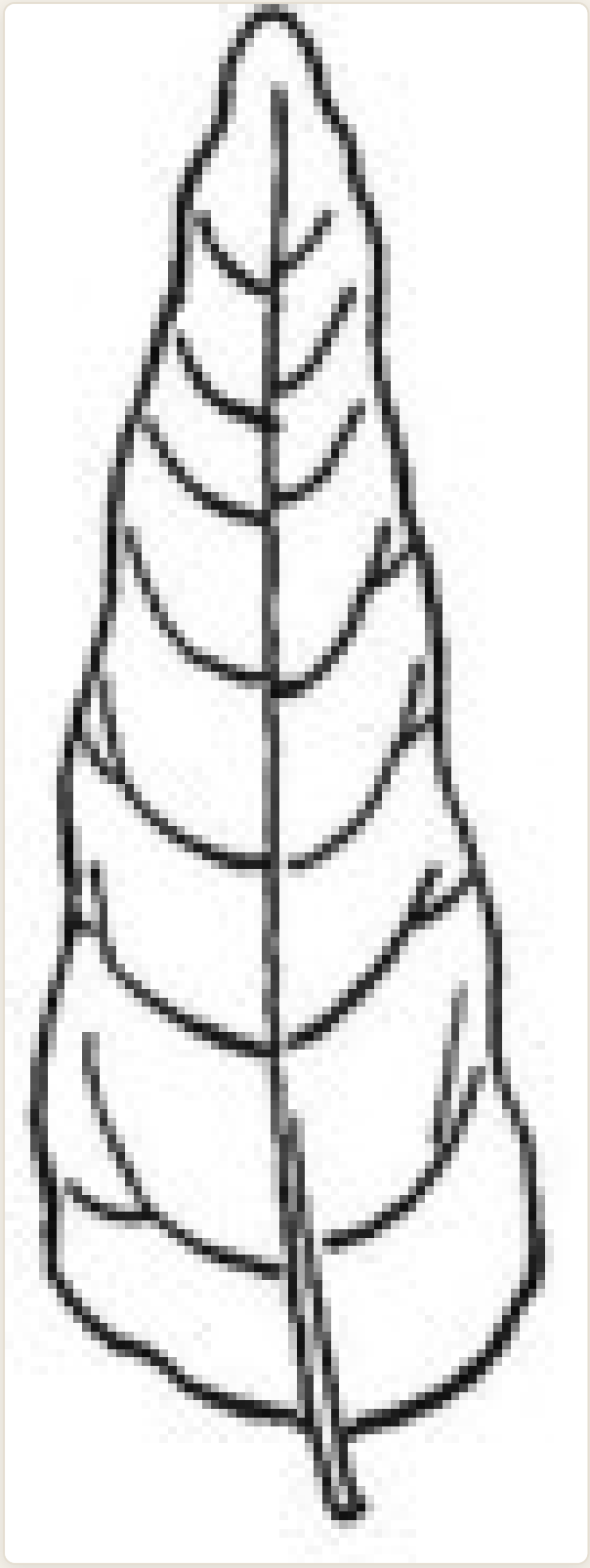
Lá là bộ phận cây tạo ra thức ăn.

HÌNH 115



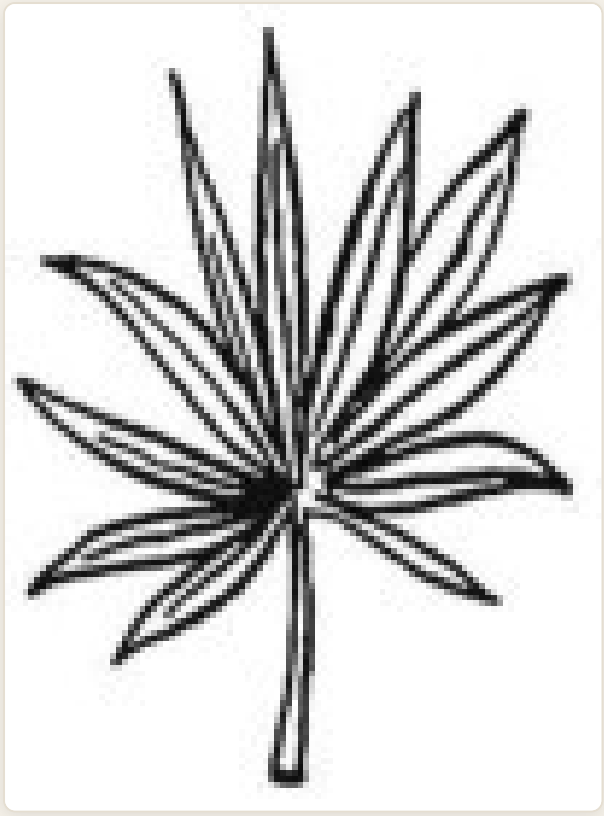
Bốn kiểu lá đặt cạnh nhau: lá hình thìa gân lông chim, lá hình trứng có răng cưa, lá dài hình dải với gân bên song song, và lá xẻ thùy kiểu lá phong.

HÌNH 116



Một chiếc lá lớn hình giọt nước với các gân cong song song và cuống dài.

HÌNH 117



Lá hình quạt với nhiều thùy nhọn mảnh tỏa ra từ gốc.

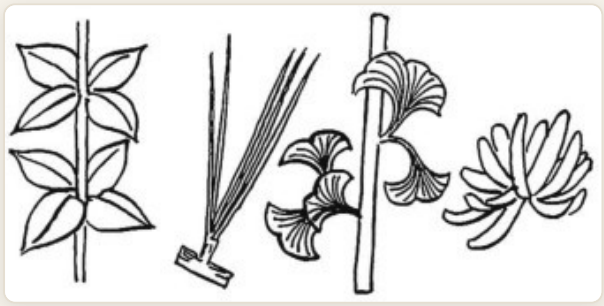
HÌNH 118

Lá kép lông chim: các cặp lá chét hình bầu dục mọc đối dọc theo cuống, tận cùng là một lá chét đơn.

HÌNH 119

Hai cành lá mang những chiếc lá hình bầu dục mọc so le.

HÌNH 120

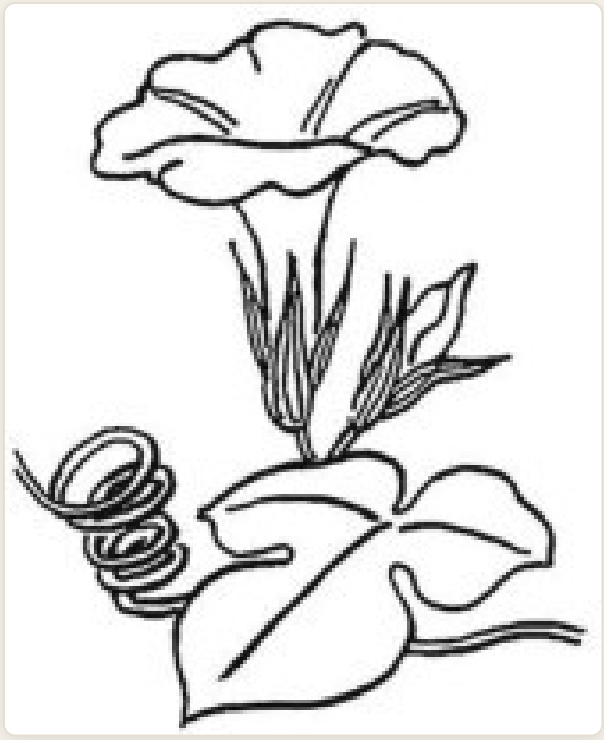


Một cụm các dạng lá: một thân có lá hình mác mọc đối, một bó lá dài hình cỏ, một chùm lá bạch quả hình quạt, và một lá xẻ thùy hình quạt.

Hoa

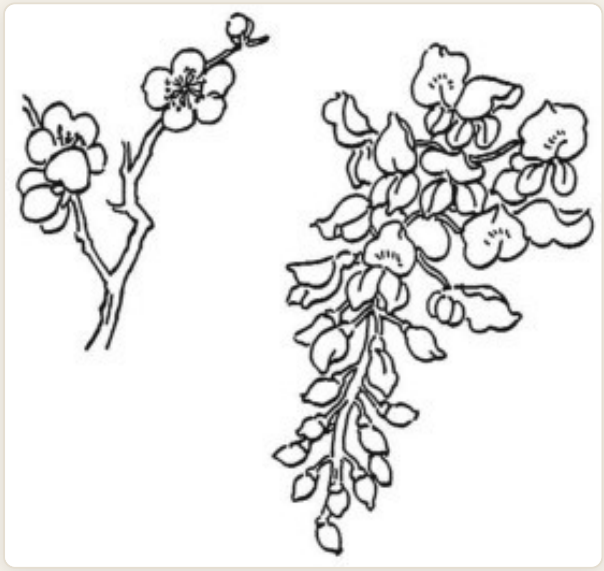
Hoa chủ yếu đảm nhiệm việc sinh sản của cây.

HÌNH 121



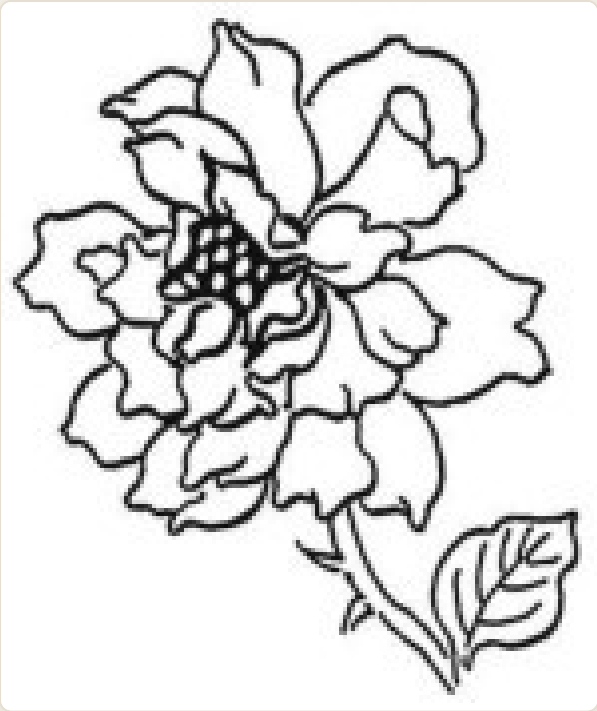
Hoa bìm bìm: bông hoa hình kèn với tua cuốn xoắn ốc và những chiếc lá hình tim.

HÌNH 122



Hai cành hoa: một cành khô nở hoa mai, và một chùm hoa hình đậu rủ xuống.

HÌNH 123

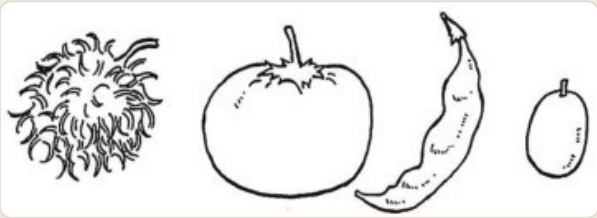


Một bông hoa kép lớn với nhiều cánh xếp tầng uốn lượn, kèm theo một chiếc lá và cuống.

Quả

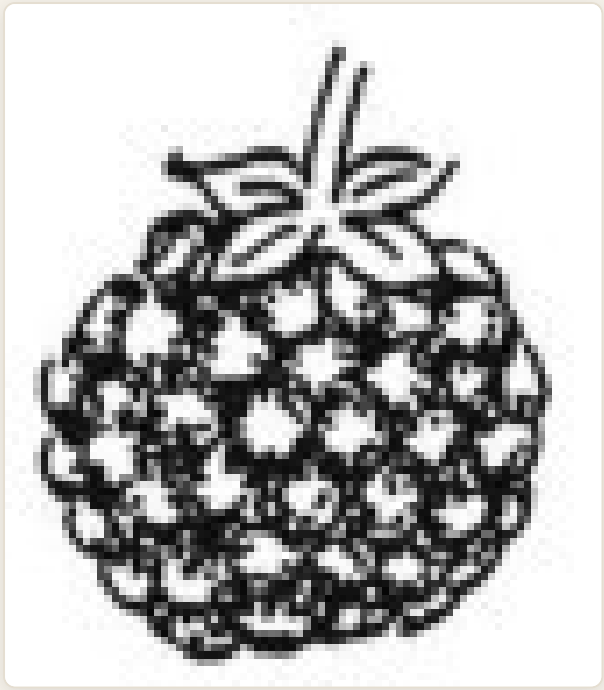
Quả là bộ phận đã được thụ tinh của cây, có chức năng sinh sản.

HÌNH 124



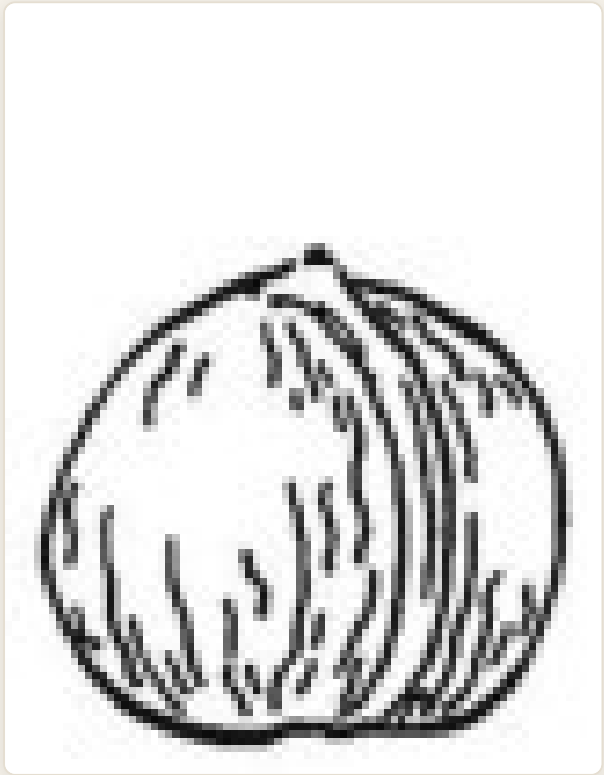
Một nhóm quả: một quả có gai nhọn, một quả tròn có cuống, một quả dài cong và một quả nhỏ hình bầu dục.

HÌNH 125



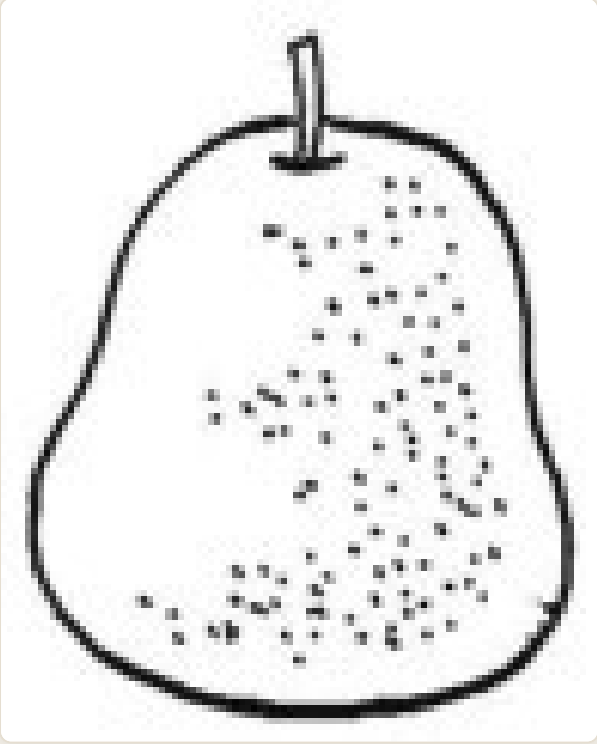
Một quả mọng kết thành chùm từ nhiều múi nhỏ, trên đỉnh có đài lá xanh.

HÌNH 126



Một quả tròn có sọc dọc.

HÌNH 127



Một quả hình lê có cuống và vỏ lốm đốm.

TRANG SÁCH 54 · SCAN P063

Thu hái và bào chế dược thảo

Thu hái và bào chế dược thảo

Dược thảo có nhiều công dụng khác nhau và hiệu quả của chúng phụ thuộc vào thời điểm trong năm (sự thay đổi theo mùa). Vì vậy, việc hái dược thảo phải được tiến hành trong điều kiện khí hậu thích hợp và vào đúng giai đoạn sinh trưởng của cây, cùng nhiều yếu tố khác, để bảo đảm dược thảo đạt hiệu quả tối ưu. Ví dụ, các cây lấy rễ thường được hái vào mùa thu, mùa đông và đầu xuân, khi lá đã tàn. Đó chính là những thời điểm rễ cây dự trữ lượng chất dinh dưỡng nhiều nhất.

Ngoài thời điểm thu hái, dược thảo còn phải trải qua các công đoạn bào chế như làm sạch, thái, sao, hấp và tôi (nhúng nhanh vào nước sau khi sao nóng). Những công đoạn này loại bỏ hoặc làm giảm độc tính và tác dụng phụ của dược thảo; làm tăng hiệu lực, thay đổi tính chất của dược thảo, đồng thời ngăn nấm mốc và ký sinh trùng phát triển để bảo quản được lâu dài.

TRANG SÁCH 55 · SCAN P064

Một số dược thảo thông dụng

Một số dược thảo thông dụng

Rễ đương quy (Angelica root)

Vị ngọt và cay, tính ấm. Bổ khí huyết, nhuận tràng để dễ đi đại tiện. Tốt cho chứng huyết hư, thể chất suy nhược, táo bón và các vết thương ngoài.

Rễ hà thủ ô (Fleeceflower root)

Vị đắng ngọt, tính ấm. Bổ thận và can, tốt cho việc rụng trứng, giải độc, nhuận tràng. Dùng chữa rụng tóc do thiếu sắt gây ra bởi kinh nguyệt, da dẻ xanh xao, v.v.

Rễ nhân sâm (Ginseng root)

Vị ngọt và hơi đắng, tính không ấm cũng không lạnh. Bổ sinh lực, bổ tỳ và phế, thúc đẩy sinh tân dịch và an thần. Tốt cho chứng tay chân lạnh, mệt mỏi uể oải, ăn kém, thể chất suy nhược, v.v.

Vỏ quýt (Tangerine peel)

Vị đắng và cay, tính ấm. Điều hòa khí, kiện tỳ, trừ nội nhiệt và đờm. Tốt cho chứng khí trệ ở tỳ vị, ăn kém, ho có đờm, v.v.

Rễ địa hoàng (Rehmannia root)

Sinh địa vị đắng ngọt, tính hàn. Trừ nhiệt, bổ âm, thúc đẩy sinh tân dịch, cầm máu. Thục địa vị ngọt, tính hơi ấm. Tốt cho thận và huyết, điều hòa kinh nguyệt và bổ âm.

Lá tỳ bà (Loquat leaf)

Vị đắng, tính mát. Trừ nhiệt ở phế và chữa ho, cầm nôn. Tốt cho chứng ho do phế nhiệt, thở nặng, khát do nhiệt.

TRANG SÁCH 56 · SCAN P065

Trang 56

Hạt sen (Lotus seed)

Vị ngọt và đắng, tính không lạnh cũng không nóng. Bổ tỳ, cầm tiêu chảy, ích thận, an thần. Tốt cho chứng thận hư, tiêu chảy kéo dài, mất ngủ do lo nghĩ, tiểu không tự chủ và di tinh.

Hạt bạch quả (Gingko nut)

Vị đắng ngọt, tính không lạnh cũng không nóng, có độc. Tốt cho bệnh hen suyễn, phòng ngừa ký sinh trùng, khống chế tiểu tiện. Dùng chữa ho có đờm, khí hư ra chất nhầy trắng, tiểu không tự chủ, tiểu nhiều lần.

Táo tàu (Chinese date)

Vị ngọt, tính ấm. Bổ khí, dưỡng huyết và an thần, tính dược ôn hòa. Tốt cho chứng tỳ vị hư nhược, huyết hư, mất ngủ, mệt mỏi uể oải, v.v.

Hoa cúc (Chrysanthemum flower)

Vị đắng ngọt, tính hàn. Trừ phong nhiệt, ích mắt và giải độc. Dùng chữa cảm lạnh do ngoại tà phát sốt, đau đầu, chóng mặt, nhiễm trùng.

Vỏ hậu phác (Magnolia bark)

Vị đắng và cay, tính ấm. Trừ thấp và hóa đờm, chữa khí trệ. Tốt cho chứng khó chịu ở tỳ vị do thấp, khó tiêu và khí trệ; buồn nôn, táo bón, ho nhiều đờm.

Vỏ đỗ trọng (Eucommia bark)

Vị ngọt, tính ấm. Bổ thận và can, làm mạnh gân cốt, an thai. Tốt cho chứng đau khớp do can thận hư suy, chân yếu, thai không ổn định, huyết áp cao, v.v.

TRANG SÁCH 57 · SCAN P066

Truyện quả sơn tra

Truyện quả sơn tra

Vị ngọt, tính ôn (ấm). Quả giúp tiêu hóa, tiêu ứ bầm, hóa đàm và cầm máu.

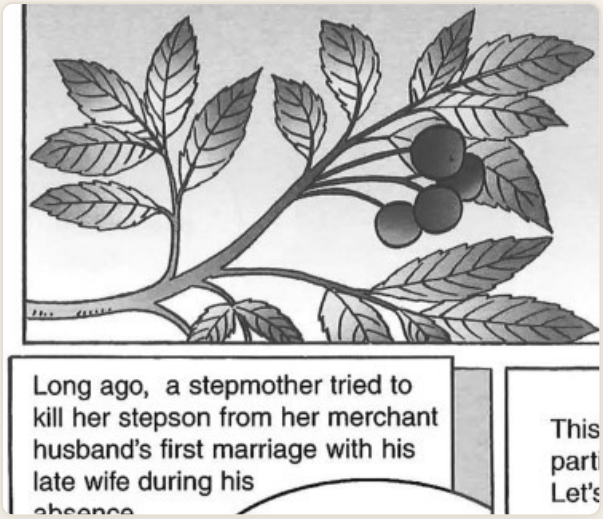
Ngày xưa, có một người dì ghẻ tìm cách giết đứa con riêng của chồng — con của người vợ trước đã mất — trong lúc người chồng đi buôn xa.

Ta phải nhổ cái gai trước mắt này đi, để con ta được hưởng số tiền ấy.

Cơm này mới chín có một nửa. Để xem mày tiêu hóa nổi không.

Nếu ta kêu ca về chén cơm này, dì ghẻ sẽ nổi giận. Thôi ta cứ ăn hết vậy.

HÌNH 128



Hình vẽ nét một cành sơn tra: một thân cành trần chạy ngang khung, tua tủa những chùm lá hình bầu dục với mép lá răng cưa nhọn, và một chùm bốn quả tròn nhỏ buông xuống ở phía trên bên phải.

HÌNH 129

Trang truyện tranh bốn khung. Khung trên bên trái: một người đàn bà quấn khăn trên đầu, mặc áo dài, sau lưng địu một bọc vải chấm bi và một đứa bé, đang nhìn cậu bé xách giỏ bước đi; bên cạnh bà là ô ghi chú kể rằng người dì ghẻ toan hại đứa con riêng khi chồng đi buôn vắng, và bà lẩm bẩm rằng phải nhổ cái gai trước mắt để con mình hưởng tiền. Khung trên bên phải: cũng người đàn bà ấy múc cơm đang bốc khói vào bát bên cửa sổ có chấn song gỗ, miệng nói cơm mới chín một nửa. Khung dưới bên trái: cậu bé ngồi đất ăn cơm bằng đũa, vẻ mặt buồn bã, quyết định không kêu ca. Khung dưới bên phải, không có lời thoại: cậu bé cầm bát húp cơm, mắt mở to.

TRANG SÁCH 58 · SCAN P067

Trang 58

Hừ!

Ngày tháng trôi qua, cậu bé bắt đầu sụt cân.

Ôi, bụng ta thấy khó chịu quá.

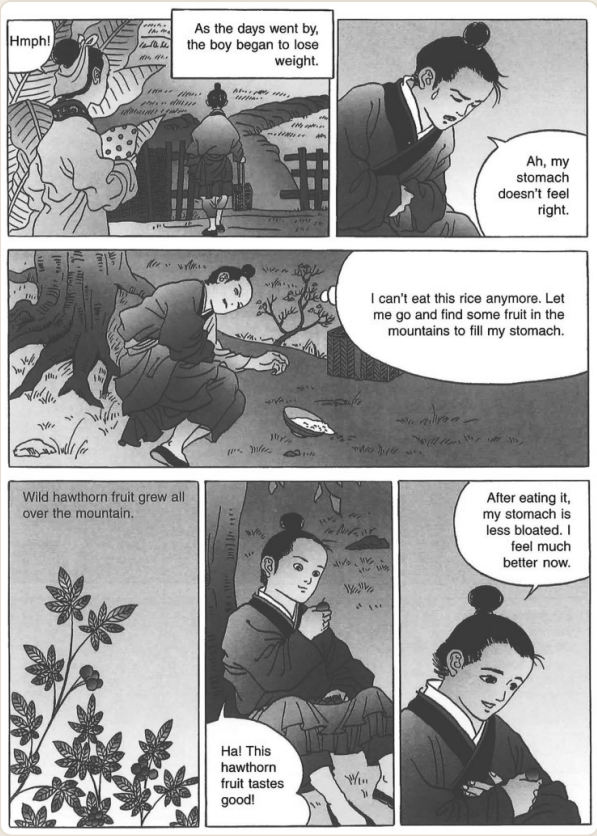
Ta không ăn nổi chén cơm này nữa. Để ta lên núi tìm quả gì đó lót dạ vậy.

Sơn tra mọc hoang khắp núi.

Ha! Quả sơn tra này ngon thật!

Ăn xong, bụng ta đỡ đầy hơn. Người thấy khỏe hẳn ra.

HÌNH 130



Trang truyện tranh sáu khung xếp thành ba hàng. Hàng trên: bên trái người dì ghẻ quay mặt đi với vẻ khinh khỉnh "Hừ!", ô ghi chú giữa hai khung kể rằng ngày tháng trôi qua cậu bé bắt đầu sụt cân, còn bên phải cậu bé gập người ôm bụng. Hàng giữa: một khung rộng, cậu bé ngồi xổm dưới gốc cây cạnh chiếc bát không bị lật úp, rồi lầm lũi bước theo con đường về phía núi xa. Hàng dưới: bên trái một cành sơn tra với lá răng cưa và từng chùm quả mọc tràn sườn núi; ở giữa cậu bé ngồi dưới gốc cây ăn quả; bên phải cậu mỉm cười xoa bụng, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.

TRANG SÁCH 59 · SCAN P068

Trang 59

Lạ thật. Đứa bé này chẳng những không yếu đi mà còn khỏe khoắn hơn.

Hay là nó được thần linh che chở?

Thôi ta đừng ngược đãi nó nữa.

Cha, cha về rồi!

Dì ghẻ đối xử với con có tốt không?

Dì cho con ăn cơm sống quá nên bụng con khó chịu.

Nhưng sau khi ăn quả sơn tra hái trên núi, con thấy dễ chịu hơn nhiều.

Xem ra quả sơn tra giúp tiêu hóa.

Vậy ta hãy làm thành viên thuốc rồi đem bán lấy tiền.

Quả sơn tra trở nên vô cùng nổi tiếng. Người ta thấy nó rất hiệu nghiệm trong việc làm giảm chứng khó tiêu.

HÌNH 131

Trang truyện tranh tám khung xếp thành ba hàng. Hàng trên: người dì ghẻ địu con trong chiếc bọc chấm bi, nhìn cậu bé sải bước đi trên đường và thắc mắc vì sao nó chẳng yếu đi mà lại khỏe khoắn hơn; khung kế tiếp bà tự hỏi phải chăng nó được thần linh che chở, và quyết định từ nay không ngược đãi nó nữa. Hàng giữa: người cha đi buôn trở về, cậu bé chạy ùa vào lòng cha khóc "Cha, cha về rồi!"; người cha hỏi dì ghẻ đối xử với con có tốt không, cậu bé kể rằng chén cơm sống do dì cho ăn khiến bụng con khó chịu, nhưng quả sơn tra ăn trên núi lại làm con dễ chịu hơn nhiều. Hàng dưới: người cha vuốt má con và kết luận quả sơn tra giúp tiêu hóa, rồi bảo hãy làm thành viên thuốc đem bán; khung cuối là cảnh phố xá, một tấm biển hiệu treo trên cao có chữ 山楂丸 (sơn tra hoàn — viên thuốc sơn tra), phía dưới là đám đông vây quanh người bán hàng.

Truyện quả nữ trinh tử (Nuzhenzi)

Truyện quả nữ trinh tử (Nuzhenzi)

Vị ngọt xen đắng, tính không hàn cũng không nhiệt. Quả bổ cho can và thận, làm khỏe lưng gối, sáng mắt, giúp tóc đen, tiêu sưng và giảm đau.

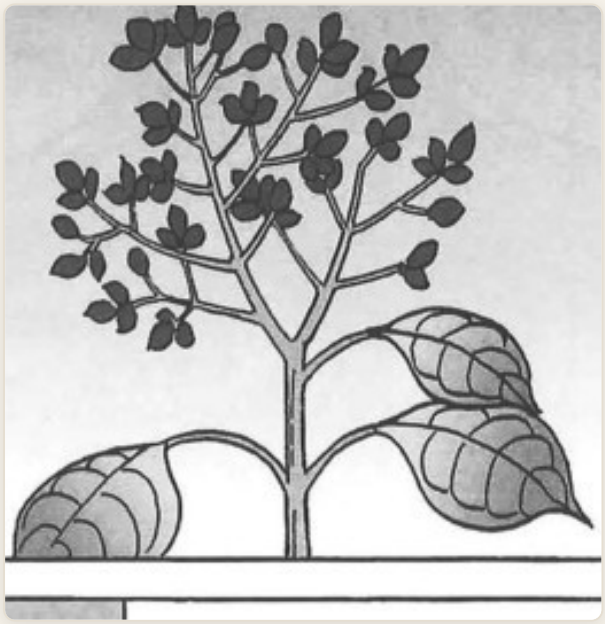
Ngày xưa, có một người phụ nữ tên là Trinh Tử (Zhenzi) lấy một người nông dân. Hai vợ chồng rất mực thương yêu nhau.

Chàng nhất định phải bình an trở về nhé. Thiếp sẽ chờ chàng.

Một năm kia, người chồng bị bắt đi lính đánh giặc.

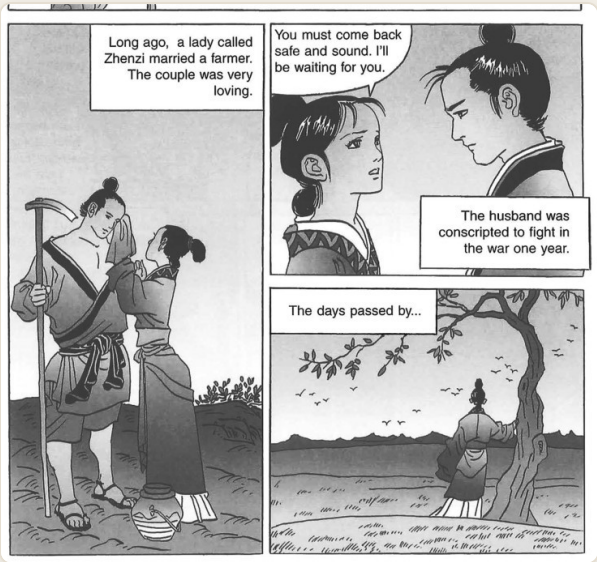
Ngày tháng cứ thế trôi qua...

HÌNH 132



Hình vẽ nét cây nữ trinh: một thân cây mảnh khảnh phân nhiều nhánh, chi chít những lá nhỏ tròn mọc thành từng cặp đối nhau, và ở gốc là hai chiếc lá to, bản rộng, gân rõ, cong vươn ra hai bên trái phải.

HÌNH 133



Trang truyện tranh bốn khung. Bên trái, một khung cao: người nông dân mặc áo ngắn đứng vác cuốc trên vai, người vợ trẻ cầm khăn lau mồ hôi trán cho chàng; ô ghi chú phía trên kể rằng ngày xưa có người phụ nữ tên Trinh Tử lấy một người nông dân, hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Khung trên bên phải: người vợ búi tóc ngước nhìn chồng, chàng ngoảnh mặt đi, nàng dặn chàng nhất định phải bình an trở về vì nàng sẽ chờ; một ô ghi chú thêm rằng năm ấy người chồng bị bắt đi lính. Khung dưới bên phải: người vợ đứng một mình bên gốc cây giữa khung cảnh đồng quê rộng, chim bay ngang trời, nàng dõi mắt nhìn về chân trời, kèm dòng chữ "Ngày tháng cứ thế trôi qua...".

TRANG SÁCH 61 · SCAN P070

Trang 61

Trinh Tử ốm nặng vì quá nhớ chồng.

Mẹ ơi, con sợ mình không qua khỏi.

Khi con chết, mẹ hãy trồng cây nữ trinh trước mộ con.

Cây ấy sẽ thay con đứng đó. Dẫu chết đi, con vẫn chờ chàng trở về.

Vài năm sau...

Trinh Tử, ta về muộn quá. Hu... hu...

Ông ấy đã khóc suốt ba ngày ba đêm.

Ông ấy mỗi ngày một yếu đi.

HÌNH 134

Trang truyện tranh sáu khung xếp thành ba hàng. Hàng trên: Trinh Tử nằm trên giường bệnh, người mẹ ngồi bên cạnh; ô ghi chú kể rằng nàng ốm vì quá nhớ chồng, nàng thì thào rằng sợ mình không qua khỏi, rồi xin trồng một cây nữ trinh trước mộ mình, nói rằng cây ấy sẽ thay nàng đứng đó và dẫu chết đi nàng vẫn chờ chồng trở về. Hàng giữa: một khung rộng vẽ cánh đồng thoáng đãng có chim bay trên trời, một người đàn ông đơn độc khoác áo đi đường bước về phía gốc cây, kèm ô ghi chú "Vài năm sau...". Hàng dưới: người chồng giờ đã bạc đầu quỳ khóc bên gốc cây cạnh bức tường đá của ngôi mộ, kêu rằng mình về quá muộn; hai người đứng xem bàn rằng ông ấy đã khóc suốt ba ngày ba đêm và mỗi ngày một yếu đi; khung nhỏ cuối cùng vẽ cành nữ trinh trĩu nặng từng chùm quả, phía sau là những tia sáng tỏa ra.

TRANG SÁCH 62 · SCAN P071

Trang 62

Ô! Nhìn kìa!

Cây nữ trinh đã ra quả rồi! Quả tím sẫm nhiều vô kể!

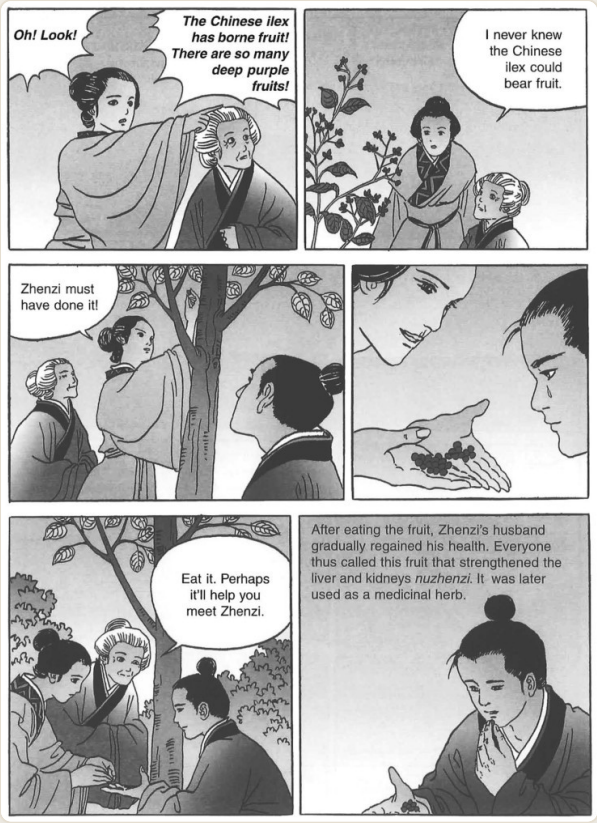
Ta chưa từng biết cây nữ trinh lại có thể ra quả.

Hẳn là do Trinh Tử làm nên.

Ăn đi. Biết đâu nó sẽ giúp ông gặp được Trinh Tử.

Sau khi ăn quả ấy, chồng của Trinh Tử dần dần hồi phục sức khỏe. Mọi người bèn gọi thứ quả bổ can thận này là nữ trinh tử. Về sau nó được dùng làm dược liệu.

HÌNH 135



Trang truyện tranh sáu khung xếp thành ba hàng. Hàng trên: một bà lão mặc áo có hoa văn giơ tay kinh ngạc khi trông thấy gốc cây, kêu lên rằng cây nữ trinh đã ra quả và quả tím sẫm nhiều vô kể; khung kế bên, một người đàn ông trẻ đứng cạnh bụi cây xanh tốt nói rằng mình chưa từng biết cây nữ trinh có thể ra quả. Hàng giữa: người vợ, bà lão và người đàn ông trẻ quây quanh thân cây, người vợ khẳng định hẳn là do Trinh Tử làm nên; rồi đến khung cận cảnh hai bàn tay nâng một nắm quả nhỏ sẫm màu, dâng cho người chồng tóc đã bạc. Hàng dưới: người vợ chìa quả ra trước người chồng đang quỳ và bảo ông ăn đi, biết đâu nó sẽ giúp ông gặp được Trinh Tử; khung cuối vẽ ông ăn quả với vẻ mặt trầm ngâm và đầy hy vọng.

Truyện quả kỷ tử

Truyện quả kỷ tử

Kỷ tử: vị ngọt, tính không hàn cũng không nhiệt. Là thuốc bổ cho can và thận, giúp ích tinh (tinh khí của sự sống) và sáng mắt. Dùng để trị chứng chóng mặt và ù tai do thận âm hư cùng huyết kinh không đủ, thị lực giảm sút, đau mỏi lưng gối, v.v.

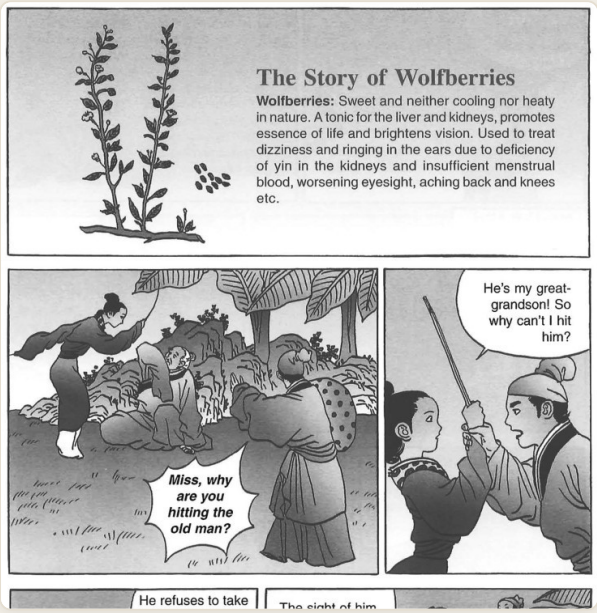
Tiểu thư, sao cô lại đánh ông lão?

Nó là chắt của ta! Vậy sao ta không đánh nó được?

Nó không chịu uống thuốc. Còn trẻ mà đã bạc đầu, rụng răng. Giờ yếu đến mức không đi nổi.

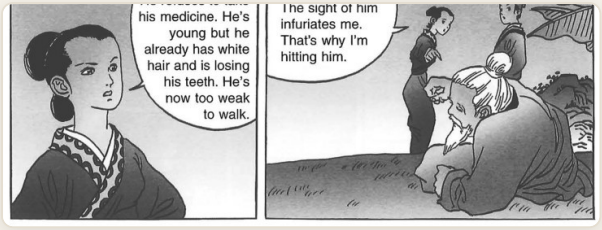
Nhìn thấy nó là ta phát bực. Nên ta mới đánh nó.

HÌNH 136



Khối tiêu đề của trang: hình vẽ nét một cây kỷ tử với hai thân mảnh vươn thẳng, mang những lá nhỏ hình bầu dục và hoa li ti, bên cạnh rải rác mấy quả khô nhỏ, phía bên phải là phần chữ tiêu đề và lời dẫn in sẵn. Phía dưới khối này, truyện bắt đầu: giữa khung cảnh cây cối, một người phụ nữ mặc áo dài giơ gậy lên trước một ông lão đang ngồi xổm trên đất, trong khi một người đàn ông đeo giỏ đan sau lưng hỏi vì sao cô lại đánh ông lão; khung kế tiếp, người phụ nữ vẫn nắm chặt cây gậy giơ lên còn một người đàn ông trẻ giữ tay cô lại, và cô phân trần rằng ông lão là chắt của mình, vậy cớ sao không được đánh.

HÌNH 137



Các khung dưới của cùng trang truyện tranh ấy: bên trái là khung cận cảnh người phụ nữ đáp rằng đứa chắt của bà không chịu uống thuốc, còn trẻ mà đã bạc đầu rụng răng, giờ yếu đến mức không đi nổi; bên phải, bà đứng trước ông lão đang quỳ trên đất với chòm râu bạc dài, một người đàn ông trẻ đứng nhìn, và bà giải thích rằng chỉ nhìn thấy nó là bà phát bực nên mới đánh.

TRANG SÁCH 64 · SCAN P073

Trang 64

Tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi rồi?

Ta 372 tuổi. Chắt của ta mới có 90.

Thì ra bà lão này thường dùng một loại dược thảo đặc biệt tên là Essence of Heaven (Tinh của Trời) vào mùa xuân. Sang mùa hạ, nó được gọi là kỷ tử. Mùa thu, người ta gọi nó là cốt địa (xương đất), còn mùa đông thì gọi là tiên trượng (gậy của thần tiên). Tương truyền rằng ai ăn nó quanh năm suốt tháng thì sẽ sống lâu như trời đất.

Tương truyền cây kỷ tử có thể biến thành chó.

Này! Hai con chó con!

Sao chúng biến đâu mất rồi?

Hai chú chó con, ra đây nào.

Ha ha! Ta đào được hai cây kỷ tử. Trông chúng cứ như hai con chó con vậy.

Oa! Giờ ta bay được rồi!

TRANG SÁCH 65 · SCAN P074

Thuốc từ động vật

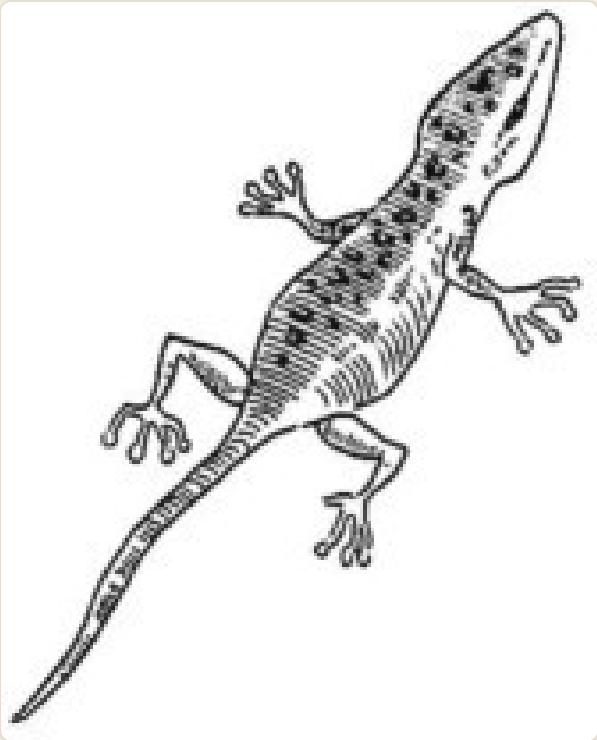
Thuốc từ động vật

Thuốc từ động vật còn bao gồm những loài bò sát nhỏ như thằn lằn, rết, giun đất và tắm, cùng các loài thủy sinh như hải mã và hải cẩu.

Một số ví dụ về thuốc từ động vật

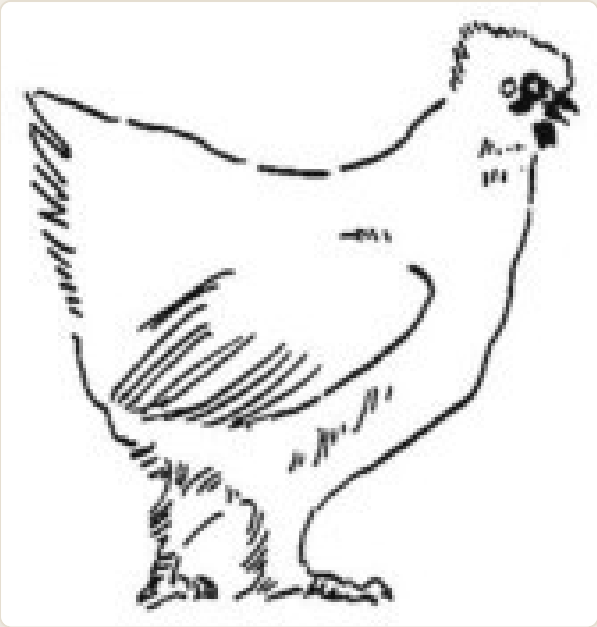
- - **Thằn lằn (thạch sùng):** Vị mặn, tính hàn, hơi có độc. Khu phong, giảm đau do hàn hoặc thấp gây nên và an thần. Dùng để chữa chứng tê liệt do trúng phong, tê mỏi do phong thấp, mụn nhọt sưng viêm v.v.
- - **Gà ác (ô kê):** Vị ngọt, tính không ôn cũng không hàn. Bổ thận, dưỡng khí huyết, trừ nhiệt thuộc thể hư.
- - **Vỏ bào ngư (thạch quyết minh):** Vị mặn, tính hàn. Giải độc cho can và làm sáng mắt, chữa đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ v.v.
- - **Hải mã:** Vị ngọt, tính ôn. Bổ thận và tăng cường sinh lực, giảm sưng. Dùng để chữa liệt dương, tiểu tiện không tự chủ, thận hư, chấn thương do té ngã, sinh đẻ khó.
- - **Rết (ngô công):** Vị cay, tính ôn, có độc. Khu phong và trị các bệnh sốt nóng, trung hòa độc tố, thông kinh lạc và giảm đau. Dùng để chữa co giật ở trẻ nhỏ, co rút, trúng phong, uốn ván, rắn độc cắn, mụn nhọt sưng viêm.
- - **Sừng linh dương (linh dương giác):** Vị mặn, tính hàn. Bình can tiềm dương để trấn nội phong, thanh can và làm sáng mắt. Dùng để chữa sốt cao, ngất xỉu do bệnh sốt nóng, rối loạn lưỡng cực, đau đầu và chóng mặt v.v.

HÌNH 138



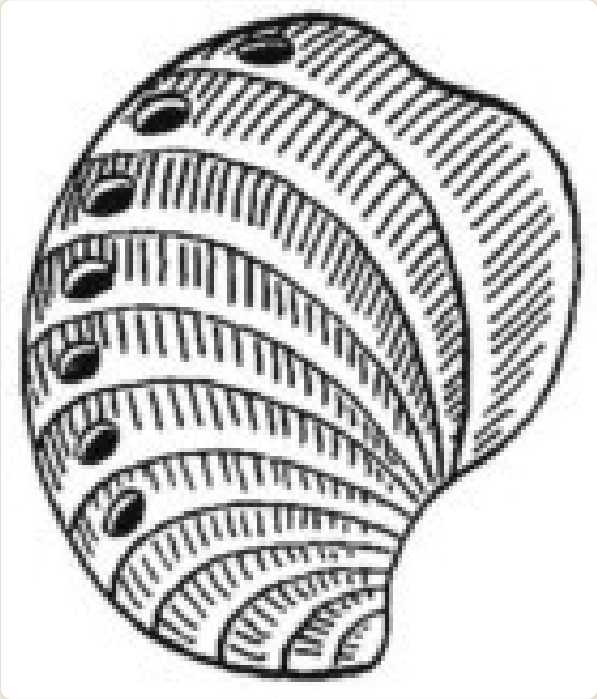
Hình vẽ nét một con thằn lằn nhìn từ trên xuống, đầu hướng lên phía trên bên phải, đuôi dài uốn cong xuống dưới bên trái; bốn bàn chân xòe rộng bám vào mặt phẳng và lưng rải rác những đốm nhỏ sẫm màu.

HÌNH 139



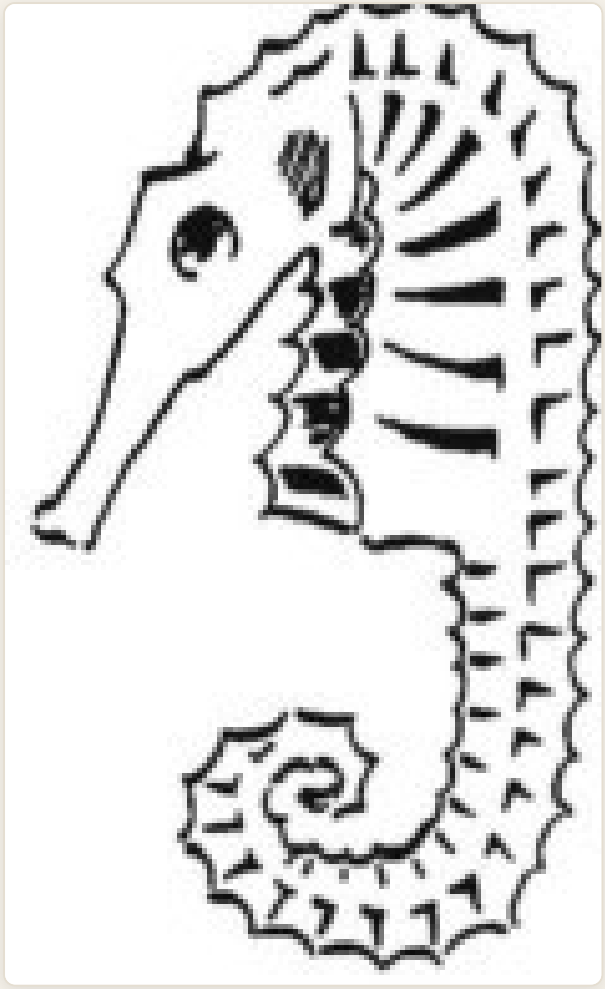
Hình vẽ nét một con gà ác đứng nghiêng nhìn sang phải, mào nhỏ lốm đốm, tích ngắn, cánh gấp và đuôi ngắn.

HÌNH 140



Hình vẽ nét một vỏ bào ngư hình tai, một hàng lỗ nhỏ chạy dọc theo mép trái và những đường gờ mảnh tỏa ra trên mặt vỏ.

HÌNH 141

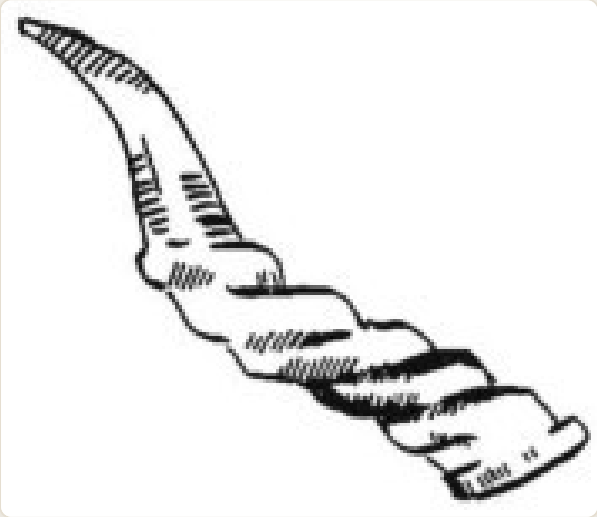


Hình vẽ nét một con hải mã nhìn nghiêng sang trái, mõm dài, thân có gờ và đuôi cuộn chặt.

HÌNH 142

Hình vẽ nét một con rết bò chéo qua khung hình, thân gồm nhiều đốt tròn như chuỗi hạt, một đôi râu ở phía dưới bên trái và mỗi đốt có một đôi chân.

HÌNH 143



Hình vẽ nét một chiếc sừng linh dương đơn lẻ, dài và thon dần, cong lên nhọn hoắt ở phía trên bên trái, phần gốc dày có những vòng gờ bao quanh.

Đông trùng hạ thảo

- - **Địa (thủy điệt):** Vị mặn và đắng. Tính không hàn cũng không ôn, có độc. Trừ huyết ứ, thông ứ trệ và khai thông kinh lạc. Chữa vết bầm tím, chấn thương do té ngã.
- - **Vỏ nghêu (cáp xác):** Vị đắng và mặn, tính hàn. Thanh nhiệt hóa đàm, giảm đau nhức. Chữa ho có đàm do nhiệt, đau ngực, có máu trong đàm, đau bụng và chứng ợ chua.
- - **Tằm (bạch cương tàm):** Vị mặn và cay. Tính ôn. Tức phong và khu phong, trị các bệnh sốt nóng, hóa đàm. Chữa co rút do co giật, đau đầu do phong, đau họng, ngứa và ban đỏ v.v.

Những vị thuốc từ động vật như mật gấu, nhung hươu, xương báo và sừng tê giác đã thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động vì quyền động vật. Để có được những bộ phận động vật này dùng làm thuốc, người ta đã săn trộm và giết hại các loài vật ấy. Ngoài ra, cách thức thu lấy những vị thuốc này thường rất tàn nhẫn. Vì vậy, nhiều thầy thuốc Đông y tránh dùng những bộ phận động vật đó trong đơn thuốc của mình, mà thay bằng các vị thuốc khác có tính chất tương tự.

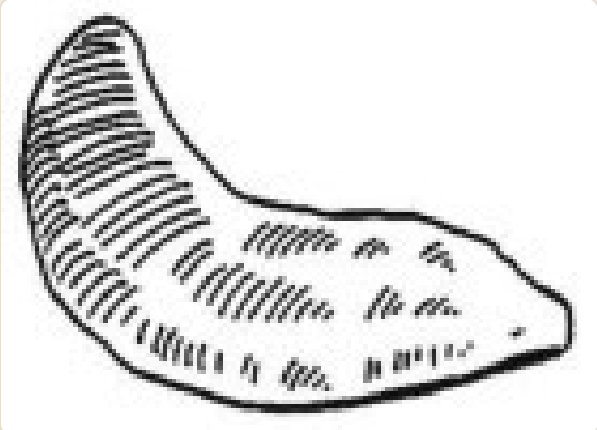
Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo (một vị thuốc Đông y) là sâu hay là cây?

Thực ra đây là một loại nấm ký sinh trên sâu non của bướm đêm vào mùa đông, phát triển lấp đầy toàn bộ khoang cơ thể con sâu, chỉ còn lại lớp da. Sang mùa hè, một chiếc lá hình lưỡi kiếm mọc ra. Loại nấm này cần năm đến sáu năm mới trưởng thành. Vì trông giống con sâu, nó được gọi là *dong chong xia cao* (đông trùng hạ thảo), nghĩa đen là "sâu mùa đông, cỏ mùa hè".

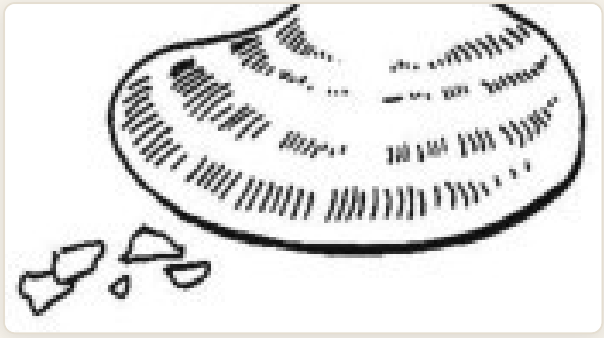
Đông trùng hạ thảo chủ yếu có ở Tứ Xuyên, Thanh Hải, Quý Châu và Vân Nam. Vị ngọt và tính ôn. Bổ phế thận, cầm máu, hóa đàm v.v.

HÌNH 144



Hình vẽ nét một con đỉa: thân dẹt, thuôn dài, uốn cong như dấu phẩy, trên mặt có những đường vân ngang xếp sít nhau.

HÌNH 145

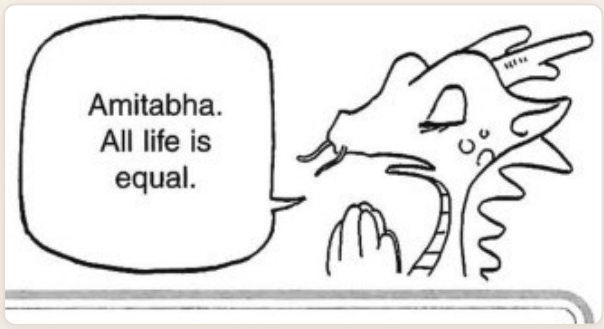


Hình vẽ nét một vỏ nghêu nhìn nghiêng, dạng đĩa bầu dục rộng với những đường gờ sinh trưởng đồng tâm, bên dưới bên trái có vài mảnh vỏ vụn nhỏ.

HÌNH 146

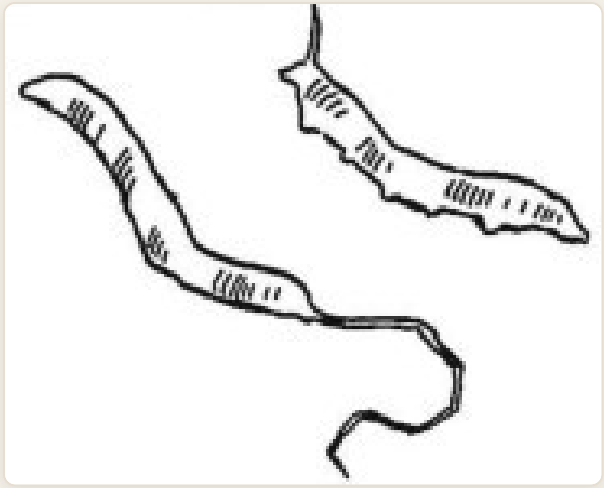
Hình vẽ nét một con tằm nhìn nghiêng, thân non nhẵn chia đốt với phần đầu hơi nhô lên ở phía bên phải.

HÌNH 147



Một chú rồng hoạt hình với vẻ mặt dịu dàng, cúi nhìn xuống, hai bàn tay có móng chắp lại, bên cạnh là bong bóng hội thoại ghi "Amitabha. All life is equal."

HÌNH 148



Hình vẽ nét hai mẫu đông trùng hạ thảo: một cuống mảnh mọc ra từ thân con sâu, một mẫu uốn cong như cái móc còn mẫu kia cong về phía bên phải, dọc thân có những nét chải mảnh.

TRANG SÁCH 67 · SCAN P076

Khoáng vật

Khoáng vật

Khoáng vật là những vật liệu lấy từ tự nhiên, mang các tính chất hóa học. Vào thời cổ, khoáng vật cũng được dùng để làm thuốc viên. Thực tế, khoáng vật chiếm một phần khá lớn trong Đông y.

Một số ví dụ về khoáng vật dùng trong Đông y

Thạch cao: Vị ngọt và cay. Tính hàn. Thanh nhiệt tả hỏa, giải khát.

Hùng hoàng: Vị cay, tính ôn và có độc. Giải độc, sát trùng, đặc biệt hiệu quả trong việc vô hiệu hóa nọc rắn độc và côn trùng cắn. Thời xưa, người ta uống rượu pha hùng hoàng trong dịp Tết Đoan Ngọ.

Vân mẫu: Vị ngọt. Tính không ôn cũng không hàn. Bổ thận và làm dịu các triệu chứng hen, cầm máu và chữa nhiễm trùng. Dùng để chữa phế lao và thận hư, hen suyễn và ho hen, chóng mặt, sốc, mụn nhọt sưng viêm.

Mảnh hóa thạch (long cốt): Hóa thạch còn lại của các loài động vật thời tiền sử. Vị đắng ngọt và tính không ôn cũng không hàn. An thần, cố sáp (cầm thoát). Dùng để chữa tâm thần bất an, mất ngủ do lo lắng, tiêu chảy, di tinh v.v.

Tính chất và công năng của thuốc Đông y

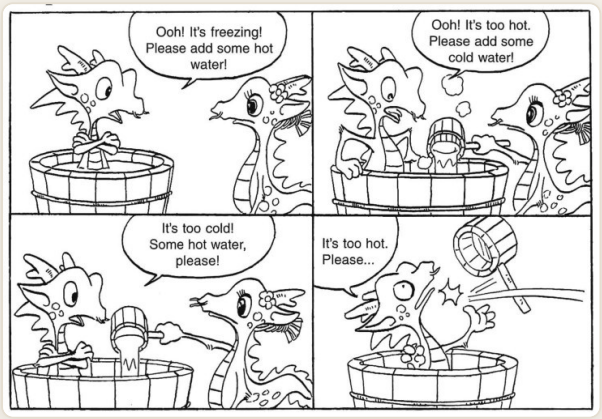
Tính chất và công năng của thuốc Đông y

Tứ khí:

- - **Hàn, lương (lạnh, mát)** — Thanh nhiệt, tả hỏa, giải độc
- - **Ôn, nhiệt (ấm, nóng)** — Ôn trung tán hàn, trợ dương

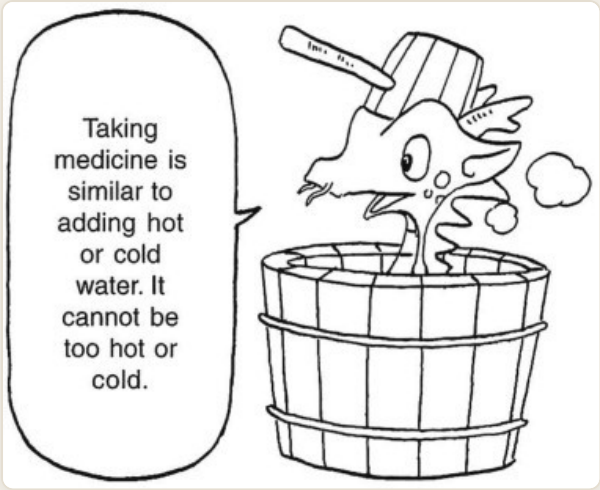
Việc chữa các bệnh thuộc chứng nhiệt dùng những vị thuốc có tính hàn và lương. Ngược lại, những vị thuốc có tính ôn và nhiệt được dùng để chữa các bệnh thuộc chứng hàn. Ở đây vận dụng nguyên lý cân bằng âm dương. Những vị thuốc không mạnh lắm được gọi là thuốc có tính bình. Những vị thuốc này dùng để chữa các bệnh thuộc cả chứng nhiệt lẫn chứng hàn.

HÌNH 149



Một truyện tranh bốn khung, xếp thành hai hàng, mỗi hàng hai khung. Ở mỗi khung, một chú rồng nhỏ ngồi trong chậu gỗ đựng nước, bên cạnh có một chú rồng thứ hai đứng hầu; ở khung thứ nhất và khung thứ ba, chú rồng đang tắm run rẩy xin thêm nước nóng, còn ở khung thứ hai và khung thứ tư thì mặt đỏ bừng vì quá nóng và xin thêm nước lạnh.

HÌNH 150



Một chú rồng hoạt hình ngồi trong chậu gỗ, vẻ mặt giật mình khi nước từ chiếc gàu gỗ trên đòn gánh được đổ xuống đầu, bên cạnh là một bong bóng hội thoại cao, giải thích rằng uống thuốc cũng giống như pha thêm nước nóng hay nước lạnh — không được quá nóng cũng không được quá lạnh.

TRANG SÁCH 69 · SCAN P078

Trang 69

Ngũ vị:

Toan (chua)	Cam (ngọt)	Khổ (đắng)	Tân (cay)	Hàm (mặn)
Cầm thoát, có tác dụng thu liễm.	Bồi bổ cơ thể, điều hòa âm dương, giảm đau.	Tả nhiệt, táo thấp, kiên âm, giáng hỏa.	Tán nội nhiệt, thúc đẩy tuần hoàn khí huyết.	Nhuận táo, có tác dụng nhuận hạ.

Khuynh hướng và vị trí:

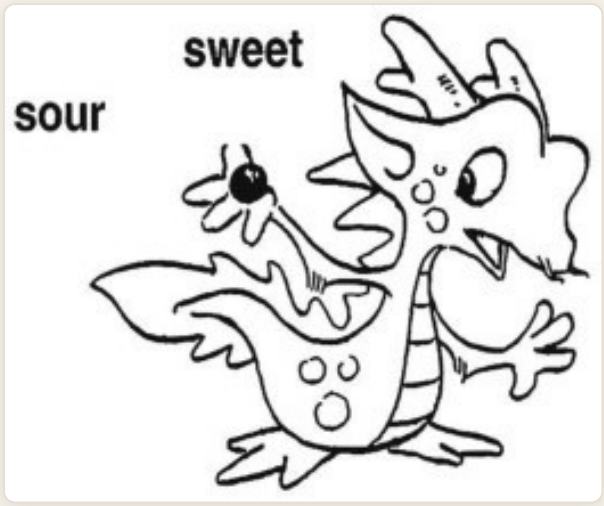
Điều này nói về vị trí và khuynh hướng tác dụng của vị thuốc trong cơ thể người. Có thể chia thành hai nhóm:

- - **Thăng (đi lên)** — trợ dương, phát tán nhiệt ở biểu của chứng biểu, tán hàn, gây nôn.
- - **Giáng (đi xuống)** — giảm nhiệt bên trong, nhuận hạ, lợi tiểu, trấn viêm.

Bệnh có thể tác động lên phần trên, phần dưới, phần biểu hoặc phần lý của cơ thể người. Bệnh có thể được nhận định là thăng, giáng, biểu hay lý về bản chất. Do đó, việc chữa bệnh phải phù

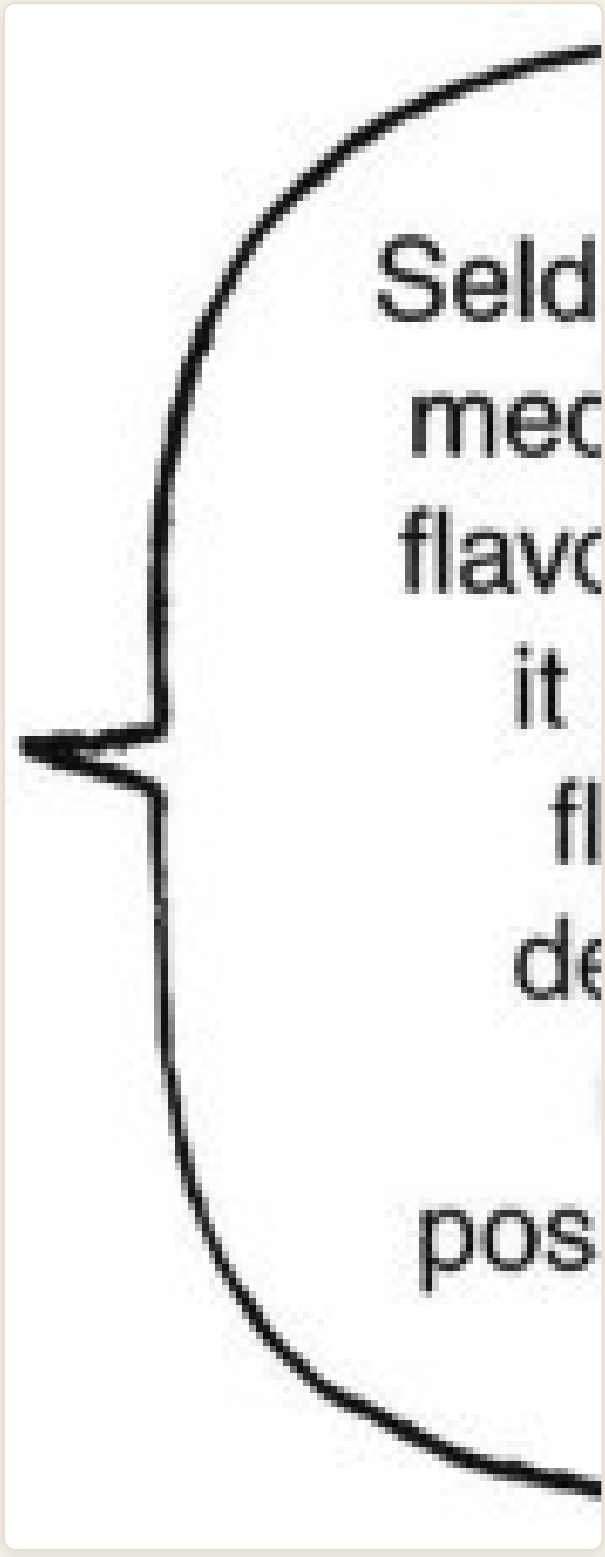
hợp với bản chất của bệnh. Ví dụ, một bệnh nhân nôn mửa và ho là đang mắc bệnh tác động lên phần trên cơ thể và mang tính biểu. Vì vậy, vị thuốc được kê sẽ có tính giáng.

HÌNH 151



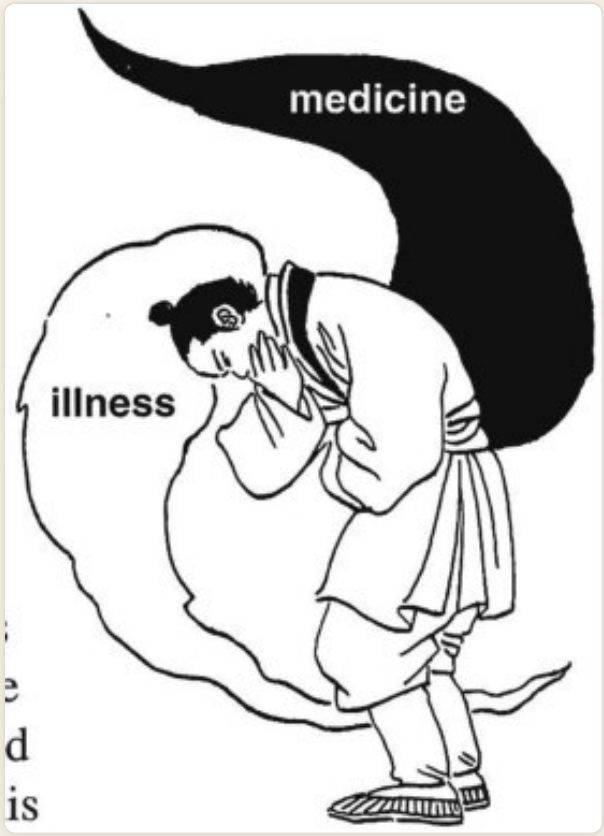
Một chú rồng hoạt hình đang nếm thử: nó giơ lên một quả tròn nhỏ sẫm màu có cuống, liếm môi và tỏ vẻ thích thú, phía trên có chữ "sweet" và bên trái có chữ "sour".

HÌNH 152



Một bong bóng hội thoại cao và hẹp, được cắt sát, mang lời giải thích rằng hiếm khi một vị thuốc chỉ thuộc một vị duy nhất mà thường mang vài vị ở các mức độ khác nhau.

HÌNH 153



Một người đàn ông mặc áo dài truyền thống và đội mũ của kẻ sĩ, đứng với hai tay đưa lên mặt và cúi đầu, xung quanh là một vệt mờ nhạt hình đám mây có ghi chữ "illness", trong khi một nét cọ đen đậm, lớn, ghi chữ "medicine" quét xuống trùm lên ông từ phía trên.

TRANG SÁCH 70 · SCAN P079

Trang 70

Phân loại thuốc theo kinh lạc:

Bệnh thường phát sinh ở những kinh lạc và tạng phủ khác nhau. Các vị thuốc khác nhau có tác dụng khác nhau trên từng tạng phủ và kinh lạc. Cùng một vị thuốc có tác dụng với một bệnh nào đó lại có thể không hiệu quả với một bệnh khác.

Ví dụ, ma hoàng có hiệu quả với các bệnh thuộc phế kinh nhưng không có tác dụng với can kinh; chu sa tác dụng trên tâm kinh nhưng không tác dụng trên tỳ kinh.

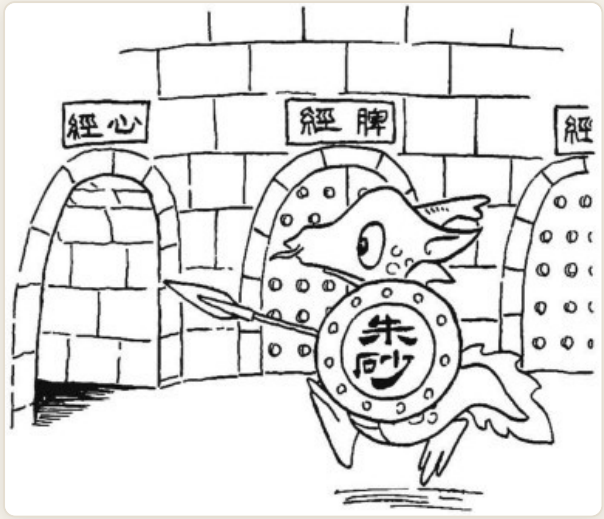
Độc tính

Thuốc có hai mặt. Một mặt, chúng chữa bệnh và có lợi cho cơ thể người; mặt khác, chúng có độc tính ở một mức độ nhất định. Nếu dùng không đúng cách, chúng sẽ gây hại cho cơ thể người.

Trong Đông y, người ta phát huy lợi ích của vị thuốc đồng thời giảm độc tính và tác hại của nó đối với cơ thể người xuống mức tối thiểu. Trong các sách dược học Đông y, mỗi vị thuốc đều được ghi rõ là có độc, không độc, rất độc hoặc hơi độc.

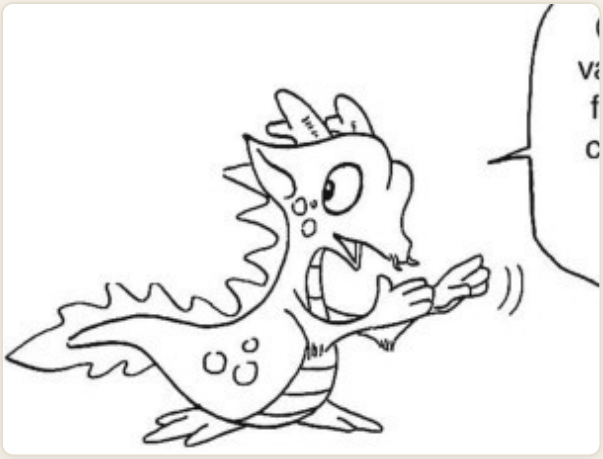
Những vị thuốc rất độc là thạch tín, ba đậu v.v.; những vị thuốc hơi độc là khiên ngưu tử, hạnh nhân đắng; những vị thuốc không độc là phục linh và cam thảo.

HÌNH 154



Một nhân vật hoạt hình một tay cầm giáo, tay kia cầm chiếc khiên tròn có khắc chữ chỉ vị chu sa, đang xông về phía một bức tường đá có ba cửa vòm; phía trên các cửa vòm treo những tấm biển ghi "tâm kinh", "tỳ kinh" và "kinh".

HÌNH 155



Một chú rồng hoạt hình giơ một bàn chân có móng lên và há miệng nói, bên cạnh là một bong bóng hội thoại nhắc rằng thuốc Đông y có nhiều tính chất và công năng khác nhau, tốt nhất nên hỏi ý kiến thầy thuốc Đông y trước khi dùng.

TRANG SÁCH 71 · SCAN P080

Bào chế một bài thuốc

Bào chế một bài thuốc

Sự kết hợp của các vị thuốc được gọi là một bài thuốc. Bài thuốc kết hợp những tính chất khác nhau của các vị thuốc nhằm tăng hiệu quả của nó. Ngoài ra, nó còn có tác dụng điều hòa một số tác dụng phụ của những vị thuốc được dùng trong bài và phát huy hiệu quả của bài thuốc.

Những điều kiêng kỵ khi bào chế bài thuốc:

Một số vị thuốc không thể phối hợp với nhau vì có thể trở nên độc hoặc làm giảm hiệu quả của bài thuốc. Trong Đông y, những điều kiêng kỵ khi bào chế bài thuốc được gọi là Thập bát phản (18 vị thuốc xung khắc) và Thập cửu úy (19 vị thuốc kỵ nhau).

Thập bát phản (18 vị thuốc xung khắc):

- - Ô đầu (*wutou*) xung khắc với bối mẫu, qua lâu, bán hạ, *baijian*, bạch cập;
- - cam thảo xung khắc với *gansui*, *dajian*, hải tảo, hoa nguyên hoa;
- - *lihui* xung khắc với nhân sâm, *shashen*, *danshen*, *xuanshen*, *xixin*, rễ thược dược.

Thập cửu úy (19 vị thuốc kỵ nhau):

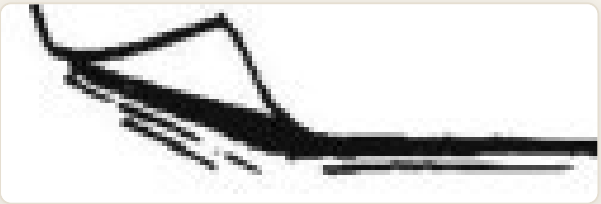
- - Lưu huỳnh kỵ cây phác (Chinese hackberry); bạc kỵ thạch tín;

- - *langdu* kỵ hoàng đan (yellow lead); ba đậu kỵ khiên ngưu tử; đinh hương kỵ uất kim;
- - diêm tiêu kỵ *jingsanling*; *chuanwu* và thảo ô kỵ sừng tê giác; nhân sâm kỵ *wulingzhi*; quế kỵ *shizhi*.

HÌNH 156

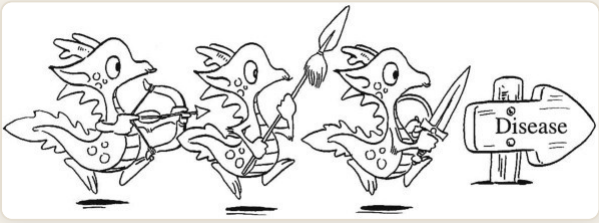
Hình vẽ nét một bó dược liệu khô nằm trên một tờ giấy: những thanh vỏ cây dẹt, một nắm lá và thân khô, những quả tròn và những hạt có sọc xếp thành đống.

HÌNH 157



Một mảnh cắt nhỏ cho thấy đầu nhọn sẫm màu hình cái nêm của tấm biển hình mũi tên cùng những đường kẻ mặt đất bên dưới.

HÌNH 158



Ba chú rồng hoạt hình xông lên phía trước thành một hàng: một chú giương cung, một chú vác cờ trên cây sào dài và một chú cầm gươm cùng khiên, lao về phía tấm biển hình mũi tên cắm xuống đất, trên biển ghi chữ "Disease".

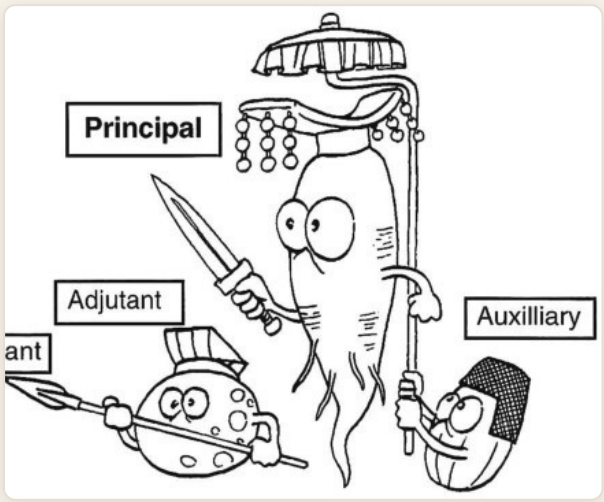
Nguyên tắc xây dựng một bài thuốc

Nguyên tắc xây dựng một bài thuốc

Một bài thuốc được tạo nên dựa trên nhiều nguyên tắc:

- - **Thành phần quân (chủ dược):** Có tác dụng điều trị chính.
- - **Thành phần thần (phụ dược):** Tăng cường tác dụng của vị quân.
- - **Thành phần tá (tá dược):** Điều hòa tác dụng của các vị chính, nhờ đó giảm bớt và ngăn ngừa tác dụng phụ.
- - **Thành phần sứ (sứ dược):** Dẫn tác dụng của các vị thuốc đến kinh lạc hoặc vị trí bị bệnh.

HÌNH 159



Bốn vị thuốc được vẽ hoạt hình như những chiến binh nhỏ xếp hàng ra trận: ở giữa là một cây hành lá cao lớn vung dao găm và cầm cây gậy dài, có ghi nhãn "Principal"; bên trái nó là một củ tròn có sọc cầm ngọn giáo, ghi nhãn "Adjutant"; tận cùng bên trái là một nhân vật nhỏ như cây nấm cầm giáo, ghi nhãn "Conductant"; còn bên phải là một củ nhỏ đội chiếc mũ sẫm có hoa văn và cầm cây gậy, ghi nhãn "Auxiliary".

HÌNH 160

Một chú rồng hoạt hình một bàn chân cầm chiếc quạt xếp đang mở, bàn chân kia chỉ tay, bên cạnh là một bong bóng hội thoại cảnh báo rằng nếu việc bào chế bài thuốc không theo đúng các nguyên tắc trên thì phương thuốc sẽ trở nên vô hiệu.

TRANG SÁCH 73 · SCAN P082

Tám phép trị liệu chính

Tám phép trị liệu chính

Phát hãn (汗法 — làm ra mồ hôi)

Bằng cách làm cho người bệnh ra mồ hôi, các tà khí (邪氣 — nguyên nhân gây bệnh) bị đẩy ra khỏi cơ thể. Phép này thường được dùng để chữa các bệnh do ngoại tà gây ra, như cảm lạnh và sốt.

Thổ pháp (吐法 — gây nôn)

Gây nôn cho người bệnh. Phép này dùng để chữa chứng ăn quá nhiều, khó tiêu, ngộ độc thức ăn hoặc đờm ứ đọng.

Hạ pháp (下法 — gây tiêu chảy)

Dùng thuốc nhuận tràng để làm thông sự ứ trệ trong ruột và làm dịu chứng táo bón hoặc kiết lỵ.

Hòa pháp (和法 — điều hòa)

Khi không nên dùng phép phát hãn và hạ pháp, người ta dùng phép này để chữa những bệnh do tà khí ở nửa trong nửa ngoài (bán biểu bán lý). Ví dụ như ăn kém ngon, đau đầu và chóng mặt, khát nước và miệng đắng, v.v.

TRANG SÁCH 74 · SCAN P083

Trang 74

Ôn pháp (溫法 — phép làm ấm)

Loại bỏ hàn (lạnh) và khôi phục dương khí trong cơ thể. Phép này chủ yếu dùng để chữa các chứng âm và hàn. Có hai loại: hồi dương (khôi phục dương đã mất) và khu hàn (trừ hàn).

Thanh pháp (清法 — phép làm mát)

Dùng những vị thuốc có tính hàn, mát để làm giảm nhiệt. Phép này chữa các bệnh thuộc chứng nhiệt, như sốt, bồn chồn, ngất xỉu, v.v.

Tiêu pháp (消法 — phép làm tiêu)

Chữa chứng ứ trệ thức ăn, hóa đờm, giảm sưng, v.v.

Bổ pháp (補法 — phép bồi bổ)

Bồi bổ âm, dương, khí và huyết; tăng cường thể chất. Có bốn cách: bổ khí, bổ huyết, bổ âm và bổ dương.

TRANG SÁCH 75 · SCAN P084

Các dạng bào chế của y học cổ truyền Trung Hoa

Các dạng bào chế của y học cổ truyền Trung Hoa

Y học cổ truyền Trung Hoa có nhiều dạng khác nhau: thuốc sắc (thang dược), thuốc hoàn, cao dược và rượu thuốc.

Thuốc sắc

Đây là dạng phổ biến nhất để chữa các bệnh cấp tính. Dược liệu được sắc thành nước rồi gạn bỏ bã. Thuốc được cơ thể hấp thu nhanh hơn nên cho tác dụng nhanh hơn.

Thuốc hoàn

Dược liệu được tán thành bột, thêm nước hoặc mật ong rồi viên thành những viên tròn. Dạng này cần nhiều thời gian hơn mới thấy hiệu quả và được dùng trong thời gian dài. Rất thích hợp cho bệnh mạn tính và cơ thể suy nhược lâu ngày.

Thuốc bột

Dược liệu được tán thành bột. Bột được uống với nước để hấp thu nhanh hơn, hoặc dùng để bôi ngoài. Thuốc cũng được bôi vào cổ họng và mắt. Thích hợp cho các bệnh cấp tính.

Cao dược

Dược liệu được sắc cho đến khi đặc lại thành dạng sền sệt như thạch, có thể uống hoặc bôi ngoài. Rất thích hợp cho bệnh mạn tính hoặc để bồi bổ cơ thể. Khi bôi ngoài, người ta thường dán giấy tẩm dầu hoặc cao dán lên trên lớp cao để chữa nhọt, chai chân hoặc phong thấp.

Rượu thuốc

Dược liệu được ngâm trong rượu rồi gạn bỏ bã. Thuốc được cơ thể hấp thu nhanh và phát huy tác dụng mau chóng. Thường dùng để chữa đau nhức phong thấp và các vết thương do ngã hoặc bị đánh.

TRANG SÁCH 76 · SCAN P085

Cách sắc thuốc

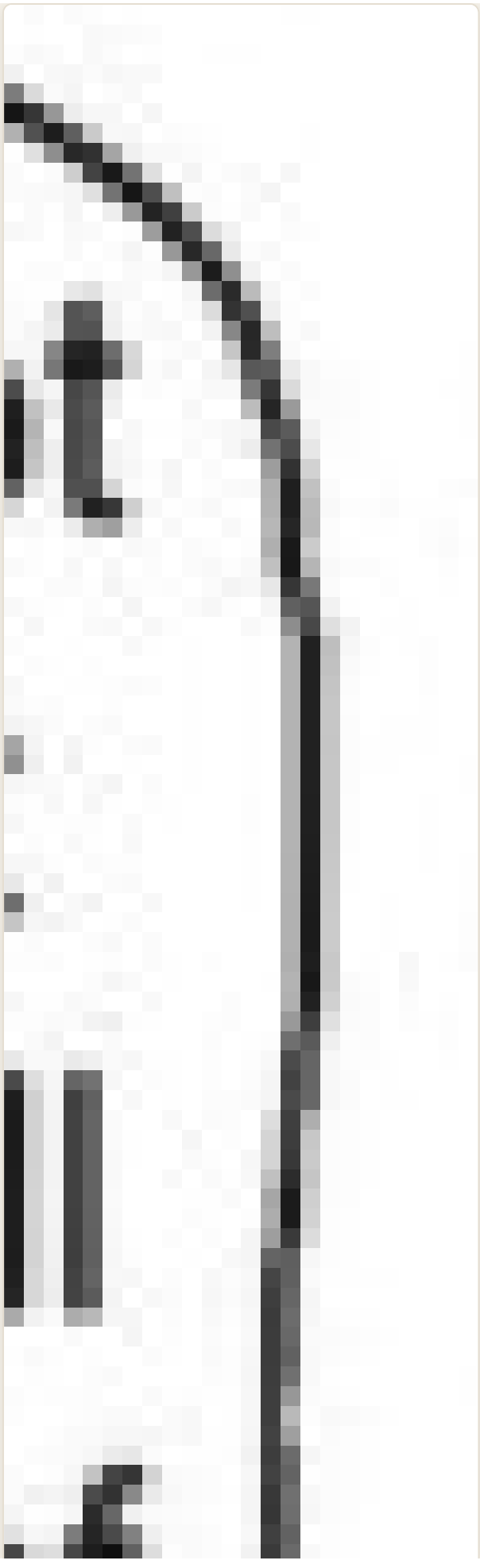
Cách sắc thuốc

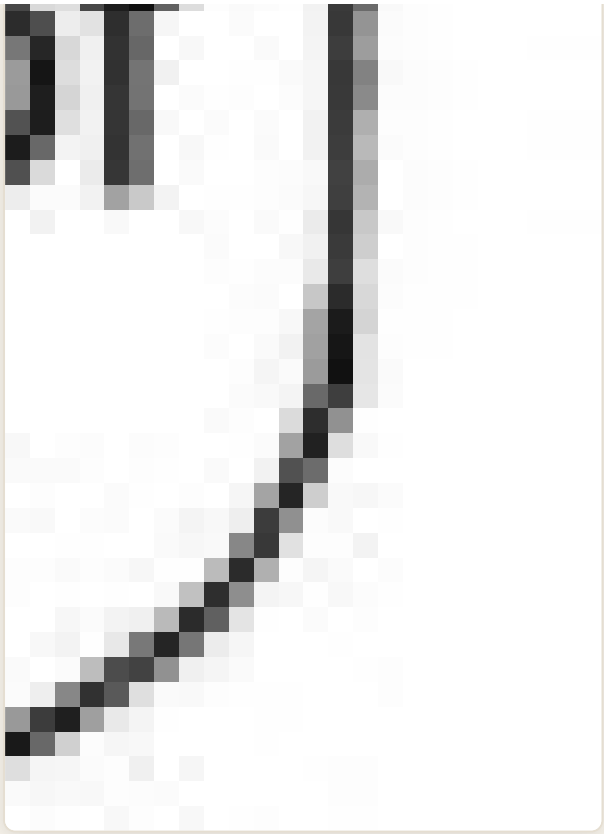
Sắc thuốc không đơn giản như ta tưởng. Nếu làm không đúng cách, việc sắc thuốc sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của bài thuốc.

HÌNH 161

Hình vẽ nét một chiếc nồi sắc thuốc bằng gốm, bụng tròn, nhìn nghiêng: miệng nồi có vành, một vòi ngắn nhô ra bên trái và một quai nhỏ hình vành khuyên ở vai nồi bên phải; bên cạnh có nhãn in "Pot".

HÌNH 162





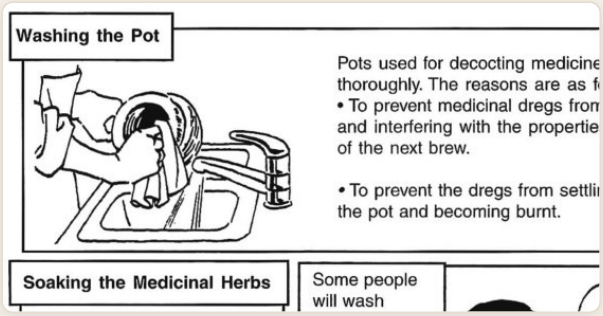
Một mảnh cắt hẹp theo chiều dọc: phần viền cong bên trái của một bong bóng hội thoại, bên trong còn thấy phần đuôi bị cắt của vài chữ.

HÌNH 163

Một chú rồng hoạt hình đứng trên một chân, một tay chỉ lên trên và tay kia nâng chiếc bát nông đựng thuốc sẫm màu; phía trên đầu chú thoáng thấy đuôi của một bong bóng hội thoại.

Nồi sắc thuốc tốt nhất là loại làm bằng gốm sứ, vì chúng không phản ứng hóa học với dược liệu. Do gốm dẫn nhiệt chậm nên thuốc không bị cháy và không dính đáy nồi. Nồi thép không gỉ và nồi thủy tinh cũng dùng được. Nhưng phải tránh dùng nồi bằng đồng, nhôm và sắt. Những nồi kim loại này sẽ phản ứng hóa học với dược liệu, làm giảm hiệu quả của thuốc. Chúng thậm chí có thể gây ra tác dụng phụ!

HÌNH 164

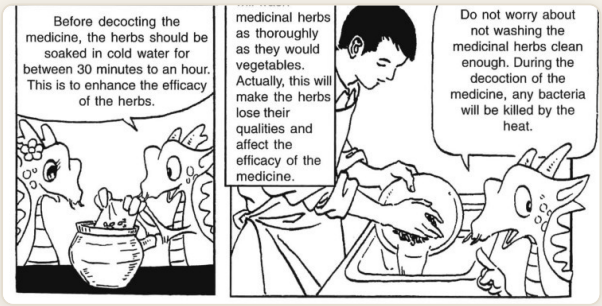


Một khung tranh vẽ nét có tiêu đề "Washing the Pot": một người phụ nữ đứng bên bồn rửa, hai tay giữ chiếc nồi dưới vòi nước đang chảy và dùng khăn cọ bên trong nồi; bên cạnh là một chiếc đĩa và giá úp bát trên mặt bàn.

Nồi dùng để sắc thuốc phải được rửa thật sạch. Lý do như sau:

- - Để tránh bã thuốc còn đọng lại trong nồi, gây ảnh hưởng đến tính chất và hiệu quả của thang thuốc sắc lần sau.
- - Để tránh bã thuốc lắng xuống đáy nồi và bị cháy khét.

HÌNH 165



Một khung tranh vẽ nét có tiêu đề "Soaking the Medicinal Herbs": bên trái, hai chú rồng hoạt hình đang nhìn một chiếc nồi đậy nắp có dược liệu đang ngâm; bên phải, một người đàn ông đứng bên chậu, rửa một nắm dược liệu dưới vòi nước chảy, trong khi một chú rồng thứ ba đứng nhìn.

Trước khi sắc thuốc, dược liệu nên được ngâm trong nước lạnh từ 30 phút đến một giờ. Việc này nhằm tăng hiệu lực của dược liệu.

Một số người rửa dược liệu kỹ như rửa rau. Thực ra, làm vậy sẽ khiến dược liệu mất đi phẩm chất và làm giảm hiệu quả của thuốc.

Đừng lo nếu dược liệu chưa được rửa thật sạch. Trong quá trình sắc thuốc, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt bởi sức nóng.

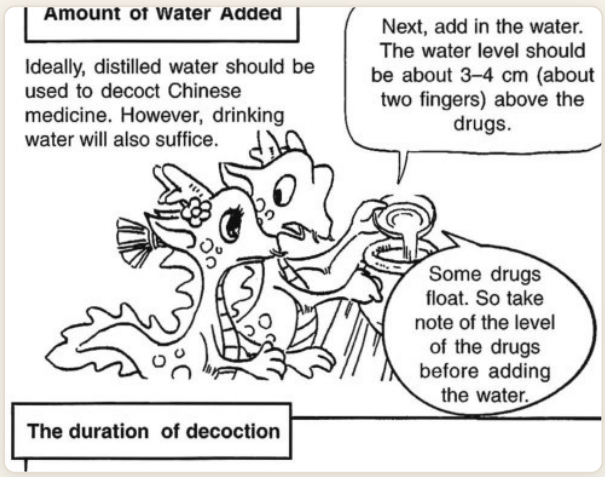
TRANG SÁCH 77 · SCAN P086

Trang 77

Lượng nước cho vào

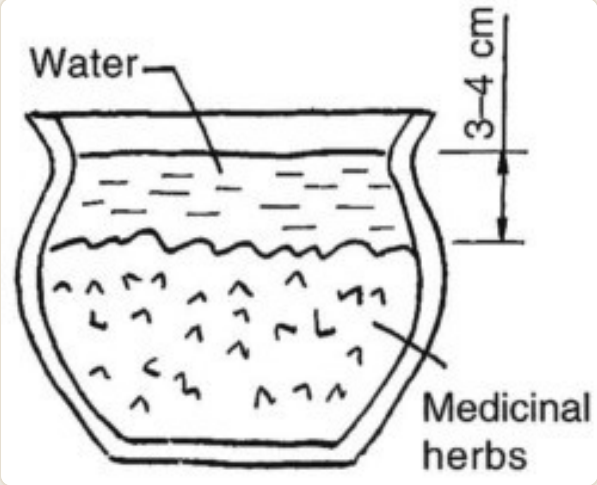
Tốt nhất nên dùng nước cất để sắc thuốc Đông y. Tuy nhiên, nước uống thường cũng đủ dùng.

HÌNH 166



Khung truyện có tiêu đề "Amount of Water Added": hai chú rồng hoạt hình ngồi bên chiếc nồi sắc thuốc, một chú đang rót nước từ chiếc ca nhỏ vào nồi; phía trên có hai bong bóng hội thoại, một bong bóng nhắc rót thêm nước, bong bóng kia lưu ý rằng một số vị thuốc sẽ nổi lên.

HÌNH 167



Sơ đồ mặt cắt của chiếc nồi: một đường gợn sóng đánh dấu mặt nước, ghi nhãn "Water"; lớp dược liệu nằm bên dưới, ghi nhãn "Medicinal herbs"; và một dấu ngoặc bên phải cho thấy mực nước cao hơn dược liệu 3–4 cm.

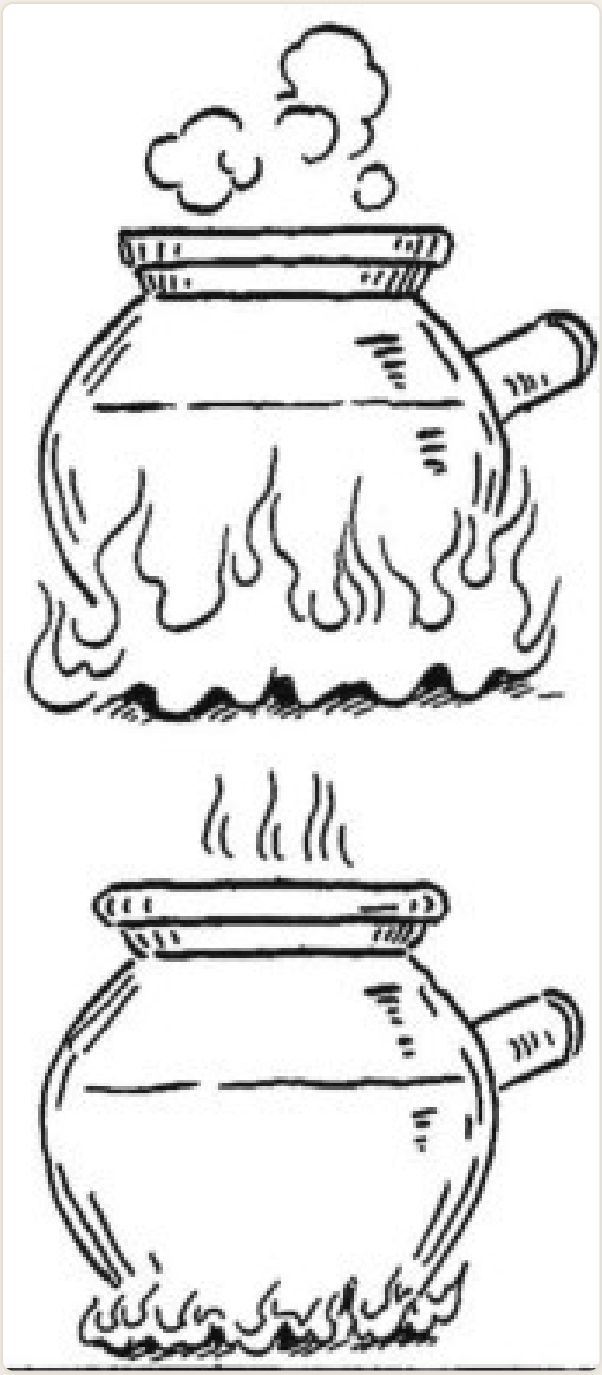
Tiếp theo, cho nước vào. Mực nước nên cao hơn dược liệu khoảng 3–4 cm (chừng hai đốt ngón tay). Một số vị thuốc nổi lên trên mặt nước, nên hãy để ý mức dược liệu trước khi cho nước vào.

Thời gian sắc thuốc

Thông thường, người ta dùng lửa lớn để đun sôi nước rồi hạ xuống lửa nhỏ để sắc thuốc. Các vị thuốc bổ phải được sắc bằng lửa nhỏ.

Hầu hết các vị thuốc Đông y nên được sắc ít nhất hai lần. Chỉ khi đó các hoạt chất mới được chiết xuất hoàn toàn ra khỏi dược liệu.

HÌNH 168

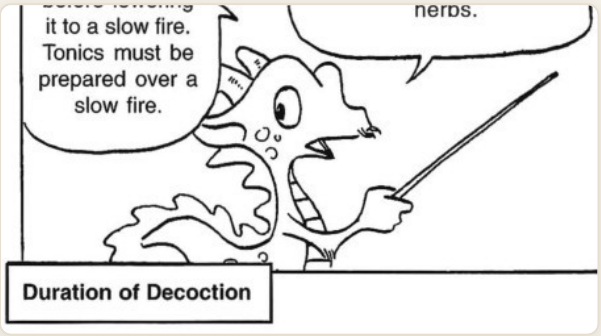


Hai hình vẽ nét chiếc nồi sắc thuốc có nắp, xếp chồng lên nhau: nồi trên nằm giữa ngọn lửa lớn bùng lên và tỏa ra nhiều hơi nước, còn nồi dưới nằm trên ngọn lửa nhỏ liu riu với chỉ vài làn hơi mỏng.

HÌNH 169

Một mảnh cắt nhỏ: phần viền cong phía trên của một bong bóng hội thoại, bên dưới là phần đầu của một dòng chữ.

HÌNH 170



Một chú rồng hoạt hình cầm cây que dài chỉ về phía các hình vẽ chiếc nồi, bên cạnh là một bong bóng hội thoại và một ô nhãn nhỏ ghi "Duration of Decoction" ở bên dưới.

HÌNH 171

Một chú rồng hoạt hình há miệng, hai tay giơ lên như đang nói.

Thời gian sắc thuốc tùy thuộc vào loại thuốc được dùng và mục đích chữa bệnh của nó.

	Sắc lần một	Sắc lần hai
Thuốc chữa bệnh thông thường	Đun sôi rồi sắc 30 phút	Đun sôi rồi sắc 20 phút
Thuốc để giải biểu nhiệt	Đun sôi rồi sắc 8–10 phút	Đun sôi rồi sắc 5 phút
Thuốc bồi bổ	Đun sôi rồi sắc 60 phút	Đun sôi rồi sắc 30 phút

TRANG SÁCH 78 · SCAN P087

Những điều cần lưu ý khi sắc thuốc

Những điều cần lưu ý khi sắc thuốc

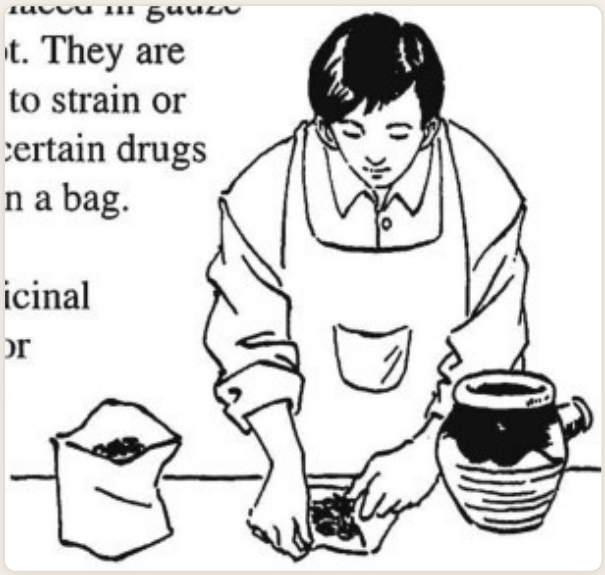
Sắc trước: Một số vị thuốc phải được sắc trước khi cho các vị khác vào. Sắc trước có hai tác dụng:

- - Giúp một số vị thuốc tan ra nhanh hơn. Những vị cần sắc trước thường là khoáng vật, vỏ sò và sừng động vật, vì chúng mất nhiều thời gian mới tan.
- - Giảm độc tính. Một số vị thuốc độc như xuyên ô (*chuanwu*), sinh phụ tử (*shengfuzi*) và thương lục (*shanglu*) phải được sắc ít nhất hai giờ thì độc tính mới bị loại bỏ.

Cho vào sau cùng: Một số vị thuốc như bạc hà, đương quy (*danggui*) và đại hoàng (*dahuang*) dễ mất hiệu lực khi bị đun ở nhiệt độ cao. Vì vậy chúng chỉ được cho vào sau khi các vị thuốc khác đã được đun từ 5 đến 10 phút.

Gói trong túi: Một số vị thuốc phải được gói trong gạc hoặc túi trà trước khi cho vào nồi. Đó thường là những vị có lông, khó gạn hoặc có thể gây khó chịu cho cổ họng. Ngoài ra, một số vị thuốc có thể dính vào nồi nếu không được đựng trong túi.

HÌNH 172



Hình vẽ nét một người phụ nữ đeo tạp dề đứng bên bàn: cô dùng hai tay gói một nắm dược liệu sẫm màu vào túi giấy hoặc túi vải; bên trái cô là một gói dược liệu đã gói xong, bên phải là một chiếc nồi gốm sẫm màu có nắp.

Sắc riêng: Một số vị thuốc quý như nhân sâm, sâm Mỹ hay sừng linh dương được sắc riêng để giữ hiệu lực và ngăn các vị thuốc khác hút mất dược tính của chúng.

Sáu cách tránh để đáy nồi bị cháy khét:

1. Chọn loại nồi dẫn nhiệt đều.

2. Rửa sạch đáy nồi trước khi sắc thuốc.

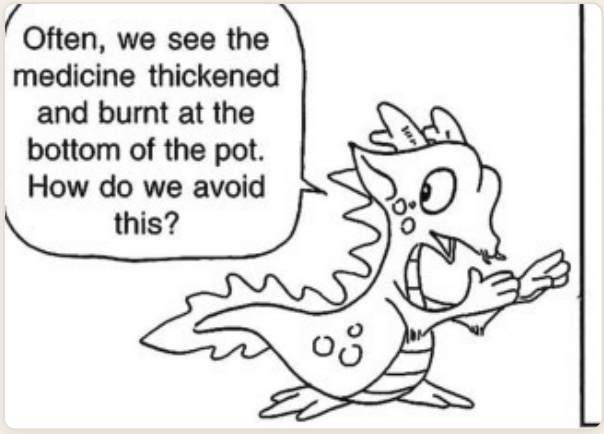
3. Cho những vị thuốc dính hoặc nhiều xơ vào túi trước khi bỏ vào nồi.

4. Sắc thuốc bằng lửa nhỏ và đậy nắp nồi.

5. Bảo đảm cho đủ nước.

6. Khuấy đều hỗn hợp theo từng khoảng thời gian trong khi sắc.

HÌNH 173



Một chú rồng hoạt hình với vẻ mặt giật mình, miệng há ra và hai tay giơ lên, bên cạnh là một bong bóng hội thoại hỏi làm thế nào để tránh thuốc bị đặc lại và cháy khét ở đáy nồi.

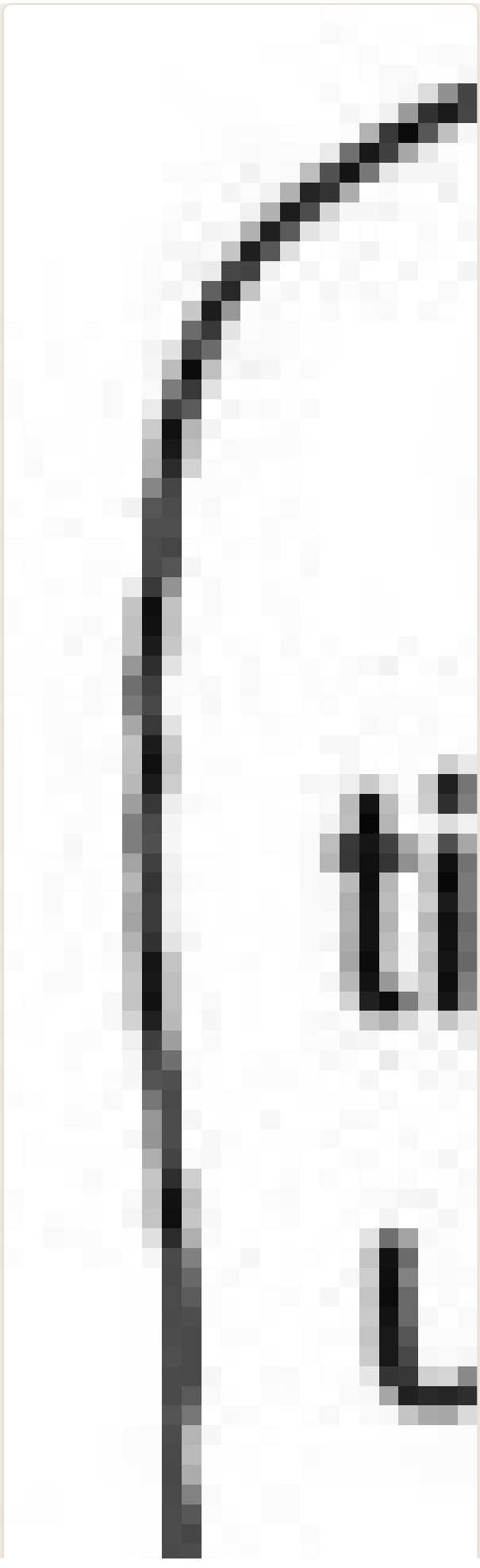
TRANG SÁCH 79 · SCAN P088

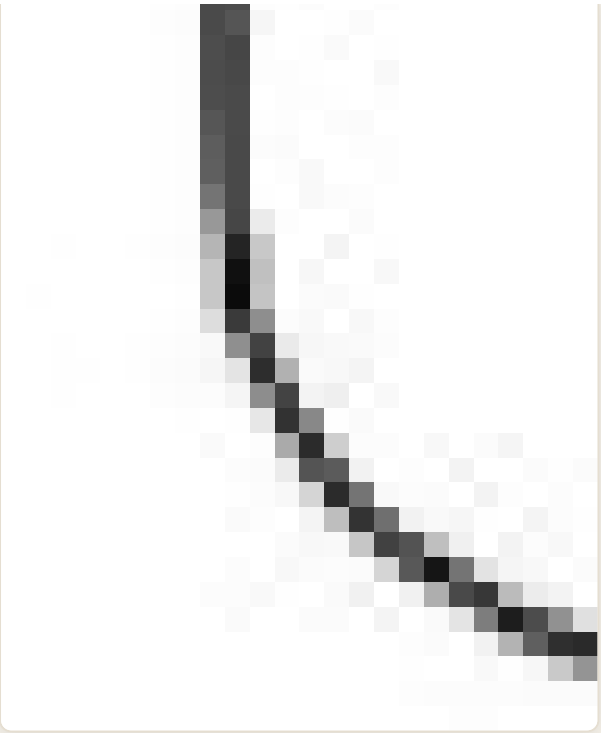
Trang 79

Ôi không! Ta quên canh thời gian rồi. Nước đã cạn khô. Biết làm sao đây? Thêm nước vào vậy!

Không được đâu! Hiệu quả của thang thuốc đã bị phá hỏng rồi. Nồi thuốc này không thể uống được nữa. Phải sắc một nồi thuốc khác.

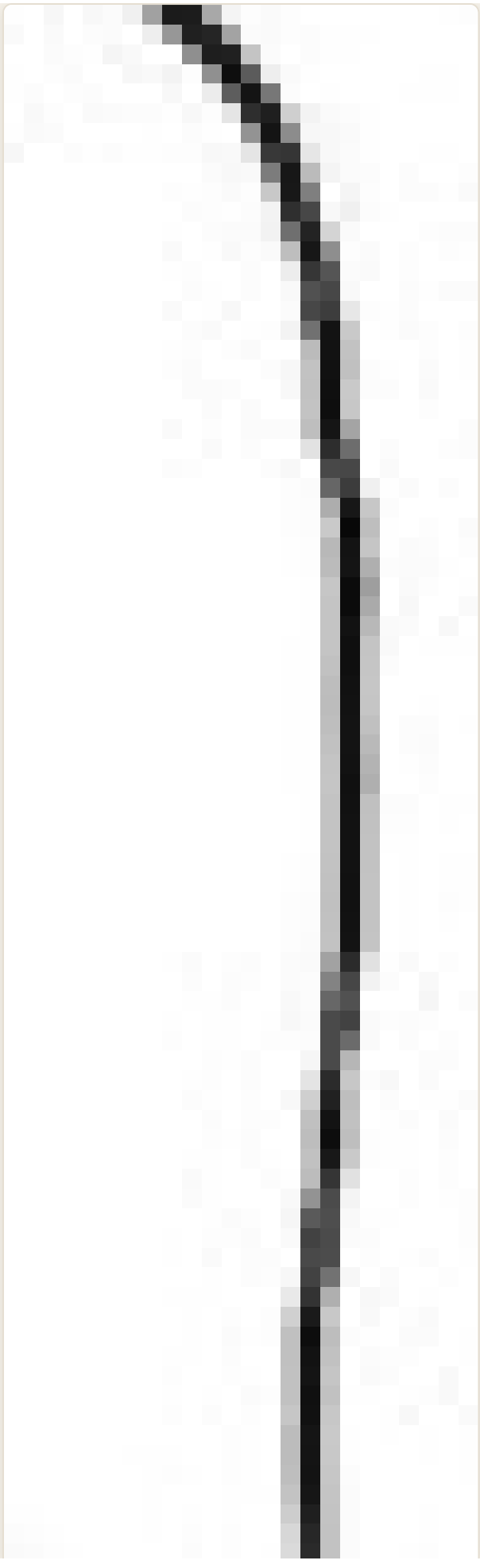
HÌNH 174

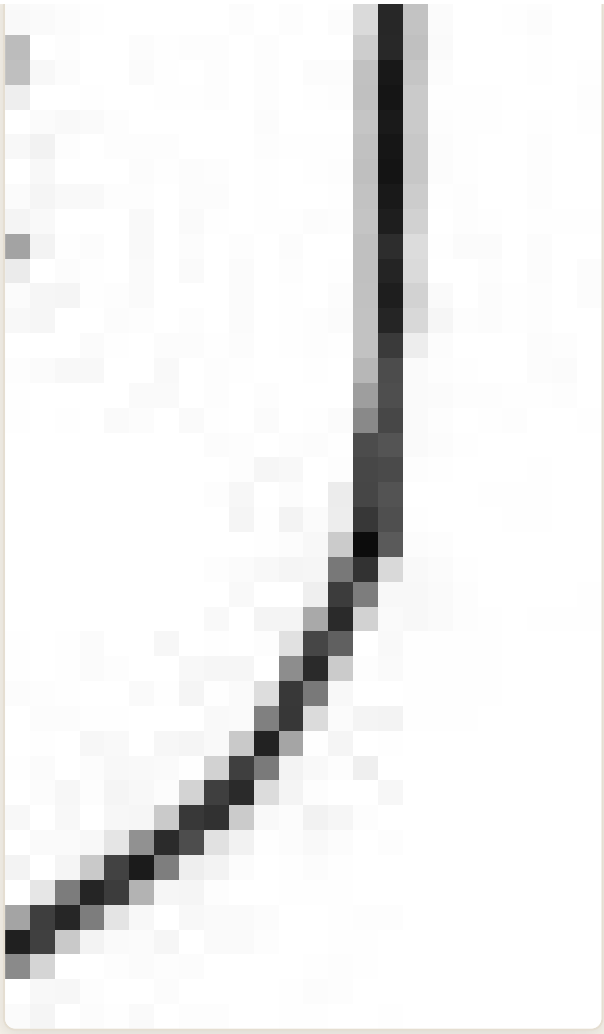




Một mảnh cắt hẹp theo chiều dọc: phần viền cong của một bong bóng hội thoại.

HÌNH 175



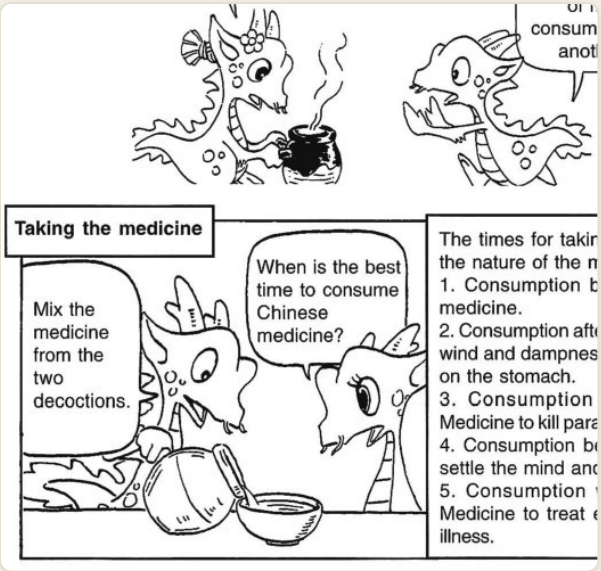


Một mảnh cắt hẹp theo chiều dọc: một đoạn viền cong khác của bong bóng hội thoại.

Cách uống thuốc

Trộn thuốc từ hai lần sắc lại với nhau. Khi nào là thời điểm tốt nhất để uống thuốc Đông y?

HÌNH 176



Khung truyện có tiêu đề "Taking the medicine": hai chú rồng hoạt hình ngồi bên nồi sắc thuốc và chiếc bát, một chú rót thuốc từ nồi vào bát; các bong bóng hội thoại hỏi khi nào là thời điểm tốt nhất để uống thuốc, và một ô liệt kê bên cạnh nêu năm thời điểm uống thuốc.

Thời điểm uống thuốc tùy thuộc vào tính chất của vị thuốc:

1. **Uống trước bữa ăn:** Thuốc bồi bổ.

2. **Uống sau bữa ăn:** Thuốc trừ phong thấp hoặc thuốc mạnh đối với dạ dày.

3. **Uống lúc đói:** Thuốc diệt ký sinh trùng và chữa táo bón.

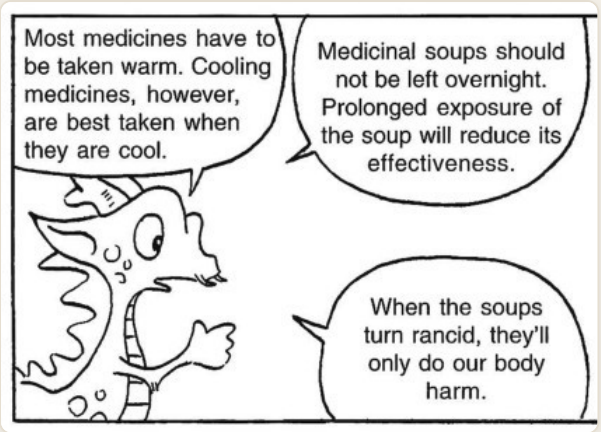
4. **Uống trước khi đi ngủ:** Thuốc an thần và định tâm.

5. **Uống không hạn chế thời gian:** Thuốc chữa chứng biểu hoặc bệnh cấp tính.

Liều lượng

- - **Uống cách quãng:** Mỗi lần uống một liều, mỗi ngày một hoặc hai lần. Cách này phù hợp với các bệnh thông thường. Bệnh mạn tính có thể chỉ cần uống một liều mỗi hai ngày.
- - **Uống một lần:** Uống hết một liều trong một lần. Cách này phù hợp với bệnh cấp tính. Người bệnh nặng có thể uống hai đến ba liều mỗi ngày.
- - **Uống nhiều lần:** Thuốc được uống với liều nhỏ nhưng thường xuyên hơn. Không có thời điểm cố định. Cách này thường dùng cho các bệnh ở cổ họng và khoang miệng.

HÌNH 177



Khung truyện với một chú rồng hoạt hình và ba bong bóng hội thoại: một bong bóng nói rằng hầu hết các vị thuốc phải uống khi còn ấm, còn thuốc tính mát thì tốt nhất nên uống khi đã nguội; bong bóng khác lưu ý không nên để thang thuốc qua đêm, vì để lâu sẽ làm giảm hiệu quả; bong bóng thứ ba nói thêm rằng khi thang thuốc đã ôi thiu thì chỉ gây hại cho cơ thể.

HÌNH 178

Một chú rồng hoạt hình có bông hoa nhỏ trên đầu và gương mặt tươi cười, bên cạnh là bong bóng hội thoại thốt lên rằng có quá nhiều điều phải ghi nhớ chỉ để uống một bát thang thuốc.

Hầu hết các vị thuốc đều phải uống khi còn ấm. Tuy nhiên, thuốc tính mát thì tốt nhất nên uống khi đã nguội.

Không nên để thang thuốc qua đêm. Để thang thuốc tiếp xúc với không khí lâu sẽ làm giảm hiệu quả. Khi thang thuốc ôi thiu, chúng chỉ gây hại cho cơ thể mà thôi.

Oa! Có quá nhiều điều phải ghi nhớ chỉ để uống một bát thang thuốc!

TRANG SÁCH 80 · SCAN P089

Những điều cần lưu ý khi uống thuốc Đông y

Những điều cần lưu ý khi uống thuốc Đông y

Những thứ cần kiêng

Khi đang uống thuốc Đông y, nên tránh ăn đồ sống lạnh, đồ nhiều dầu mỡ và những thức ăn khó tiêu. Điều đó giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và giúp thuốc được hấp thu tốt hơn.

Đồng thời, tránh ăn tỏi, hành và ớt.

Một số vị thuốc Đông y không nên uống cùng trà. Nếu nhất thiết phải uống trà, hãy uống sau khi uống thuốc khoảng hai đến ba giờ. Tuy nhiên, có những vị thuốc Đông y lại phải uống cùng trà. Một ví dụ là xuyên khung (*chuanxiong*).

HÌNH 179

Một dải cắt ngang cho thấy đầu và vai của một chú rồng hoạt hình đang ngó vào từ bên trái, bên cạnh là mép trên bo tròn của một ô chữ có viền chạy suốt phần còn lại của dải.

Thời gian dùng thuốc Đông y

Thuốc Đông y cần nhiều thời gian mới thấy hiệu quả, không tức thời. Thuốc Đông y khác với thuốc Tây vốn có một liệu trình nhất định. Nói chung, thời gian dùng thuốc Đông y tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh, đáp ứng của người bệnh với thuốc và nhiều yếu tố khác. Thời gian này có thể ngắn chỉ vài ngày cho đến dài tới vài năm.

Những vị thuốc cần tránh khi mang thai

Một số vị thuốc Đông y có hại cho thai nhi và có thể gây sảy thai. Tuyệt đối không được dùng chúng khi mang thai. Nói chung, những vị thuốc này có thể được chia thành thuốc cấm dùng và thuốc dùng có chừng mực.

Thuốc cấm dùng: Những vị thuốc độc và mạnh như ba đậu (croton), khiên ngưu tử (pharbitis seed), đại kích (*dajian*), ban miêu (*mylabris*), rễ thương lục (pokeberry root), tam lăng (*sanling*), đỉa, thủy ngân, thạch tín và cam toại (*gansui*) tuyệt đối không được uống.

Thuốc dùng có chừng mực: Những vị thuốc làm thông kinh lạc, làm tiêu vết bầm và khí trệ, cùng các vị thuốc cay nồng, có thể dùng có chừng mực tùy theo thể trạng của thai phụ. Chúng gồm đào nhân (peach kernel), hồng hoa (safflower), chỉ thực (*zhishi*), đại hoàng (*dahuang*), can khương (gừng khô), quế, thường sơn (*changshan*) và củ thiên nam tinh (Jack-in-the-pulpit).

TRANG SÁCH 81 · SCAN P090

Truyền thuyết về nghề bốc thuốc

Truyền thuyết về nghề bốc thuốc

Chúng ta thường thấy những dãy ngăn kéo nhỏ xếp sau quầy ở một hiệu thuốc bắc, nơi người bán hàng lấy thuốc ra cho khách.

Người ta tin rằng tục bốc thuốc này là di sản do Tôn Tư Mạc (Sun Simiao) để lại, vị Dược Vương (藥王) sống vào thời nhà Đường.

Tôn Tư Mạc thường rong ruổi khắp nơi để hành nghề y. Vì phải mang theo rất nhiều loại thuốc bên mình, ông đã may một chiếc tạp dề có nhiều túi để đựng dược liệu.

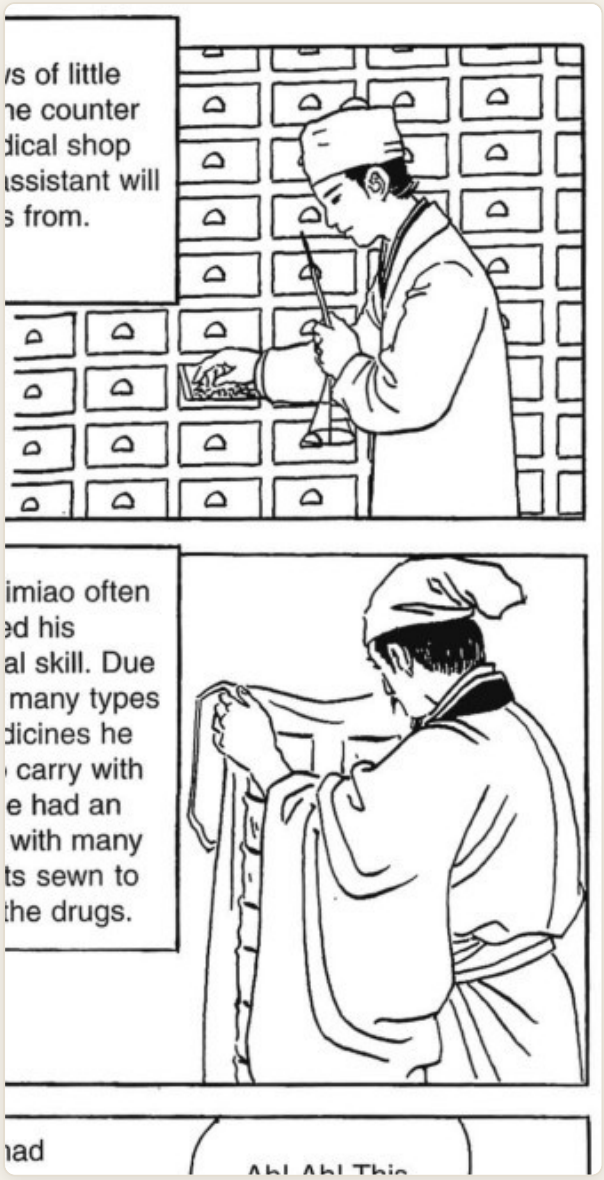
Một hôm, Tôn Tư Mạc đến một ngôi làng nhỏ.

"Hôm nay ta hái được bao nhiêu là thảo dược!"

Ông nhìn thấy một người phụ nữ bị chó cắn.

"Ối! Ối! Đau quá đi mất!"

HÌNH 180



Cột bên phải của truyện tranh, gồm hai khung xếp trên dưới. Khung trên: một người bán thuốc đội mũ vải mềm đứng trước bức tường đầy những ngăn kéo thuốc nhỏ hình vuông, mỗi ngăn có nhãn và tay nắm tròn, đang với tay lấy thuốc. Khung dưới: Tôn Tư Mạc, nhìn từ phía sau, đội mũ vải và mặc áo choàng rộng, đang giơ lên chiếc tạp dề dài được may nhiều túi.

HÌNH 181

Cột bên trái của truyện tranh. Khung trên mang tiêu đề câu chuyện Truyền thuyết về nghề bốc thuốc bên trên chân dung Tôn Tư Mạc, một người đàn ông râu dài đội mũ của kẻ sĩ. Khung dưới: ông đứng nghiêng người, vác chiếc cuốc trên vai, bên cạnh là một ô chữ.

HÌNH 182

Hàng dưới cùng của truyện tranh, gồm hai khung cạnh nhau. Khung trái: Tôn Tư Mạc nghiêng người, đội mũ, nâng niu một nhánh thảo dược vừa hái, bên cạnh có bong bóng hội thoại. Khung phải: ông đứng giữa khoảng trời bên một người phụ nữ ngồi trên đất, tay ôm lấy chân bị thương, một con chó đứng gần đó, phía sau là ngôi nhà và rặng núi thấp; một bong bóng hội thoại bay lên từ phía người phụ nữ.

TRANG SÁCH 82 · SCAN P091

Trang 82

"Để ta bôi thuốc cho cô."

Dược Vương không chậm trễ lấy thuốc ra.

"Cô thấy trong người thế nào?"

"Đã cầm máu rồi. Cũng đỡ đau hơn nhiều."

Vì lượng thuốc dùng cho mỗi thang rất ít, người ta bắt đầu gọi cách lấy thuốc này là "bốc thuốc".

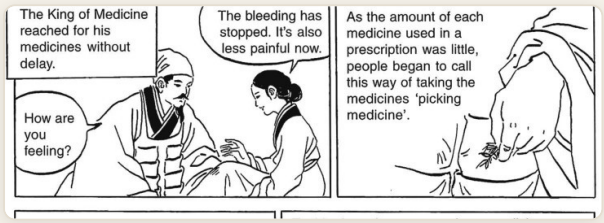
Về sau, để khỏi lẫn lộn giữa muôn vàn loại dược liệu, những người chủ hiệu thuốc đã làm theo cách cất giữ thuốc của Dược Vương: chia thuốc vào từng ngăn nhỏ. Mỗi ngăn ấy lại được chia tiếp thành ba bốn ô nhỏ hơn để đựng các loại thuốc khác nhau.

Cho đến ngày nay, mỗi khi mua thuốc ở hiệu thuốc bắc, người ta vẫn gọi đó là bốc thuốc.

HÌNH 183

Hàng trên của truyện tranh, gồm hai khung cạnh nhau. Khung trái: Dược Vương quỳ trên đất bên một người phụ nữ đang ngồi, bôi thuốc lên chân cho cô, giữa hai người là một ngọn đèn đứng, phía dưới bên phải có một bong bóng hội thoại. Khung phải: cận cảnh ông — một cụ già râu dài đội mũ vải mềm — đang cúi xuống bên chân người phụ nữ, cô ngồi đối diện với ông.

HÌNH 184

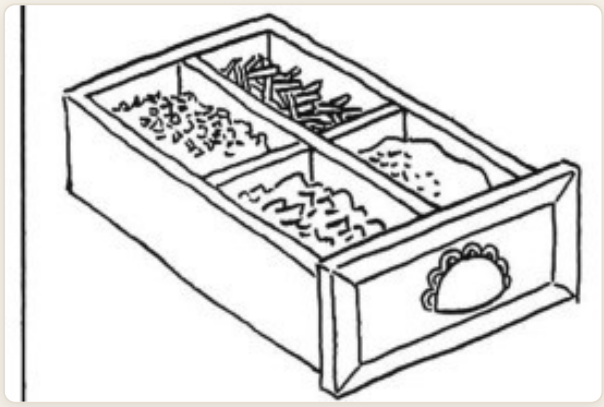


Hàng giữa của truyện tranh. Khung trái: Dược Vương chăm sóc chân cho người phụ nữ, phía trên hai người là hai bong bóng hội thoại, và một ô chữ nhỏ ở góc trên bên trái. Khung phải: một bàn tay thò vào túi vải, nhón ra một nắm thảo dược nhỏ, bên trái là một ô chữ.

HÌNH 185

Khung dưới bên phải: một khách hàng mặc áo khoác, nhìn từ phía sau, đứng ở quầy mua thuốc từ người bán hàng; người bán hàng cầm một gói nhỏ như chiếc lọ trước bức tường đầy ngăn kéo thuốc.

HÌNH 186



Hình nhỏ ở dưới bên trái: một ngăn kéo gỗ mở ra nhìn theo góc nghiêng, bên trong chia thành ba bốn ô nhỏ, mỗi ô đựng một loại dược liệu khác nhau, mặt trước ngăn kéo có một quai kéo bằng đồng.

Đơn thuốc bí mật

Đơn thuốc bí mật

"Này cậu, sao tôi đọc mãi mà không hiểu thầy thuốc viết gì nhỉ?"

"Đơn thuốc của ông ấy là bí mật. Nên ông viết dưới dạng câu đố. Chỉ có chúng ta mới hiểu được ông viết gì."

"Thầy thuốc đâu rồi?"

"Ông ấy ở trong. Xin mời vào."

"Ông ta có vẻ không phải người địa phương."

"Bệnh của ngươi không nặng. Cứ theo đơn thuốc ta kê mà uống."

"Đa tạ! Tôi sẽ bốc đơn này khi về quê."

"Bảo trọng nhé."

"Ôi không!"

"Ta quên nói với anh ấy rằng đơn thuốc này khác với những đơn thường ngày!"

HÌNH 187

Cả trang là một dải truyện tranh. Khung trên bên trái mang tiêu đề câu chuyện Đơn thuốc bí mật bên trên chân dung một thầy thuốc già đội mũ sẫm màu, râu trắng dài, tay cầm bút lông trên một cuốn sách. Khung trên bên phải: hai người đàn ông đứng trước bức tường đầy ngăn kéo thuốc, một người đang băn khoăn nhìn tờ đơn thuốc. Hàng giữa: người thanh niên giải thích rằng đơn thuốc được viết dưới dạng câu đố; một người khách đứng ở cửa hỏi thầy thuốc ở đâu và được cho biết ông ở trong; một người đứng cạnh nhận xét rằng thầy thuốc có vẻ không phải người địa phương. Hàng dưới: thầy thuốc nói với người bệnh rằng bệnh không nặng rồi đưa cho anh ta một tờ đơn; người bệnh đa tạ và hứa sẽ bốc đơn khi về quê; anh ta bước ra khỏi cửa; và cuối cùng thầy thuốc đập tay lên đầu, hoảng hốt khi nhận ra mình quên dặn người bệnh rằng đơn thuốc này khác với những đơn thường ngày.

TRANG SÁCH 84 · SCAN P093

Trang 84

"Đây là vị thuốc gì vậy?"

"Tiệm tôi không có vị này."

"Tôi đã đi mấy hiệu rồi mà ai cũng nói y như vậy."

"Để tôi xem đơn thuốc đã."

"Ha ha! Ta hiểu câu đố này rồi! Để ta viết cho ngươi một đơn khác."

"À, ta hiểu rồi! Đây chính là những vị thuốc ngươi cần. Này cậu, xem đi."

"Chúng ta có đủ cả những vị này."

"Viết đơn thuốc dưới dạng câu đố đúng là một ý hay!"

- * Chín chết một sống - duhuo (rễ độc hoạt), Đạp lên hoa mà về, bướm theo vó ngựa - xiangfu, hai mươi mốt - sanqi (tam thất), Áo cừu nghìn năm - trần bì, mục đồng - qianniuzi (hạt khiên ngưu)

HÌNH 188

Cả trang là một dải truyện tranh. Hàng trên: người bán thuốc đứng sau quầy, vẻ mặt bối rối nói rằng tiệm mình không có vị thuốc này; khung kế tiếp, một khách hàng cùng người bạn đồng hành đứng trước một người chủ hiệu khác, người này xin xem đơn thuốc. Hàng giữa: một bàn tay giơ cao tờ đơn thuốc, trên đó tên các vị thuốc được viết thành cột chữ Hán dọc kèm trọng lượng tính bằng "tiền"; một người đàn ông reo lên rằng mình hiểu câu đố và sẽ viết lại một đơn khác. Hàng dưới: người bán thuốc bày các vị thuốc ra và bảo khách xem thử; một bàn tay đang viết tờ đơn đố mới với tên các vị thuốc cùng trọng lượng; và người khách nhận xét rằng viết đơn thuốc dưới dạng câu đố quả là một ý hay.

TRANG SÁCH 85 · SCAN P094

Bảng các vị thuốc bắc thường dùng

Bảng các vị thuốc bắc thường dùng

Trị chứng biểu (đau đầu, cảm mạo, v.v.):

Ma hoàng, rễ phòng phong (saposhnikova root), gừng tươi, kinh giới (schizonepeta), rễ *lanxiang*, rễ bạch chỉ (dahurian angelica root), bạc hà, lá dâu, hoa cúc, rễ sắn dây (kudzuvine root), rễ

thăng ma (bugbane root).

Thuốc tẩy (thông hạ):

Đại hoàng, mật ong, hạt khiên ngưu tử (pharbitis seed), hoa nguyên hoa (genkwa flower).

Thanh nhiệt tà (trừ nhiệt bệnh lý):

Hoạt thạch (talc), vỏ bào ngư (abalone shell), lô hội, hoa hạ khô thảo (selfheal spike).

Trừ nhiệt trong huyết:

Ngưu hoàng (bezoar), vỏ mẫu đơn (peony bark), rễ tử thảo (gromwell root), rễ bạch mao (baimao root), rễ tử uyển (starwort root).

Giải nhiệt độc:

Hoa kim ngân (honeysuckle), rễ liên kiều (forsythia), bồ công anh (dandelion), bạch hoa xà thiệt thảo (oldenlandia).

Trừ nhiệt:

Đậu xanh, hạt hyacinth, bội lan (eupatorium).

Trừ phong thấp:

Rễ độc hoạt (pubescent angelica root), vỏ ngũ gia bì (acanthopanax bark), quả mộc qua (flowering-quince fruit), quả thương nhĩ tử (cocklebur fruit), *suanpanzi*.

Ôn ấm bên trong:

Củ bạch phụ tử (Typhonium tuber), gừng khô, quế (Chinese cinnamon), đinh hương (clove), quả tiểu hồi (fennel fruit).

Trừ thấp:

Phục linh (poria), hạt mã đề (plaintain seed), vỏ bầu sáp (wax-gourd peel), lõi cây thông thảo (ricepaper-plant pith), kim tiền thảo (loosestrife).

Hóa đàm:

Củ nam tinh (jack-in-the-pulpit tuber), rễ phụ tử (monkshood daughter root), rễ viễn chí (milkwort root), củ bối mẫu (fritillary bulb), hải tảo (seaweed), hải đới (sea tangle).

Trị ho, long đàm và bình suyễn:

Hạt hạnh nhân (apricot kernel), cát cánh (balloonflower), hạt bạch quả (gingko seed), lá tỳ bà (loquat leaf), vỏ dâu (mulberry bark).

Bảng các vị thuốc bắc thường dùng

Bảng các vị thuốc bắc thường dùng

Lý khí (điều hòa khí):

Trần bì (vỏ quýt), củ gấu (flatsedge tuber), quả phật thủ (finger citron), trầm hương (eaglewood), đậu khấu (cardamon), rễ mộc hương (costus root).

Hoạt huyết (thúc đẩy tuần hoàn huyết):

Củ xuyên khung (*Chuanxiong* rhizome), rễ đan sâm (red sage root), nhân đào (peach kernel), củ *wenyujin*, rễ nghệ (turmeric root), gỗ tô mộc (sappan wood).

Cầm máu:

Tam thất (notoginseng), tiên hạc thảo (agrimony), lá ngải cứu (argyi wormwood leaf), rễ địa du (burnet root).

Bổ khí:

Nhân sâm, cam thảo, táo tàu (Chinese date), *baishu* (bạch truật).

Bổ huyết:

Rễ đương quy (angelica root), rễ hà thủ ô (fleeceflower root), quả dâu (mulberry fruit), dâu ký sinh (mulberry mistletoe).

Bổ âm:

Rễ thiên môn đông (asparagus root), củ bách hợp (lily bulb), quả nữ trinh tử (glossy privet fruit), củ ngọc trúc (solomonseal rhizome), kỷ tử (wolfberry).

Bổ dương:

Tắc kè (gecko), củ tiên mao (curculigo rhizome), hạt thỏ ty tử (dodder seed).

An thần / trấn tĩnh:

Chu sa (cinnabar), hạt táo nhân (spiny jujube seed), hoa hợp hoan (silktree flower).

HÌNH 189

Hình vẽ nét nhỏ chèn trong trang, mô tả một hiệu thuốc bắc. Sau quầy là người chủ hiệu đội mũ của kẻ sĩ, tay nâng một chiếc bình thuốc tròn lớn, phía sau là bức tường đầy ngăn kéo thuốc nhỏ. Một khách hàng đứng ở quầy đối diện ông; bên trái, dưới đất có hai chiếc chum gốm lớn đậy vải, phía xa bên phải là những chiếc chum khác xếp chồng.

TRANG SÁCH 87 · SCAN P096

Phương pháp thứ hai — Châm cứu và cứu ngải

Phương pháp thứ hai — Châm cứu và cứu ngải

"Đầu tôi đau quá."

"Để tôi giúp bạn!"

"Ối! Sao lại châm kim vào tôi thế?!"

"Đây gọi là châm cứu. Thật là kỳ diệu!"

"Cậu đang châm vào tôi bằng cây kim khâu đấy à?!"

"Bạn thấy thế nào?"

"Bạn có thấy tê hay đau không? Nói cho tôi biết đi!"

"Đau lắm! Hu... hu..."

Chẳng phải thật kỳ diệu sao khi một cây kim lại có thể làm dịu cơn đau trong cơ thể?

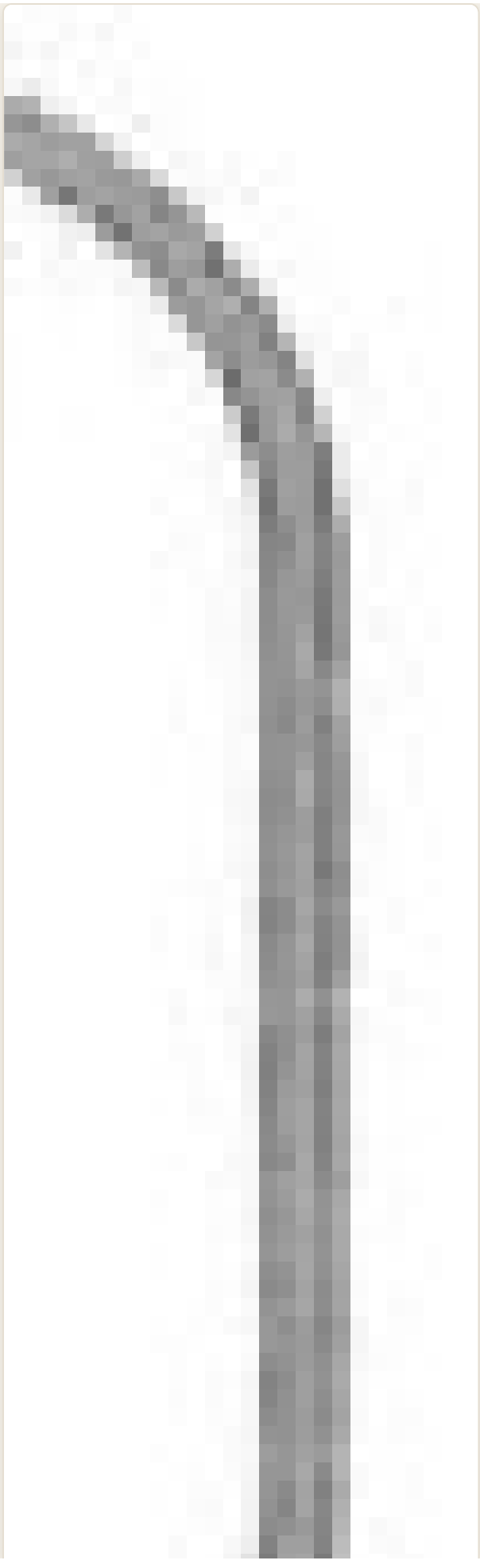
Châm cứu và cứu ngải là những kỹ thuật đặc sắc của Đông y. Chúng được dùng để chữa trị và phòng ngừa nhiều loại bệnh. Hiệu quả gần như tức thì và ít khi có tác dụng phụ.

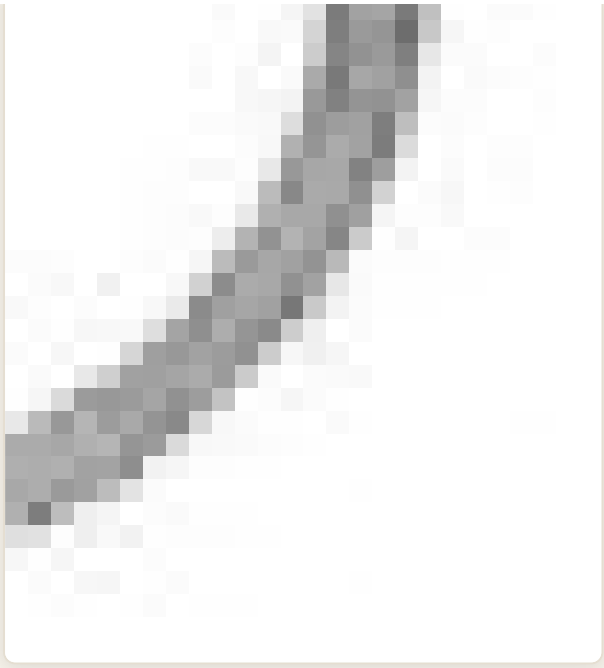
Châm cứu và cứu ngải là hai cách chữa trị khác nhau. Cả hai phương pháp đều kích thích các huyệt đạo trên bề mặt cơ thể để đưa khí, huyết, âm và dương ở vùng cơ thể bị bệnh trở về trạng thái hài hòa.

Châm cứu

Cứu ngải

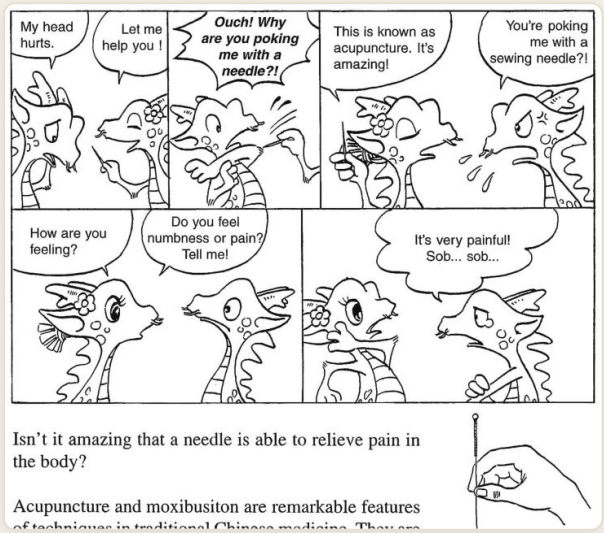
HÌNH 190





Một mảnh cắt hẹp cho thấy đầu tròn bên trái của tấm băng-rôn đóng khung tiêu đề chương.

HÌNH 191



Dải truyện tranh ở đầu trang, gồm hai hàng khung. Hàng thứ nhất: một chú rồng kêu đau đầu, chú rồng kia (đội một bông hoa) nói sẽ giúp; khung kế tiếp, chú rồng cầm kim châm vào bạn mình khiến chú này kêu lên và hỏi sao lại châm kim vào mình; khung thứ ba, chú cầm kim giải thích đây gọi là châm cứu, còn chú kia phản đối rằng mình đang bị châm bằng cây kim khâu. Hàng thứ hai: chú rồng hỏi bạn mình thấy thế nào, có tê hay đau không, trong khi chú kia gào lên rằng đau lắm. Phía dưới dải truyện, ở góc phải, một hình vẽ nét nhỏ cho thấy bàn tay đang giữ thẳng một cây kim châm.

Nguồn gốc của châm cứu

Nguồn gốc của châm cứu

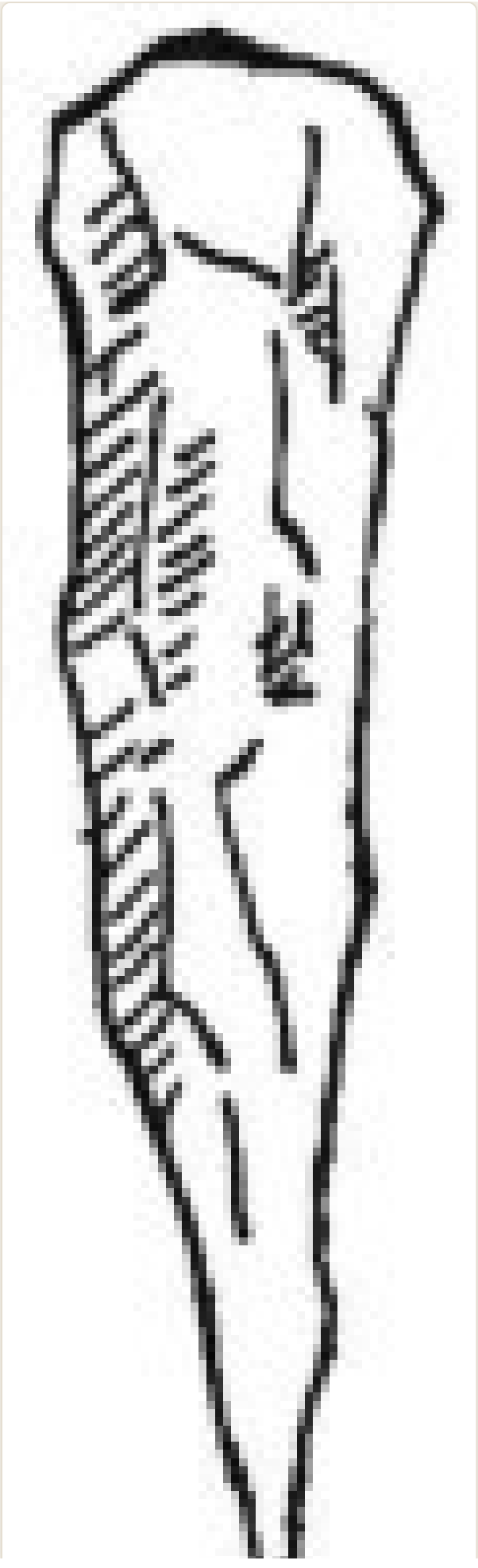
Hai phương pháp chữa bệnh này có thể bắt nguồn từ việc dùng kim đá vào thời kỳ đồ đá mới. Hồi đó, người ta dùng những cây kim đủ hình dạng và kích cỡ khác nhau, làm từ xương thú.

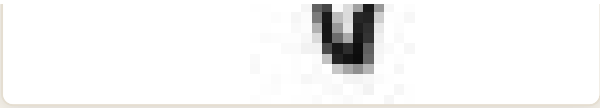
Vào thời kỳ sau nhà Chu, kim châm bằng kim loại lần đầu tiên xuất hiện. Việc dùng kim để chữa bệnh khi ấy đã rất phổ biến.

Đến thời Tần – Hán, châm cứu đã lan truyền sang Nhật Bản và Đông Nam Á. Người châu Âu bắt đầu biết đến châm cứu vào thế kỷ 17. Hiện nay, hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người hành nghề châm cứu. Châm cứu đang giữ một vai trò quan trọng trong nền khoa học sức khỏe của loài người.

Kim châm làm bằng xương

HÌNH 192





Một cây kim châm bằng xương được vẽ dựng đứng: một mảnh xương dẹt, dày, hơi cong, vót nhọn ở đầu, trên bề mặt có những vết xước khắc thành rãnh mảnh.

HÌNH 193

Một bức vẽ nét khổ rộng mô tả cảnh trị bệnh. Ở giữa, một người đàn ông lớn tuổi có ria mép ngồi chồm tới trước trong bộ quần áo có hoa văn, còn một thầy thuốc râu dài, tóc búi cao, đưa cây kim nhỏ ra sau gáy người bệnh; phía sau người bệnh, một người đứng giữ đầu và vai cho ông. Bên trái, một đứa trẻ nhỏ đang ló ra nhìn bên cạnh một chàng trai đội mũ vải mềm đang ngồi, cả hai đều chăm chú theo dõi. Bên phải, một người phụ việc trẻ mặc áo có hoa văn nâng chiếc khay đựng một hộp nhỏ, phía sau cậu là một giá đỡ và một vật đựng hình tròn. Dưới đất phía trước, một đôi giày đen, một bọc hành lý gói ghém và vài dụng cụ nằm rải rác.

TRANG SÁCH 89 · SCAN P098

Châm cứu được tiến hành như thế nào

Châm cứu được tiến hành như thế nào

Châm cứu là việc đưa kim xuyên qua da của người bệnh. Người ta thường dùng những cây kim rất mảnh làm bằng kim loại hoặc thép không gỉ. Kim có nhiều cỡ dài khác nhau, từ 15 milimét đến 100 milimét. Độ dày của kim cũng khác nhau.

Thầy châm cứu sẽ chọn loại kim dùng cho từng trường hợp dựa trên tình trạng sức khỏe và thể trạng của người bệnh. Chẳng hạn, ở những vùng nhiều thịt và nhiều cơ, người ta dùng kim dài và dày hơn. Với vùng ngực và lưng thì dùng kim ngắn và mảnh hơn.

Sau khi đưa kim vào huyệt đạo trên bề mặt da, thầy thuốc có thể vận kim theo nhiều cách khác nhau để tạo ra mức kích thích khác nhau trên huyệt đó. Người bệnh sẽ cảm thấy ê, tê và nặng tức ở chỗ kim đâm vào. Trạng thái này gọi là "đắc khí". Nếu không có cảm giác ấy, rất có thể là do đã chọn sai huyệt, và vì thế mà không chữa được đúng chỗ bị bệnh.

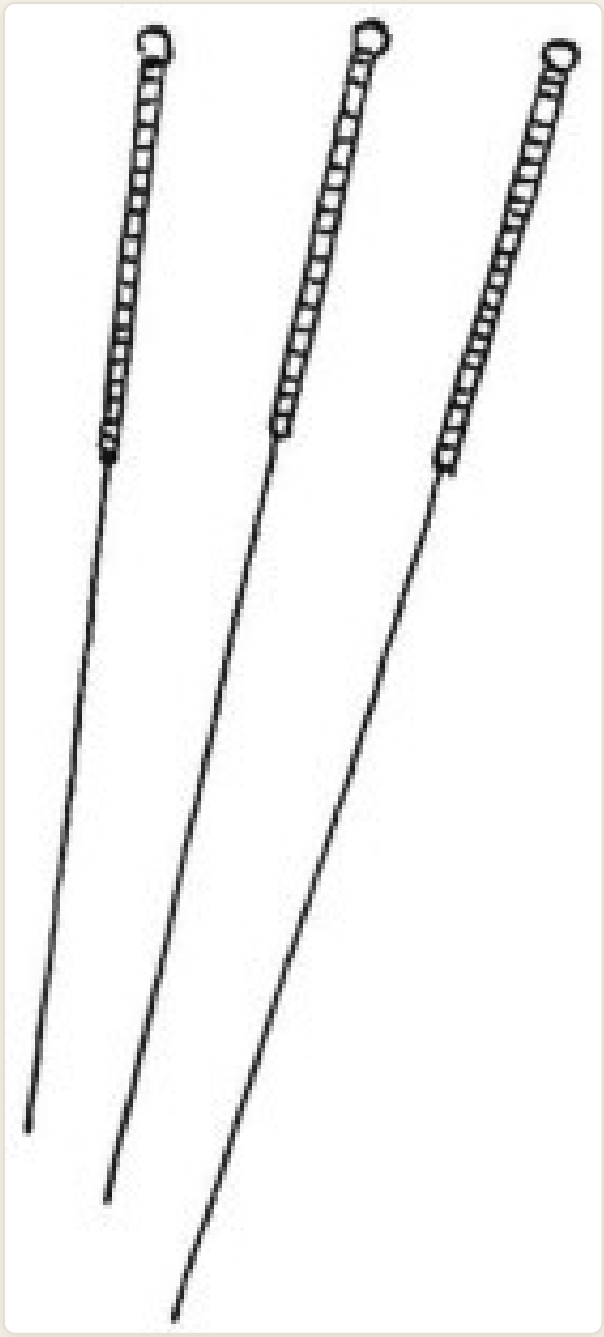
Phương pháp đề sáp (nâng lên và ấn xuống):

Sau khi kim đã được đưa vào, người ta nâng kim lên rồi ấn xuống xuyên qua bề mặt da hoặc vào trong cơ.

Phương pháp vê kim (xoay kim):

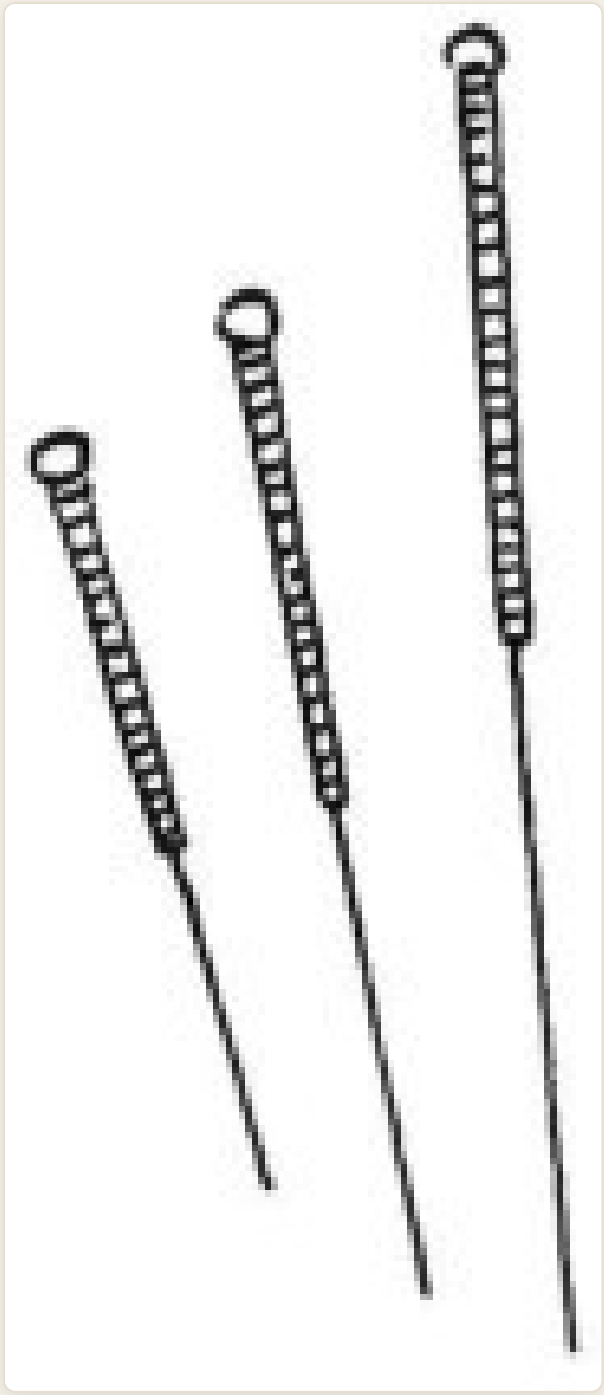
Khi kim đã được giữ chắc trên bề mặt da, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa sẽ giữ lấy kim rồi xoay kim qua lại.

HÌNH 194



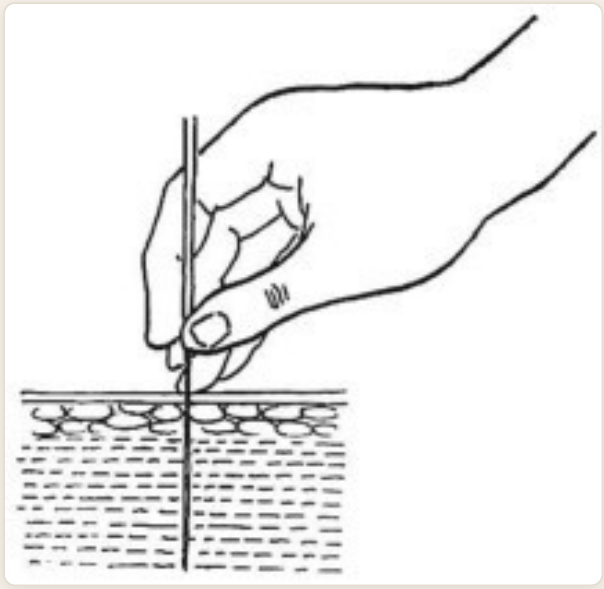
Ba cây kim châm mảnh với chuôi quấn dây xoắn khít, xòe ra theo một góc nghiêng.

HÌNH 195



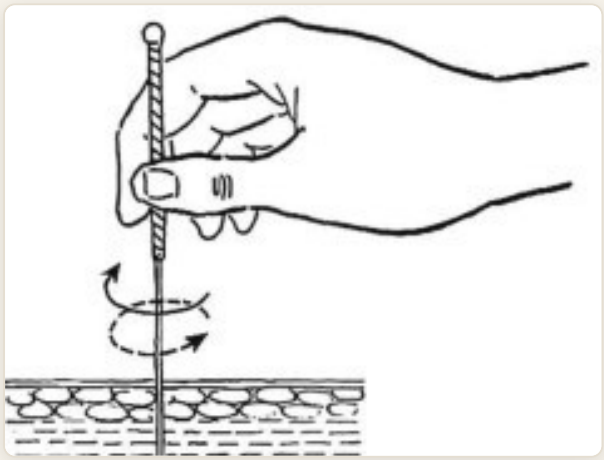
Ba cây kim châm nữa cũng có chuôi quấn dây xoắn, nghiêng theo hướng ngược lại, hợp thành phần còn lại của cùng một cụm kim.

HÌNH 196



Một bàn tay cầm kim dựng đứng và ấn thẳng xuống; phần da được vẽ cắt lớp, cho thấy các lớp mô bên dưới bề mặt và cây kim xuyên qua đó.

HÌNH 197



Một bàn tay nắm chuôi quấn dây của cây kim đã đâm vào, quanh thân kim có các mũi tên cong biểu thị động tác xoay kim qua lại.

TRANG SÁCH 90 · SCAN P099

Trang 90

Phương pháp búng kim:

Người ta dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa búng vào kim để gây rung, nhờ đó thúc đẩy khí lưu thông nhanh hơn.

Phương pháp lắc kim:

Sau khi kim đã được đưa vào và giữ chắc, người ta bẻ nghiêng kim sang hai bên để cây kim tác động mạnh hơn.

Phương pháp vê kim gián đoạn:

Kim được xoay thật mạnh rồi mới rút ngón cái và ngón trỏ ra. Thao tác này được lặp đi lặp lại.

TRANG SÁCH 91 · SCAN P100

Liệu pháp nhĩ châm (châm cứu ở tai)

Liệu pháp nhĩ châm (châm cứu ở tai)

Tai có những điểm phản ứng gắn với nhiều loại bệnh khác nhau. Vì vậy, khi tiến hành nhĩ châm (耳针) trên những điểm này, người ta có thể chữa được bệnh. Nhĩ châm được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh như các chứng đau, đờm, chứng mẫn cảm, rối loạn cảm xúc, bệnh truyền nhiễm, bệnh mạn tính, v.v. Phương pháp này cũng có thể hữu ích trong việc cai nghiện thuốc lá và các chất gây nghiện khác, đồng thời hỗ trợ giảm cân, v.v.

Sơ đồ huyệt đạo trong nhĩ châm.

TRANG SÁCH 92 · SCAN P101

Cứu ngải

Cứu ngải

Cứu ngải là dùng ngải nhung đã đốt cháy, điếu ngải hoặc nắm ngải để đốt nóng huyệt đạo, nhờ đó điều hòa khí và huyết bằng sức nóng. Ngải có vị cay, tính ấm. Vì thế nó làm ấm các lạc mạch và kinh mạch, giúp đẩy lui hàn và thấp.

Khi trị liệu, người ta đốt một đầu điếu ngải rồi đặt lên huyệt đạo hoặc giữ cách huyệt khoảng một milimét.

Người ta cũng dùng lát gừng tươi hoặc lát tỏi để làm lớp ngăn giữa ngải và bề mặt da.

Sau một lần cứu ngải, da hơi ửng đỏ là chuyện bình thường.

Cứu ngải được dùng để chữa các chứng âm, lý, hư và hàn, chẳng hạn như các nhân tố hàn tà và phong tà mạn tính.

TRANG SÁCH 93 · SCAN P102

Biển Thước dùng châm cứu cứu sống mạng người

Biển Thước dùng châm cứu cứu sống mạng người

Danh y Biển Thước (Bian Que) thời Chiến Quốc một ngày nọ đi ngang qua nước Quắc.

"Muộn quá rồi. Thái tử vừa mới qua đời."

"Tâu bệ hạ, thần nghe nói Thái tử bệnh nặng lắm. Xin cho thần được vào xem."

"À! Thái tử vẫn còn mạch đập!"

"Thưa ngài, sao ngài lại đâm kim vào thi thể Thái tử?"

HÌNH 198

Toàn bộ trang là một dải truyện tranh gồm ba hàng khung, lấy bối cảnh cung điện nước Quắc. Khung trên cùng bên trái mang tiêu đề Bian Que Restores Life with Acupuncture (Biển Thước dùng châm cứu cứu sống mạng người), phía dưới là Biển Thước đội mũ văn sĩ, tay cầm một cây kim dài giơ lên. Khung trên cùng bên phải có ô chú thích kể rằng danh y Biển Thước thời Chiến Quốc một ngày nọ đi ngang qua nước Quắc; bên cạnh, một người hầu bẩm với ông rằng đã quá muộn, Thái tử vừa mới qua đời, còn Biển Thước thì cúi mình trước nhà vua đang ngồi sau bình phong cùng các cận thần, xin được vào xem vị Thái tử bệnh nặng. Khung giữa bên trái: Biển Thước quỳ bên giường, bắt mạch cổ tay vị Thái tử đang nằm dưới chăn, và kêu lên rằng Thái tử vẫn còn mạch; khung giữa bên phải là cận cảnh gương mặt Thái tử khi một bàn tay ấn cây kim xuyên qua da trán. Khung dưới bên trái: Biển Thước đang châm cứu cho Thái tử, người nằm gối đầu trên gối trong khi vài cây kim đã dựng thẳng trên ngực và vai; khung dưới bên phải: một vị quan, nhìn từ phía sau với mũ cánh chuồn, phản đối và hỏi vì sao Biển Thước lại đâm kim vào thi thể Thái tử.

TRANG SÁCH 94 · SCAN P103

Trang 94

"Thái tử không chết."

"Khí và huyết của Thái tử chảy ngược, khiến thân thể người bất động."

"Vì thế trông người như đã chết."

"Ý ngài là ngài có cách khiến người sống lại?"

"Châm cứu sẽ cứu được Thái tử."

"Ta vừa chữa trị cho Thái tử. Chẳng bao lâu nữa người sẽ tỉnh lại."

Sau đó, Biển Thước sai học trò chuẩn bị thuốc cứu ngải để đặt dưới nách Thái tử.

"Thái tử đã ngồi dậy được trên giường. Người đã qua cơn nguy hiểm."

Sau 20 ngày điều trị, Thái tử hoàn toàn bình phục.

"Ngài đúng là bậc thần y có thể khiến người chết sống lại!"

HÌNH 199

Phần tiếp theo của câu chuyện tranh, gồm ba hàng khung. Khung trên cùng bên trái: Biển Thước, nhìn từ phía sau, khẳng định rằng Thái tử không chết; khung trên cùng bên phải: ông giải thích với nhà vua rằng khí và huyết của Thái tử chảy ngược nên thân thể bất động, vì thế trông người như đã chết, và nhà vua hỏi liệu ông có cách khiến người sống lại không. Khung giữa bên trái: Biển Thước tuyên bố rằng châm cứu sẽ cứu được Thái tử; khung giữa bên phải là cận cảnh Thái tử nằm trên gối, mắt mở, khi Biển Thước nói rằng ông vừa chữa trị cho người và chẳng bao lâu nữa người sẽ tỉnh lại. Một ô chú thích ở bên trái hàng dưới cùng kể rằng sau đó Biển Thước sai học trò chuẩn bị thuốc cứu ngải để đặt dưới nách Thái tử, và khung ngay dưới đó cho thấy vị Thái tử cởi trần, tựa người trên giường với một búi ngải đang bốc khói ở mỗi bên nách, cùng người học trò đang hầu bên cạnh. Khung giữa hàng dưới: Thái tử đã ngồi dậy được trên giường, đã qua cơn nguy hiểm; khung dưới cùng bên phải có ô chú thích ghi rằng sau hai mươi ngày điều trị Thái tử hoàn toàn bình phục, còn một vị quan nơi sân vườn thì tuyên bố rằng Biển Thước đúng là bậc thần y có thể khiến người chết sống lại.

Vương Duy Nhất chế tạo tượng người bằng đồng

Vương Duy Nhất chế tạo tượng người bằng đồng

Vương Duy Nhất (Wang Weiyi) là ngự y thời Bắc Tống. Nhiệm vụ của ông là dạy châm cứu.

"Châm cứu được giảng dạy trong triều đình này. Con phải nắm thật vững."

"Con phải ghi nhớ hết các huyệt đạo. Chỉ sơ sẩy một chút là có thể mất mạng."

"Thưa thầy, việc nhớ hết các huyệt đạo thì con không gặp khó khăn gì."

"Nhưng con rất sợ khi phải đâm kim vào người sống."

"Lại đây, để ta làm mẫu xem phải làm thế nào."

"Run tay..."

HÌNH 200

Toàn bộ trang là một dải truyện tranh gồm ba hàng khung, lấy bối cảnh triều đình Bắc Tống. Khung trên cùng bên trái mang tiêu đề Wang Weiyi Creates the Bronze Man (Vương Duy Nhất chế tạo tượng người bằng đồng), phía dưới là một mô hình giải phẫu bằng đồng để trần đứng cạnh Vương Duy Nhất; khung trên cùng bên phải là chân dung Vương Duy Nhất đội mũ quan màu đen, kèm ô chú thích cho biết ông là ngự y thời Bắc Tống, có nhiệm vụ dạy châm cứu. Hàng giữa: Vương Duy Nhất đứng trước một dãy kệ, nói với học trò rằng châm cứu được giảng dạy trong triều đình này và họ phải nắm thật vững, phải ghi nhớ hết các huyệt đạo vì chỉ sơ sẩy một chút là có thể mất mạng; hai người học trò đang lắng nghe, một người cầm tấm bản đồ cơ thể người có đánh dấu các huyệt đạo. Khung dưới bên trái: một học trò sợ hãi, tay cầm kim, nói rằng mình nhớ hết các huyệt đạo thì không có vấn đề gì, nhưng lại rất sợ phải đâm kim vào người sống; khung dưới bên phải: Vương Duy Nhất cầm kim trên một cánh tay và làm mẫu động tác đúng, bên cạnh cây kim có in chữ Tremble... (Run tay...).

TRANG SÁCH 96 · SCAN P105

Trang 96

"Ngài gọi thế này là châm cứu sao?"

"Xin thầy tha lỗi. Con không muốn tạo ra những lỗ kim không cần thiết trên người thầy. Nhưng nếu thầy làm bằng gỗ thì con đã làm rồi."

"Người bằng gỗ ư? Con đã cho ta một ý tưởng tuyệt vời."

"Dùng mô hình giải phẫu cơ thể người trong lớp học là một ý hay."

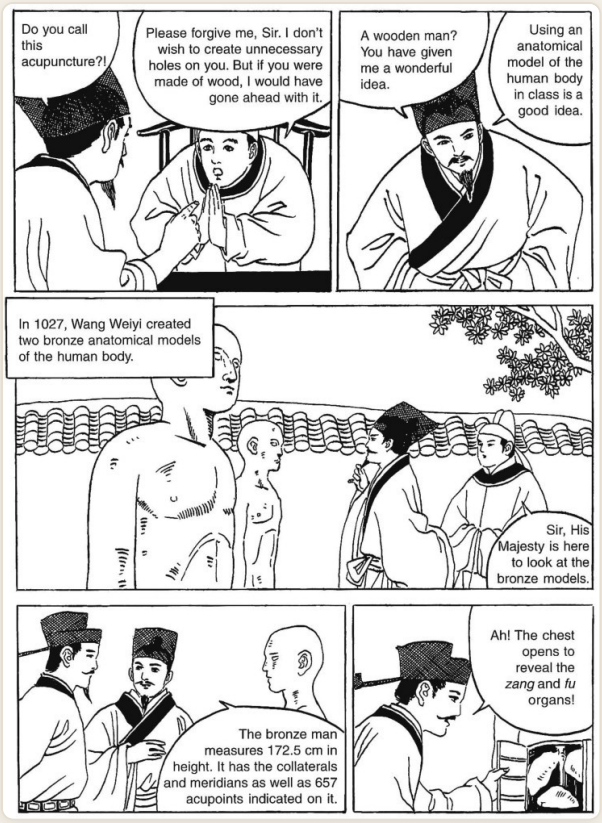
Năm 1027, Vương Duy Nhất chế tạo hai mô hình giải phẫu bằng đồng của cơ thể người.

"Thưa thầy, bệ hạ đến xem các mô hình bằng đồng."

"Người đồng cao 172,5 cm. Trên đó có ghi các lạc mạch và kinh mạch cùng 657 huyệt đạo."

"A! Ngực mở ra để lộ các tạng phủ!"

HÌNH 201



Phần tiếp theo của câu chuyện tranh, gồm ba hàng khung. Khung trên cùng bên trái: Vương Duy Nhất, nhìn từ phía sau với mũ quan, mắng người học trò và hỏi rằng đó có phải là châm cứu không; người học trò chắp hai tay xin lỗi, nói rằng mình không muốn tạo ra những lỗ kim không cần thiết trên người thầy, nhưng nếu thầy làm bằng gỗ thì mình đã làm rồi. Khung trên cùng bên phải: Vương Duy Nhất sáng mắt, lặp lại "Người bằng gỗ ư?" và nói với học trò rằng cậu đã cho ông một ý tưởng tuyệt vời, trong khi người học trò nhận xét rằng dùng mô hình giải phẫu cơ thể người trong lớp học là một ý hay. Hàng giữa có ô chú thích ghi rằng năm 1027 Vương Duy Nhất chế tạo hai mô hình giải phẫu bằng đồng của cơ thể người; khung truyện cho thấy hai tượng đồng, một lớn một nhỏ, đứng trong sân có mái ngói, cùng lúc một người học trò bẩm rằng bệ hạ đã đến xem các mô hình bằng đồng. Khung dưới bên trái: hai vị quan và người học trò xem phần đầu và vai của tượng đồng, kèm bong bóng hội thoại giải thích rằng tượng cao 172,5 cm, trên đó có ghi các lạc mạch, kinh mạch và 657 huyệt đạo. Khung dưới bên phải: Vương Duy Nhất nâng phần ngực có bản lề của tượng đồng lên để lộ các cơ quan bên trong, và kêu lên rằng ngực mở ra để lộ các tạng phủ.

TRANG SÁCH 97 · SCAN P106

Trang 97

"Tâu bệ hạ, chúng thần dự định phủ một lớp sáp lên mô hình trước khi cho học trò vào kiểm tra."

"Vậy chúng ta dùng người đồng này thế nào?"

"Nó cũng sẽ được đổ đầy nước."

"Sau đó học trò sẽ chọn huyệt đạo dựa trên câu hỏi được đưa ra."

"Nhìn này, một khi cây kim được đâm vào đúng vị trí, nước sẽ chảy ra."

"Nếu kim đâm trượt huyệt đạo, nó sẽ không thể xuyên vào người đồng."

"Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ đặt một mô hình ở chùa Đại Tướng Quốc và một ở Thái y viện."

"Thật tuyệt! Tay ta sẽ không còn run khi phải thực hành châm cứu nữa."

HÌNH 202

Một trang truyện tranh khổ đầy đủ, gồm ba hàng khung. Hàng trên, từ trái sang phải: một vị quan đội mũ có cánh nói với hoàng đế rằng họ dự định phủ một lớp sáp lên mô hình trước khi cho học trò vào kiểm tra; một học giả hỏi dùng người đồng này thế nào, và một người khác giải thích rằng nó cũng sẽ được đổ đầy nước; rồi một khung cho thấy một cây kim đang được đâm vào vai tượng đồng, kèm ô chú thích giải thích rằng sau đó học trò sẽ chọn huyệt đạo dựa trên câu hỏi được đưa ra. Hàng giữa: một vị quan chỉ vào tượng đồng, nói rằng một khi kim đâm đúng vị trí thì nước sẽ chảy ra; một học trò trẻ nhận xét rằng nếu kim đâm trượt huyệt đạo thì nó không thể xuyên vào người đồng; và một vị quan có râu mép cùng râu dài thốt lên rằng thật tuyệt vời, nói thêm rằng một mô hình sẽ được đặt ở chùa Đại Tướng Quốc và một ở Thái y viện. Hàng dưới: một học trò vui mừng nói rằng tay mình sẽ không còn run khi phải thực hành châm cứu; mặt tiền một ngôi chùa hiện ra với tấm biển đề chữ 相國寺 (chùa Đại Tướng Quốc); và một người thực hành ngồi bên cạnh tượng đồng đang đứng, đưa kim vào lưng tượng, các đường kinh lạc trên tượng được vẽ bằng nét chấm.

TRANG SÁCH 98 · SCAN P107

Trang 98

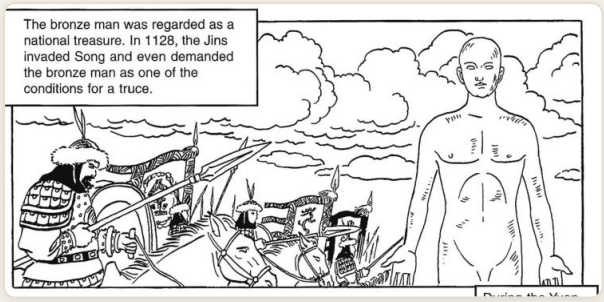
Người đồng được coi là quốc bảo. Năm 1128, người Kim xâm lược nhà Tống và còn đòi người đồng như một trong những điều kiện để đình chiến.

Dưới các triều Nguyên và Minh, người đồng tiếp tục được cải tiến thêm. Thật đáng tiếc là người đồng của triều Tống đã thất truyền qua những biến đổi của các triều đại.

Nhưng đến các triều Minh và Thanh, người đồng đã hồi sinh. Nhờ đó châm cứu lại được truyền bá đến người dân.

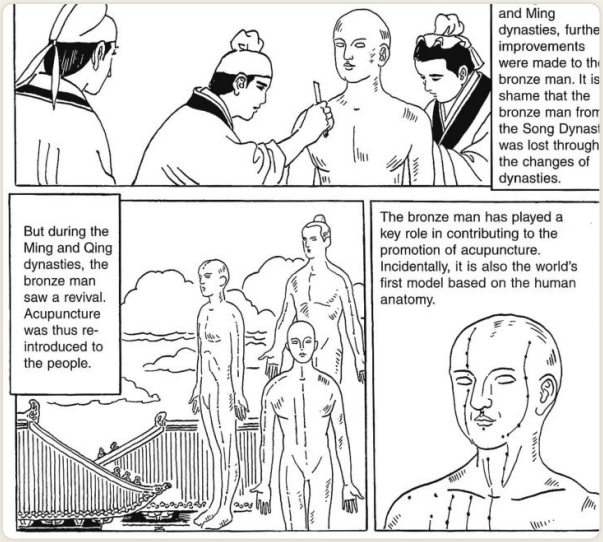
Người đồng đã đóng vai trò then chốt trong việc góp phần quảng bá châm cứu. Nhân đây cũng nói thêm, nó còn là mô hình đầu tiên trên thế giới dựa trên giải phẫu cơ thể người.

HÌNH 203



Hàng khung trên cùng của trang truyện. Một ô chú thích ở góc trên bên trái ghi rằng người đồng được coi là quốc bảo và rằng năm 1128 người Kim xâm lược nhà Tống, thậm chí còn đòi người đồng như một trong những điều kiện để đình chiến. Bên dưới, những kỵ binh Kim mặc giáp, đội mũ có lông vũ và cầm giáo dài xông qua một cánh đồng rộng dưới những đám mây cuồn cuộn, trong khi ở phía bên phải là tượng người đồng trần, nhìn từ phía trước, trên bề mặt rải rác những nét khắc nhỏ đánh dấu kinh lạc và huyệt đạo.

HÌNH 204



Hàng khung giữa và hàng khung dưới của trang truyện. Ở hàng giữa, ba nhân vật đội mũ học giả và mặc áo dài quây quần quanh người đồng: người ở giữa đâm một cây kim vào vai tượng, còn hai người hai bên đứng nhìn; một ô chú thích bên phải ghi rằng dưới các triều Nguyên và Minh người đồng tiếp tục được cải tiến thêm và rằng người đồng của triều Tống đã thất truyền qua những biến đổi của các triều đại. Khung dưới bên trái: ba tượng đồng đứng trước một con sông và một cây cầu vòm có mái chùa phía sau, kèm ô chú thích ghi rằng đến các triều Minh và Thanh người đồng đã hồi sinh và châm cứu lại được truyền bá đến người dân. Khung dưới bên phải: cận cảnh phần đầu và vai của tượng đồng, cho thấy các nét chấm đánh dấu huyệt đạo rải khắp mặt, cổ và ngực, kèm ô chú thích giải thích rằng người đồng đã đóng vai trò then chốt trong việc quảng bá châm cứu và cũng là mô hình đầu tiên trên thế giới dựa trên giải phẫu cơ thể người.

TRANG SÁCH 99 · SCAN P108

Phương pháp thứ ba — Xoa bóp

Phương pháp thứ ba — Xoa bóp

Xoa bóp đẩy, ấn, nhào nặn hoặc chà xát cơ thể để kích thích tuần hoàn máu, tăng sức đề kháng của da và điều hòa hệ thần kinh.

"Ngày nay, công dụng của xoa bóp đã mở rộng, bao gồm cả việc nâng cao sức khỏe và tăng cường thể chất. Nó không còn giới hạn ở việc chữa bệnh nữa. Xoa bóp đều đặn sẽ làm dịu mệt mỏi và khiến tinh thần sảng khoái!"

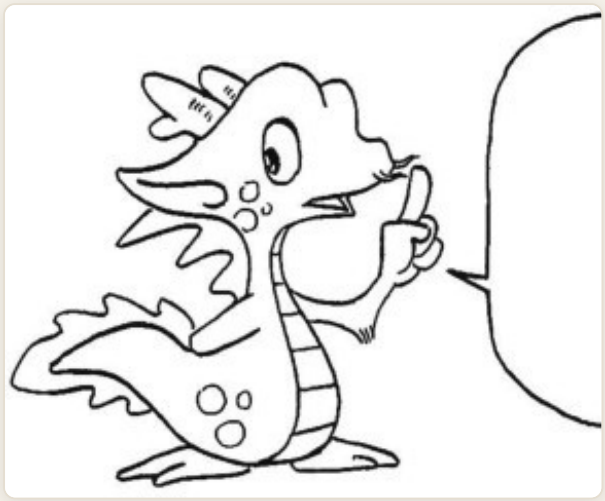
"Xoa bóp có phải là 'đẩy' và 'nắm' không?"

"Có tám kiểu xoa bóp phổ biến. Đẩy và nắm chỉ là hai kiểu trong số đó."

Đẩy: Dùng ngón tay, lòng bàn tay hoặc cùi chỏ đẩy và ép các bắp thịt theo chiều tới rồi lui.

Nắm: Dùng ba hoặc năm ngón của một hay cả hai bàn tay để nhấc lên và ép da hoặc bắp thịt.

HÌNH 205



Linh vật rồng hoạt hình của sách, đứng thẳng, đầu quay sang phải và một chi trước có vuốt giơ lên như đang nói; mép răng cưa của một bong bóng hội thoại thấp thoáng bên phải, trên mình rồng có những đốm tròn nhỏ và sống lưng có vây.

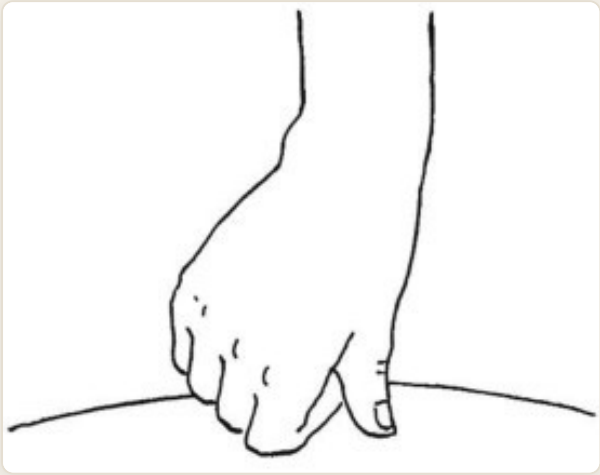
HÌNH 206

Một dải khung có viền, chia làm hai nửa. Nửa trên: hai chú rồng hoạt hình đối diện nhau, con bên trái giơ vuốt lên với bong bóng hội thoại hỏi rằng xoa bóp có phải là "đẩy" và "nắm" không, con bên phải trả lời trong một bong bóng rằng có tám kiểu xoa bóp phổ biến và đẩy với nắm chỉ là hai kiểu trong số đó. Nửa dưới là hai hình vẽ bàn tay: bên trái, một bàn tay đặt phẳng trên một chi và đang được đẩy tới rồi lui, bên cạnh có một mũi tên nhỏ chỉ hướng di chuyển; bên phải, một bàn tay đang nắm và nhấc lên một nếp da hoặc bắp thịt.

Trang 100

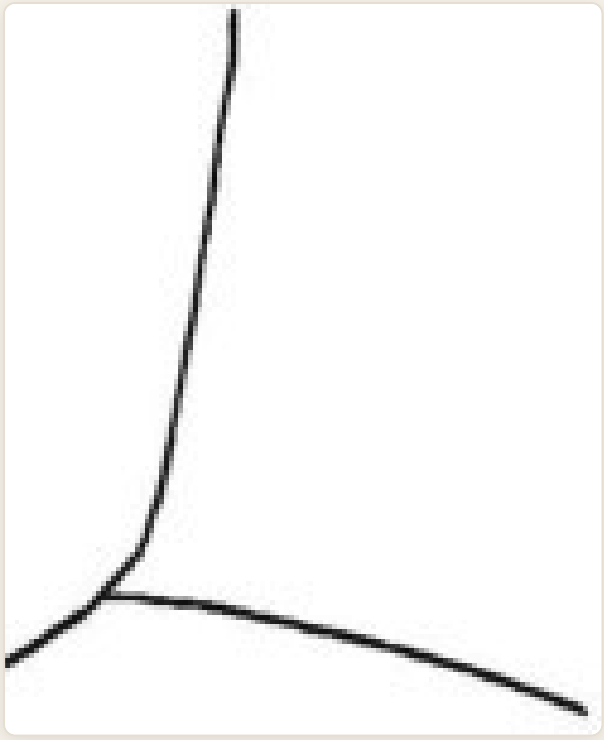
- - **Ấn:** Dùng ngón cái, lòng bàn tay hoặc khớp ngón tay ấn vào huyệt đạo hay chỗ đau.
- - **Gõ:** Dùng đầu ngón tay gõ vào một điểm trên cơ thể người bệnh.
- - **Ấn móng tay:** Dùng móng tay ấn vào một điểm trên cơ thể để tạo kích thích mạnh.
- - **Xoa:** Dùng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay xoa chỗ đau theo động tác vòng tròn.
- - **Nhào nặn:** Dùng lòng bàn tay nhào và ấn các bắp thịt ở tay chân.
- - **Vỗ:** Dùng lòng bàn tay hoặc cạnh bàn tay vỗ nhẹ để gây thư giãn.

HÌNH 207



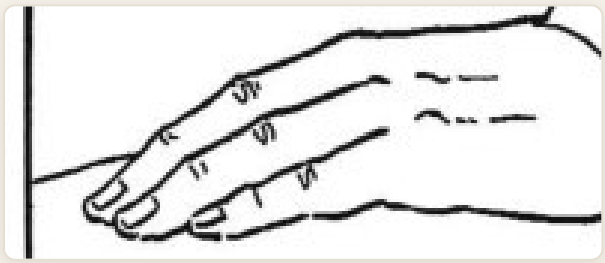
Một bàn tay nhìn nghiêng, cẳng tay đưa xuống từ phía trên, các ngón co lại và đầu ngón ấn xuống một mặt phẳng; hình vẽ này minh họa động tác gõ.

HÌNH 208



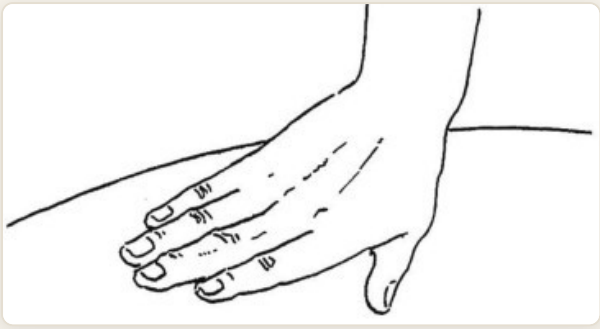
Một phần cắt nhỏ chi tiết từ cùng khung hình minh họa: đường cong của cánh tay người thực hiện khi đưa xuống mặt phẳng, với đường mặt phẳng chạy ra phía bên phải, phần còn lại của khung để trống.

HÌNH 209



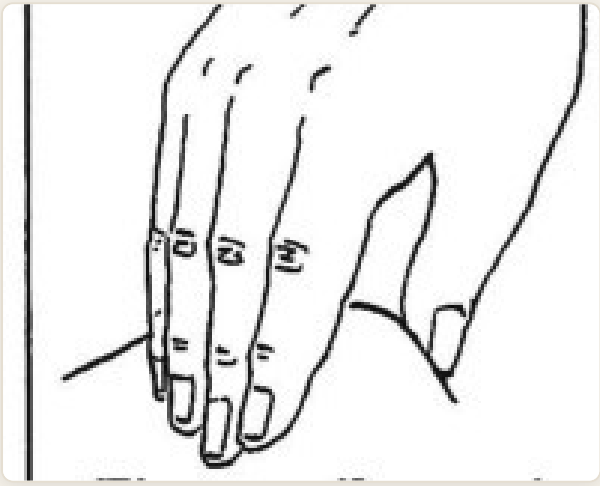
Một bàn tay đặt phẳng, nhìn nghiêng, các ngón duỗi ra và hướng về bên trái, lòng bàn tay ấn xuống mặt phẳng, trên mu bàn tay có những nét chấm nhỏ.

HÌNH 210



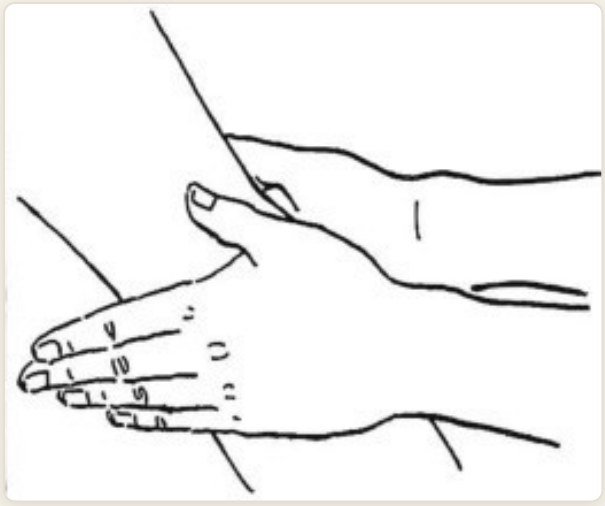
Một bàn tay nhìn từ mu, các ngón duỗi ra và hơi xòe, cổ tay quay về bên phải, đặt phẳng trên một mặt phẳng như đang chà xát.

HÌNH 211



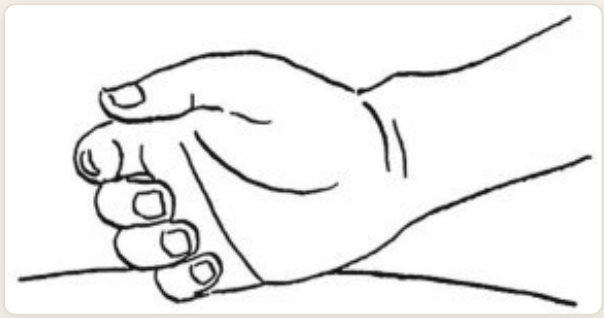
Một bàn tay dựng đứng, các ngón hướng xuống dưới và móng tay được vẽ rõ, đang ấn vào một điểm duy nhất trên mặt phẳng.

HÌNH 212



Hai bàn tay: một bàn tay đặt lên trên bàn tay kia trên một chi và nhào nặn, ấn xuống; một cánh tay vắt ngang phía trên bên trái khung hình.

HÌNH 213



Một bàn tay với các ngón co và gập lại, lòng bàn tay cùng cạnh bàn tay hướng xuống mặt phẳng, như trong động tác vỗ nhẹ.

TRANG SÁCH 101 · SCAN P110

Trang 101

"Chính khi việc tác động lên huyệt đạo gây ra cảm giác ê ẩm thì huyệt đạo mới đã đắc khí."

"Nếu chỉ thấy đau mà không ê ẩm, thì có thể là do xoa bóp quá mạnh tay hoặc xác định sai huyệt đạo."

Xoa bóp bao trùm một phổ rộng các hệ như hệ thần kinh, hệ cơ, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, v.v. Nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc chữa trị các bệnh của những hệ này.

Xoa bóp tim

Chúng ta thường thấy trên truyền hình cảnh bác sĩ ấn vào ngực bệnh nhân để cố đưa nhịp tim trở lại bình thường, nhờ đó hồi sinh người bệnh. Đây cũng là một kỹ thuật được dùng trong xoa bóp. Vào thời Đông Hán, danh y Trương Trọng Cảnh đã giới thiệu phương pháp này trong cuốn *Kim Quỹ Yếu Lược* (Synopsis of The Prescriptions of Golden Chamber).

HÌNH 214

Linh vật rồng hoạt hình, miệng há ra và hai bàn tay có vuốt giơ lên như đang ra hiệu, với đường viền răng cưa của một bong bóng hội thoại ở phía trên bên trái; mép của một bong bóng thứ hai thấp thoáng bên phải.

HÌNH 215

Một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay quỳ bên trên một bệnh nhân nằm thẳng trên nền và dùng cả hai tay ấn xuống ngực bệnh nhân để thực hiện xoa bóp tim; bệnh nhân nhắm mắt, một cánh tay duỗi ra. Phía bên phải là một cuốn sách đóng kiểu truyền thống khổ lớn với nhãn đề chữ 金匱要略 (Kim Quỹ Yếu Lược, Synopsis of the Golden Chamber).

Xoa bóp phản xạ bàn chân

Xoa bóp phản xạ bàn chân

Xoa bóp phản xạ bàn chân đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Các thầy thuốc Trung Quốc tin rằng trên bàn chân của mỗi người có sáu kênh chính và 66 huyệt đạo, và những huyệt này có liên quan đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Thông qua việc kích thích các huyệt đạo ấy, người ta có thể duy trì sức khỏe tốt và chữa bệnh. Xoa bóp phản xạ bàn chân giúp tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy cân bằng nội tiết tố, đào thải độc tố có hại ra khỏi cơ thể, giảm mệt mỏi, duy trì và cải thiện làn da, v.v.

Sơ đồ huyệt đạo trong xoa bóp phản xạ bàn chân

- - A. Đầu
- - B. Tuyến giáp
- - C. Phổi
- - D. Tim
- - E. Gan
- - F. Dạ dày
- - G. Lách
- - H. Tụy
- - I. Thận phải
- - J. Thận trái
- - K. Tá tràng*
- - L. Ruột già
- - M. Ruột non
- - N. Đầu gối phải
- - P. Đầu gối trái
- - P. Bàng quang
- - Q. Cơ quan sinh sản

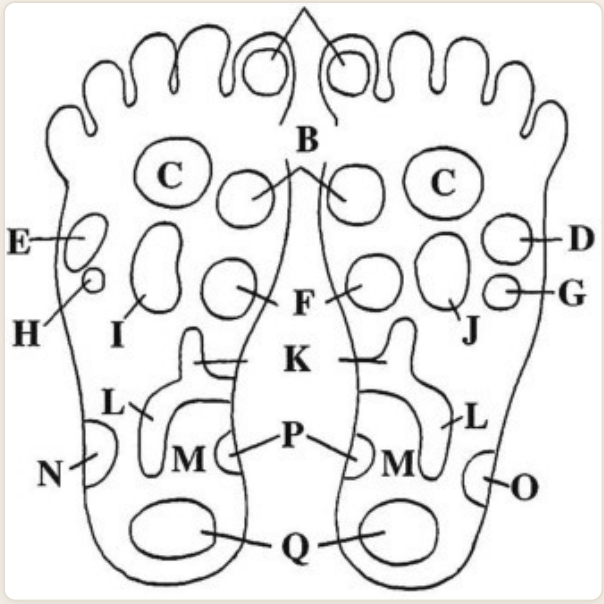
* Phần đầu tiên của ruột non nối với dạ dày.

Có bốn phương pháp cơ bản trong xoa bóp phản xạ bàn chân:

- - Nhào nặn, xoa và day
- - Kéo giãn
- - Kéo giãn
- - Vặn xoắn

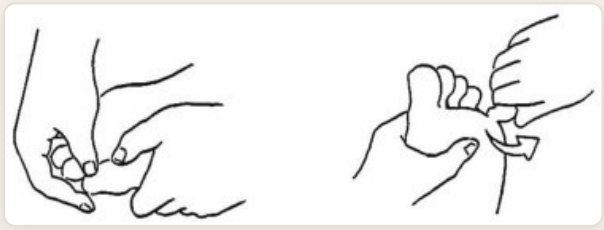
"Nhớ uống nước sau khi xoa bóp phản xạ bàn chân. Chất thải của cơ thể tích tụ ở thận trong quá trình xoa bóp phản xạ bàn chân. Vì vậy, uống nước sẽ giúp đào thải những chất thải này ra ngoài qua việc đi tiểu."

HÌNH 216



Sơ đồ lòng bàn chân của hai bàn chân, đặt cạnh nhau và hơi xòe ra, trên mỗi lòng bàn chân có những vùng hình bầu dục và hình tròn nhỏ, được đánh dấu bằng các chữ cái từ A đến Q: A ở đầu các ngón chân cái ứng với đầu, B ở gốc các ngón chân ứng với tuyến giáp, C trên phần ức bàn chân ứng với phổi, D ở mép ngoài ứng với tim, E và H ở mép ngoài ứng với gan và tụy, cùng nhiều vùng khác được đánh chữ F, G, I, J, K, L, M, N, O, P và Q chạy dần xuống gót chân ứng với dạ dày, lách, thận phải và trái, tá tràng, ruột già và ruột non, đầu gối, bàng quang và cơ quan sinh sản.

HÌNH 217



Cặp tư thế đặt tay trên của bốn phương pháp xoa bóp phản xạ bàn chân. Bên trái: một bàn tay giữ bàn chân trong khi các ngón của bàn tay kia ấn và day lòng bàn chân, tức động tác nhào nặn, xoa và day. Bên phải: một bàn tay nắm bàn chân và bẻ cong lại, kèm một mũi tên nhỏ chỉ hướng kéo giãn.

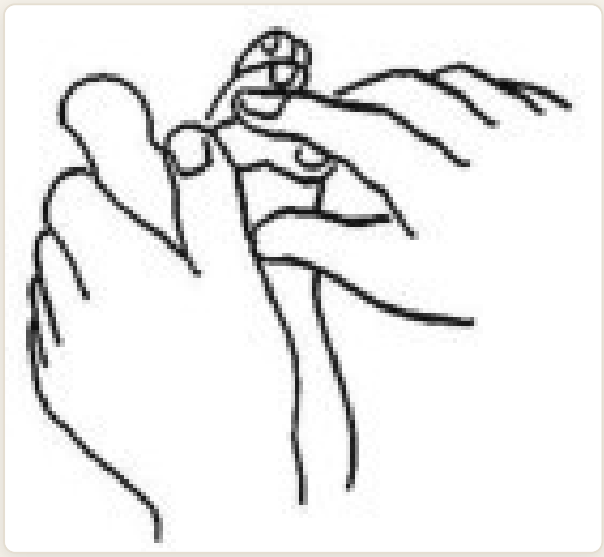
HÌNH 218

Tư thế vặn xoắn: cả hai bàn tay nắm bàn chân và xoay nó, phía trên hai bàn tay có hai mũi tên cong chỉ chuyển động vặn theo hai chiều ngược nhau.

HÌNH 219

Linh vật rồng hoạt hình, ngồi với miệng há ra cười và đuôi cuộn phía sau, một bàn tay có vuốt giơ lên một ly nước; phía trên là phần đuôi của một bong bóng hội thoại mang dòng chữ "passing of urine."

HÌNH 220



Tư thế kéo giãn: một bàn tay giữ bàn chân từ phía dưới trong khi các ngón của bàn tay kia nắm lấy các ngón chân và kéo giãn chúng lên trên.

Các phương pháp khác trong xoa bóp phản xạ bàn chân

Các phương pháp khác trong xoa bóp phản xạ bàn chân

Rửa chân:

Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng việc rửa chân cũng có tác dụng xoa bóp. Rửa chân tốt nhất nên làm trước khi đi ngủ. Đây là một phương pháp đơn giản. Đổ nước ấm vào một cái chậu rồi ngâm chân trong đó. Đồng thời chà xát bàn chân. Việc này không chỉ làm sạch chân mà còn tăng cường tuần hoàn máu, chữa bệnh và tăng cường thể chất. Bạn cũng có thể cho thêm bi ve vào chậu rồi giẫm lên những viên bi ấy.

Đi dép có gờ nổi:

Một số loại dép có những gờ nổi nhỏ trên mặt đế. Mang những đôi dép này cũng giúp xoa bóp bàn chân.

Đi chân đất trên sỏi:

Đi chân đất trên con đường trải sỏi cũng giống như được xoa bóp phản xạ bàn chân và có tác dụng trị liệu.

"Bạn cũng có thể giẫm lên sỏi ngay tại nhà!"

"Chỉ cần cho sỏi vào một túi vải là bạn có thể giẫm lên bất cứ lúc nào mình thích!"

HÌNH 221

Một khung hình tròn vẽ một người phụ nữ mặc áo sọc ngồi trên ghế đẩu thấp, ống quần xắn lên, đang ngâm và chà xát bàn chân trong một chậu nước ấm bốc khói đặt trên nền nhà.

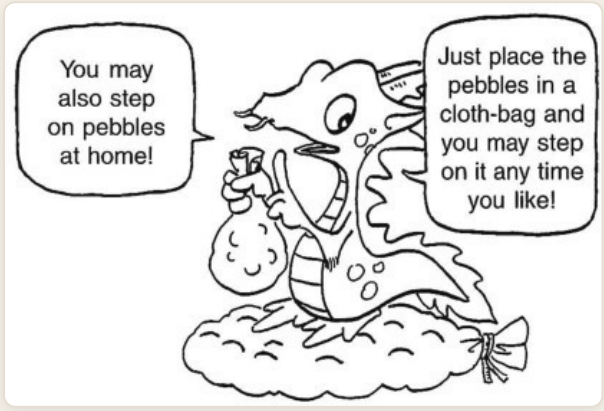
HÌNH 222

Một khung hình tròn vẽ một đôi dép quai ngang, mặt đế rải đầy những gờ nổi nhỏ.

HÌNH 223

Một khung hình tròn vẽ một người đàn ông trẻ mặc áo khoác và quần dài, nhìn nghiêng, đang đi chân đất trên một bãi sỏi tròn nhẵn.

HÌNH 224



Linh vật rồng hoạt hình đứng trên một tấm thảm sỏi, một bàn tay có vuốt giơ lên một túi vải nhỏ đựng sỏi, hai bên là hai bong bóng hội thoại.

TRANG SÁCH 104 · SCAN P113

Phương pháp thứ tư — Thực liệu

Phương pháp thứ tư — Thực liệu

"Sao trông bạn ủ rũ vậy? Bạn thấy trong người không khỏe à?"

"Để tôi xem có giúp được gì cho bạn không. Tôi vừa mới học về thực liệu. Bạn không cần uống thuốc hay đi tiêm đâu."

"Tôi sẽ nấu cho bạn canh củ sen, cháo cà rốt, hồng, dưa hấu, xoài..."

"Vừa nãy tôi ăn quá nhiều. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi."

"Vậy thì bạn nên ăn những món giúp tiêu hóa..."

Thực liệu dùng chính thức ăn chúng ta ăn hằng ngày để chữa bệnh hoặc hỗ trợ chữa bệnh.

Từ xa xưa ở Trung Quốc, thức ăn và thuốc đã được xem là gắn bó với nhau. Nhiều loài cây thực ra từng là thức ăn. Theo thời gian, chúng được dùng rộng rãi như những vị thuốc.

HÌNH 225

Hàng khung trên của trang truyện, gồm hai khung đặt cạnh nhau. Khung bên trái: chú rồng mõm dài hỏi người bạn đồng hành, vốn có một bông hoa nhỏ trên đầu và đôi mắt sụp xuống, rằng sao trông bạn ủ rũ vậy và có phải bạn thấy trong người không khỏe không. Khung bên phải: chú rồng có bông hoa trả lời rằng để mình xem có giúp được gì không, vì mình vừa mới học về thực liệu và bạn không cần uống thuốc hay đi tiêm.

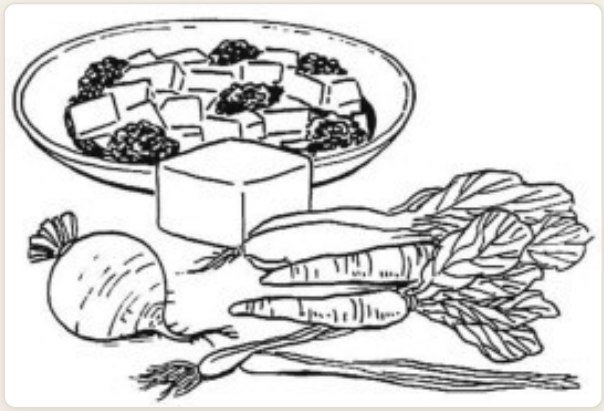
HÌNH 226

Hàng khung dưới của trang truyện, gồm hai khung đặt cạnh nhau. Khung bên trái: chú rồng có bông hoa ngỏ ý sẽ nấu canh củ sen, cháo cà rốt, hồng, dưa hấu và xoài. Khung bên phải: chú rồng mõm dài nói rằng vừa nãy mình ăn quá nhiều và giờ chỉ muốn ngủ, còn chú rồng có bông hoa đáp rằng vậy thì bạn nên ăn những món giúp tiêu hóa.

HÌNH 227

Một bức tĩnh vật về thức ăn và dụng cụ nấu nướng: một chõ tre đựng bánh bao với một đống trứng bên cạnh, một cái nồi đậy nắp, một bát canh có cả con gà, một nồi đất om với nấm và một bát cơm, bên cạnh là một cây cải thảo cùng các loại rau lá khác, khói bốc lên từ các món ăn.

HÌNH 228



Một đĩa đậu phụ cắt miếng điểm rau xanh, bên cạnh là một củ cải trắng lớn cùng hai củ cà rốt còn nguyên phần lá.

Thực liệu sư

Danh y Tôn Tư Mạc (Sun Simiao) từng nói:

> *"Muốn giữ thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải nhờ vào thức ăn. Chỉ khi mắc bệnh nặng mới phải dùng đến thuốc. Hiểu biết kém về chế độ ăn đúng đắn sẽ không giữ được sức khỏe. Một thầy thuốc giỏi phải biết nguyên nhân của bệnh và tìm ra bộ phận bị tổn thương. Trước tiên hãy chữa bệnh bằng thực liệu (chế độ ăn trị liệu); chỉ kê thuốc khi cách này không hiệu quả."*

Thực liệu sư

Vào thời Tiên Tần, thầy thuốc đã được chia thành bốn nhóm: ngoại khoa (phẫu thuật), nội khoa, thực liệu và thú y. Riêng thực liệu sư phụ trách chế độ ăn uống của vua chúa và hoàng đế. Ông lên thực đơn dựa trên mùa trong năm và tình trạng sức khỏe của người dùng, nhằm duy trì sức khỏe tốt và phòng ngừa bệnh tật.

HÌNH 229

Chân dung danh y Tôn Tư Mạc: một người đàn ông có râu, mặc y phục kiểu thời Đường và đội khăn vải mềm, cổ áo chéo có viền đen.

HÌNH 230

Bốn nhân vật mặc áo choàng đứng cạnh nhau, mỗi người tượng trưng cho một ngành y học thời sơ khai: một vị quan đội mũ cao giơ tay lên; một thầy thuốc cầm chiếc búa nhỏ; một thực liệu sư bưng khay đựng các món ăn có nắp đậy; và một thầy thuốc thú y đang ôm một con vật nhỏ. Trong bản gốc có một dòng chú thích ngắn in dưới mỗi nhân vật.

TRANG SÁCH 106 · SCAN P115

Mối liên hệ giữa ăn uống và bệnh tật

Mối liên hệ giữa ăn uống và bệnh tật

Một số rau quả có tác dụng phòng bệnh:

Rau củ	
Cải xanh (cải bắp dạng hoa)	Hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất.
Củ bách hợp	Lợi tiểu, cầm máu, tiêu sưng.
Cải cay (mù tạt lá)	Sáng mắt.
Súp lơ xanh	Nhuận tràng, thanh nhiệt.
Bắp cải	Ích thận.
Rau chân vịt (cải bó xôi)	Dưỡng huyết, thanh nhiệt và giải độc, làm sạch ruột và dạ dày.
Mướp đắng	Thanh nhiệt, bổ khí.
Mướp hương	Bổ huyết, giải độc và hóa đàm, giảm đau.
Dưa chuột	Lợi tiểu, giải khát.

Bí đao	Thanh nhiệt, lợi tiểu.
Gừng tươi	Tán hàn, chống buồn nôn, hóa đàm và giải độc.
Ngó sen	Cầm nôn ra máu, giảm mệt mỏi, thanh nhiệt.
Cà rốt	Phòng nhiễm trùng, giảm sưng mặt và giải độc.
Cà chua	Giảm đau, tán huyết, tiêu sưng.
Nấm	Hỗ trợ tiêu hóa, hạ huyết áp.
Đậu Hà Lan	Bổ khí, cầm máu, lợi tiểu.
Đậu cô-ve (đậu que)	Dưỡng huyết, sáng mắt, phòng yếu mềm chi dưới.
Hành tây	Làm ra mồ hôi, hỗ trợ tiêu hóa, trị cảm lạnh.
Ớt đỏ	Tán hàn và trừ thấp, làm trẻ hóa cơ thể.
Đậu lăng	Tốt cho tỳ vị yếu, trị tiêu chảy.

TRANG SÁCH 107 · SCAN P116

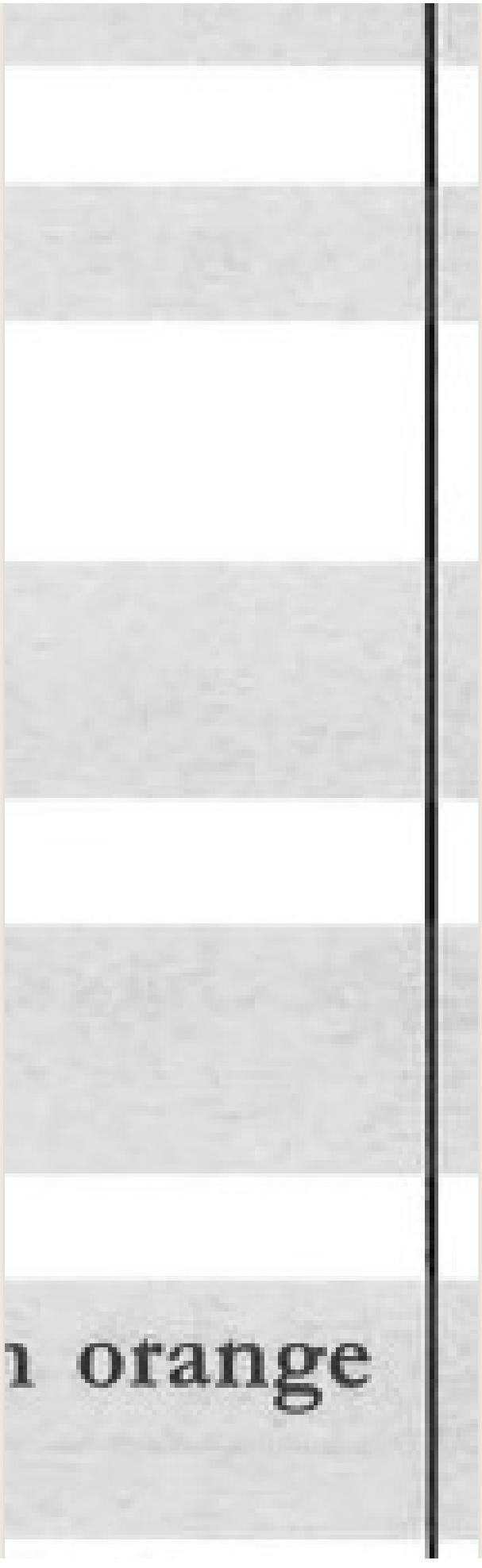
Trang 107

Trái cây	
Xoài	Trị ho, buồn nôn và chóng mặt.
Dưa hấu	Lợi tiểu, giải nhiệt, trị viêm thận.
Nho	Dưỡng huyết, lợi tiểu, trị bệnh gan.
Bưởi	Hỗ trợ tiêu hóa, trung hòa độc tố của rượu.
Lê	Trị ho và hóa đàm, giải khát, nhuận tâm phế.
Mía	Trị nhiễm trùng, bổ tỳ, giải khát, thanh độc.
Nhót (loquat)	Trị ho và nhuận phổi.
Hồng	Kích thích ăn ngon, làm sạch nhiễm trùng, trị ho và nhuận phổi.
Nhãn	Dưỡng huyết, an thần, kích thích ăn ngon và bổ tỳ.
Vải	Giải khát, làm sáng tinh thần.

Khế	Giải khát, thanh nhiệt, trị đau họng.
Đu đủ	Sáng mắt, thanh nhiệt, thanh nhiệt ở ruột, hỗ trợ tiêu hóa.
Táo	Dưỡng tâm và bổ khí, sinh tân dịch, giải khát.
Chanh	Hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, thanh khí.
Chuối	Giải khát, nhuận phổi và ruột, làm thông huyết mạch.
Ổi	Lợi tiểu, trị táo bón.
Quýt (mandarin)	Thông khí trệ, trị ho và trừ thấp.
La hán quả	Thanh nhiệt, trị ho.
Dứa (thơm)	Giải khát, phòng cảm nắng, tiêu sưng và trừ thấp.
Đào	Trị nhiễm trùng, làm tan cục máu đông, phòng táo bón.

HÌNH 231

lon
ne
n


n orange

Một mảnh cắt dọc cao và hẹp của cột bên trái bảng Trái cây, cho thấy các dải hàng xen kẽ có tô nền và không tô nền cùng phần đuôi bị cắt của vài tên trái cây, trong đó đọc được "Mandarin orange" ở gần cuối.

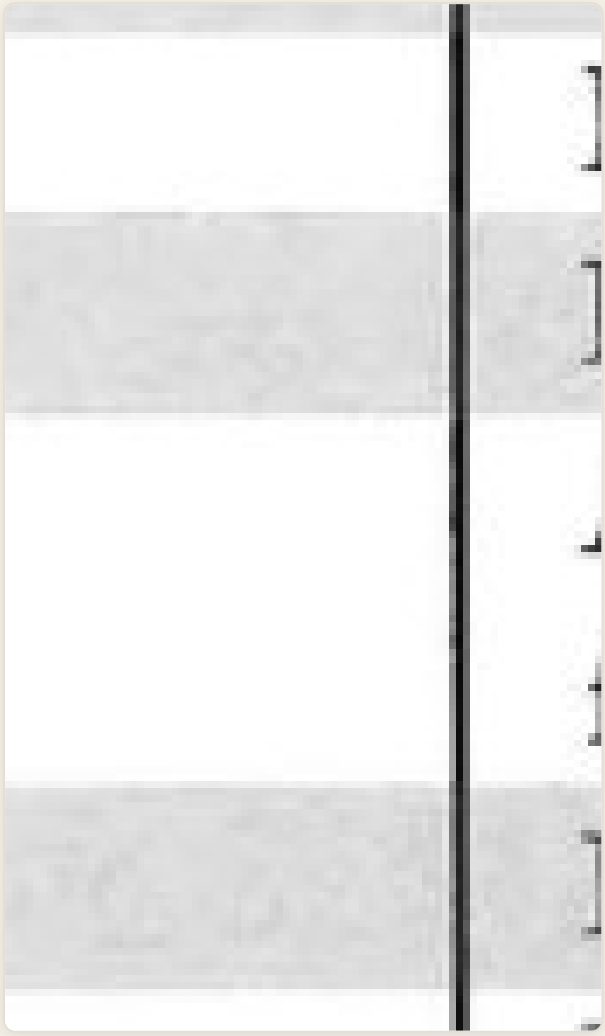
TRANG SÁCH 108 · SCAN P117

Trang 108

Khác	
Đậu đỏ	Lợi tiểu, trị yếu mềm chi dưới và chứng nước ứ đọng.
Đậu xanh	Lợi tiểu, thanh nhiệt.
Vừng (mè)	Bổ can thận; thúc đẩy sinh huyết.
Lạc (đậu phộng)	Cầm máu, làm đẹp da, trị yếu mềm chi dưới.
Hạt dẻ	Bổ thận.
Hạt dưa	Làm sáng sắc diện, bổ khí.
Óc chó (hạch đào)	Làm đẹp da, giúp tóc đen, bổ sung năng lượng.
Ô liu	Giải rượu, phòng ho.
Khoai lang	Bồi bổ tỳ, vị và thận.
Khoai tây	Hạ huyết áp, trị loét dạ dày, hen suyễn.
Ngô (bắp)	Bồi bổ cơ thể, dưỡng não, giúp đại tiện đều đặn.
Khoai mài (củ từ)	Bồi bổ đường ruột, trị tiêu chảy.
Hướng dương	Thúc đẩy sinh huyết, nhuận tràng.
Hoa hồng	Ích khí và thúc đẩy sinh huyết, tan vết bầm và giảm đau.
Cánh hoa bách hợp	Thanh nhiệt, an thần, phòng ho và hóa đàm.
Hoa cúc	Sáng mắt, thanh nhiệt, điều hòa huyết áp.

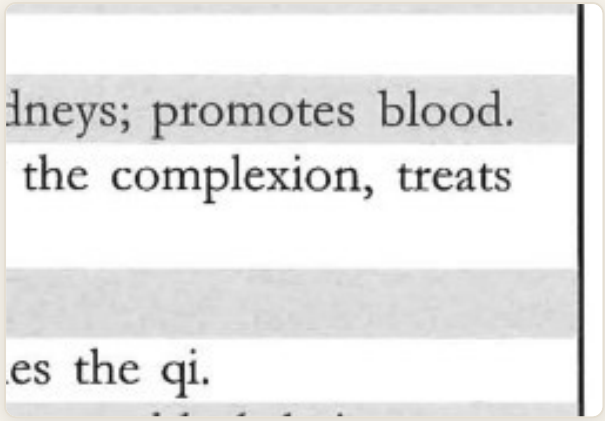
Đậu phụ	Làm sạch ruột và dạ dày, bổ khí.
Rong đen (mộc nhĩ đen)	Dưỡng huyết, giúp tóc đen.

HÌNH 232



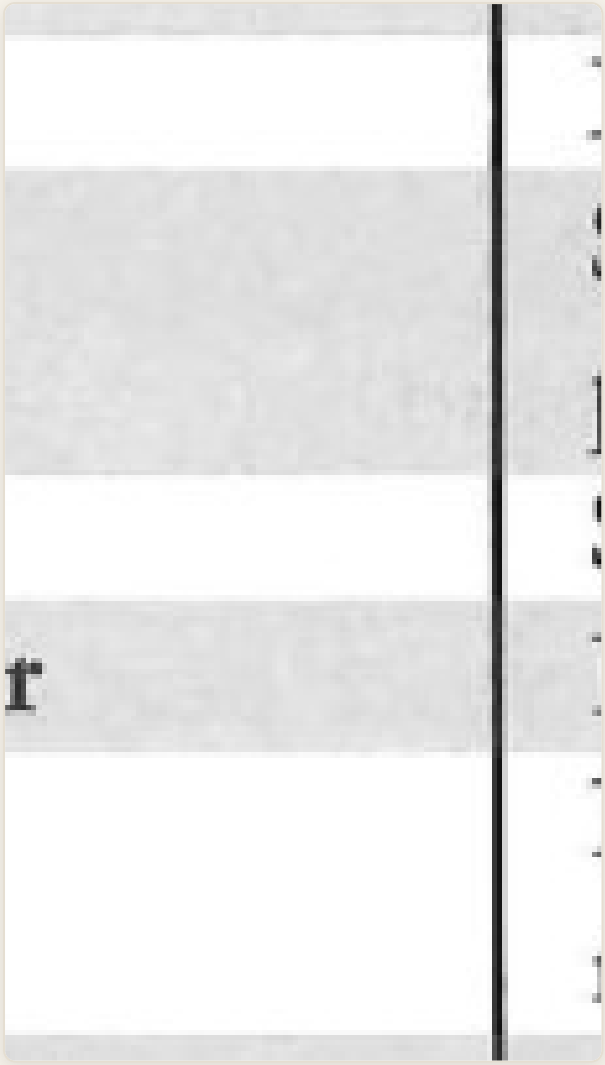
Một mảnh cắt nhỏ ở cột bên trái bảng Khác, cho thấy các dải hàng có tô nền và không tô nền cùng đường kẻ dọc của bảng.

HÌNH 233



Một mảnh cắt ở cột bên phải bảng Khác, mang theo phần đuôi bị cắt của vài dòng mô tả công dụng, trong đó có "...dneys; promotes blood." và "...es the qi."

HÌNH 234



Một mảnh cắt hẹp ở cột bên phải bảng Khác, cho thấy các dải hàng xen kẽ, đường kẻ dọc của bảng và một ký tự lạc ở mép.

TRANG SÁCH 109 · SCAN P118

Ngũ vị của thức ăn

Ngũ vị của thức ăn

"Năm vị của thức ăn là chua, mặn, cay, đắng và ngọt. Mỗi vị đem lại lợi ích cho một tạng khác nhau trong cơ thể."

"Ra vậy! Thế thì tôi chỉ cần ăn mãi để bổ cho cơ thể mình!"

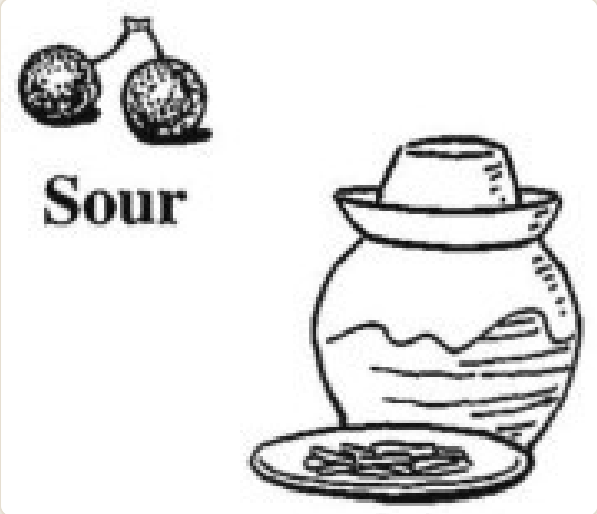
"Không phải vậy đâu. Ngũ tạng (năm tạng) phải phối hợp để cân bằng lẫn nhau."

"Nếu ăn quá nhiều một loại thức ăn, nó sẽ gây hại cho một tạng khác."

"Ăn đồ chua điều độ thì có lợi cho can (gan). Nhưng ăn quá nhiều sẽ hại tỳ (lá lách)."

"Nếu tỳ không hoạt động bình thường, nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tâm và phế. Phế lại ảnh hưởng đến can. Cứ thế thành một vòng luẩn quẩn."

HÌNH 235



Hai quả tròn nhỏ lốm đốm treo trên cuống, bên dưới có chữ in "Sour" (chua), cạnh đó là một hũ miệng rộng đựng muối với một đĩa nhỏ đựng hạt muối đặt phía trước.

HÌNH 236

Một chú rồng hoạt hình có bông hoa nhỏ trên đầu, đứng cạnh một bong bóng hội thoại, một tay giơ lên như đang thắc mắc.

HÌNH 237

Hình vẽ nét một quả mướp đắng, lớp vỏ sần sùi có gờ uốn cong nhọn về phía bên phải, phía trên có chữ in "Bitter" (đắng).

HÌNH 238

Hàng giữa của truyện tranh: hai chú rồng hoạt hình đối diện nhau, mỗi chú có một bong bóng hội thoại — chú rồng bên trái nói rằng mình chỉ cần ăn mãi để bổ cho cơ thể, chú rồng bên phải chỉnh lại rằng ngũ tạng phải phối hợp để cân bằng lẫn nhau; ở mép phải có bong bóng thứ ba bắt đầu, cảnh báo rằng ăn quá nhiều một loại thức ăn sẽ hại một tạng khác.

HÌNH 239

Khung dưới bên trái của truyện tranh: một chú rồng hoạt hình đang nói, bong bóng hội thoại giải thích rằng ăn đồ chua điều độ thì có lợi cho can, nhưng ăn quá nhiều sẽ hại tỳ.

HÌNH 240

Khung dưới bên phải của truyện tranh: một chú rồng hoạt hình có chiếc nơ buộc ở đuôi, vừa nói vừa khoát tay, bong bóng hội thoại giải thích rằng tỳ hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng đến thận, thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tâm và phế, phế lại ảnh hưởng đến can — một vòng luẩn quẩn.

TRANG SÁCH 110 · SCAN P119

Mối quan hệ giữa Ngũ vị và Ngũ tạng:

Mối quan hệ giữa Ngũ vị và Ngũ tạng:

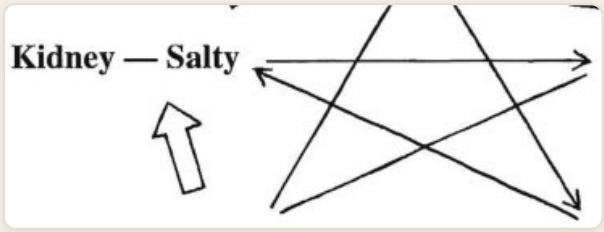
- - Can (gan) — Chua
- - Tâm (tim) — Đắng
- - Phế (phổi) — Cay
- - Tỳ (lá lách) — Ngọt
- - Thận — Mặn

Ăn quá nhiều một vị sẽ gây hại cho cơ thể:

Vị	Tác hại

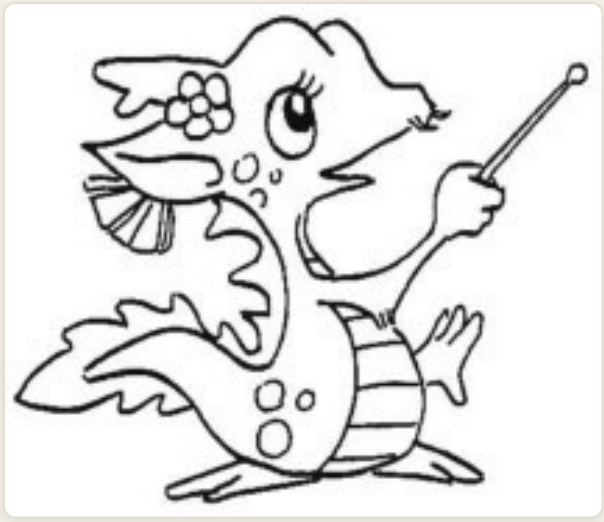
Quá chua	Da trở nên dày và nhăn nheo. Người mắc bệnh về cơ bắp và tỳ nên tránh đồ chua.
Quá mặn	Gây khát, làm máu đặc lại. Người mắc bệnh về huyết và tâm nên tránh đồ mặn.
Quá cay	Gây co cứng cơ và móng tay giòn. Người mắc bệnh về hệ hô hấp và can nên tránh đồ cay.
Quá đắng	Gây da khô héo và rụng tóc. Người mắc bệnh về xương và phế nên tránh đồ đắng.
Quá ngọt	Gây đau xương khớp và rụng tóc. Người mắc bệnh về cơ thịt và thận nên tránh đồ ngọt.

HÌNH 241



Một mảnh của biểu đồ: ngôi sao năm cánh được vẽ bằng những đường dài có đầu mũi tên đan chéo nhau, kèm nhãn in "Kidney — Salty" (Thận — Mặn) và một mũi tên ngắn hướng lên ở bên trái.

HÌNH 242



Một chú rồng hoạt hình cầm que chỉ dài giơ lên bằng một chân trước, miệng há ra như đang giảng giải biểu đồ, trên đầu cài một bông hoa và ở đuôi buộc một chiếc nơ.

TRANG SÁCH 111 · SCAN P120

Bốn tính của thức ăn

Bốn tính của thức ăn

Thức ăn có thể mang tính ôn (ấm), nhiệt (nóng), hàn (lạnh) hoặc lương (mát).

Thức ăn ôn nhiệt (ấm, nóng): thịt cừu, gừng tươi, tỏi, cà rốt, nhãn, tiêu, rượu v.v.

Công dụng: Bổ tỳ, kích thích ăn ngon, bổ thận, bồi bổ cơ thể.

Thức ăn hàn lương (lạnh, mát): vịt, cua, đậu phụ, rau chân vịt, mướp đắng, lê, đậu xanh v.v.

Công dụng: Thanh nhiệt, giáng hỏa (hạ hỏa), giải độc.

Thức ăn không nóng cũng không lạnh: gạo, đậu nành, thịt lợn, cá chép, nấm, táo, bí đỏ v.v.

Công dụng: Phù hợp với người ốm yếu và người đang hồi phục nói chung.

TRANG SÁCH 112 · SCAN P121

Bốn loại thuốc bổ

Bốn loại thuốc bổ

Thuốc bổ thường là những món ăn được chế biến cùng các vị thuốc. Chúng được dùng như một phần trong khẩu phần ăn hằng ngày, vừa có tác dụng chữa bệnh cho người ốm, vừa mang lại lợi ích cho người khỏe mạnh. Trước khi dùng bất kỳ loại thuốc bổ nào, chúng ta nên hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình để chọn loại phù hợp giúp cải thiện sức khỏe.

Bổ khí:

Ví dụ: nhân sâm, táo đỏ (táo Tàu), cam thảo v.v.

Phù hợp với người hay mệt mỏi, hụt hơi, ăn kém ngon, dễ đổ mồ hôi, đang bị cảm lạnh.

Bổ huyết:

Ví dụ: đương quy (angelica), *shoudi* (thục địa), hà thủ ô (fleeceflower root), kỷ tử (wolfberry) v.v.

Phù hợp với người da nhợt nhạt, hay chóng mặt và nhìn mờ, mắc chứng mất ngủ.

Bổ âm:

Ví dụ: củ bách hợp, *shashen* (sa sâm), *zhimu* (tri mẫu), nấm tuyết (ngân nhĩ) v.v.

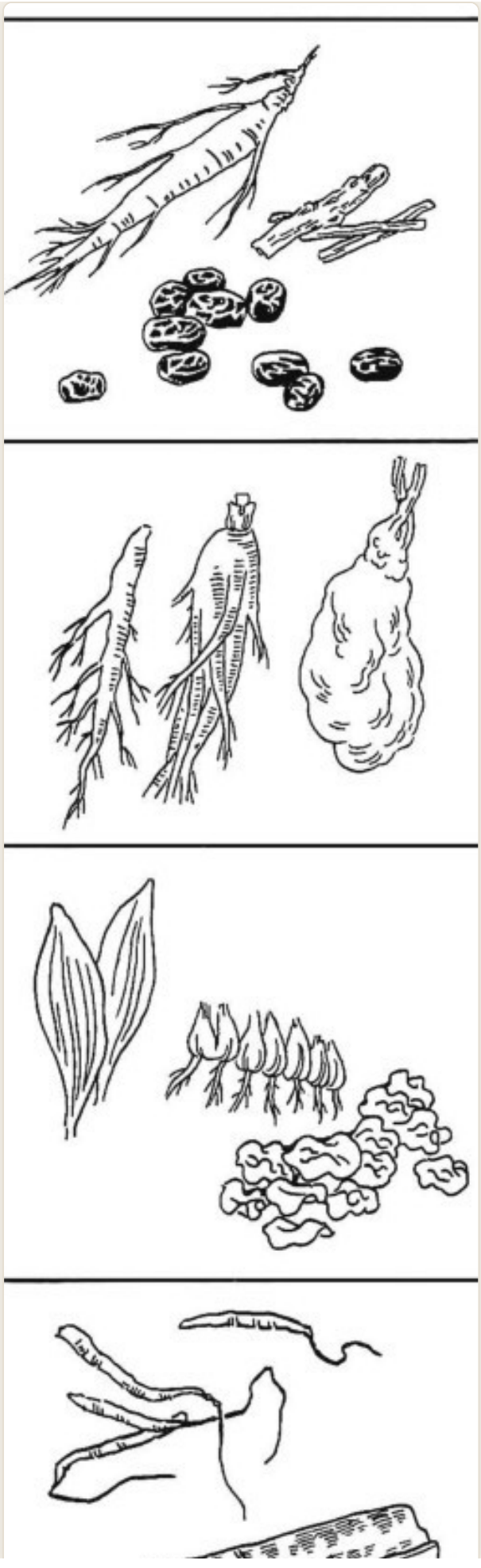
Phù hợp với người thể trạng yếu, mất ngủ do căng thẳng, táo bón, chóng mặt kèm ù tai, khô miệng.

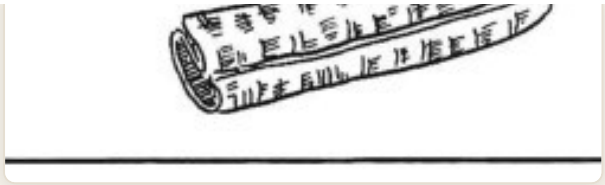
Bổ dương:

Ví dụ: đông trùng hạ thảo (cordyceps), phụ tử (monkshood daughter root), nhục quế (Chinese cinnamon bark) v.v.

Phù hợp với người sợ lạnh, chân tay lạnh, lưng và tay chân yếu mỏi nhức, tiểu tiện nhiều lần.

HÌNH 243





Một dải cắt cao ở cột bên trái của bảng các loại thuốc bổ, chứa bốn hình minh họa nguyên liệu bổ xếp chồng lên nhau: rễ nhân sâm cùng một bó cành khô và một đống lát tròn sẫm màu; hai rễ phân nhánh nhiều rễ con bên cạnh một củ to phình; một củ bách hợp xếp lớp cùng một chùm rễ nhỏ đầu nhọn và một cụm nấm tuyết xù xì; và một thân rễ dài mảnh cùng một con đông trùng hạ thảo hình sâu bướm bên cạnh một thanh quế cuộn vỏ sần sùi.

TRANG SÁCH 113 · SCAN P122

Kiêng ăn

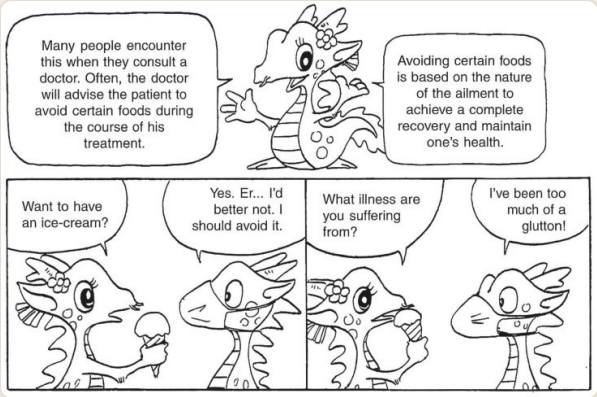
Kiêng ăn

Những món cần tránh khi bị bệnh

Chứng bệnh	Món cần tránh
Sốt cao	Đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay nóng.
Mất ngủ	Trà đặc, cà phê.
Phù nề (ứ nước)	Muối.
Cảm lạnh	Đồ chiên ngập dầu, đồ ngọt, rượu, ớt, nấm tuyết (ngân nhĩ).
Ho	Đồ chiên ngập dầu hoặc nhiều mỡ, rượu, tiêu, tôm.
Tiêu chảy	Cá, tôm, đồ chiên và chiên ngập dầu, thịt mỡ, gừng tươi, tiêu.
Đột quỵ	Thịt và rau muối, thịt mỡ, cà phê, trà đặc.
Táo bón	Rượu, cà phê, ớt, nấm tuyết.
Hen suyễn	Thịt mỡ, cá, tôm, cua, rượu, đậu nành, bí đỏ, cải bẹ, nước ngọt có ga.
Đái tháo đường	Đường, mía, trái cây, khoai lang, tinh bột, củ mã thầy, củ sen, khoai mài.
Sỏi thận	Hải sản có vỏ, măng tây, rau chân vịt, đậu phụ, đậu lăng, quả hồng.

Cao huyết áp	Nội tạng động vật, gạch cua, lòng đỏ trứng, ớt, rượu, trà đặc, cà phê.
Vàng da	Thịt mỡ, đồ chiên ngập dầu, ớt, rượu, cá, tôm, cua.
Hồi hộp, tim đập nhanh	Thịt mỡ, trà đặc, cà phê.

HÌNH 244



Chú rồng nhỏ đội hoa đứng giữa hai ô thoại: ô bên trái nói rằng rất nhiều người gặp lời khuyên này khi đi khám, thầy thuốc thường bảo người bệnh kiêng một số món trong suốt quá trình chữa trị; ô bên phải nói rằng việc kiêng món này món kia là dựa trên tính chất của bệnh, nhằm giúp bệnh khỏi hẳn và giữ gìn sức khỏe. Bên dưới là dải truyện bốn khung: chú rồng đưa ra một cây kem; chú rồng kia tuy thèm nhưng vẫn khoát tay từ chối, bảo rằng mình nên kiêng; chú rồng thứ nhất hỏi đang mắc bệnh gì; và chú rồng thứ hai thú nhận rằng mình chỉ ăn quá nhiều mà thôi.

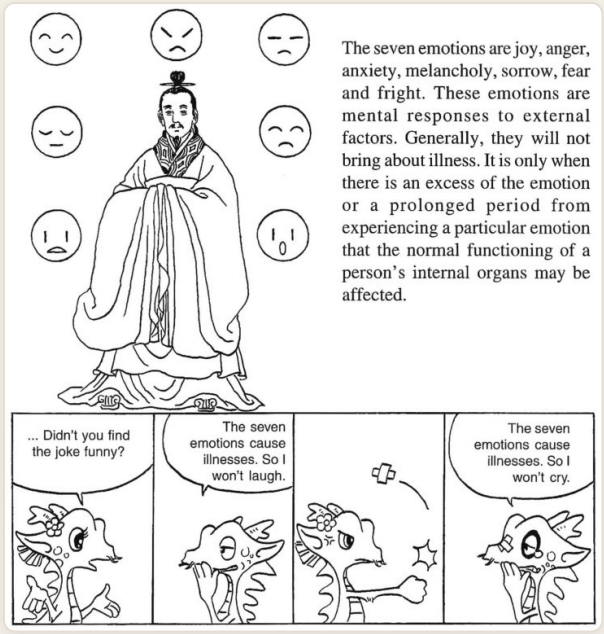
TRANG SÁCH 114 · SCAN P123

Phương pháp thứ năm — Tâm lý liệu pháp

Phương pháp thứ năm — Tâm lý liệu pháp

Người ta thường nói: Bệnh trong lòng thì phải lấy thuốc trong lòng mà chữa. Câu này nói về những bệnh do tâm lý. Các thầy thuốc Trung Hoa gọi những bệnh do yếu tố tâm lý gây ra là bệnh của thất tình (bảy thứ tình cảm).

HÌNH 245

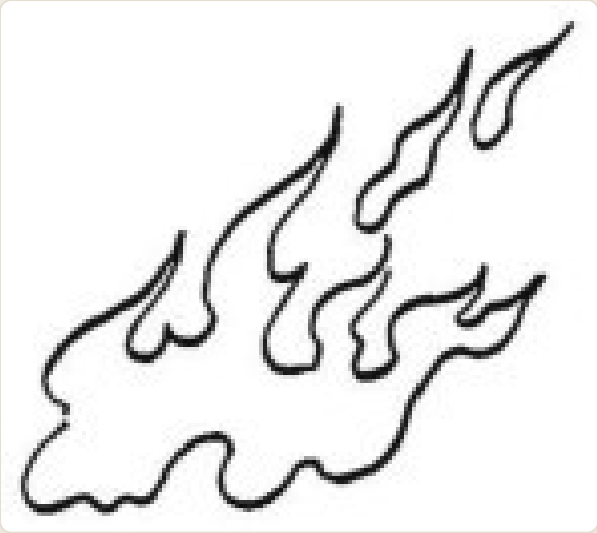


Một danh y Trung Hoa trong bộ áo rộng và mũ văn sĩ đứng khoanh tay trước ngực. Quanh ông là bảy khuôn mặt tròn, mỗi khuôn mặt mang một vẻ khác nhau: mặt cười, mặt cau có, mặt bình thản, mặt ủ rũ, mặt nhíu mày, mặt khóc và mặt giật mình hoảng hốt. Bên phải ông là một khối chữ giải thích rằng thất tình gồm hỷ (vui), nộ (giận), ưu (lo), tư (u sầu), bi (buồn thương), khủng (sợ hãi) và kinh (kinh hoảng); rằng đó là những phản ứng tinh thần trước các yếu tố bên ngoài; rằng bình thường chúng không gây bệnh; và chỉ khi một cảm xúc trở nên quá độ, hoặc kéo dài dai dẳng, thì hoạt động bình thường của các tạng phủ bên trong mới có thể bị ảnh hưởng. Bên dưới là dải truyện bốn khung về chú rồng nhỏ: ngơ ngác không hiểu vì sao bạn mình không thấy câu đùa buồn cười; bạn đáp rằng vì thất tình gây bệnh nên mình không cười; chú rồng vung gậy đập bạn; và bạn rồng, nước mắt lưng tròng, nói rằng vậy mình cũng không khóc nữa.

Thất tình và mối quan hệ với ngũ tạng, ngũ hành

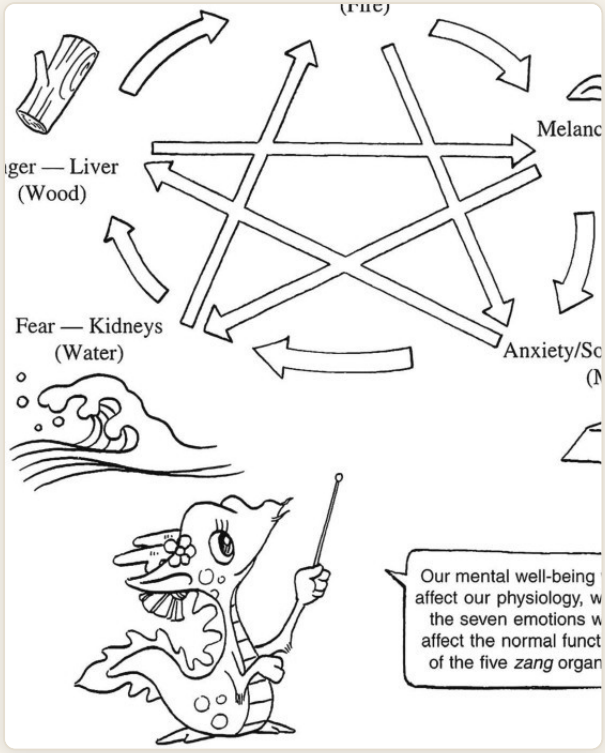
Thất tình và mối quan hệ với ngũ tạng, ngũ hành

HÌNH 246



Hình vẽ cách điệu những ngọn lửa đang bùng lên, biểu tượng của hành Hỏa.

HÌNH 247

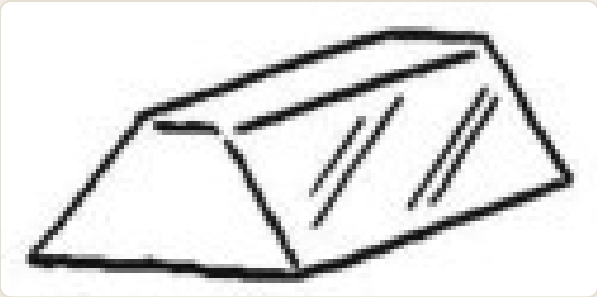


Một ngôi sao năm cánh vẽ trên nền đồ hình ngũ hành. Các đỉnh được ghi tên, theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: Hỷ/Kinh — Tâm (Hỏa); Tư — Tỳ (Thổ); Ưu/Bi — Phế (Kim); Khủng — Thận (Thủy); Nộ — Can (Mộc). Những mũi tên cong lớn nối từ đỉnh này sang đỉnh kế tiếp phía ngoài ngôi sao, còn bên trong là các đường thẳng đan chéo nhau. Cạnh đồ hình có hình vẽ khúc gỗ chẻ đôi tượng trưng cho Mộc và ngọn sóng vỗ tượng trưng cho Thủy. Ở phía dưới bên trái, chú rồng nhỏ dùng gậy chỉ vào một ô thoại nói rằng trạng thái tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến sinh lý, còn thất tình thì ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngũ tạng.

HÌNH 248

Hình vẽ nhỏ hai ngọn đồi tròn, biểu tượng của hành Thổ.

HÌNH 249



Hình vẽ nhỏ một thỏi kim loại hình nêm, biểu tượng của hành Kim.

TRANG SÁCH 116 · SCAN P125

Trang 116

Hỷ (vui mừng) có hại cho Tâm

Người xưa nói: "Buồn sinh ra từ niềm vui quá độ." Tuy hỷ (vui mừng) là biểu hiện của hạnh phúc, nhưng vui quá mức sẽ làm hao tổn tinh thần và khí, gây tổn hại cho tâm.

HÌNH 251

Chân dung một người đàn ông mặc cổ phục, tóc búi thành búi trên đỉnh đầu, đang cười sảng khoái, miệng há to và mắt nhắm tít lại.

Kinh (giật mình) có hại cho Tâm

Kinh (giật mình) là khi một việc bất ngờ xảy đến gây cảm giác lo lắng và sợ hãi. Nhịp tim sẽ đập nhanh hơn, làm tăng thêm gánh nặng cho tâm.

HÌNH 252

Chân dung một cậu bé giật mình, đầu cạo trọc chỉ chừa một chỏm tóc, hai tay ôm chặt lấy ngực; mồ hôi văng ra từ đầu và mắt mở to vì hoảng hốt.

Nộ (giận dữ) có hại cho Can

Nộ (giận) là cảm giác bực bội, khiến khí đi ngược và chạy lên phía trên. Điều này có thể gây hại cho khí ở can (gan).

HÌNH 250

Chân dung một người đàn ông vạm vỡ, đầu hói, mặt mày cau có dữ dằn và hai tay nắm chặt, trên đỉnh đầu bùng lên những ngọn lửa.

Tư (u sầu) có hại cho Tỳ

Đắm chìm trong tư (u sầu) hay đa cảm sẽ dẫn đến trầm cảm, ăn mất ngon, gây hại cho khí ở tỳ (lá lách).

HÌNH 255

Chân dung một người phụ nữ với kiểu tóc búi cầu kỳ cài hoa, chống cằm lên tay, vẻ mặt ủ rũ, bâng khuâng.

Bi (buồn thương) có hại cho Tâm và Phế

Bi (buồn thương) là biểu hiện của nỗi buồn và tâm trạng rối bời. Đắm chìm trong bi thương sẽ làm tổn hại đến tâm và phế (phổi).

HÌNH 254

Chân dung một người phụ nữ búi tóc, đang lấy khăn áp vào mặt và khóc lặng lẽ.

Khủng (sợ hãi) có hại cho Thận

Khủng (sợ hãi) là nỗi khiếp sợ hay kinh hoàng. Đó là biểu hiện cực độ của sự lo lắng và sẽ gây hại cho thận.

HÌNH 253

Chân dung một người đàn ông quấn khăn trên đầu, co ro lấy tay che miệng, răng đánh lập cập; những làn hơi lạnh uốn lượn quanh người.

TRANG SÁCH 117 · SCAN P126

Dùng cảm xúc này để chế ngự cảm xúc kia

Dùng cảm xúc này để chế ngự cảm xúc kia

Vì bệnh trong lòng thì phải lấy thuốc trong lòng mà chữa, nên thuốc men không thể làm nổi việc chữa trị ấy. Chỉ khi điều chỉnh được cảm xúc thì mới đạt được hiệu quả chữa trị tốt nhất.

Bảy thứ tình cảm (thất tình) vừa thúc đẩy vừa kìm hãm lẫn nhau. Một loại cảm xúc này sẽ dẫn đến một loại cảm xúc khác:

Đắm chìm trong u sầu và lo lắng → Tâm trạng bi quan, buồn bã → Sự nhút nhát, sợ hãi

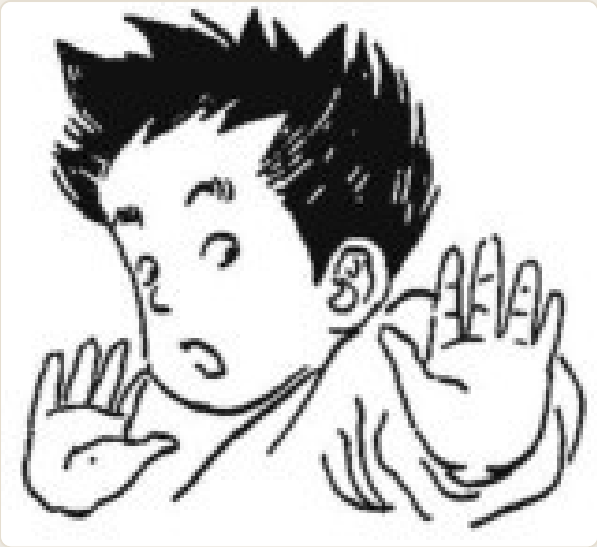
HÌNH 256

Bức chân dung thứ nhất trong chuỗi ba hình: một người đàn ông chống cằm, vẻ mặt cau có suy tư, trên đầu có một nét ngoằn ngoèo như làn khói bực bội bốc lên.

HÌNH 258

Bức chân dung thứ hai: một thiếu niên ủ rũ, mắt cụp xuống, miệng trễ xuống, có một mũi tên nhỏ chỉ vào từ bên trái.

HÌNH 257



Bức chân dung thứ ba: một thanh niên giật mình, tóc dựng đứng, giơ hai bàn tay ra trước mặt, miệng há ra vì hoảng hốt.

Phương pháp dùng cảm xúc này để chế ngự cảm xúc kia là lấy một cảm xúc kìm hãm một cảm xúc khác:

Bi thắng nộ: Nỗi buồn sẽ khiến cơn giận tan biến. Có thể dùng cách này để chữa những bệnh phát sinh từ sự giận dữ.

Nộ thắng tư: Người u sầu có thể bị khơi lên cơn giận để làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng họ.

Tư thắng khủng: U sầu giúp con người ta lý trí hơn, nhờ đó nỗi sợ hãi vô cớ có thể bị khuất phục bằng lý lẽ.

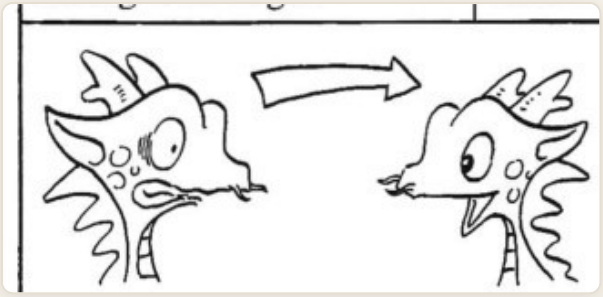
Khủng thắng hỷ: Làm cho người bệnh đang chìm đắm trong niềm vui quá độ sợ hãi sẽ giúp họ bình tĩnh lại.

Hỷ thắng bi: Hãy chăm sóc người bệnh và đáp ứng nhu cầu của họ để họ thấy vui. Điều đó sẽ kìm hãm nỗi buồn mà họ đang mang.

HÌNH 259

Hàng trên của đồ hình: ba ô nằm cạnh nhau, mỗi ô vẽ một đôi rồng nhỏ với một mũi tên rỗng chỉ từ trái sang phải ở giữa, minh họa một cảm xúc kìm hãm một cảm xúc khác.

HÌNH 260



Một ô ở hàng dưới của đồ hình: hai chú rồng nhỏ với một mũi tên rỗng ở giữa, con bên trái trợn mắt há miệng dữ dằn còn con bên phải thì mỉm cười.

TRANG SÁCH 118 · SCAN P127

Vị danh y bị nấu chín

Vị danh y bị nấu chín

Thời Xuân Hạ có một danh y tên là Văn Chí. Một hôm, ông được triệu vào chữa bệnh đau đầu cho vua nước Tề.

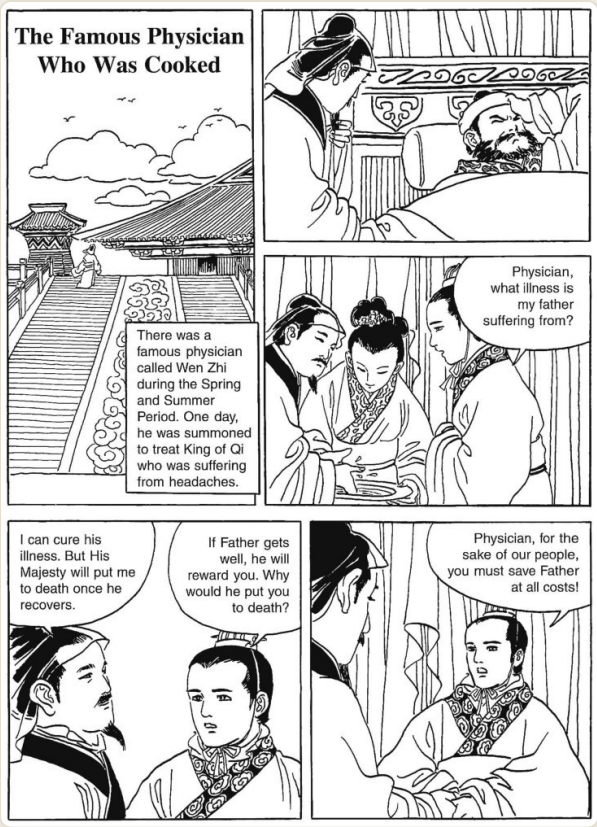
"Thưa thầy thuốc, cha tôi mắc bệnh gì?"

"Ta có thể chữa khỏi bệnh cho người. Nhưng khi khỏi bệnh, nhà vua sẽ giết ta."

"Nếu cha tôi khỏi bệnh, người sẽ thưởng cho thầy. Sao lại giết thầy được?"

"Thưa thầy thuốc, vì muôn dân, xin thầy nhất định cứu cha tôi!"

HÌNH 261



Toàn bộ trang truyện tranh. Ô khung trên cùng bên trái: tên truyện và cảnh sân cung điện với cổng có mái và dãy bậc thềm dài, phía dưới bên phải là một ô chữ kể chuyện. Ô khung trên cùng bên phải: Văn Chí đội mũ văn sĩ cúi xuống bên giường vua Tề, nhà vua nằm trên giường với một miếng vải đắp trên trán. Ô khung giữa bên phải: Văn Chí cùng hai người hầu túc trực bên vua, còn vị thái tử trẻ tuổi cất lời hỏi. Ô khung dưới cùng bên trái: Văn Chí và thái tử đối diện trò chuyện. Ô khung dưới cùng bên phải: thái tử van xin Văn Chí cứu cha mình.

TRANG SÁCH 119 · SCAN P128

Trang 119

"Nhưng xin hứa với ta một điều. Dù ta có làm gì, ngươi cũng không được can thiệp."

"Được."

Sau khi về nhà, Văn Chí không còn đến cung chữa bệnh cho vua nữa.

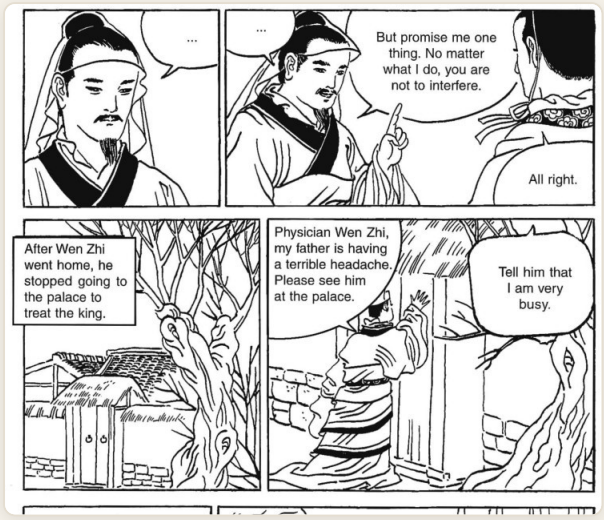
"Thưa thầy Văn Chí, cha tôi đau đầu dữ dội. Xin thầy đến cung xem bệnh cho người."

"Hãy nói với người rằng ta rất bận."

"Tên thầy thuốc hèn mọn ấy dám khinh thường ta!"

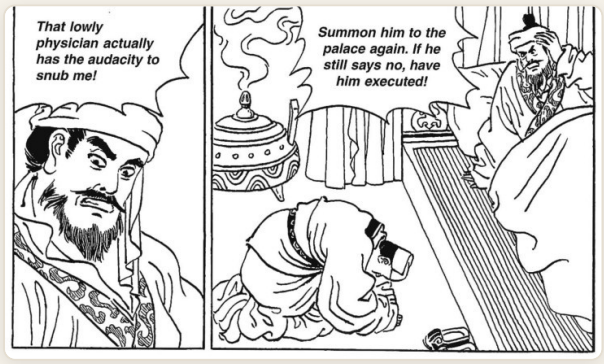
"Hãy triệu hắn vào cung lần nữa. Nếu hắn vẫn từ chối, hãy đem hắn ra xử tử!"

HÌNH 262



Phần trên của trang truyện. Ô bên trái: cận cảnh Văn Chí cúp mắt, bong bóng thoại chỉ có một dấu lửng. Ô bên phải: Văn Chí giơ một ngón tay ra điều kiện duy nhất, còn thái tử quay lưng lại đáp "Được". Ô dưới bên trái: ngôi nhà của Văn Chí đứng sau một gốc cây xù xì, bên cạnh là ô chữ kể chuyện. Ô dưới bên phải: một người đưa tin đứng trước cổng báo tin vua đau đầu, còn lời đáp của Văn Chí vọng ra từ sau cánh cửa.

HÌNH 263



Hàng dưới của trang truyện. Ô bên trái: cận cảnh một người đàn ông râu quai nón, mặt mày giận dữ vì cảm thấy bị khinh thường. Ô bên phải: vua Tề ngồi trên ngai ra lệnh triệu thầy thuốc, trong khi một người đưa tin quỳ gối cúi lạy trước mặt vua.

Trang 120

Cuối cùng Văn Chí cũng xuất hiện ở cung. Nhưng ông giẫm lên giường của vua Tề mà không cởi giày.

"Ngài vẫn còn sống à? Nhìn bộ dạng ngài kìa, ngày tháng của ngài chẳng còn bao nhiêu đâu!"

"Ngươi! Ngươi!"

"Đi khám thầy thuốc thì có ích gì? Ngài đang phí thời gian của ta!"

"Kẻ xấc xược! Quân đâu, ta muốn nấu chín tên thầy thuốc đáng ghê tởm này trong nồi!"

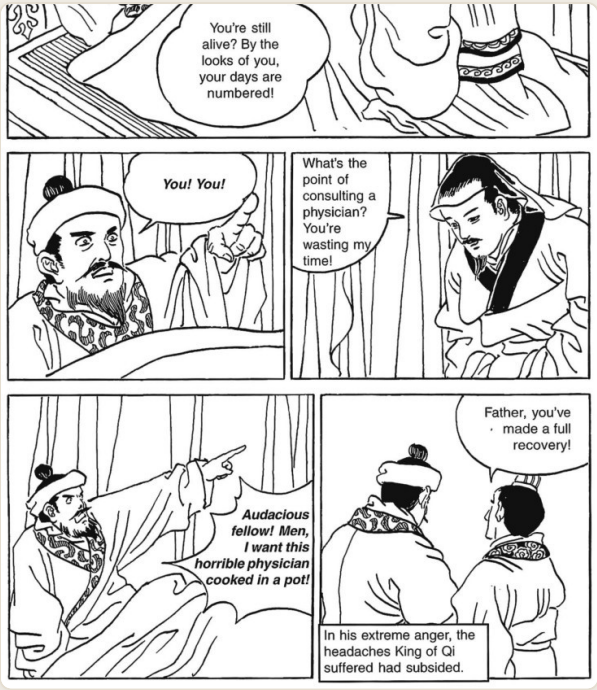
"Cha ơi, cha đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi!"

Trong cơn giận dữ tột độ, những cơn đau đầu mà vua Tề mắc phải đã thuyên giảm.

HÌNH 264

Dải trên cùng của trang truyện: ô chữ kể chuyện ở bên trái, và bên phải là Văn Chí đứng cạnh giường vua Tề, nhà vua nằm tựa trên gối dưới tán màn.

HÌNH 265



Phần còn lại của trang truyện. Ô trên: Văn Chí buông lời chế giễu vua trên giường bệnh, bong bóng thoại chứa lời lăng mạ. Ô giữa bên trái: vua Tề giận dữ chỉ tay hét "Ngươi! Ngươi!". Ô giữa bên phải: Văn Chí quay lưng bỏ đi với vẻ khinh bỉ. Ô dưới bên trái: vua Tề ngồi ra lệnh nấu chín thầy thuốc trong nồi. Ô dưới bên phải: thái tử báo với vua rằng người đã khỏi bệnh hoàn toàn, kèm một ô chữ kể chuyện bên dưới.

TRANG SÁCH 121 · SCAN P130

Trang 121

"Xin tha mạng cho vị thầy thuốc."

"Ai cầu xin tha mạng cho hắn cũng sẽ bị đem đi nấu chín!"

"Thầy thuốc Văn Chí..."

"Đừng buồn. Ta biết ngày này sẽ đến. Nay bệ hạ đã bình phục hoàn toàn, ta có thể chết mà không hối tiếc."

"Vài ngày sau..."

"Thầy thuốc Văn Chí đã cố tình chọc tức ngài để chữa chứng đau đầu của ngài."

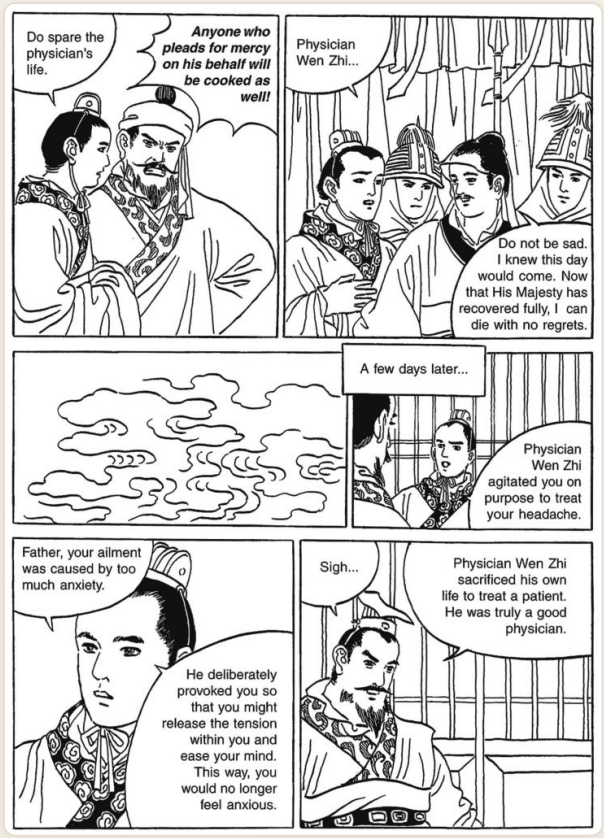
"Thưa cha, bệnh của cha là do quá nhiều lo nghĩ mà ra."

"Ông ấy cố tình chọc giận cha để cha có thể giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng và nhẹ nhõm tinh thần. Như vậy cha sẽ không còn cảm thấy lo âu nữa."

"Than ôi..."

"Thầy thuốc Văn Chí đã hy sinh mạng sống của mình để chữa bệnh cho người bệnh. Ông ấy thật sự là một vị thầy thuốc giỏi."

HÌNH 266



Toàn bộ trang là một dải truyện tranh gồm ba hàng khung, tiếp nối câu chuyện về thầy thuốc Văn Chí (Wen Zhi). Khung trên cùng bên trái: một người trẻ mặc áo có hoa văn chắp tay cầu xin nhà vua đội mũ có tua và để râu dài tha mạng cho vị thầy thuốc; nhà vua giận dữ từ chối, nói rằng ai cầu xin tha mạng cho hắn cũng sẽ bị đem đi nấu chín. Khung trên cùng bên phải: binh lính mặc giáp đứng canh quanh Văn Chí, ông mỉm cười bình thản khi được báo rằng mình sắp bị xử tử, và đáp rằng ông đã biết ngày này sẽ đến, nay bệ hạ đã bình phục nên ông có thể chết mà không hối tiếc. Khung giữa bên trái là một bức phong cảnh không lời, chỉ có những đám mây cuộn. Khung giữa bên phải có dòng chú thích "Vài ngày sau...", phía sau song cửa sổ một người đang giải thích cho thái tử rằng Văn Chí cố tình chọc tức ngài để chữa chứng đau đầu. Khung dưới bên trái: thái tử ngồi với vẻ mặt buồn bã, được cho biết rằng bệnh của cha ngài là do quá nhiều lo nghĩ, và Văn Chí cố tình chọc giận ngài để ngài giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng, nhờ đó tinh thần được nhẹ nhõm. Khung dưới bên phải: nhà vua đứng sau song sắt, thở dài nặng nề, một ô thoại nói rằng Văn Chí đã hy sinh mạng sống để chữa bệnh cho người bệnh và thật sự là một vị thầy thuốc giỏi.

Các kiểu tính cách trong y học cổ truyền Trung Quốc

Các kiểu tính cách trong y học cổ truyền Trung Quốc

Tính cách con người cũng có thể được phân loại dựa trên âm dương và ngũ hành, từ đó tạo ra năm kiểu tính cách *thái* và năm kiểu tính cách theo ngũ hành.

Năm kiểu tính cách *Thái*

Người Thái Dương

- - Đặc điểm: Dễ tính, nói năng không suy nghĩ trước, tham vọng trong đời quá cao.
- - Dáng vẻ: Đi đứng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bụng hóp, lưng thẳng.

Người Thiếu Dương

- - Đặc điểm: Khéo giao tiếp, năng lực mạnh, tự cao tự đại.
- - Dáng vẻ: Khi đứng thì ngẩng cao đầu, đi lại vênh váo, có thói quen chắp hai tay ra sau lưng với lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Người Âm Dương Hòa Bình

- - Đặc điểm: Tấm lòng trong sáng, ít ham muốn, biết đủ, điềm tĩnh, dễ thích nghi.
- - Dáng vẻ: Nét mặt bình thản, ung dung tự tại, phong thái thoải mái.

Người Thiếu Âm

- - Đặc điểm: Tham lam, thích chuyện phiếm, thiếu lòng thương người.
- - Dáng vẻ: Vẻ mặt lạnh nhạt, kín đáo, đi lại lặng lẽ, khi đứng thì hay ngọ nguậy.

Người Thái Âm

- - Đặc điểm: Khôn ngoan và sâu kín, khó bộc lộ cảm xúc, hành động chậm rãi, khư khư giữ nếp cũ.
- - Dáng vẻ: Vẻ mặt trầm ngâm, ít khi mỉm cười, lúc nào cũng như đang suy nghĩ sâu xa.

HÌNH 267

Tranh vẽ nét chân dung nửa người, phần đầu và vai, của kiểu Thái Dương: một người đàn ông búi tóc thành búi trên đỉnh đầu, lông mày đen rậm, ánh mắt nhìn thẳng đầy cương nghị, cổ áo sẫm màu, đầu hơi quay sang một bên.

HÌNH 268

Tranh vẽ nét chân dung nửa người, phần đầu và vai, của kiểu Thiếu Dương: một người đàn ông quấn một mảnh vải quanh búi tóc, vải buông xuống phía sau, cằm hếch lên, mắt nhìn lên và nhìn sang hướng khác, mặc áo có cổ đầy hoa văn nổi bật.

HÌNH 269

Ba bức chân dung vẽ nét xếp chồng lên nhau. Bức trên cùng là kiểu Âm Dương Hòa Bình: một người đàn ông để râu, đội mũ vải mềm có hai vành che tai, mặc áo hoa văn, nét mặt bình thản ung dung. Bức ở giữa là kiểu Thiếu Âm: một người đàn ông búi tóc, liếc xéo với vẻ lạnh nhạt, khóe miệng trễ xuống. Bức dưới cùng là kiểu Thái Âm: một người đàn ông đội mũ kẻ ô sẫm màu, có ria mép và râu, lông mày rủ xuống thành vẻ mặt trầm tư, ưu uất.

TRANG SÁCH 123 · SCAN P132

Năm kiểu tính cách theo ngũ hành

Năm kiểu tính cách theo ngũ hành

Người hành Hỏa

- - Đặc điểm: Làm việc nhanh nhẹn, chịu được áp lực, có năng lực, hào phóng và ít coi trọng tiền bạc.
- - Dáng vẻ: Sắc mặt hồng hào, mặt gầy, đầu nhỏ, tay chân nhỏ.

Người hành Kim

- - Đặc điểm: Vừa trầm tĩnh vừa năng động, làm việc tinh khôn, trung thực.
- - Dáng vẻ: Sắc mặt nhợt nhạt, mặt vuông, đầu nhỏ, vai nhỏ, bụng nhỏ.

Người hành Thổ

- - Đặc điểm: Đáng tin cậy, biết tiết chế cảm xúc, hay giúp đỡ người khác.
- - Dáng vẻ: Sắc mặt hơi vàng, mặt tròn, đầu to, vai và lưng dày, bụng to, tay chân nhỏ.

Người hành Mộc

- - Đặc điểm: Tài hoa và thông minh, hướng nội, hay u sầu, hành động có toan tính.
- - Dáng vẻ: Sắc mặt nhợt nhạt, mặt dài và đầu nhỏ, vai và lưng rộng, tay chân nhỏ.

Người hành Thủy

- - Đặc điểm: Năng động, hay do dự.
- - Dáng vẻ: Sắc mặt sạm tối, đầu to, vai nhỏ, bụng to.

HÌNH 270

Hai bức chân dung vẽ nét xếp chồng lên nhau. Bức trên là kiểu hành Hỏa: một người đàn ông búi tóc, lông mày đen rậm, miệng hơi mỉm cười, mặt dài và gầy, cổ áo sẫm màu. Bức dưới là

kiểu hành Kim: một người đàn ông trẻ với chỏm tóc buộc gọn trên đỉnh đầu, mặt hơi vuông, cổ áo tròn có hoa văn.

HÌNH 271

Tranh vẽ nét chân dung của kiểu hành Thổ: một người đàn ông mập mạp, mặt tròn, cười tươi, trên đỉnh đầu có một búi tóc nhỏ cài trâm, vai khoác tấm áo có sọc.

HÌNH 272

Tranh vẽ nét chân dung của kiểu hành Mộc: một người đàn ông đội mũ vải sẫm màu, mặt dài và gầy, có ria mép và chòm râu nhỏ, lông mày hơi cau lại, ánh mắt nhìn sang một bên.

HÌNH 273

Tranh vẽ nét chân dung của kiểu hành Thủy: một người đàn ông đầu to, búi tóc buộc bằng một dải vải nhỏ dựng đứng phía trên, lông mày rậm, mắt mở to, mặc áo có viền sẫm màu.

TRANG SÁCH 124 · SCAN P133

Chẩn đoán bệnh qua phân tích giấc mơ

Chẩn đoán bệnh qua phân tích giấc mơ

Giấc mơ của chúng ta thường gắn liền với trạng thái cảm xúc, những trải nghiệm và gặp gỡ trong đời sống thực, cùng thể trạng cơ thể... Chính vì vậy mà giấc mơ có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của một người.

Trong *The Yellow Emperor's Medicine Classic — Miraculous Pivot* (Hoàng Đế Nội Kinh — Linh Khu), các giấc mơ được phân loại chi tiết để chẩn đoán bệnh.

Giấc mơ	Tình trạng sức khỏe
Mơ thấy sợ hãi	Khí ở tâm và đởm hư suy, bệnh kéo dài, lo âu quá độ.

Mơ thấy giận dữ	Khí ở can và đởm bị ứ trệ, như trong trường hợp gan xơ cứng hoặc có sỏi mật.
Mơ thấy vui vẻ	Khí huyết lưu thông thuận lợi, dù có ốm cũng mau khỏi bệnh.
Mơ thấy buồn	Khí ở tâm và phế hư suy, âm ở can hư suy như trong bệnh gan mạn tính và bệnh lao.
Mơ thấy u sầu	Mất cân bằng giữa can và tỳ, có thể do tiêu hóa kém và loét dạ dày.
Mơ thấy tranh đấu	Khí ở can và đởm chảy ngược, dương ở can thăng lên quá mức như trong bệnh cao huyết áp và tiêu hóa kém.
Mơ thấy mình bay bổng	Thừa ở phần trên cơ thể nhưng thiếu ở phần dưới, như thận hư, đàm thịnh, bệnh mạch vành.
Mơ thấy mình rơi xuống	Thiếu ở phần trên nhưng thừa ở phần dưới cơ thể. Thường gặp trong chứng ứ nước của thận, tâm dương hư suy.
Mơ thấy đi tìm đồ ăn	Tỳ hư yếu và vị mạnh, âm ở vị hư suy kèm nhiệt tà, loét dạ dày, ký sinh trùng đường ruột.
Mơ thấy đi tìm nhà vệ sinh	Thường do chứng niệu (tiểu buốt), viêm ruột, tiêu hóa kém, tiêu chảy.
Mơ thấy đi tìm nước uống	Phần lớn do dương thịnh và tân dịch cạn kiệt, như trong sốt cao và mất nước.
Mơ thấy lạnh	Dương và nhiệt không đủ, âm hàn thịnh. Ví dụ như tỳ dương và thận dương hư suy, chứng nội hàn.
Mộng du	Thường do khí ở can bị ứ trệ, tinh thần phân tán.

TRANG SÁCH 125 · SCAN P134

Liệu pháp âm nhạc cổ truyền

Liệu pháp âm nhạc cổ truyền

Cùng với sự chấp nhận ngày càng rộng rãi các phương pháp chữa bệnh thay thế, liệu pháp âm nhạc đã nhận được nhiều sự chú ý. Trên thực tế, các thầy thuốc thời xưa đã nghiên cứu khá nhiều về liệu pháp âm nhạc.

Âm nhạc Trung Hoa cổ có năm nốt: *gong*, *shang*, *jiao*, *zhi*, *yu*. Các thầy thuốc Trung Hoa gắn mỗi nốt này với một tạng phủ:

Gong (Do) — Tỳ — Tính điều hòa

Nốt 'do' mang lại cảm giác bình tĩnh và trang nghiêm. Nốt này dùng để chữa cho người vừa bị giật mình nên hay bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Shang (Re) — Phế — Tính thanh khiết

Nốt trong trẻo và tĩnh lặng này dùng để chữa cho người mắc chứng lo âu và dễ cáu gắt.

Jiao (Mi) — Can — Tính êm dịu

Nốt này tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu và thư giãn. Nốt này dùng để tiêu trừ cơn giận.

Zhi (Sol) — Tâm — Tính khích lệ

Nốt này mang lại cảm giác hưng phấn và đam mê. Nốt này dùng để chữa cho người bị trầm cảm.

Yu (La) — Thận — Tính thanh nhiệt và tư nhuận

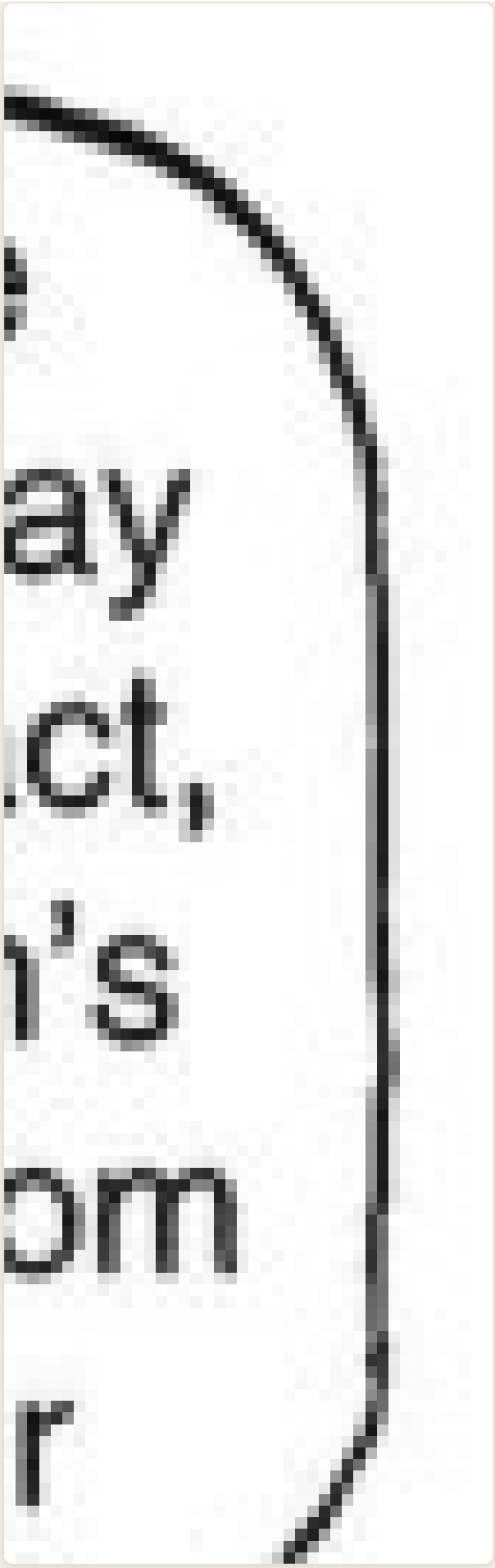
Đây là nốt u sầu và có tác dụng an thần. Nốt này có thể dùng để chữa chứng mất ngủ do vui mừng hoặc buồn bã quá độ, chứng hồi hộp tim đập nhanh...

"Người Trung Hoa xưa tin rằng âm nhạc có thể bồi dưỡng con người. Trên thực tế, ta có thể đọc được tâm trạng và tính cách của một người qua thứ âm nhạc mà người đó chơi hoặc nghe."

HÌNH 274

Tranh vẽ nét một học giả Trung Hoa quấn dải vải quanh búi tóc, mặc áo có viền sẫm màu; những khuông nhạc năm dòng cùng các nốt nhạc uốn lượn trong không trung ở hai bên người ông, một khuông chạy về phía trái và một khuông khác trôi về phía phải.

HÌNH 275


ay
ct,
's
rm
r

Một mảng cắt hẹp theo chiều dọc cho thấy mép trái của bong bóng hội thoại của chú rồng nhỏ, chỉ còn vài mảnh chữ in lộ ra dọc theo đường viền.

HÌNH 276

Chú rồng nhỏ ngồi bên một nhạc cụ có dây dài như đàn tranh, hai tay đặt trên dây đàn, quay đầu sang phải để nói; bên cạnh là một bong bóng hội thoại lớn chứa lời nhận xét rằng người Trung Hoa xưa tin âm nhạc có thể bồi dưỡng con người, và rằng ta có thể đọc được tâm trạng cùng tính cách của một người qua thứ âm nhạc mà người đó chơi hoặc nghe.

TRANG SÁCH 126 · SCAN P135

Phương pháp sáu — Khí công

Phương pháp sáu — Khí công

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng cơ thể con người gồm có tinh, khí và thần. Khí, tức năng lượng sống, là lực duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Mọi hoạt động của các tạng phủ trong cơ thể con người đều cần đến khí.

Khí có tiên thiên chi khí và hậu thiên chi khí. Tiên thiên chi khí hình thành từ trong bào thai của người mẹ. Đó là nguồn sống cơ bản. Khí này còn được gọi là Nguyên Khí hay Chân Khí. Hậu thiên chi khí có được từ không khí, thức ăn và các nguồn khác. Tiên thiên chi khí nhờ vào sự nuôi dưỡng của hậu thiên chi khí để thực hiện chức năng của mình.

HÌNH 277

Hình bóng đen đặc của một người đứng dang rộng hai chân, hai tay duỗi ngang, xung quanh là những đường cong uốn lượn gợi lên luồng năng lượng đang xoáy quanh cơ thể. Ba nhãn in được đặt chồng lên hình người: "Vital Essences" (Tinh) phía trên đầu, "Vital Energy" (Khí) ngang ngực, và "Mentality" (Thần) ngang phần dưới cơ thể.

TRANG SÁCH 127 · SCAN P136

Trang 127

Khi khí không đủ, người ta sẽ uể oải, sức khỏe nói chung kém và dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Bằng cách bồi bổ khí trong cơ thể, chức năng của các tạng phủ sẽ được tăng cường và người ta cũng trở nên sung sức hơn. Nhưng nếu dòng khí bị tắc nghẽn hoặc ứ trệ trong các tạng phủ, cơ thể sẽ phát sinh bệnh tật. Chính vì vậy, dòng khí lưu thông thông suốt rất quan trọng để bảo đảm sức khỏe tốt.

Khí hư	Rối loạn hệ khí
Nói lắp	Dễ bị kích động (khí uất dẫn đến tính nóng nảy)
Cảm thấy yếu toàn thân	Cáu gắt và bồn chồn (khí uất)
Bi quan	Ho và hụt hơi (khí nghịch)
Mau mệt	Bụng đầy hơi (khí trệ)
Hơi thở yếu và nông	Khó thở (khí trệ)

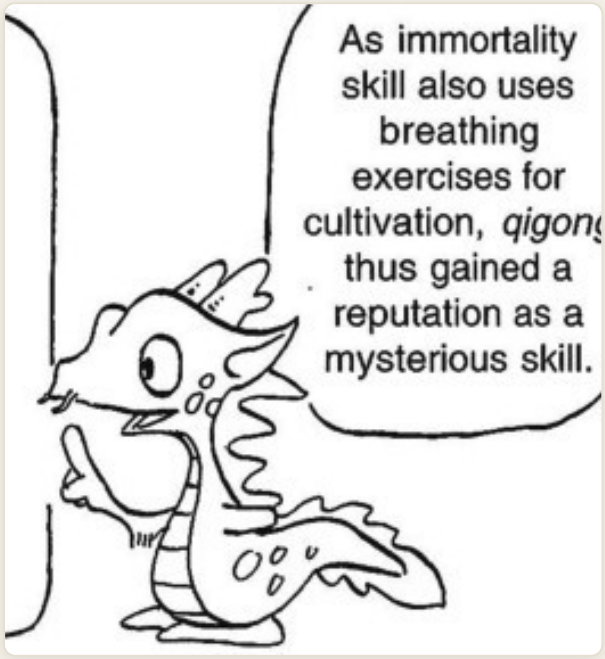
Thở hổn hển và hụt hơi	Buồn nôn (khí nghịch)

Việc luyện tập khí công sẽ gia tăng hay bồi bổ sinh lực, nhờ đó khai thông kinh lạc, bổ sung khí trong huyết, đồng thời điều hòa âm dương. Khí công chữa được bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho cả người khỏe mạnh.

"Khí công không phải là một môn kỹ năng thần bí nào đó. Nó làm cường tráng cơ thể và kéo dài tuổi thọ thông qua việc điều hòa khí trong cơ thể. Tất cả đều rất khoa học."

Hiện nay, Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản và nhiều nước khác đã thành lập các cơ quan nghiên cứu về khí công. Nhiều người không phải người Trung Quốc cũng đã tập thái cực quyền (tai chi) và thiền định.

HÌNH 278



Chú rồng nhỏ ở bên phải của dải truyện đứng thẳng trên hai chân sau, quay đầu lại qua vai để nói, một bàn chân trước nhỏ giơ lên; bong bóng hội thoại bên cạnh giải thích rằng vì các phép tu luyện thành tiên cũng dùng bài tập thở để tu dưỡng, nên khí công dần bị xem là một môn kỹ năng thần bí.

HÌNH 279

Chú rồng nhỏ ở bên trái, trên đầu có một bông hoa nhỏ, đứng với một chân trước giơ lên như đang đặt câu hỏi; bong bóng hội thoại phía trên thắc mắc liệu khí công có thật sự kỳ diệu đến vậy không, liệu chỉ hít thở không khí và vận động tay chân mà có thể chữa được bệnh và nâng cao sức khỏe hay chăng.

TRANG SÁCH 128 · SCAN P137

Trang 128

Khí công có thể được chia thành hai loại chính

Nội công

Còn được gọi là khí công tĩnh, nội công chú trọng rèn luyện trạng thái tinh thần. Các phương pháp bao gồm thiền định, bài tập thở, thư giãn v.v.

Ngoại công

Còn được gọi là khí công động. Ngoại công thúc đẩy tuần hoàn khí huyết thông qua việc vận động cơ bắp. Các phương pháp bao gồm những bài tập nhẹ nhàng như thái cực quyền, xoa bóp, dẫn khí v.v.

Dù là khí công động hay khí công tĩnh, điểm cốt lõi đều nằm ở việc điều hòa thân, hơi thở và tâm.

TRANG SÁCH 129 · SCAN P138

Trang 129

Các hiệu ứng của việc luyện tập *khí công*

- - Bụng nhỏ lại và tay chân ấm khi chạm vào.
- - Hơi ra mồ hôi.
- - Nước bọt tiết ra nhiều hơn.
- - Dạ dày và ruột co bóp nhanh hơn, khiến tần suất trung tiện tăng lên.
- - Ăn ngon miệng hơn.
- - Ngủ ngon.
- - Đầu óc minh mẫn.
- - Cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu luyện tập *khí công* đúng cách, trạng thái sinh lý của một người sẽ có những thay đổi. Những thay đổi này được gọi là các hiệu ứng của *khí công*.

Khi tôi luyện nội công, tôi cảm thấy như có giun bò trên da mình.

Như vậy có bình thường không?

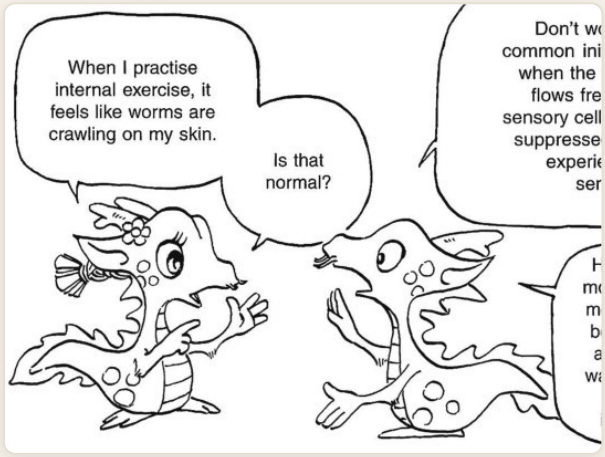
Đừng lo. Đó là hiện tượng ban đầu phổ biến khi khí trong cơ thể bạn lưu thông tự do. Khi các tế bào cảm giác trong não bị ức chế, da bạn sẽ có những cảm giác nhất định.

Vì thế, da bạn nhạy cảm hơn với mọi chuyển động bên trong cơ thể. Đừng quá hoảng sợ. Bạn không muốn bị xao nhãng khi luyện nội công.

HÌNH 280

Hình vẽ một con rồng ở tư thế năng động, minh họa cho dòng khí lưu thông tự do trong cơ thể.

HÌNH 281



Hai con rồng đang nói chuyện: một con nói khi luyện nội công thì cảm thấy như có giun bò trên da và hỏi liệu như vậy có bình thường không; con kia giải thích đó là hiện tượng ban đầu phổ biến khi khí lưu thông tự do.

Trang 130

Nguồn gốc của Khí công

Tiền đề của *khí công* nằm ở sự vận động của tay chân. Người ta tin rằng *khí công* khởi nguồn từ những điệu múa thời Đồ đá.

Vào thời đó, điều kiện lạnh và ẩm thường gây ứ trệ khí huyết và mang lại cảm giác khó chịu cho cơ và xương.

Ái! Lạnh cóng cả người! Tay chân tôi cứng đờ ra rồi!

Đúng vậy! Các khớp của tôi đau nhức.

Để xem thử vận động tay chân có làm dịu cảm giác khó chịu không.

Ái! Được thật rồi! Người tôi thấy ấm hơn rồi!

Tay chân tôi không còn tê nữa!

Con người lấy cảm hứng từ những động tác vận động tay chân, và điệu múa cổ xưa ra đời. Một số động tác không bị mai một theo thời gian mà còn được cải biên thêm để trở thành *khí công*, giúp tăng cường sức khỏe và có tính trị liệu.

HÌNH 282

Truyện tranh toàn trang: "Nguồn gốc của Khí công" — người thời Đồ đá bị lạnh và cứng khớp, vận động tay chân theo các động tác như múa, phát hiện ra rằng điều này làm dịu cơn khó chịu, và điệu múa cổ xưa ấy trở thành nguồn gốc của khí công.

TRANG SÁCH 131 · SCAN P140

Giác hơi (Cupping)

Các phương pháp trị liệu đặc biệt

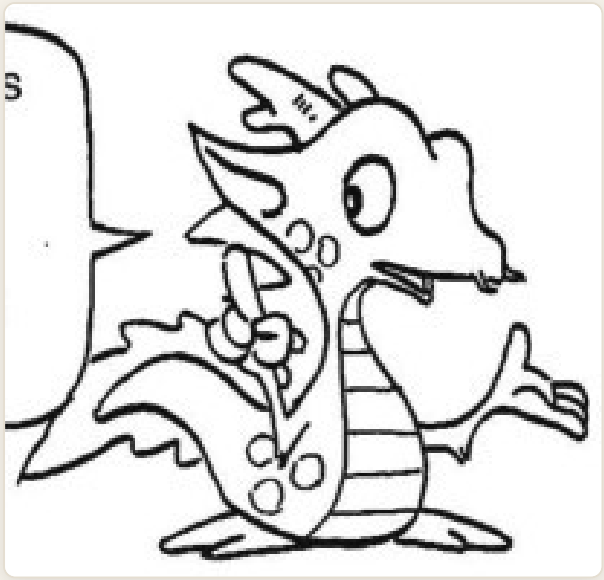
Ngoài những phương pháp điều trị khác nhau đã giới thiệu ở các trang trước, còn có những phương pháp trị liệu đặc biệt và rất độc đáo được người Trung Hoa thực hành.

Ví dụ như giác hơi, cạo gió và trích máu.

Giác hơi (Cupping)

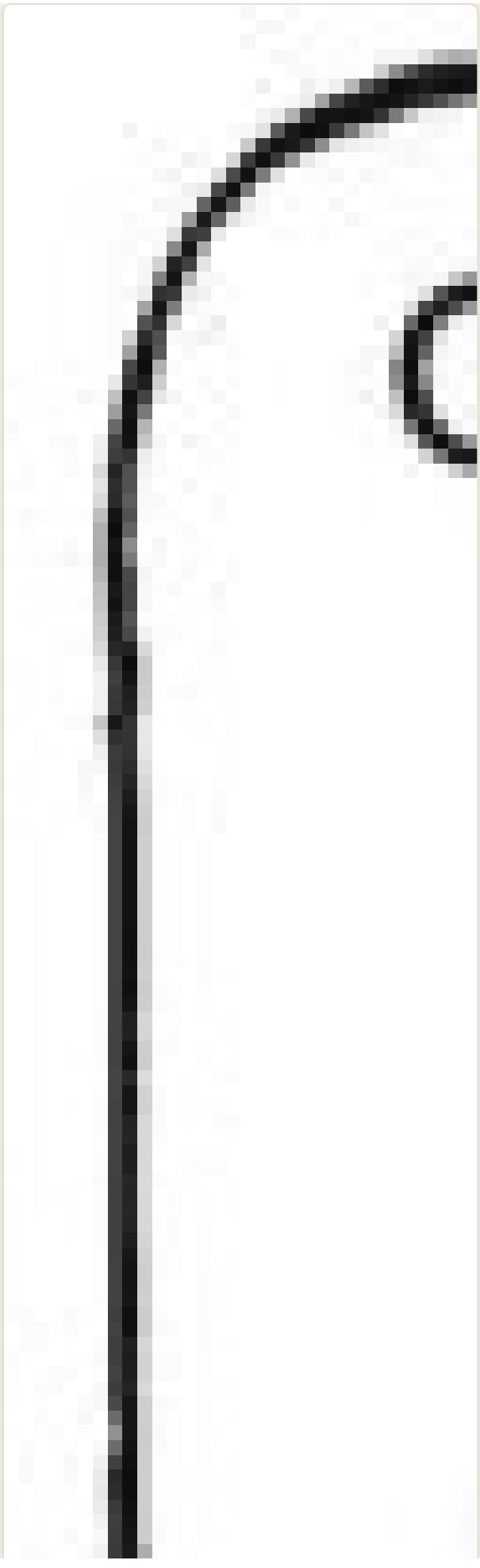
Một ngọn lửa nhỏ được đặt vào bên trong chiếc cốc trong chốc lát để hơ nóng và đẩy hết không khí trong cốc ra ngoài. Dựa trên nguyên lý chân không, chiếc cốc sau đó được hút chặt lên bề mặt da để tạo sung huyết cục bộ nhằm điều trị bệnh. Phương pháp này được dùng để trị phong thấp, đào thải độc tố và nhiệt thừa, thúc đẩy tuần hoàn *khí* huyết, giảm sưng và giảm đau.

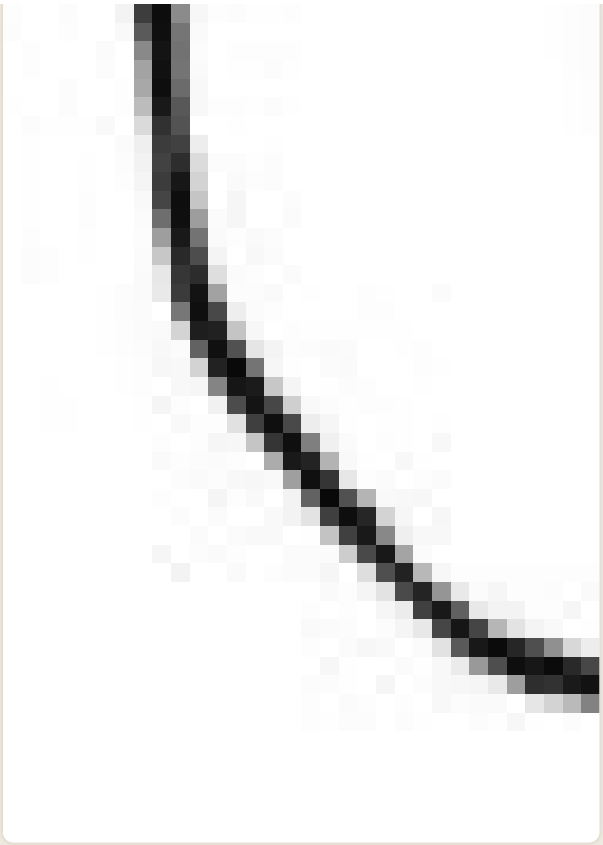
HÌNH 283



Quả bầu hồ lô, biểu tượng truyền thống của y học Trung Hoa, bên cạnh tiêu đề "Các phương pháp trị liệu đặc biệt".

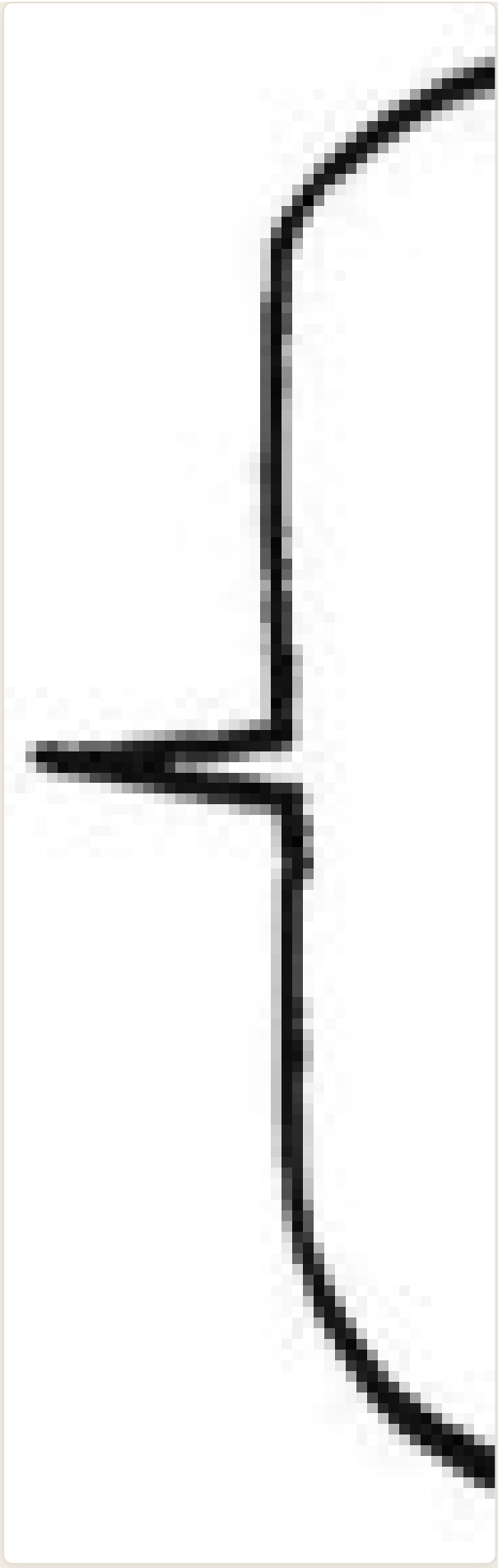
HÌNH 284





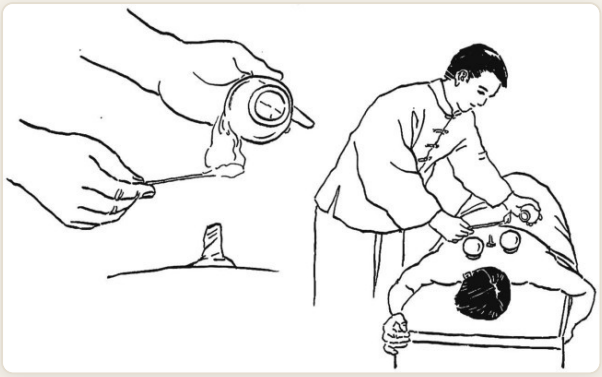
Bàn tay cầm ngọn lửa đưa gần miệng cốc để hơ nóng và đẩy không khí bên trong ra ngoài.

HÌNH 285



Bàn tay đặt cốc lên da để tạo lực hút.

HÌNH 286



Thầy thuốc đặt nhiều cốc giác hơi lên lưng bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị.

TRANG SÁCH 132 · SCAN P141

Trang 132

Các cốc thủy tinh dùng trong giác hơi có ba cỡ — lớn, vừa và nhỏ. Thể tích của chúng từ 30 đến 60 xăng-ti-mét khối. Phần thủy tinh quanh miệng cốc dày hơn để hạn chế không khí thoát ra.

Khi không có cốc thủy tinh, người ta cũng dùng cốc sứ hoặc các vật liệu khác. Một số lựa chọn thay thế là tách trà, ly rượu, bát nhỏ hoặc ống tre.

Có nhiều phương pháp khác nhau được dùng trong liệu pháp giác hơi:

Phương pháp một cốc: Thích hợp để điều trị một vùng nhỏ.

Phương pháp cốc ngâm thuốc: Thuốc giảm đau hoặc thuốc được bôi lên chỗ đau trước khi đặt cốc lên đó. Đôi khi gừng tươi hoặc tỏi cũng được giã nhuyễn và bôi lên trước khi đặt cốc. Cốc thường được đặt ở đó từ 10 đến 20 phút.

Cốc đã hút chân không sẽ mang lại cho da cảm giác bị kéo căng. Nó cũng tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Việc các vết đỏ tím hoặc tím do cốc để lại tồn tại trong một hoặc vài ngày là điều bình thường.

Liệu pháp giác hơi không được khuyến khích cho những người quá căng thẳng, người có làn da nhạy cảm hoặc chùng nhão, và những người rất gầy.

TRANG SÁCH 133 · SCAN P142

Cạo gió (Scraping)

Cạo gió (Scraping)

Một đồng xu hoặc một chiếc thìa nhỏ nhúng vào dầu hoặc nước được dùng để cạo ngực, lưng, cổ và các vùng khác của bệnh nhân. Mỗi vùng được cạo 20 lần cho đến khi xuất hiện những vết đỏ tím. Phương pháp này được dùng để trị chóng mặt, tức ngực, bụng đầy hơi và đau, nhức mỏi toàn thân, v.v.

Trước đây, các dụng cụ dùng trong liệu pháp cạo gió khá thô sơ. Người ta dùng đồng xu, thìa và mảnh ngói, và rất thường gây chảy máu và nhiễm trùng. Vì thế, nó mang lại ấn tượng thô sơ và thiếu khoa học. Ngày nay, sừng trâu được dùng trong liệu pháp cạo gió. Sừng trâu có thể thanh nhiệt và đào thải độc tố. Chúng không dẫn nhiệt và dẫn điện. Sừng cũng có thể được mài thành nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau để tiếp cận các bộ phận khác nhau của cơ thể. Ngoài ra, bề mặt nhẵn mịn của sừng tạo cảm giác dễ chịu và không làm tổn thương da.

Trước khi cạo gió, không nên ăn quá no hoặc để bụng quá đói. Chỉ nên cạo gió sau khi ăn một giờ và dưới sự giám sát của thầy thuốc được đào tạo. Những bệnh nhân mắc bệnh về máu hoặc dễ chảy máu nên tránh liệu pháp cạo gió. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi cạo gió nên được lót một tấm bông lên vùng cần cạo để tránh làm tổn thương làn da non. Bệnh nhân có vấn đề về da không nên cạo gió.

TRANG SÁCH 134 · SCAN P143

Trích máu (Bloodletting)

Trích máu (Bloodletting)

Kim hoặc dao được dùng để chích vào huyệt đạo hoặc mạch để lấy ra một lượng máu nhỏ. Phương pháp này rất thích hợp cho bệnh nhân bị say nắng, sốt cao, bị côn trùng có nọc độc cắn hoặc ngộ độc qua đường ăn uống, v.v.

Liệu pháp rốn (Umbilical cord therapy)

Thuốc, điếu ngải cứu, nhiệt, giác hơi và các liệu pháp khác được dùng trên rốn để trị nhiều chứng bệnh, đặc biệt là hen suyễn, tiêu chảy ở trẻ nhỏ, khó tiêu ở trẻ nhỏ, chứng sợ hãi ban đêm, kinh nguyệt không đều, v.v.

Liệu pháp nhét thuốc vào mũi (Nasal-insertion therapy)

Thuốc được tán thành bột rồi bôi lên một miếng gạc bông, sau đó cuộn lại thành một cây gậy. Cây bông này được nhét vào lỗ mũi. Phương pháp này được dùng để trị chảy máu cam, nghẹt

mũi, đau răng, đau đầu, hen suyễn, v.v.

TRANG SÁCH 135 · SCAN P144

Gối thuốc

Gối thuốc

Gối thuốc là một phương pháp trị liệu được dùng trong y học cổ truyền Trung Hoa. Các loại thảo dược thơm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và khai thông kinh mạch được sao nóng trước khi dùng làm nhân gối. Ngủ trên những chiếc gối thuốc này sẽ giúp phòng bệnh, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Các loại gối thuốc khác nhau

Gối vải: Gối làm bằng bông hoặc gạc nhồi thảo dược.

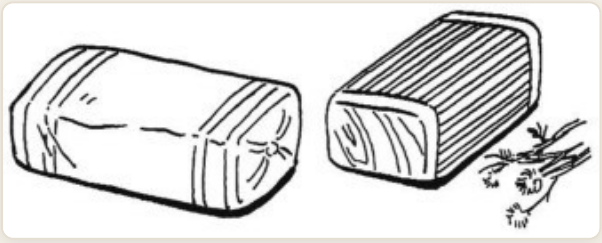
Gối gỗ: Phần rỗng bên trong gối gỗ được nhồi thảo dược thơm. Sau đó gối gỗ được bọc trong một miếng vải bông.

Gối đá: Đá và gốm có dược tính được tạo hình thành gối.

Gối điện từ: Các thiết bị điện từ được gắn vào một chiếc gối thuốc truyền thống để tăng hiệu quả.

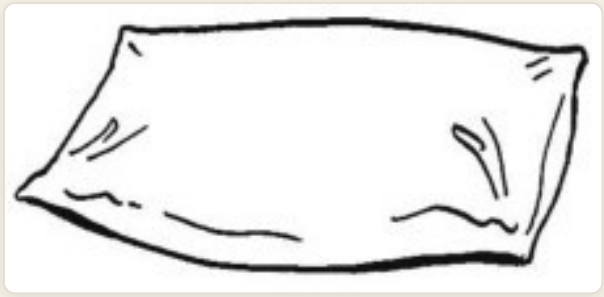
Chà! Thì ra những chiếc gối gỗ cứng mà bà chúng ta thường ngủ có dược tính!

HÌNH 287



Một chiếc gối vải trơn làm bằng bông hoặc gạc.

HÌNH 288

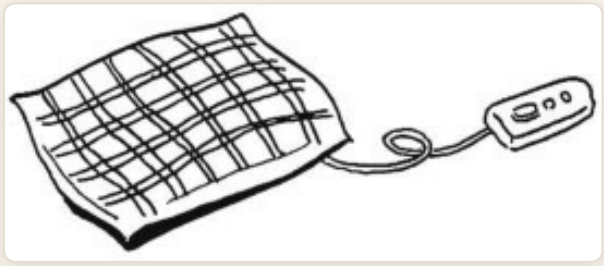


Một chiếc gối gỗ với thảo dược thơm được nhồi vào phần rỗng bên trong.

HÌNH 289

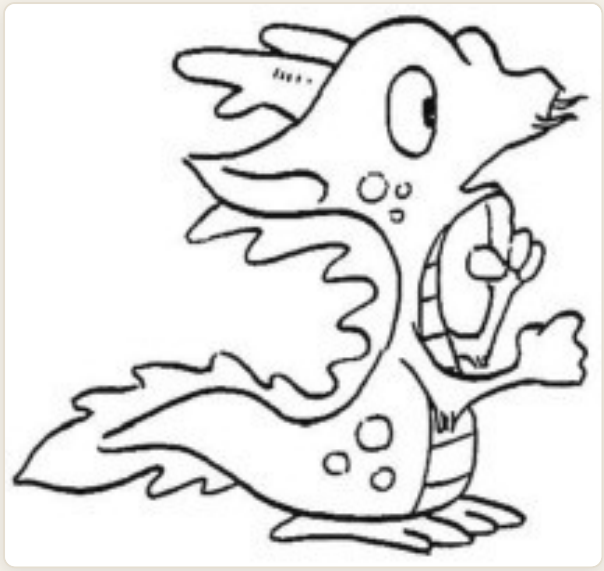
Một người nằm nghỉ trên chiếc gối đá được chạm khắc hoa văn.

HÌNH 290



Một chiếc gối gắn thiết bị điện từ nối bằng dây với hộp điều khiển.

HÌNH 291



Một con rồng thốt lên rằng những chiếc gối gỗ cứng mà bà nó thường ngủ có dược tính.

HÌNH 292

Hình minh họa nhỏ một chiếc gối thuốc bên cạnh phần văn bản.

Liệu pháp khiêu vũ

Liệu pháp khiêu vũ

Khiêu vũ giúp thư giãn cơ bắp và thúc đẩy tuần hoàn máu. Nó không chỉ làm khỏe cơ thể mà còn có thể được dùng để trị các bệnh về vận động như chuột rút, cứng khớp, v.v. Các ghi chép cổ cho thấy khiêu vũ từng được dùng để trị các bệnh về thể chất.

Liệu pháp bùn

Bùn tự nhiên được bôi lên người. Thông thường, người ta dùng bùn giàu khoáng chất từ giếng, đất từ ruộng và đất vàng. Các loại bùn khác nhau có dược tính khác nhau. Ví dụ, bùn ở suối nước nóng thì ấm, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và khai thông kinh mạch. Đất vàng, vốn không mát cũng không nóng, thì có lợi cho tỳ và vị.

Tôi đang được trị liệu bằng "liệu pháp cát". Cát tự nhiên từ sông hoặc sa mạc được dùng để phủ lên cơ thể tôi. Liệu pháp này trị phong thấp do hàn tà, đau nhức phong thấp, teo cơ, v.v.

Phơi cơ thể dưới ánh nắng cũng giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đây được gọi là "liệu pháp ánh nắng". Nó rất thích hợp cho những người bị thiếu dương khí.

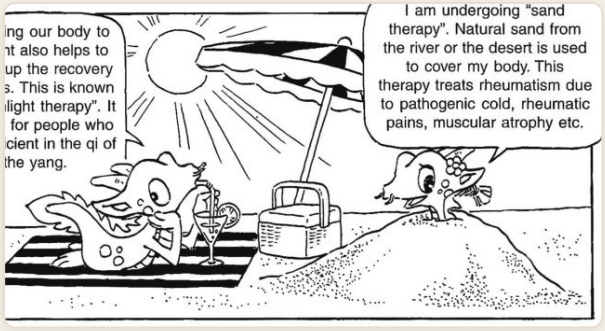
HÌNH 293

Một vũ công đang chuyển động, minh họa cho liệu pháp khiêu vũ.

HÌNH 294

Một người đang bôi bùn tự nhiên lên cơ thể khi tắm.

HÌNH 295



Cảnh truyện tranh trên bãi biển: một con rồng đang được phủ cát để "trị liệu bằng cát", trong khi con kia giải thích về "liệu pháp ánh nắng" và lợi ích của việc phơi cơ thể dưới ánh nắng.

TRANG SÁCH 137 · SCAN P146

Trang 137

Chữa được bệnh nhưng không cứu được người

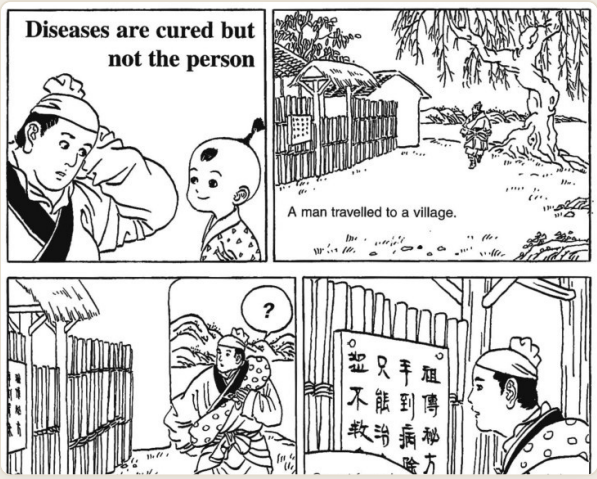
Một người khách lữ hành đi đến một ngôi làng.

(Tấm bảng trước cổng: "Bí phương tổ truyền chữa được bệnh nhưng không cứu được mạng người.")

Bí phương tổ truyền chữa được bệnh nhưng không cứu được mạng người.

Chữa được bệnh mà không cứu được mạng người. Rốt cuộc là thế nào?

HÌNH 296



Người khách lữ hành mang khăn gói đứng bên cậu bé tò mò, dưới dòng tiêu đề "Chữa được bệnh nhưng không cứu được người".

HÌNH 297

Người khách lữ hành, với dấu hỏi lơ lửng trên đầu, đọc tấm bảng tổ truyền quảng cáo bí phương chữa được bệnh nhưng không cứu được mạng người.

TRANG SÁCH 138 · SCAN P147

Trang 138

Này cậu bé, chủ căn nhà kia có phải là thầy thuốc không?

Phải, đúng vậy.

Tổ tiên nhà ông ấy đều là thầy thuốc. Ông ấy giỏi lắm. Ông ấy là một thầy thuốc nổi tiếng ở đây.

Nhưng sao tấm bảng trước nhà ông ấy lại ghi rằng ông ấy không cứu được mạng người?

Tấm bảng ghi đúng đấy. Nhà thầy thuốc ấy không chữa cho người.

Nhưng sao họ lại không cứu được mạng người?

Chú không đoán ra sao? Hì hì! Để cháu kể cho chú nghe. Ông ấy là ...

Rốt cuộc cậu bé đã nói gì với người khách? Mọi người thử đoán xem!

À, ra thế! Ha ha!

Đáp án: Ông ấy là thú y!

HÌNH 298

Người khách hỏi cậu bé về căn nhà của thầy thuốc và tấm bảng kỳ lạ trước cửa, và cậu bé giải thích nghề lạ của gia đình ấy.

Danh y

Danh y

Nhiều danh y lỗi lạc của Trung Hoa đã để lại dấu ấn trong sử sách nước này. Những thầy thuốc ấy không chỉ sở hữu y thuật tinh thông tuyệt đỉnh, mà còn góp phần thiết yếu vào sự phát triển của y học Trung Hoa. Không chỉ là những người thầy thuốc tài ba, họ còn mang trong mình phẩm hạnh đạo đức cao quý nhất.

TRANG SÁCH 140 · SCAN P149

Y đức

Y đức

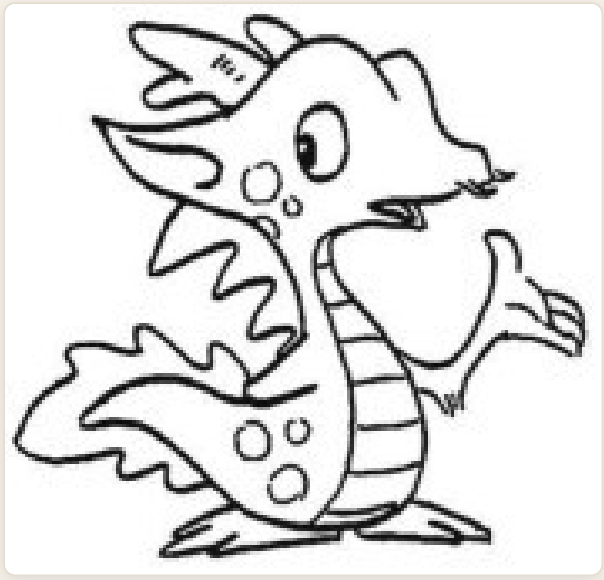
Y đức đã được thực hành và đề xướng ở Trung Hoa từ vài nghìn năm nay. Nó đề cao lòng nhân từ và lòng trắc ẩn. Người thầy thuốc không chỉ cần y thuật xuất sắc, mà còn phải có nhân cách ngay thẳng và đạo đức. Trong lịch sử Trung Hoa, những thầy thuốc nhân từ như vậy chưa bao giờ thiếu. Cho đến ngày nay, những con người ấy vẫn được trọng vọng trong giới y học.

Đổng Phụng, một thầy thuốc thời nhà Hán, chữa bệnh cho người mà không hề mong nhận thù lao. Khi bệnh nhân khỏi bệnh, điều duy nhất người ấy phải làm là trồng một cây hạnh trên ngọn núi nơi Đổng Phụng ở. Sau nhiều thập kỷ, người ta có thể thấy cả một rừng hạnh. Đổng Phụng được biết đến với danh hiệu Lương y của rừng hạnh.

Người đời bắt đầu dùng những cụm từ 'sống giữa rừng hạnh' và 'nổi danh giữa rừng hạnh' để ca ngợi những thầy thuốc nhân từ.

Họ thật đáng để chúng ta khâm phục!

HÌNH 299



Nhân vật rồng hoạt hình minh họa cho câu chuyện với dáng điệu sinh động, giàu biểu cảm.

HÌNH 300

Hình vị lương y Đổng Phụng đứng trong bộ trọng phục dài rộng.

HÌNH 301

Hai chú rồng hoạt hình bàn luận về việc những cụm từ như 'sống giữa rừng hạnh' đã trở thành lời ca ngợi các thầy thuốc nhân từ như thế nào.

TRANG SÁCH 141 · SCAN P150

Biển Thước

Biển Thước

Là một thầy thuốc nổi tiếng thời Chiến Quốc, Biển Thước đã đưa ra Tứ Chẩn trong chẩn đoán bệnh — vọng (nhìn), văn (nghe và ngửi), vấn (hỏi) và thiết (bắt mạch).

Tên khai sinh của Biển Thước là Tần Việt Nhân. Ông là thầy thuốc đầu tiên được ghi chép trong lịch sử Trung Hoa. Tư Mã Thiên thời Tây Hán đã thuật lại sinh động việc hành nghề của Biển Thước trong *Sử Ký — Biển Thước Thương Công Liệt Truyện*.

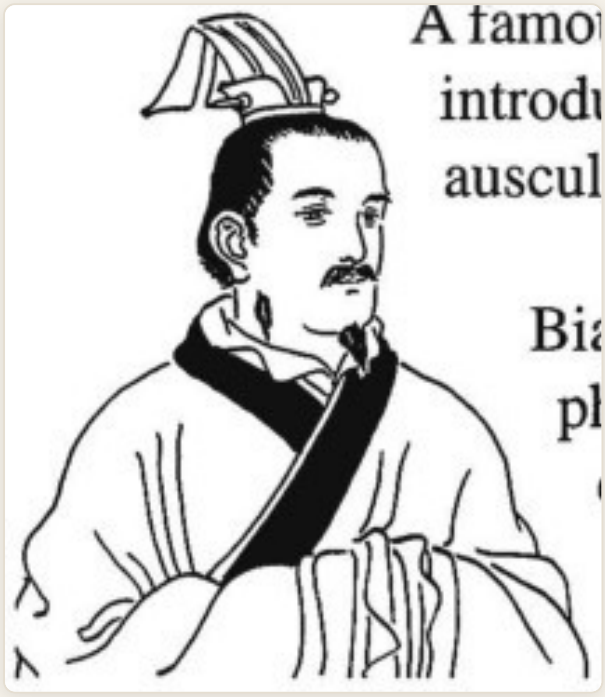
Thuở trẻ, Biển Thước làm việc trong một quán trọ. Về sau, ông trở thành học trò của Trường Tang Quân để được đào tạo về y học. Tương truyền Trường Tang Quân cho Biển Thước uống một loại thuốc giúp ông nhìn xuyên qua tường, nhờ đó có thể nhìn thấu các tạng phủ (*tạng* và *phủ*) của bệnh nhân khi khám bệnh.

Biển Thước là người đa tài trong lĩnh vực y học, tinh thông nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa cùng nhiều bộ môn khác. Trong khi đi đây đó, ông biết điều chỉnh kỹ năng của mình cho phù hợp với văn hóa và nhu cầu của người dân từng nơi. Ở Hàm Đan, nơi phụ nữ được trọng vọng, ông hành nghề phụ khoa; còn ở Lạc Dương, nơi người già được kính trọng, ông trở thành thầy thuốc tai mũi họng (chuyên gia tai–mũi–họng). Tại Hàm Dương, ông chuyển sang hành nghề nhi khoa vì người dân nơi đấy yêu quý trẻ nhỏ.

Biển Thước đã viết *Biển Thước Nội Kinh* và *Biển Thước Ngoại Kinh*, những sách này về sau đã thất truyền. Cuốn duy nhất còn lại là *Nan Kinh* (Kinh Vấn Nạn) do Tần Việt Nhân viết. Cuốn sách này trình bày về kỹ thuật bắt mạch.

Y thuật tuyệt đỉnh của Biển Thước nổi danh khắp nơi. Ông đi nhiều nơi để chữa bệnh cho dân chúng. Như chim khách (chim báo tin vui), ông mang điều lành đến cho người dân. Vì thế, dù tên khai sinh là Tần Việt Nhân, dân gian vẫn gọi ông là Biển Thước. Tuy nhiên, danh tiếng ấy khiến ngự y Lý Hi của nước Tần ghen ghét, kẻ đã sai người ám sát ông.

HÌNH 302



Chân dung Biển Thước đội mũ nho sĩ và khoác áo cổ đen.

TRANG SÁCH 142 · SCAN P151

Biển Thước dùng Tứ Chẩn để chẩn đoán Tề Hoàn Hầu

Biển Thước luận về bệnh tật:

"Khi bệnh còn ở trên da, dùng cách chườm nóng;

nếu bệnh đã vào huyết mạch, chữa bằng châm cứu và cứu ngải;

nếu bệnh phát ở ruột và dạ dày, chữa bằng thuốc sắc;

nhưng một khi bệnh đã vào tủy xương, thì dù là thầy thuốc giỏi nhất cũng đành bó tay."

Biển Thước dùng Tứ Chẩn để chẩn đoán Tề Hoàn Hầu

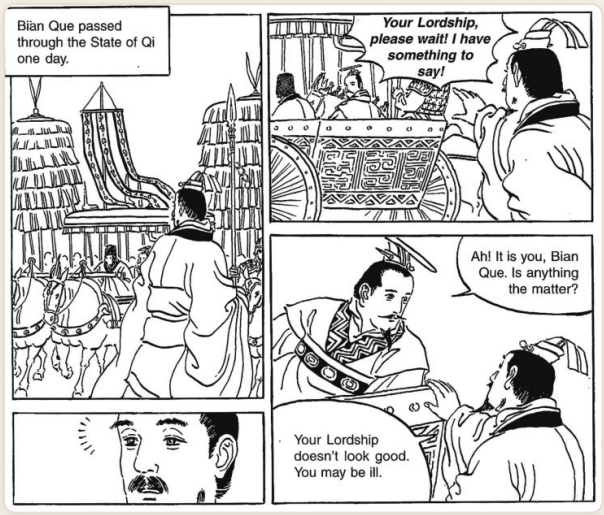
Một ngày nọ, Biển Thước đi ngang qua nước Tề.

Xin bệ hạ dừng lại! Thần có điều muốn thưa!

A! Là ngươi đấy, Biển Thước. Có chuyện gì vậy?

Khí sắc của bệ hạ không được tốt. E rằng bệ hạ đã nhiễm bệnh.

HÌNH 303



Biển Thước chặn xe của Tề Hoàn Hầu để cảnh báo, rồi nói thẳng với ông rằng sắc mặt trông không được khỏe.

TRANG SÁCH 143 · SCAN P152

Trang 143

Bệnh của bệ hạ còn nhẹ và mới ở bên ngoài. Nhưng nếu không chữa trị sớm, bệnh sẽ chỉ càng nặng thêm.

Ta thấy mình khỏe lắm! Ta không bệnh.

Mấy thầy thuốc này chỉ muốn trục lợi bằng cách chữa một căn bệnh vốn không hề tồn tại.

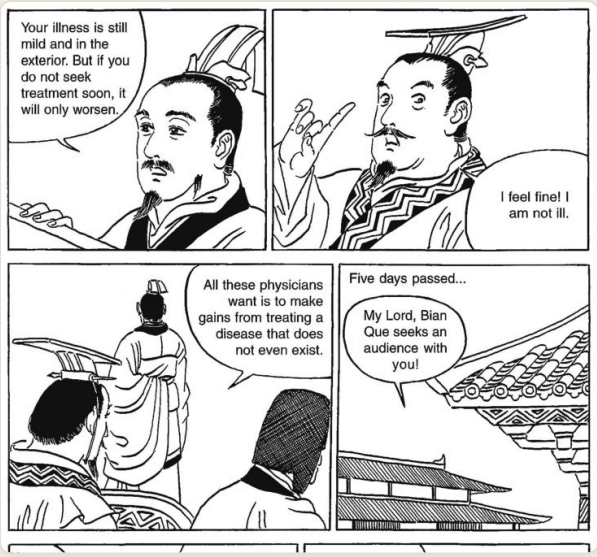
Năm ngày trôi qua...

Thưa chúa thượng, Biển Thước xin được yết kiến!

Bệ hạ, bệnh của bệ hạ đã xâm nhập vào huyết mạch. Nếu để không chữa, e rằng tình trạng của bệ hạ sẽ ngày càng xấu đi.

Ta hoàn toàn khỏe mạnh. Ta không cần ngươi. Ngươi có thể lui.

HÌNH 304



Biển Thước cảnh báo Tề Hoàn Hầu rằng bệnh vẫn còn nhẹ và mới ở bên ngoài, nhưng hầu vẫn khăng khăng rằng mình khỏe. Năm ngày sau, người hầu báo rằng Biển Thước xin được yết kiến.

HÌNH 305

Biển Thước tâu rằng bệnh của hầu đã xâm nhập vào huyết mạch, nhưng hầu gạt đi, nói rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh và không cần ông.

TRANG SÁCH 144 · SCAN P153

Trang 144

Năm ngày nữa lại trôi qua trước khi Biển Thước xin được yết kiến Tề Hoàn Hầu.

Bệnh của bệ hạ đã xâm nhập vào tạng phủ (*zang* và *fu*). Sẽ quá muộn nếu bệ hạ không chịu chữa trị.

Ngươi lại đến quấy rầy ta nữa rồi! Đi đi! Đi đi!

Than ôi!

Khi Biển Thước gặp Tề Hoàn Hầu lần thứ tư...

Ông không nói gì mà bỏ đi.

HÌNH 306

Biển Thước nói với Tề Hoàn Hầu rằng bệnh đã vào tạng phủ, bị đuổi đi trong giận dữ, và đến lần gặp thứ tư thì ông không nói gì mà rời đi.

TRANG SÁCH 145 · SCAN P154

Trang 145

"Thầy thuốc, xin đừng đi vội. Chúa công muốn nói chuyện với ngài."

"Ngài đã đến mấy lần để chữa trị cho ta. Lần này sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào?"

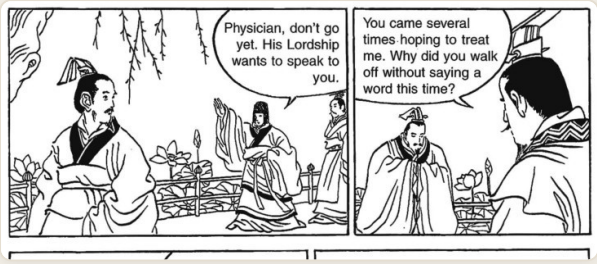
"Trước đây, bệnh của Chúa công vẫn còn có thể chữa được. Nhưng nay nó đã ăn vào tận tủy xương, ta không còn cách nào nữa."

"..."

Quả nhiên, Hầu tước phát bệnh ngay sau đó.

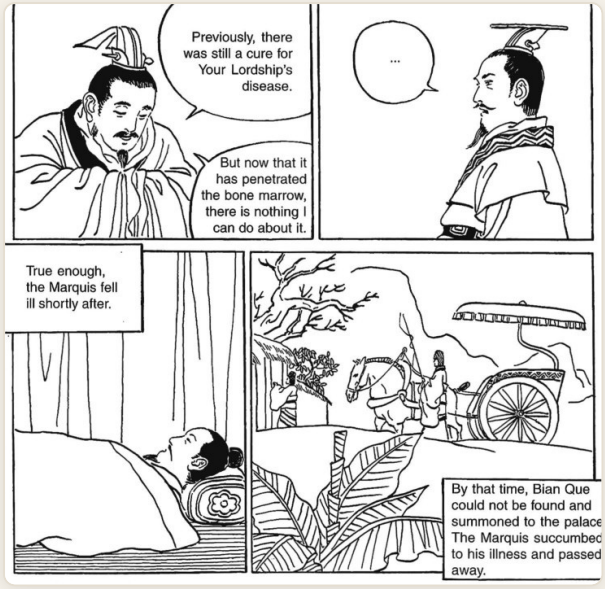
Đến lúc ấy, Biển Thước không thể tìm thấy và bị triệu vào cung. Hầu tước khuất phục trước bệnh tật và qua đời.

HÌNH 307



Hai khung truyện: các thị tòng xin thầy thuốc Biển Thước ở lại vì Hầu tước muốn nói chuyện với ngài; Hầu tước than rằng Biển Thước đã đến mấy lần để chữa bệnh cho mình, vậy mà lần này lại bỏ đi không một lời.

HÌNH 308



Bốn khung truyện: Biển Thước giải thích rằng bệnh của Hầu tước trước kia còn chữa được nhưng nay đã ăn vào tận tủy xương; Hầu tước im lặng không nói gì; sau đó Hầu tước lâm trọng bệnh, và vì không tìm thấy Biển Thước nên Hầu tước đã chết vì bệnh.

TRANG SÁCH 146 · SCAN P155

Trang 146

Hoa Đà

Hoa Đà (145–208 SCN), một thầy thuốc thời Đông Hán, là một người đa tài khác về kiến thức y học. Ông tinh thông phụ khoa, các bệnh nội khoa, nhi khoa và bệnh giun sán đường ruột, cùng nhiều lĩnh vực khác. Nhưng thành tựu lớn nhất của ông là ở lĩnh vực ngoại khoa. Ông được tôn xưng là Tổ sư của ngành ngoại khoa và là Bàn tay thánh của ngành ngoại khoa.

Ông là người tiên phong trong việc gây mê toàn thân để phẫu thuật vùng bụng, trước ca phẫu thuật thành công đầu tiên dưới gây mê toàn thân được ghi nhận trong y học phương Tây năm 1848 tới 1600 năm.

Vào thời đó, Hoa Đà đã tiến hành việc loại bỏ khối u và phẫu thuật dạ dày, ruột. Khi châm cứu và thuốc men không làm được việc, ông chuyển sang phẫu thuật. Bệnh nhân của ông uống thuốc mê cùng với rượu. Khi họ mất tri giác, ông mổ bụng và loại bỏ bất kỳ khối u nào có thể có. Nếu bệnh nằm ở ruột, ông cắt vào ruột và làm sạch chúng rồi khâu lại và bôi dầu thuốc lên đó. Vết mổ sẽ lành trong bốn đến năm ngày, và bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng một tháng.

Hoa Đà cũng là một chuyên gia về bệnh giun sán đường ruột. Ông phát hiện ra rằng ăn thức ăn sống là nguyên nhân chính gây ra bệnh giun sán đường ruột, và cho bệnh nhân uống thuốc xổ để

khiến họ nôn ra giun sán và nhờ đó bình phục.

Hoa Đà nhận ra tầm quan trọng của việc vận động thể chất. Ông tin rằng vận động phù hợp có thể phòng bệnh và kéo dài tuổi thọ. Ông đã sáng tạo ra hình thức dưỡng sinh lâu đời nhất của Trung Quốc — Ngũ Cầm Hí (xem tr.154).

HÌNH 309

Chân dung mực vẽ Hoa Đà, thầy thuốc thời Đông Hán, đội mũ văn sĩ và để râu rậm.

TRANG SÁCH 147 · SCAN P156

Hoa Đà chữa chứng đau đầu dữ dội

Ông đã chữa khỏi chứng đau đầu dữ dội của Tào Tháo và giải độc trong người Quan Vũ bằng cách cạo xương. Đáng tiếc thay, Hoa Đà về sau bị Tào Tháo giết hại. Ông đã biên soạn kinh nghiệm y học của mình thành một cuốn sách mang tên *Thanh Nang Thư*, nhưng nó đã bị thất truyền sau khi ông qua đời.

> ***Hoa Đà:***

> *"Nước chảy mãi không cạn, bản lề cửa luôn động thì không bị mọt ăn."*

>

> *Vì nước chảy luôn luôn vận động nên nó không bao giờ trở nên tù đọng và hôi thối; bản lề cửa quay mỗi ngày nên không bị mọt ăn. Cơ thể con người cần được vận động đầy đủ và phù hợp. Vận động thúc đẩy tiêu hóa thức ăn, lưu thông khí và huyết và phòng ngừa bệnh tật.*

Hoa Đà chữa chứng đau đầu dữ dội

"Đầu ta đau quá! Ai có thể giúp ta đây?"

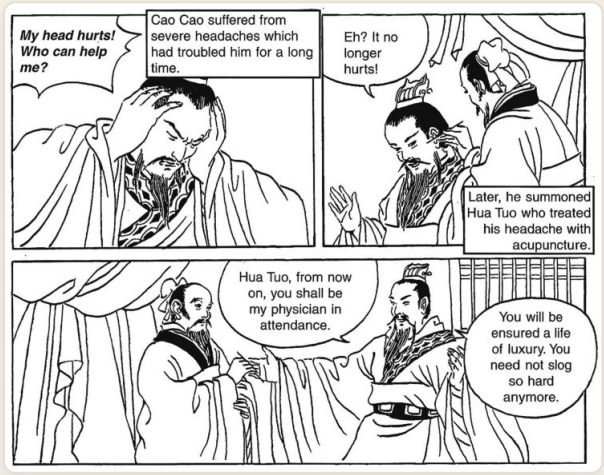
Tào Tháo mắc chứng đau đầu dữ dội đã hành hạ ông từ lâu.

"Ơ? Không còn đau nữa!"

Về sau, ông cho triệu Hoa Đà đến, người đã chữa khỏi cơn đau đầu của ông bằng châm cứu.

"Hoa Đà, từ nay về sau, ngươi sẽ là thái y hầu cận của ta. Ngươi sẽ được bảo đảm một cuộc sống xa hoa. Ngươi không cần phải vất vả cực nhọc như thế nữa."

HÌNH 310



Truyện tranh: Tào Tháo bị chứng đau đầu dữ dội hành hạ, cho triệu Hoa Đà đến, người chữa khỏi cơn đau bằng châm cứu; sau đó Tào Tháo ngỏ ý giữ Hoa Đà làm thái y riêng với một cuộc sống an nhàn.

Trang 148

"Ta hành nghề y để phụng sự nhân dân. Ta không muốn chỉ hầu hạ một người."

"Để ta tìm một cái cớ mà từ chối lời đề nghị của ông ấy."

"Ta đã đi đây đó một thời gian dài. Ta muốn trở về quê hương và tiện thể thu thập cuốn sách của mình."

"Được thôi. Hãy mau trở lại đây."

Đã mấy năm kể từ khi Hoa Đà trở về quê hương. Tào Tháo viết cho ông nhiều bức thư thúc giục ông quay lại. Nhưng Hoa Đà luôn tìm ra một cái cớ để từ chối lời đề nghị của ông ta.

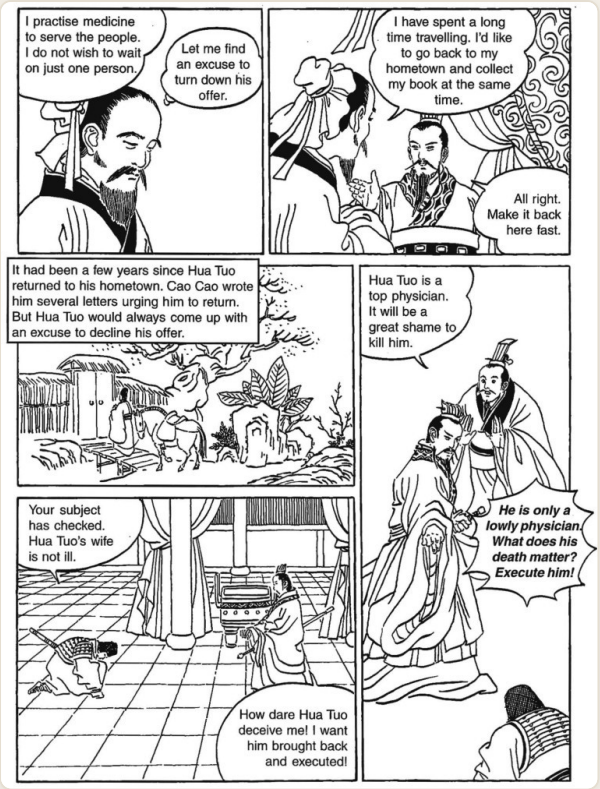
Hoa Đà là một thầy thuốc hàng đầu. Giết ông ấy sẽ là một sự đáng tiếc lớn.

Hắn chỉ là một thầy thuốc hèn mọn. Cái chết của hắn có đáng gì đâu? Hãy xử trảm hắn!

"Thần đã cho người kiểm tra. Vợ của Hoa Đà không bệnh."

"Hoa Đà dám lừa ta sao! Ta muốn hắn bị bắt trở lại và xử trảm!"

HÌNH 311



Trang truyện tranh: Hoa Đà từ chối chỉ phục vụ một người và xin phép về quê để thu thập cuốn sách của mình; nhiều năm trôi qua, ông liên tục lấy cớ từ chối sự triệu tập của Tào Tháo; khi Tào Tháo biết vợ Hoa Đà không hề bệnh, ông ta ra lệnh bắt và xử trảm Hoa Đà, bất chấp lời can ngăn của một mưu sĩ.

TRANG SÁCH 149 · SCAN P158

Trang 149

"Nếu kiến thức của ta có thể được truyền lại, ta chết cũng không hối tiếc."

"Quản ngục!"

"Cuốn sách này sẽ cứu được nhiều mạng người. Ta để nó lại cho ngươi cất giữ."

"Tôi không thể nhận cuốn sách này! Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị chém đầu!"

Và thế là, Hoa Đà đốt cuốn sách của mình.

"Than ôi!"

"Đầu ta đau dữ dội! Mau đưa Hoa Đà đến đây!"

Thừa tướng, Hoa Đà đã bị xử trảm rồi.

"Ái chà! Ta lẽ ra không nên giết Hoa Đà!"

TRANG SÁCH 150 · SCAN P159

Ngũ Cầm Hí

Ngũ Cầm Hí

Hoa Đà đã sáng tạo ra hình thức dưỡng sinh lâu đời nhất của Trung Quốc — Ngũ Cầm Hí. Nó dựa trên các động tác của hổ, hươu, gấu, vượn và chim. Chuỗi động tác này giúp tinh thần minh mẫn, tăng cường chức năng tim và phổi, làm khỏe lưng và thận, làm trơn khớp và cải thiện thể chất của con người.

Trong những năm gần đây, nó đã được ứng dụng rộng rãi trong việc trị liệu cho bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân thấp khớp, bệnh nhân viêm khớp, bệnh nhân bị tổn thương cột sống và nhiều người khác.

Hổ: Gầm gừ và lao người về phía trước như hổ.

Hươu: Chạy nhảy vui vẻ như hươu.

Gấu: Bước đi chậm rãi như gấu.

Vượn: Nhảy nhót tứ phía như vượn.

Chim: Xòe hai tay ra để bay lượn như chim.

Người ta kể rằng đệ tử của Hoa Đà luyện tập Ngũ Cầm Hí đã sống đến hơn 100 tuổi!

HÌNH 312

Hình vẽ một người mặc áo bào cổ, cúi người về phía trước với hai nắm tay siết chặt, bắt chước hổ: gầm gừ và lao về phía trước.

HÌNH 313

Hình vẽ một người mặc áo bào cổ, nâng một chân với hai tay chắp lại, bắt chước hươu: chạy nhảy vui vẻ.

HÌNH 314

Hình vẽ một người mặc áo bào cổ, ngả người ra sau với hai tay vung về phía sau, bắt chước gấu: bước đi chậm rãi.

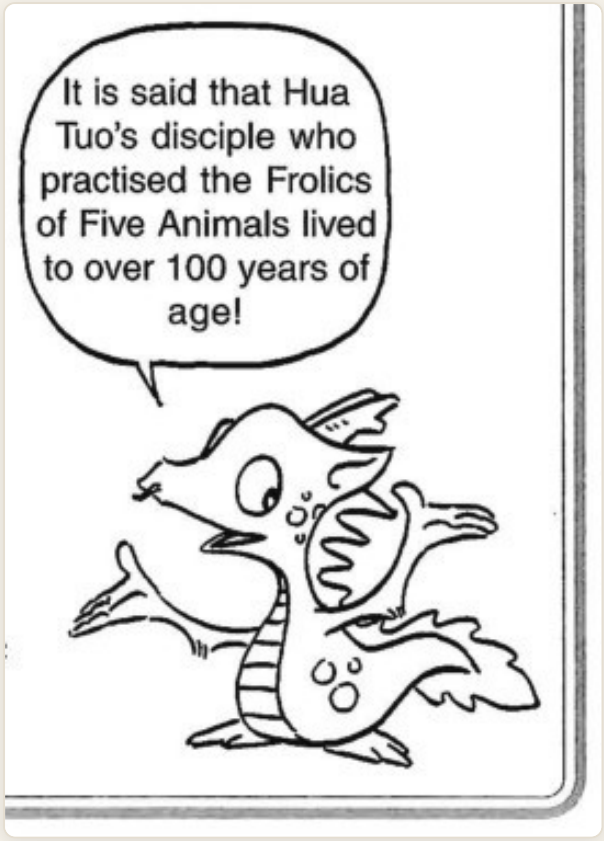
HÌNH 315

Hình vẽ một người mặc áo bào cổ với một tay giơ cao, bắt chước vượn: nhảy nhót tứ phía.

HÌNH 316

Hình vẽ một người mặc áo bào cổ với hai tay giơ lên trên đầu, bắt chước chim: xòe hai tay ra để bay lượn.

HÌNH 317



Hình rồng hoạt hình bên cạnh một bong bóng hội thoại nói rằng đệ tử của Hoa Đà luyện tập Ngũ Cầm Hí đã sống đến hơn 100 tuổi.

TRANG SÁCH 151 · SCAN P160

Trang 151

Trương Trọng Cảnh

Trương Trọng Cảnh (150–219 SCN) sống vào thời Đông Hán. Ông quyết chí trở thành thầy thuốc sau khi chứng kiến những tàn phá do các trận dịch gây ra.

Có thời ông từng giữ chức quan cao trong triều. Ngay cả khi được bổ nhiệm đến Trường Sa, ông chưa bao giờ sao nhãng việc chữa trị cho dân chúng. Vào thời ấy, quan lại trong triều không thể vào khu dân cư của thường dân bất cứ lúc nào họ muốn. Vì thế, Trương Trọng Cảnh cho mở cửa nha môn vào ngày mồng một và ngày rằm âm lịch mỗi tháng để có thể khám bệnh cho dân thường. Bệnh nhân từ khắp nơi trong nước đều lặn lội đến tìm ông để chữa trị.

Tương truyền rằng bánh chẻo (một món ăn truyền thống của Trung Quốc) do Trương Trọng Cảnh phát minh ra. Thấy người nghèo khổ chịu đựng giá rét khắc nghiệt và đôi tai bị tê cóng, Trương Trọng Cảnh quyết định bọc thịt cừu, ớt và một số vị thuốc làm ấm cơ thể trong một lớp bột mì.

Ông gấp chúng thành hình dạng một chiếc tai, luộc trong nước rồi đem cho người nghèo ăn. Ăn vào thấy ấm người, thúc đẩy lưu thông máu và làm tan giá lạnh ở đôi tai. Vị thuốc này được gọi là "Thang tai ấm", về sau trở thành bánh chẻo.

Về sau, Trương Trọng Cảnh đúc kết kinh nghiệm rút ra từ quá trình hành nghề và viết 16 quyển *Thương Hàn Tạp Bệnh Luận*. Đây là cuốn sách sớm nhất của Trung Quốc kết hợp lý thuyết y học với kinh nghiệm y học, và đưa ra những phân tích về nguyên nhân, triệu chứng, diễn biến và phương pháp xử lý các bệnh cấp tính có sốt phù hợp với lý thuyết Lục Kinh.

Hơn 300 bài thuốc và hiệu quả của chúng đã được ghi lại trong sách. Người ta gọi các bài thuốc ấy là "cổ phương". Cuốn sách của ông cũng đem lại cho Trương Trọng Cảnh danh hiệu "Tổ sư của các phương thuốc" và "Tổ sư của y học". Những người hành nghề Đông y ngày nay vẫn dùng các bài thuốc gốc của ông để chữa bệnh.

* *Thương Hàn Tạp Bệnh Luận* đã bị thất truyền qua các thời đại. Vương Thúc Hòa, một thầy thuốc nổi tiếng thời Tấn, đã sắp xếp lại tư liệu thành hai cuốn sách — *Thương Hàn Luận* và *Kim Quỹ Yếu Lược*.

HÌNH 318

Chân dung mực vẽ Trương Trọng Cảnh, thầy thuốc thời Đông Hán và là tác giả của Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, đội mũ và mặc áo bào văn sĩ.

TRANG SÁCH 152 · SCAN P161

Việc hành nghề của Trương Trọng Cảnh

Trích từ Kim Quỹ Yếu Lược — Cam Thảo Tiểu Mạch Đại Táo Thang

Thành phần: 10 g cam thảo, 30 g tiểu mạch, 10 quả đại táo

Cách bào chế: Nấu các vị thuốc trong 500 ml nước. Chia uống làm ba lần, mỗi ngày một lần.

Công dụng: Dùng làm thuốc an thần cho chứng loạn thần kinh, làm mạnh tỳ.

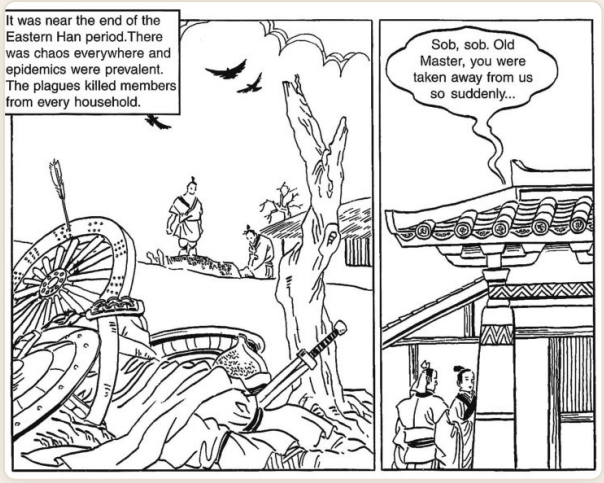
Bài thuốc gốc dùng để chữa chứng cuồng loạn (hysteria) ở phụ nữ do u uất gây ra. Ngày nay nó được dùng để chữa chứng loạn thần kinh, tâm thần phân liệt, cuồng loạn và thời kỳ mãn kinh.

Việc hành nghề của Trương Trọng Cảnh

Đó là vào gần cuối thời Đông Hán. Khắp nơi loạn lạc và dịch bệnh hoành hành. Các trận dịch đã cướp đi sinh mạng của người trong mọi gia đình.

"Huhu. Lão gia, người ra đi khỏi chúng con đột ngột quá..."

HÌNH 319



Các khung truyện tranh: một chiến trường ngổn ngang vũ khí gãy nát và bánh xe chiến xa giữa cảnh loạn lạc và dịch bệnh vào cuối thời Đông Hán; và những người đưa tang khóc than dưới một ngôi đình vì sự ra đi đột ngột của Lão gia.

TRANG SÁCH 153 · SCAN P162

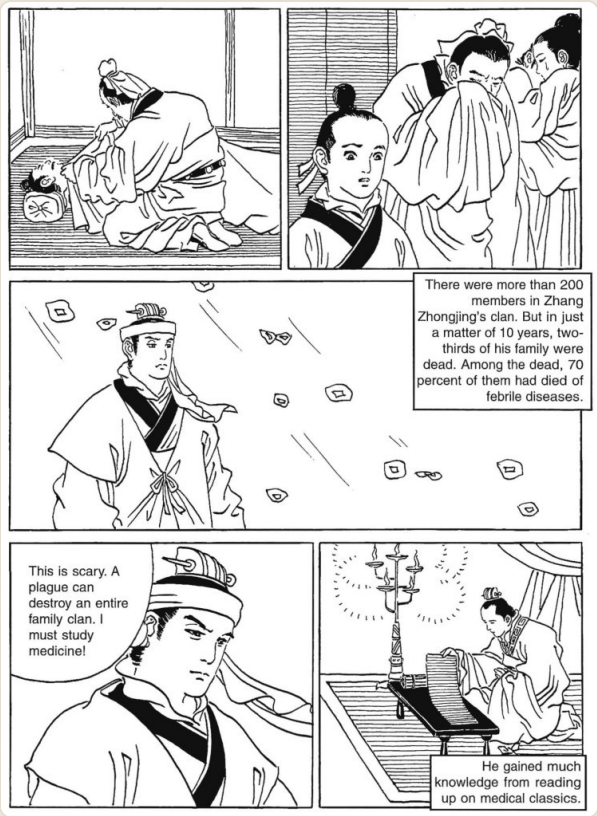
Trang 153

Họ tộc của Zhang Zhongjing có hơn 200 người. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, hai phần ba gia tộc đã chết. Trong số người chết, 70 phần trăm tử vong vì bệnh thương hàn.

Đáng sợ thật. Một trận dịch có thể hủy diệt cả một dòng họ. Ta phải học y mới được!

Ông đã học hỏi được rất nhiều điều nhờ đọc các sách y học cổ.

HÌNH 320



Một trang truyện tranh gồm năm khung. Mở đầu là cảnh một thầy thuốc quỳ bên người bệnh nằm trên chiếu, người nhà khóc than, còn Zhang Zhongjing lúc trẻ đứng nhìn. Sau đó ông vừa bước đi một mình vừa suy nghĩ, trong khi lời dẫn kể rằng dịch bệnh đã cướp đi hai phần ba dòng họ trong mười năm. Quyết chí học y, ông ngồi đọc sách y học cổ bên ánh nến của một giá đèn nhiều ngọn.

TRANG SÁCH 154 · SCAN P163

Trang 154

Ông còn sưu tầm những phương thuốc cổ nổi tiếng lẫn các bài thuốc dân gian.

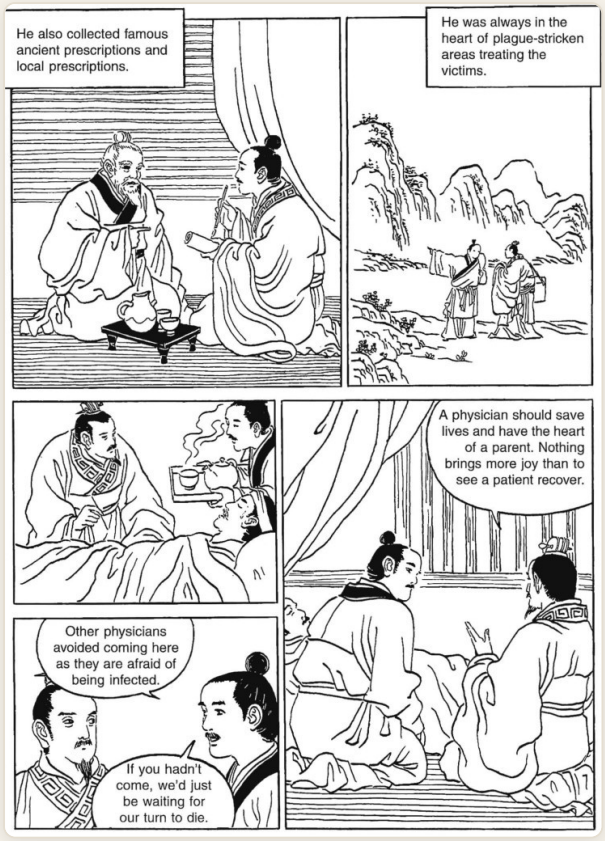
Ông luôn có mặt ở tâm điểm những vùng có dịch để chữa trị cho người bệnh.

Thầy thuốc phải cứu người và phải có tấm lòng của bậc cha mẹ. Không gì vui hơn là thấy người bệnh bình phục.

Các thầy thuốc khác đều tránh đến đây vì sợ bị lây bệnh.

Nếu không có ông đến, chúng tôi chỉ còn biết chờ đến lượt mình mà chết.

HÌNH 321



Một trang truyện tranh gồm năm khung. Khung đầu, một thầy thuốc già bàn về phương thuốc với người học trò trẻ đang ghi chép; khung kế tiếp, hai người bộ hành qua vùng núi có dịch. Một khung khác tả cảnh người bệnh được chăm sóc trên giường, người phụ việc bưng mâm thuốc vào. Zhang Zhongjing nói với người bạn đồng hành rằng thầy thuốc phải cứu người và có tấm lòng cha mẹ, và vui mừng khi người bệnh bình phục; hai người dân cảm kích nhận xét rằng các thầy thuốc khác đều tránh xa vì sợ lây.

TRANG SÁCH 155 · SCAN P164

Trang 155

Sau khi ngã bệnh, thân thể người ấy nóng như lửa đốt.

Thưa thầy thuốc, chứng dịch này gọi là gì? Chữa có dễ không?

Chứng bệnh như thế này, phát vào một mùa nhất định, là bệnh thương hàn.

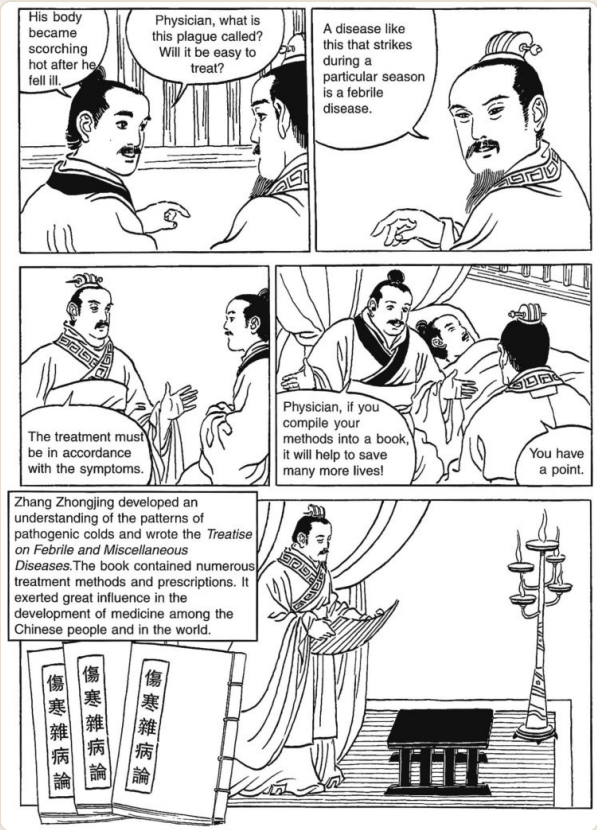
Cách chữa trị phải tùy theo từng triệu chứng.

Thưa thầy thuốc, nếu thầy biên soạn các phương pháp của mình thành sách, sẽ cứu được thêm rất nhiều người!

Ngươi nói có lý.

Zhang Zhongjing đã nắm được quy luật của những bệnh do hàn tà gây ra và viết nên cuốn *Thương hàn tạp bệnh luận* (傷寒雜病論). Sách tập hợp nhiều cách chữa trị và phương thuốc. Nó có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của nền y học Trung Hoa và cả thế giới.

HÌNH 322



Một trang truyện tranh gồm năm khung. Một người nhà kể rằng bệnh nhân lên cơn nóng như lửa đốt sau khi ngã bệnh, rồi hỏi thầy thuốc chứng dịch ấy tên là gì và có dễ chữa không; Zhang Zhongjing giải thích rằng bệnh phát vào một mùa nhất định là bệnh thương hàn, và cách chữa phải tùy theo triệu chứng. Khi người bệnh khuyên ông ghi lại các phương pháp thành sách để cứu thêm nhiều mạng người, ông đồng ý. Khung cuối cho thấy ông cầm cuộn sách bên cạnh ba bộ sách đóng của tác phẩm Thương hàn tạp bệnh luận.

Sun Simiao

Sun Simiao

Sun Simiao là thầy thuốc nổi tiếng thời Tùy Đường (581–682). Thuở nhỏ ông ốm yếu, vậy mà vẫn sống đến 101 tuổi. Sun Simiao hành nghề y hơn 80 năm và được tôn xưng là Dược Vương.

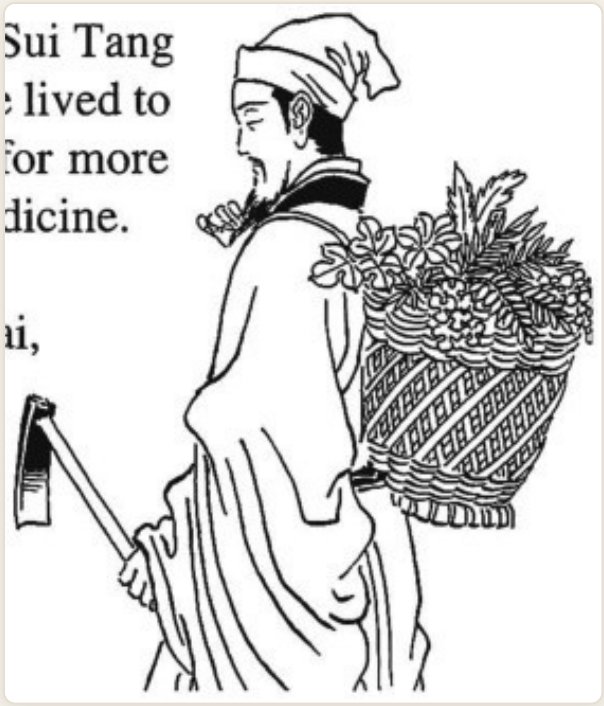
Ông thường hái thuốc trên núi Ngũ Đài, về sau ngọn núi này được gọi là núi Dược Vương. Trên núi còn có cả đền Dược Vương, nơi người ta dâng lễ trước tượng ông.

Bị cấp thiên kim yếu phương (30 quyển) và *Thiên kim dực phương* (30 quyển) nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông. Cuốn thứ nhất bàn về sản khoa, phụ khoa và nhi khoa cùng những hiểu biết đúc kết từ kinh nghiệm của ông, cách trừ độc, liệu pháp ăn uống cấp cứu, tu dưỡng tâm tính, bắt mạch, châm cứu và cứu ngải... Tác phẩm được ca ngợi là bộ bách khoa y học sớm nhất của Trung Quốc. Trong sách, ông cũng giới thiệu bài thuốc phối hợp, kết hợp hai hoặc ba phương thuốc cổ điển thành một để tăng hiệu quả, đồng thời đơn giản hóa một số bài thuốc cổ để chữa những bệnh cụ thể.

Sun Simiao là người tiên phong trong nghiên cứu sản khoa và phụ khoa. Trong *Bị cấp thiên kim yếu phương*, ông đặc biệt chú trọng phụ khoa và nhi khoa. Ông cũng tìm ra cách chữa hiệu quả chứng mềm yếu chi dưới, sớm hơn 1000 năm so với năm 1642, khi các thầy thuốc châu Âu bắt đầu nghiên cứu chữa căn bệnh này. Ông cũng là người đầu tiên dùng tuyến giáp của dê để chữa bướu cổ. Việc dùng gan động vật để chữa bệnh quáng gà cũng là một trong nhiều phát hiện y học của ông.

Sun Simiao đặt y đức lên hàng đầu. Ông cho rằng y thuật giỏi phải đi đôi với tấm lòng chân thành. Phương châm của ông là: "Hành động dứt khoát nhưng phải suy nghĩ chín chắn, chữa trị linh hoạt nhưng không bao giờ chủ quan trong phán đoán."

HÌNH 323



Hình vẽ Sun Simiao lúc tuổi già, mặc áo choàng rộng, đầu đội mũ vải mềm, sải bước với chiếc sọt đan đựng đầy dược thảo mới hái sau lưng và cây cuốc nắm chắc trong tay.

TRANG SÁCH 157 · SCAN P166

Sun Simiao — Thầy thuốc

Sun Simiao — Thầy thuốc

Sun Simiao:

"Một mạng người đáng giá ngàn lạng vàng,

Một phương thuốc cứu mạng còn quý hơn ngàn lạng vàng."

"Không gì quý hơn mạng sống con người. Nó đáng giá hơn ngàn lạng vàng. Công đức của một phương thuốc cứu mạng còn hơn cả ngàn lạng vàng."

Thuở nhỏ, Sun Simiao từng chịu đựng bệnh tật giày vò nên thấu hiểu tầm quan trọng của người thầy thuốc. Những tác phẩm nổi tiếng của ông, *Bị cấp thiên kim yếu phương* và *Thiên kim dực phương*, đều đề cao giá trị của mạng sống.

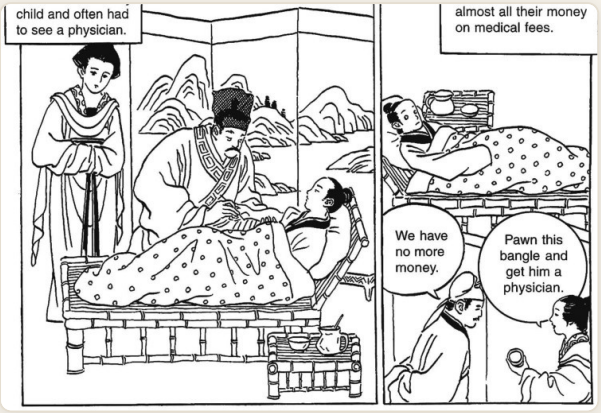
Sun Simiao thuở nhỏ ốm yếu, thường xuyên phải đi khám thầy thuốc.

Cha mẹ ông tiêu gần hết tiền bạc vào việc chạy chữa.

Chúng ta không còn tiền nữa.

Đem chiếc vòng này đi cầm, lấy tiền mời thầy thuốc về cho con.

HÌNH 324



Hai khung truyện tranh. Khung đầu, một thầy thuốc bắt mạch cho cậu bé Sun Simiao đang nằm dưới chăn bông, mẹ cậu đứng bên giường. Khung sau, cậu bé nằm trên giường, cha mẹ bàn bạc, người mẹ đưa chiếc vòng ra để đem cầm lấy tiền mời thầy thuốc.

TRANG SÁCH 158 · SCAN P167

Trang 158

Không chỉ mình ta khổ sở khi ta ngã bệnh. Những người quanh ta cũng khổ theo.

Lớn lên con muốn trở thành thầy thuốc. Con sẽ xóa bỏ nỗi đau bệnh tật cho chính mình và cho mọi người.

Sun Simiao thông minh và siêng năng. Năm lên bảy, cậu đã đọc được hơn 1000 chữ. Đến năm 20 tuổi, ông đã thông hiểu nhiều học thuyết khác nhau.

Ông nghiên cứu những trước tác nổi tiếng của các học giả thời xưa và học hỏi từ các y gia lão luyện.

HÌNH 325

Một trang truyện tranh gồm bốn khung. Cậu bé Sun Simiao nằm ốm trên giường, nghĩ rằng bệnh tật của mình cũng khiến những người quanh cậu khổ sở, và quyết tâm lớn lên làm thầy thuốc để xóa bỏ nỗi đau bệnh tật cho chính mình và cho mọi người. Hai khung dưới kể lại lúc ông lớn lên: chăm chú đọc sách giữa những giá sách trong thư phòng, rồi ngồi ngoài trời bên một học giả già để học hỏi.

TRANG SÁCH 159 · SCAN P168

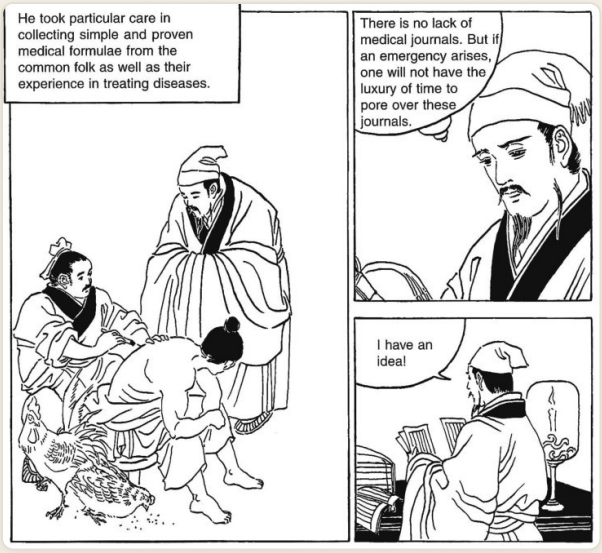
Trang 159

Ông đặc biệt chú tâm sưu tầm những phương thuốc đơn giản mà hiệu nghiệm của dân gian, cùng kinh nghiệm chữa bệnh của họ.

Sách y học thì không thiếu. Nhưng khi có ca cấp cứu, người ta chẳng có thời gian mà lật giở hết chỗ sách ấy.

Ta có ý rồi!

HÌNH 326

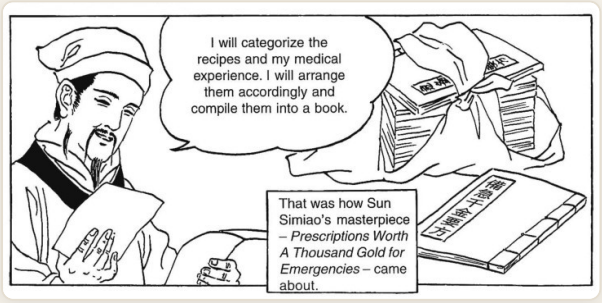


Ba khung truyện tranh. Khung đầu, Sun Simiao cúi xuống xem một lang y trong làng chữa bệnh, con gà trống bới đất dưới chân, để thu thập những bài thuốc dân gian đơn giản. Khung thứ hai, ông chăm chú nghiền ngẫm chồng sách y học bên cửa sổ. Khung thứ ba, bỗng nảy ra ý tưởng, ông quay sang bàn giấy đầy sách bên ngọn đèn.

Ta sẽ phân loại các phương thuốc và kinh nghiệm chữa bệnh của mình. Ta sẽ sắp xếp chúng cho thích hợp rồi biên soạn thành sách.

Bộ sách để đời của Sun Simiao — *Bị cấp thiên kim yếu phương* — ra đời từ đó.

HÌNH 327



Một khung tranh rộng. Sun Simiao ngồi viết trên một tờ giấy, vừa nghĩ vừa nói rằng ông sẽ phân loại các phương thuốc cùng kinh nghiệm chữa bệnh của mình rồi sắp xếp thành sách; bên cạnh là những bó giấy và một cuốn sách đã đóng thành quyển.

Trang 160

Sun Simiao coi trọng việc tu dưỡng y đức.

Một thầy thuốc chân chính phải giỏi về y thuật và chân thành trong cách đối xử với người khác.

Sun Simiao không phân biệt người nghèo. Ông đối xử với người bệnh như nhau, dù giàu hay nghèo.

Thưa thầy thuốc, tôi không có tiền trả thầy. Khi khỏi bệnh, tôi sẽ làm việc cho thầy để trả ơn.

Đừng bận tâm chuyện trả tiền.

Cầm số bạc này đi mua thuốc bổ về dùng.

Thưa thầy, hãy để chúng ta tiếp tục lên đường khi trời sáng.

Không được, cứu mạng người chẳng khác nào dập lửa! Không thể chậm trễ!

Dù hành trình có hiểm trở đến đâu, bất kể ngày hay đêm, giá rét hay nóng như thiêu, Sun Simiao cũng không để bất cứ điều gì ngăn ông đến thăm một người bệnh.

Vào những năm cuối đời, ông còn viết nên cuốn *Thiên kim dực phương*.

HÌNH 328

Một trang truyện tranh gồm sáu khung. Sun Simiao cầm một nhánh dược thảo, nói rằng thầy thuốc chân chính phải giỏi nghề và chân thành trong cách đối xử với người khác; ông bảo người bệnh nghèo đừng lo chuyện trả tiền; ông dúi bạc cho một người vừa khỏi bệnh để mua thuốc bổ; rồi trên lưng ngựa suốt đêm, ông nhất quyết không chậm trễ, nói rằng cứu mạng người chẳng khác nào dập lửa. Những khung cuối cho thấy ông rong ruổi qua núi non trong mọi thời tiết, và lúc tuổi già viết nên cuốn Thiên kim dực phương.

TRANG SÁCH 161 · SCAN P170

Chu Đan Khê

Chu Đan Khê

Chu Đan Khê (Zhu Danxi) là một danh y sống vào đời Nguyên (1281 – 1358). Ông là một thầy thuốc tài giỏi, thường chỉ cần một thang thuốc của ông là bệnh nhân khỏi bệnh. Vì vậy người đời gọi ông là "Chu Nhất Thiếp" (Chu Một Thang) và "Bán Tiên Chu".

Mãi đến năm 30 tuổi Chu Đan Khê mới bắt đầu đọc sách y học, vì mẹ ông mắc chứng đau tỳ kéo dài. Năm năm sau, ông chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Năm 36 tuổi, ông theo học Tân Nho giáo (lý học) với Từ Văn Ý. Chỉ vài năm sau, ông đã nổi tiếng là một Nho sĩ uyên bác.

Khi Từ Văn Ý lâm bệnh nặng, thầy khuyên Chu Đan Khê chuyển sang học y. Nhớ lại con trai, vợ, em trai, các chú bác và nhiều người thân khác trong nhà đều chết dưới tay những lang y kém cỏi, Chu Đan Khê từ bỏ chí nguyện làm quan trong triều và quay sang học y.

Thời bấy giờ, sách *Cục phương Hòa Tễ* đời Tống do triều đình ban hành đang rất thịnh hành. Các lang y kém cỏi cứ thế chép nguyên xi những bài thuốc trong sách rồi kê cho bệnh nhân. Chu Đan Khê nhận ra những hạn chế của cuốn sách này. Ông bèn nghiên cứu *Hoàng Đế nội kinh*, *Nan kinh* và nhiều sách khác. Ông còn đi khắp các vùng đất khác để tìm gặp những danh y. Danh y La Tri Đễ đã nhận ông làm học trò, và vài năm sau, Chu Đan Khê trở thành một bậc thượng y với kiến thức uyên thâm và y thuật điêu luyện.

Chu Đan Khê đã sáng tạo ra học thuyết độc đáo về dưỡng âm (âm dưỡng). Học thuyết này chủ trương dưỡng âm để hạ hỏa trong cơ thể. Ông cũng phản đối việc dùng bừa bãi các vị thuốc cay nóng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn ăn uống. Học thuyết của ông có ảnh hưởng rộng rãi. Các chuyên gia y học Nhật Bản đã sang Trung Quốc vào đời Minh để học tập Chu Đan Khê. Ngày nay, ở Nhật Bản vẫn còn những hội đoàn được thành lập dựa trên học thuyết của ông.

HÌNH 329

Tranh vẽ nét chân dung Chu Đan Khê: phần đầu và vai của một lão danh y râu dài, đội mũ Nho mềm gấp nếp, mặc áo bào có cổ áo hoa văn.

Học thuyết dưỡng âm phòng lão của Chu Đan Khê

Học thuyết dưỡng âm phòng lão của Chu Đan Khê

Chu Đan Khê cho rằng bệnh tật khi về già là do âm không đủ mà dương lại thừa; vì vậy ông tin rằng dưỡng âm sẽ trừ được hỏa và ngăn ngừa bệnh tật tuổi già.

"Người đã bước sang tuổi 60, 70 thì tinh huyết đã hao tổn nhiều. Dù không ăn uống thất thường hay ốm đau, người ấy cũng đã mang sẵn chứng nhiệt."

"Không được lạm dụng hoàn Ngũ Phúc. Kiêng rượu và thịt mỡ; đồ nướng, hun khói và chiên rán; đồ cay, ngọt và nhiều dầu mỡ."

"Người già bị tỳ hư và âm không đủ. Nhiệt ở vị sẽ gây cảm giác đói cồn cào; tỳ yếu thì thức ăn khó tiêu, ăn quá nhiều lại càng làm vị quá tải. Âm hư sẽ khiến khí bị trệ và sinh ra bệnh tật."

Chu Đan Khê học y

HÌNH 330

Truyện tranh hai khung. Khung bên trái: một cậu bé lê bước trên con đường quê, trên lưng cõng một bó củi lớn, phía trước là mẹ cậu cũng đang cúi lưng vác củi; ô chú thích ở góc kể rằng Đan Khê mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con sống trong cảnh nghèo khó. Khung bên phải: cậu bé ấy đứng ngoài một ngôi trường, nhìn qua khung cửa sổ chấn song mở rộng vào đám trẻ đang ngồi học, kèm bong bóng hội thoại nói rằng chỉ con nhà giàu mới có tiền đi học.

TRANG SÁCH 163 · SCAN P172

Trang 163

Ước gì mình được như các bạn ấy. Mình sẽ đứng ngoài cửa sổ nghe lỏm buổi học...

Trời, đất, người...

Cuối cùng, cậu biết được nhiều chữ hơn cả những học trò bên trong.

Trong thị trấn có một gia đình sở hữu rất nhiều sách. Vì không có tiền mua sách, Chu Đan Khê thường đến nhà ấy mượn sách về đọc.

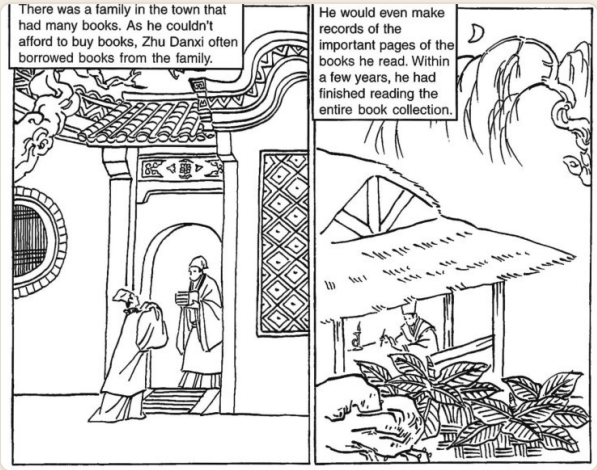
Cậu còn chép lại những trang quan trọng trong sách mình đọc. Chỉ trong vài năm, cậu đã đọc hết toàn bộ kho sách của gia đình ấy.

HÌNH 331

Truyện tranh hai khung. Khung bên trái: Chu Đan Khê thuở nhỏ bám lấy hàng rào tre, thẫn thờ nhìn qua khe; bong bóng hội thoại cho thấy cậu ghen tị với các bạn học và quyết định đứng ngoài cửa sổ nghe lỏm bài giảng. Khung bên phải: cậu ngồi xổm trên nền đất trống, dùng que vạch chữ trên cát, phía trên là bong bóng hình đám mây ghi "Trời, đất, người"; ô chú thích cho biết cuối cùng cậu biết được nhiều chữ hơn cả các học trò bên trong.

>

HÌNH 332



Truyện tranh hai khung. Khung bên trái: Chu Đan Khê cúi đầu kính cẩn trước cổng ngôi nhà ngói lớn, phía trước là một Nho sĩ đứng trên bậc thềm, tay ôm một chồng sách; ô chú thích kể rằng trong thị trấn có một gia đình sở hữu nhiều sách, vì không có tiền mua nên cậu thường đến mượn. Khung bên phải: cậu ngồi trong túp lều tranh, bên bàn chép lại những đoạn quan trọng trong sách đọc được; ô chú thích cho biết chỉ vài năm sau cậu đã đọc hết cả kho sách ấy.

TRANG SÁCH 164 · SCAN P173

Trang 164

Khi ông 30 tuổi, mẹ của Chu Đan Khê lâm bệnh.

Mẹ bị bệnh. Nhưng các thầy thuốc đều không giúp được gì.

Để con đọc các sách thuốc xem có tìm được cách chữa không.

Ông phải miệt mài học suốt năm năm mới chữa khỏi chứng tỳ hư cho mẹ.

HÌNH 333

Đoạn mở đầu của truyện tranh. Khung thứ nhất: mẹ của Chu Đan Khê nằm dưới chăn hoa, một thầy thuốc đội mũ cao đang bắt mạch bên giường, kèm ô chú thích rằng mẹ ông lâm bệnh khi ông ba mươi tuổi. Khung thứ hai: Chu Đan Khê tay bưng bát thuốc còn bốc khói, vẻ mặt trầm ngâm, với hai bong bóng hội thoại: mẹ bị bệnh mà các thầy thuốc đều không giúp được, và ông sẽ đọc sách thuốc để tìm cách chữa. Khung thứ ba: ông ngồi bên bàn khuya, học sách thuốc dưới ánh đèn dầu, kèm ô chú thích cho biết phải năm năm miệt mài học tập ông mới chữa khỏi chứng tỳ hư cho mẹ.

>

HÌNH 334

Khung kết của đoạn truyện: Chu Đan Khê lúc đã trưởng thành, có râu, nhìn ra khoảng trời mây với đàn chim bay, bong bóng hội thoại phía trên ghi rằng học y có thể cứu người, nên ông quyết chí học thuốc.

Trang 165

Ông đến học vị danh y La Tri Đễ.

Sư phụ ta không truyền y thuật cho bất kỳ ai. Đi đi. Đừng quấy rầy sư phụ ta nữa.

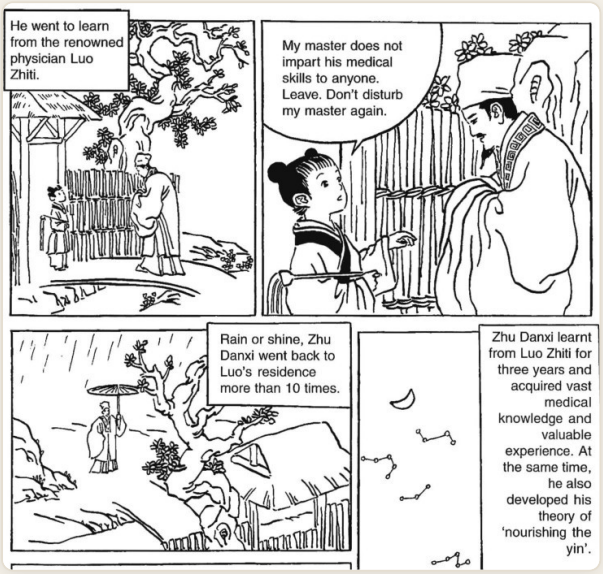
Dù mưa hay nắng, Chu Đan Khê vẫn quay lại nhà họ La hơn mười lần.

Chu Đan Khê theo học La Tri Đễ ba năm, thu được kiến thức y học sâu rộng và kinh nghiệm quý báu. Cùng lúc đó, ông cũng hình thành học thuyết "dưỡng âm" của mình.

Lòng kiên trì của ông cuối cùng đã cảm động La Tri Đễ, khiến ông nhận Chu Đan Khê làm học trò như một ngoại lệ. Lúc ấy, Chu Đan Khê đã 44 tuổi.

Dương thường thừa, âm thường thiếu.

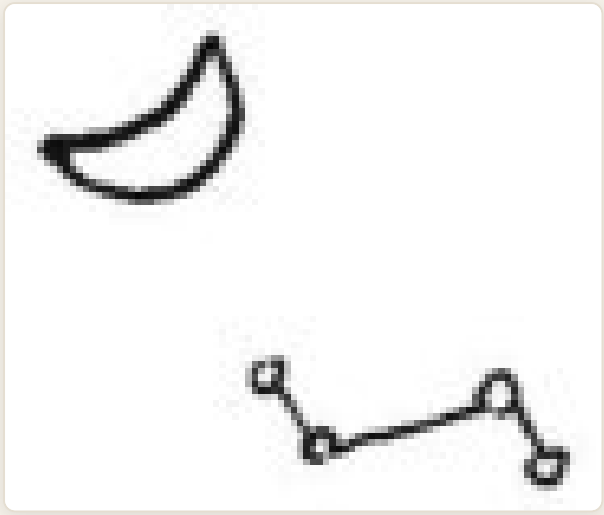
HÌNH 335



Truyện tranh bốn khung. Khung thứ nhất: Chu Đan Khê trẻ tuổi đứng trước cổng một ngôi nhà quê có hàng rào, một vị sư phụ râu bạc đang tiếp ông, kèm chú thích rằng ông đến học vị danh y La Tri Đễ. Khung thứ hai: một người hầu giơ tay chặn ông trước cổng, nói rằng sư phụ không truyền y thuật cho ai và bảo ông hãy đi, đừng quấy rầy sư phụ nữa. Khung thứ ba: Chu Đan Khê đội ô giấy dầu bước trong mưa trên đường trở về, kèm chú thích rằng dù mưa hay nắng ông vẫn quay lại nhà họ La hơn mười lần. Khung thứ tư là cảnh đêm: vầng trăng và vài ngôi sao rải rác trên nền trời tối, phía dưới là một bóng người đơn độc, kèm ô chữ nói rằng ông theo học La Tri Đễ ba năm, thu được kiến thức và kinh nghiệm y học phong phú, đồng thời hình thành học thuyết "dưỡng âm".

>

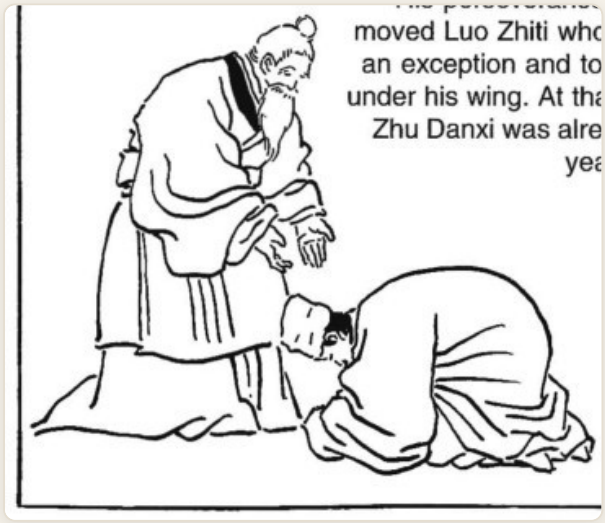
HÌNH 336



Hình vẽ trang trí nhỏ nằm trong khung cảnh đêm: một vầng trăng lưỡi liềm và vài ngôi sao sáng nối với nhau bằng những đường thẳng thành một chòm sao.

>

HÌNH 337



Tranh vẽ nét: Chu Đan Khê khi đã là người trung niên quỳ sụp xuống đất cúi lạy, còn La Tri Đễ râu bạc hơi cúi người về phía trước, đưa tay ra nhận ông làm học trò; ô chú thích kể rằng lòng kiên trì của ông cuối cùng đã cảm động La Tri Đễ, khiến ông nhận học trò như một ngoại lệ khi Chu Đan Khê đã 44 tuổi.

>

HÌNH 338

Khung nhỏ vẽ một người mặc áo dài, đội mũ cao đứng đơn độc trên khoảng đất trống, ngẩng mặt nhìn lên, bên cạnh là bong bóng hội thoại ghi rằng dương thường thừa còn âm thường thiếu.

TRANG SÁCH 166 · SCAN P175

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân (1518 – 1593), một danh y đời Minh, đã dành 27 năm để biên soạn *Bản thảo cương mục* — bộ sách y học lừng danh thế giới. Bộ sách gồm 52 quyển, ghi chép 1892 vị thuốc Trung Quốc cùng hơn 1000 hình minh họa. Đây là công trình tập hợp 2000 năm tri thức dược học của Trung Quốc.

Trong quá trình viết bộ sách, Lý Thời Trân thường tự mình quan sát, lặn lội vào núi sâu và đồng cỏ mênh mông để nghiên cứu, thu thập mẫu thuốc. Ông cũng học hỏi từ những người có kinh nghiệm hơn trong ngành y. Nhờ công trình nghiên cứu của mình, ông đã bác bỏ nhiều quan niệm sai lầm về một số vị thuốc và công dụng của chúng.

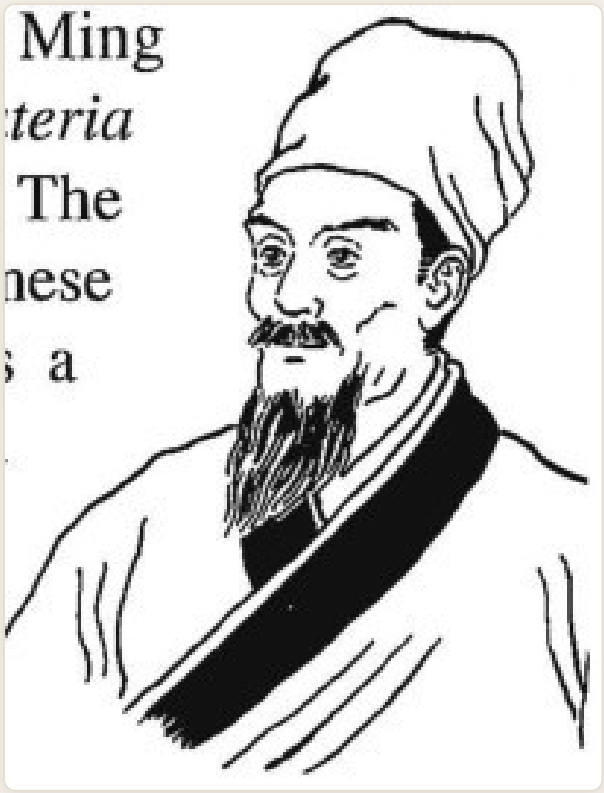
Chẳng hạn, *lang mai* từ lâu được cho là một loại tiên quả ban tặng tuổi trẻ vĩnh cửu. Lý Thời Trân đích thân hái quả và tự nếm thử. Ông phát hiện ra đó chỉ là một loại quả biến dị của cây du, không hề có tính chất đặc biệt nào.

Con tê tê được dùng làm vị thuốc. Các sách trước đây cho rằng tê tê có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước. Ban ngày nó giả chết trên cạn rồi xòe vảy ra để dụ kiến bò vào, sau đó trở lại dưới nước và xòe vảy để nhả kiến ra. Khi kiến nổi lên mặt nước, nó sẽ nuốt kiến làm thức ăn. Để kiểm

chứng điều này, Lý Thời Trân tìm gặp những người thợ săn sống trong núi. Ông phát hiện ra rằng tê tê thực ra tấn công tổ kiến và ăn kiến bằng cách thè lưỡi ra.

Với phương pháp làm việc khoa học và tỉ mỉ, Lý Thời Trân đã hoàn thành *Bản thảo cương mục* và sửa chữa nhiều sai sót của các bậc tiền bối ngành y. Ông cũng đóng góp đáng kể vào việc phân loại thực vật và các ngành khoa học liên quan khác (sinh học, hóa học, địa chất học, khoáng vật học). *Bản thảo cương mục* đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và góp phần đưa y học cổ truyền Trung Quốc tiến xa trong lĩnh vực y khoa.

HÌNH 339



Tranh vẽ nét chân dung Lý Thời Trân: phần đầu và vai của một danh y râu dài, đội mũ Nho sĩ đời Minh, mặc áo bào có dải đai sẫm màu rộng vắt ngang ngực.

TRANG SÁCH 167 · SCAN P176

Các món ăn dưỡng sinh trong *Bản thảo cương mục*

Các món ăn dưỡng sinh trong *Bản thảo cương mục*

Lý Thời Trân rất coi trọng việc dùng món ăn làm thuốc để giữ gìn sức khỏe. Nhiều bài thuốc – món ăn đã được ghi lại trong *Bản thảo cương mục*. Trong số đó có món cháo thuốc.

Cháo hạch đào

Thành phần: Hạch đào (óc chó) 60g, hạt kê 100g

Cách làm: Đập hạch đào cả vỏ cho vỡ. Cho ít nước rồi nấu hạt kê thành cháo. Cho hạch đào đã đập vào, nấu tiếp đến khi trên mặt cháo nổi lên một lớp dầu mỏng. Cháo nên ăn khi còn ấm, ngày hai lần.

Công dụng: Bổ thận, thu liễm phế. Đồng thời nhuận táo và bồi bổ tỳ vị.

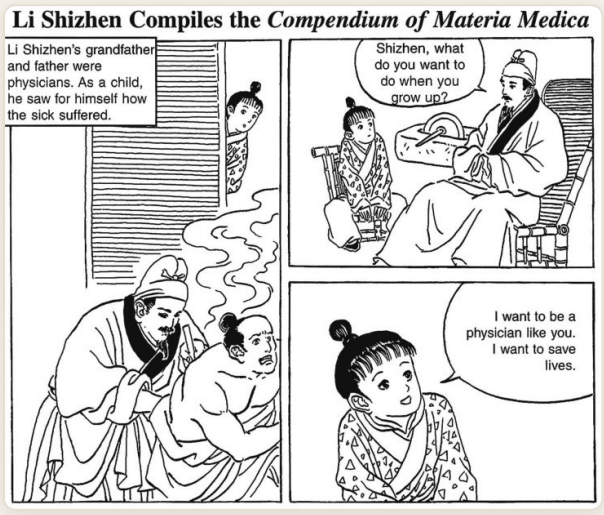
Lý Thời Trân biên soạn *Bản thảo cương mục*

Ông nội và cha của Lý Thời Trân đều là thầy thuốc. Từ nhỏ, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh người bệnh đau đớn.

Thời Trân, hành nghề y không dễ đâu. Cha muốn con học hành để sau này làm quan trong triều.

Con muốn làm thầy thuốc giống cha. Con muốn cứu người.

HÌNH 340



Truyện tranh ba khung. Khung lớn bên trái: cậu bé Lý Thời Trân nhìn qua khung cửa sổ chấn song trong khi cha cậu – một thầy thuốc đội mũ cao – đang chữa bệnh cho một người bệnh ngồi trước mặt; ô chú thích cho biết ông nội và cha cậu đều là thầy thuốc, và từ nhỏ cậu đã tận mắt thấy người bệnh đau đớn. Khung phía trên bên phải: người cha ngồi bên bàn với cậu con trai nhỏ, hỏi cậu lớn lên muốn làm gì. Khung phía dưới bên phải: cậu bé búi tóc trên đỉnh đầu, gương mặt rạng rỡ trả lời rằng cậu muốn làm thầy thuốc giống cha và muốn cứu người.

Trang 168

Thời Trân, hành nghề y không dễ đâu. Cha muốn con học hành để sau này làm quan trong triều.

Lý Thời Trân không dám trái ý cha. Năm 14 tuổi, ông dự kỳ thi khoa cử.

Nhưng sau ba lần dự thi, ông vẫn không đỗ đạt.

Thưa cha, con nghĩ mình không hợp với chốn quan trường. Xin cha cho con học thuốc.

Được rồi. Có lẽ đây là số phận.

Thế là Lý Thời Trân học y từ cha mình.

Cùng lúc đó, ông cũng học Tân Nho giáo và lịch sử. Sau 10 năm miệt mài, Lý Thời Trân trở thành một thầy thuốc nổi tiếng trong thị trấn của mình.

HÌNH 341

Truyện tranh toàn trang gồm bốn cảnh. Cảnh một: cha của Lý Thời Trân đặt tay lên vai cậu bé, nói rằng hành nghề y không dễ, cha muốn con học hành để sau này làm quan trong triều. Cảnh hai: cậu bé ngồi trong một trường thi dài, xung quanh là các thí sinh cúi đầu làm bài, cha cậu đứng phía sau; ô chú thích cho biết cậu không dám trái ý cha nên năm mười bốn tuổi đã dự kỳ thi khoa cử. Cảnh ba: Lý Thời Trân khi đã già, râu bạc, ngồi cùng cha trong sân nhà, nói rằng mình không hợp với chốn quan trường và xin được học thuốc; cha ông đáp rằng có lẽ đây là số phận. Cảnh bốn: ông cúi đầu bên chồng sách trên bàn có ngọn nến, sau khi học y từ cha và đồng thời học Tân Nho giáo cùng lịch sử; sau mười năm miệt mài, ông trở thành một thầy thuốc nổi tiếng trong thị trấn.

TRANG SÁCH 169 · SCAN P178

Trang 169

Vào thời Gia Tĩnh đời Minh, Lý Thời Trân được triệu vào phủ thái tử. Ít lâu sau, ông được tiến cử làm thái y trong cung.

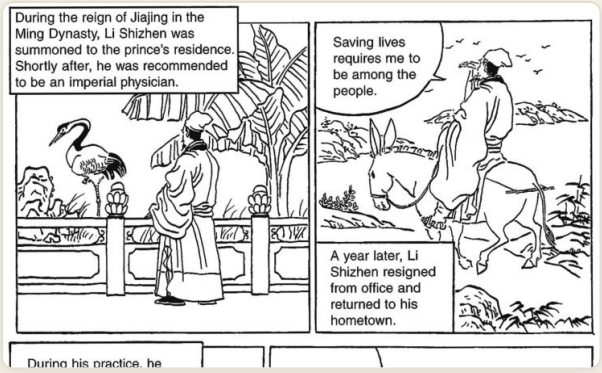
"Cứu người thì phải sống giữa dân chúng." Một năm sau, Lý Thời Trân từ chức và trở về quê nhà.

Trong quá trình hành nghề, ông phát hiện nhiều sai sót trong các sách y học trước đây.

"Chà! Những sai sót này có thể gây chết người. Hơn nữa, nhiều ghi chép y học cổ xưa không còn phù hợp với ngày nay."

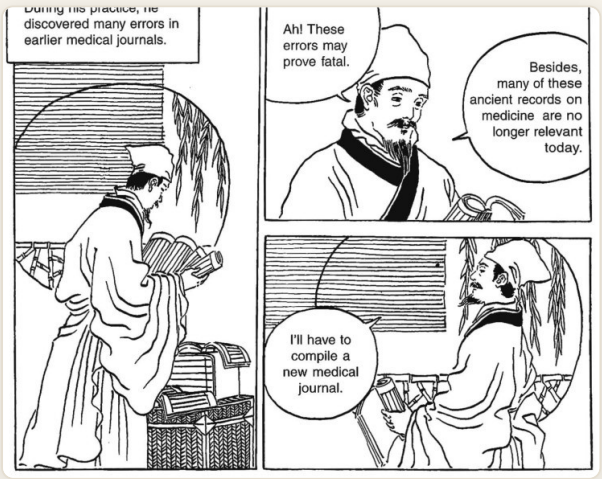
"Ta phải biên soạn một cuốn sách y học mới."

HÌNH 342



Khung truyện tranh: Lý Thời Trân đứng trong sân phủ thái tử bên lan can đá chạm trổ, một con hạc đầu đỏ đậu trên thành lan can, phía sau là những tàu lá chuối rộng; ở khung bên cạnh, ông cưỡi lừa trên con đường quê, một con chim bay phía trên, sau khi lên đường để sống giữa dân chúng.

HÌNH 343



Các khung truyện tranh: Lý Thời Trân ngồi bên bàn cạnh cửa sổ chấn song, chăm chú đọc chồng sách y học cũ, bên cạnh là chồng sách và một chiếc sọt mây có nắp đậy; ở các khung kế tiếp, ông ngẩng lên kinh ngạc trước những sai sót mình vừa phát hiện và quyết tâm biên soạn một cuốn sách y học mới.

Trang 170

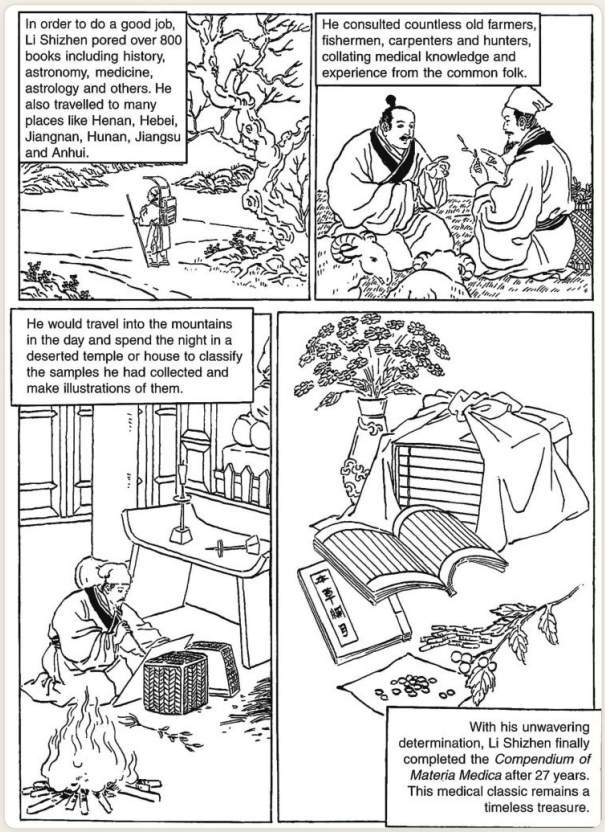
Để làm tốt công việc, Lý Thời Trân đã nghiền ngẫm hơn 800 cuốn sách gồm sử học, thiên văn học, y học, chiêm tinh học và nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng đã đi đến nhiều nơi như Hà Nam, Hà Bắc, Giang Nam, Hồ Nam, Giang Tô và An Huy.

Ông hỏi han vô số lão nông, ngư dân, thợ mộc và thợ săn, thu thập lại kiến thức y học cùng kinh nghiệm từ dân gian.

Ban ngày ông lên núi, ban đêm nghỉ lại trong một ngôi chùa hay ngôi nhà hoang để phân loại các mẫu vật đã thu thập và vẽ hình minh họa cho chúng.

Với quyết tâm không lay chuyển, Lý Thời Trân cuối cùng đã hoàn thành *Bản thảo cương mục* sau 27 năm. Bộ sách y học kinh điển này vẫn mãi là một báu vật trường tồn.

HÌNH 344



Bốn khung truyện mô tả Lý Thời Trân nghiền ngẫm 800 cuốn sách, hỏi han các lão nông, ngư dân, thợ mộc và thợ săn, phân loại mẫu cây cỏ trong đêm tại một ngôi chùa hoang, và cuối cùng hoàn thành Bản thảo cương mục.

Các nữ y sĩ thời cổ

Các nữ y sĩ thời cổ

Trung Quốc cũng từng có nhiều nữ y sĩ!

Nhưng rất ít điều về họ được ghi chép lại. Vì thế mà ít người biết đến họ.

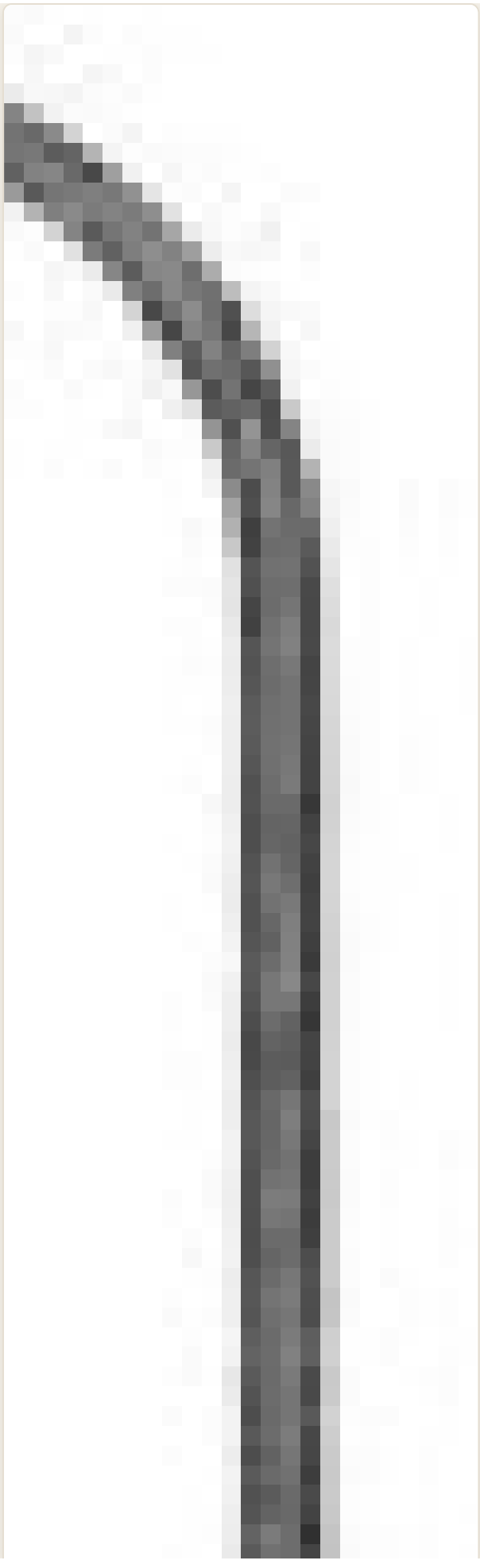
Thuần Vu Yển (Chun Yuyan)

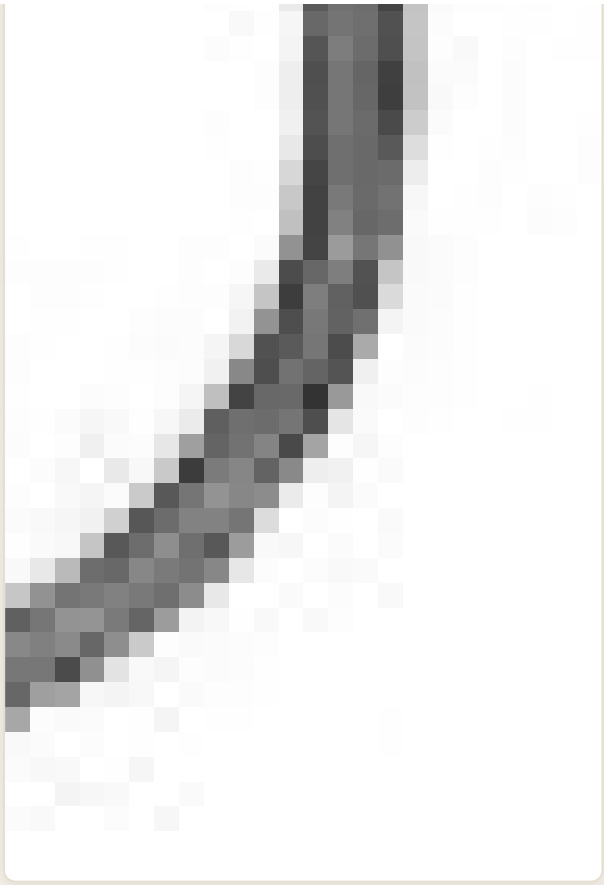
Vị nữ y sĩ thời Hán này là chuyên gia về sản khoa và phụ khoa. Tương truyền bà đã giúp Hoàng hậu đương thời trong lúc sinh nở.

Bào Cô (Bao Gu)

Một nữ y sĩ thời nhà Tấn. Bà là vợ của học giả nổi tiếng Cát Hồng. Bà học y học từ cha và chồng mình. Bà đi nhiều nơi để hành nghề y và đặc biệt giỏi về cứu ngải (moxibustion). Về sau, nhân dân đã lập một ngôi đền thờ bà để bày tỏ lòng biết ơn.

HÌNH 345





Họa tiết quả bầu trang trí bên cạnh tiêu đề chương.

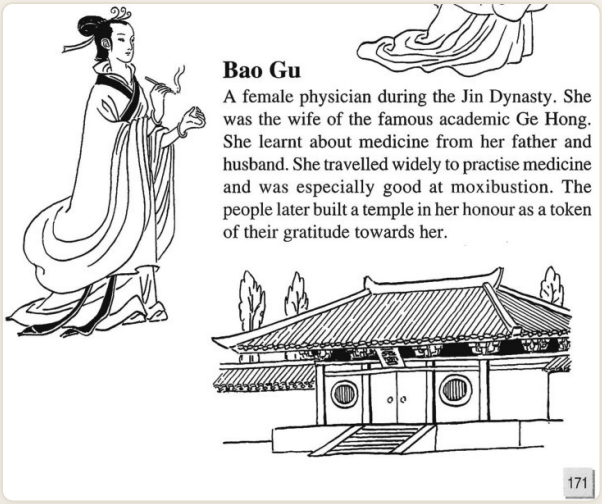
HÌNH 346

Hình vẽ trang trí nhỏ một sinh vật thần thoại giống rồng đi kèm các bong bóng hội thoại mở đầu.

HÌNH 347

Hình minh họa một nữ y sĩ đang bế đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh bong bóng hội thoại nói rằng nữ y sĩ ít được ghi chép lại.

HÌNH 348



Một nữ y sĩ đứng cầm dược thảo, cùng hình ngôi đền bên dưới đoạn văn nói về Bào Cô.

TRANG SÁCH 172 · SCAN P181

Tằng Ý (Zeng Yi)

Tằng Ý (Zeng Yi)

Vị nữ y sĩ thời nhà Thanh đã viết bộ *Cổ Hoan Thất Thư* (Gu Huan Shi Volume) gồm ba phần — *Nữ thư*, *Y thư* và *Thi văn thư*. Phần *Y thư* bàn về mạch, màu lưỡi, các bệnh sốt nhiễm trùng cấp tính, phong tà, hàn tà, sản khoa và phụ khoa, nhi khoa và ngoại khoa.

Tằng Ý từng bốn lần mắc phải dịch bệnh. Vì vậy bà có hiểu biết tận thân về hàn tà và các triệu chứng của bệnh sốt nhiễm trùng cấp tính cũng như cách điều trị tương ứng. Bà thường tự bốc thuốc cho mình và rất thành thạo việc đó. Tằng Ý cũng đặc biệt chú trọng dạy dỗ người dân về vệ sinh cá nhân. Bà khuyên nên nghỉ ngơi để giữ gìn tinh thần, hít thở không khí trong lành để bảo vệ phổi và tập luyện thường xuyên để thúc đẩy tuần hoàn máu. Tằng Ý có thể được coi là nữ y sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Y học Trung Quốc không phải là một lĩnh vực do nam giới thống trị. Các nữ thầy thuốc cũng đã có những đóng góp của mình.

TRANG SÁCH 173 · SCAN P182

Hiện đại hóa y học Trung Quốc

Hiện đại hóa y học Trung Quốc

Những lý thuyết, phương pháp chẩn đoán và cách điều trị độc đáo của y học cổ truyền Trung Quốc tương phản rõ rệt với y học phương Tây. Để vẫn còn phù hợp trong bối cảnh ngày nay, bên cạnh việc giữ gìn những tinh hoa tốt đẹp nhất của truyền thống, y học cổ truyền Trung Quốc đã dần dần bước lên con đường hiện đại hóa.

TRANG SÁCH 174 · SCAN P183

Chẩn đoán ứng dụng công nghệ cao

Chẩn đoán ứng dụng công nghệ cao

Bên cạnh việc sử dụng bốn phương pháp chẩn đoán truyền thống, y học cổ truyền Trung Quốc hiện đại cũng đã bắt đầu ứng dụng các thiết bị công nghệ để hỗ trợ quá trình chẩn đoán. Đã có những thiết bị chẩn đoán dùng để phân tích huyệt đạo, và người ta đang nghiên cứu một hệ thống tự động để chẩn đoán mạch.

Máy đo điện trở da (Electrodermal Screening Device – EDSD) là một trong những thiết bị điện tử được thiết kế để đọc hệ thống kinh lạc, kinh mạch và huyệt đạo trong y học cổ truyền Trung Quốc. Bác sĩ đo điện trở trên một huyệt đạo bằng một dụng cụ giống như cây bút, trong khi bệnh nhân cầm một điện cực tay để khép kín mạch điện với máy EDSD. Bằng cách này, bác sĩ có thể tìm ra tình trạng các cơ quan nội tạng, sự tiết hoóc-môn và nhiều thứ khác của bệnh nhân.

Các chuyên gia ở Trung Quốc và Hồng Kông cũng đã tạo ra một chương trình để thu thập và lưu trữ vô số hình ảnh lưỡi của bệnh nhân trong máy tính. Các hình ảnh được số hóa này sẽ tiếp tục được phân loại dựa trên màu sắc và lớp rêu trên lưỡi. Sau đó, tài liệu tham chiếu được nhập vào máy tính. Kết quả là một chương trình chẩn đoán bệnh dựa trên tình trạng của lưỡi.

Bệnh sử được tin học hóa

Việc sử dụng máy tính đã trở nên phổ biến trong thế giới ngày nay. Các thầy thuốc Trung Quốc cũng đã bắt đầu nhập bệnh sử và hồ sơ dùng thuốc của bệnh nhân vào máy tính. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc tra cứu hồ sơ của bệnh nhân và rút ngắn thời gian chờ đợi để bệnh nhân được gặp bác sĩ cũng như thời gian kê đơn thuốc.

TRANG SÁCH 175 · SCAN P184

Thuốc Trung Quốc dạng cao đặc

Thuốc Trung Quốc dạng cao đặc

Thuốc Trung Quốc thường mất nhiều thời gian để bào chế. Ngày nay, thuốc Trung Quốc có thể được chế biến thành dạng bột với nồng độ đậm đặc gấp năm đến 15 lần. Điều này không chỉ bảo đảm rằng mùi vị và hiệu quả của thuốc không bị ảnh hưởng, mà còn khả thi hơn về mặt kinh tế.

Một số hiệu thuốc cũng dự trữ những chai thuốc Trung Quốc dạng cao đặc. Dược sĩ sẽ pha chế cao đặc dựa trên đơn thuốc mà thầy thuốc gửi cho mình qua máy tính. Lượng cần dùng sau đó sẽ được đóng gói vào các túi nhỏ hơn và dán kín trước khi phát cho bệnh nhân.

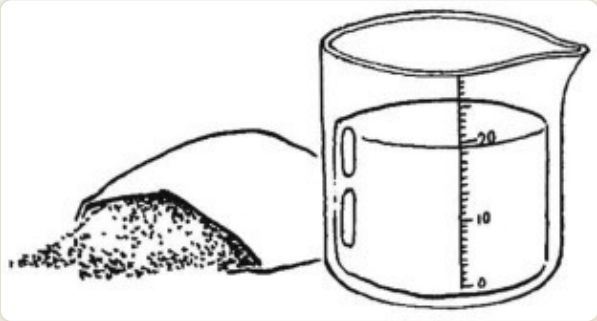
Thuốc Trung Quốc dạng cao đặc và loại thuốc Trung Quốc bào chế sẵn mà chúng ta thấy ở các hiệu thuốc là khác nhau. Loại thuốc Trung Quốc bào chế sẵn mà chúng ta thấy thực ra chỉ là thuốc Trung Quốc dạng bột được nén lại.

Dạng cao đặc của thuốc Trung Quốc trải qua một quá trình phức tạp và nghiêm ngặt, trong đó tinh chất của các thành phần hoạt tính đã được chiết xuất và xử lý.

Các phương pháp sắc thuốc hiện đại

Để giúp bệnh nhân thuận tiện hơn, một số bệnh viện đã lắp đặt thiết bị chuyên dụng để bào chế thuốc Trung Quốc. Nồi áp suất cao sẽ sắc thuốc trước khi thuốc được hút chân không và dán kín. Bệnh nhân chỉ cần hâm nóng lại thuốc khi về đến nhà trước khi uống. Đây là một hệ thống nhanh chóng và tiện lợi, đã loại bỏ được việc sắc thuốc vốn tốn nhiều thời gian.

HÌNH 349



Một đống bột thuốc bên cạnh một cốc đong có vạch chia.

HÌNH 350

Một chén nhỏ thuốc dạng cao đặc được nhân vật linh vật giống rồng nâng lên.

HÌNH 351

Một dược sĩ mặc áo blu trắng đang bào chế thuốc trong một kho chứa đầy những chai lọ đựng dược liệu.

Đông gặp Tây

Đông gặp Tây

Nhiều bệnh viện kết hợp hiện nay cung cấp cho bệnh nhân cả phương pháp điều trị của Trung Quốc lẫn phương Tây. Họ kết hợp hai phương pháp để đạt hiệu quả cao hơn trong việc chữa bệnh. Một số người còn gọi việc hiện đại hóa y học Trung Quốc cùng sự kết hợp giữa y học Trung Quốc và y học phương Tây là Nền y học thứ ba. Sự trao đổi kiến thức và học hỏi nhiều hơn giữa y học Trung Quốc và phương Tây chỉ mang lại lợi ích cho loài người.

Y học Trung Quốc vươn ra toàn cầu

Những năm gần đây chứng kiến xu hướng quay trở về với thiên nhiên. Các nước phát triển như các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu chú ý đến các loại thảo dược tự nhiên và y học Trung Quốc. Nếu trước đây y học Trung Quốc từng bị coi là phi khoa học và lạc hậu, thì nay nó đang giành được sự tôn trọng mới trong lĩnh vực y học hiện đại. Nghiên cứu đã chứng minh nhiều phương thuốc truyền thống là có hiệu quả.

Hiện nay, hơn 120 quốc gia đã thành lập các tổ chức cho nhiều trường phái y học thay thế khác nhau, bao gồm y học cổ truyền Trung Quốc. Ngày càng nhiều người sẵn sàng chấp nhận các phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe được thực hành trong y học cổ truyền Trung Quốc. Nhiều nước phương Tây đã nảy sinh mối quan tâm nghiên cứu nền khoa học cổ xưa này, và nhiều sinh viên nước ngoài cũng đã đến Trung Quốc để học nó.

TRANG SÁCH 177 · SCAN P186

Biểu tượng của y học Trung Quốc - Cá Âm Dương

Biểu tượng của y học Trung Quốc - Cá Âm Dương

Đây là cửa hiệu gì vậy? Một dây cao dán thuốc treo ở hai bên cột cửa.

Đây là một hiệu thuốc. Bạn có thấy con cá ở bên dưới các tấm cao dán thuốc không?

Con cá màu sẫm bên trái tượng trưng cho âm, còn con cá trắng bên phải tượng trưng cho dương. Ghép lại với nhau, chúng trở thành cá âm dương.

Còn được gọi là đồ hình Thái Cực (Đại Cực), đây là biểu tượng của y học cổ truyền Trung Quốc.

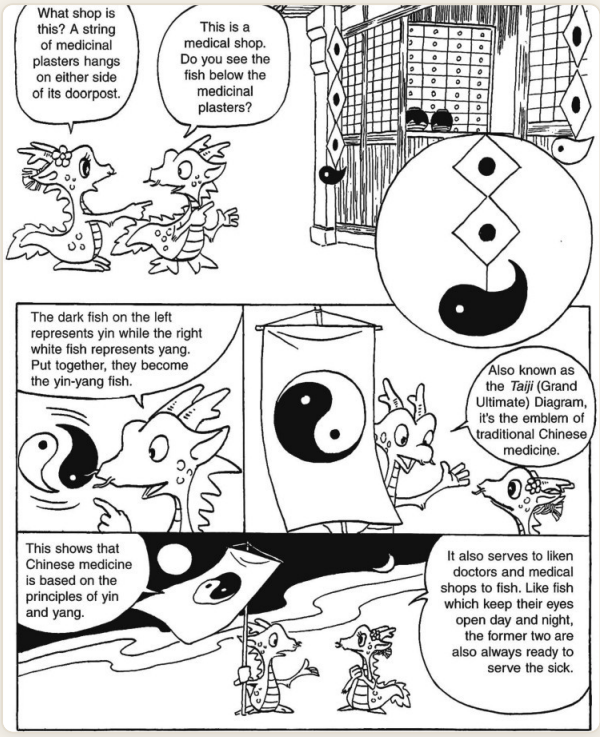
Điều này cho thấy y học Trung Quốc dựa trên các nguyên lý âm và dương.

Nó còn dùng để ví thầy thuốc và hiệu thuốc như loài cá. Giống như cá luôn mở mắt cả ngày lẫn đêm, hai đối tượng nói trên cũng luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh.

HÌNH 352

Một dải băng trang trí hẹp ở đầu trang.

HÌNH 353



Một trang truyện tranh toàn trang: hai linh vật rồng đứng trước một hiệu thuốc có treo cao dán thuốc ở hai bên cửa, rồi một khung tròn phóng to họa tiết đôi cá trên mặt tiền hiệu thuốc, tiếp theo là các khung cho thấy cá âm dương trong một vòng tròn đen trắng, trên một tấm băng rôn treo, và cuối cùng là hai linh vật đang lướt trên một chiếc thuyền hình cá, trong khi phần chữ ví thầy thuốc như loài cá luôn thức canh chừng.

TRANG SÁCH 178 · SCAN P187

Chứng trạng so với triệu chứng

Chứng trạng so với triệu chứng

Ở phần trước của quyển sách, chúng ta đã nói về Bát Cương (Tám Nguyên Tắc Chứng). Trọng tâm của y học cổ truyền Trung Quốc là "chứng" như một tổng thể, chứ không phải "triệu chứng".

"Chứng" so với "triệu chứng"

Triệu chứng là biểu hiện bên ngoài của một bệnh, chẳng hạn như đau đầu và sốt. Còn chứng thì xét đến các tình trạng do bệnh gây ra, tính chất của bệnh, các vùng bị ảnh hưởng, cùng mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh và các khí lực đang vận hành trong người bệnh. Như vậy, chứng có cái nhìn rộng hơn và toàn diện hơn về một căn bệnh.

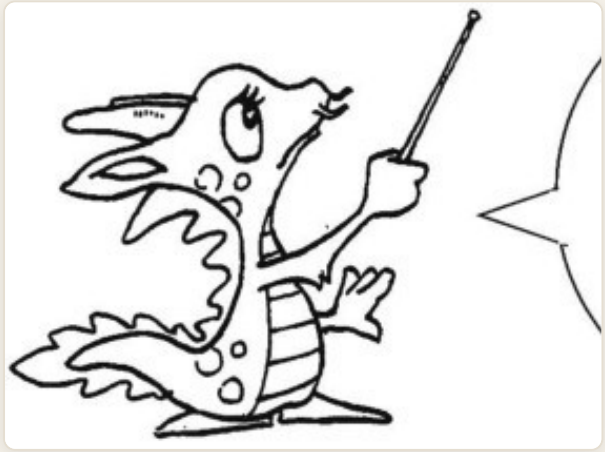
Y học Trung Quốc tuân theo phương pháp chẩn đoán gồm bốn bước: vọng (quan sát), văn (nghe và ngửi), vấn (hỏi) và thiết (bắt mạch). Bốn bước chẩn đoán này trước tiên được dùng khi thăm khám, và các kết quả thu được sẽ được tổng hợp lại để đi đến một chẩn đoán dựa trên sự phân tích các triệu chứng và dấu hiệu. Tiếp đó, cách điều trị được chỉ định sẽ dựa trên chẩn đoán ấy.

Vì thế, y học cổ truyền Trung Quốc tác động lên "chứng" mà không phải lên "triệu chứng". Đó là lý do vì sao những bệnh nhân có triệu chứng giống nhau nhưng không cùng chung một chứng sẽ được điều trị khác nhau. Ngược lại, những triệu chứng khác nhau mà cùng chung một chứng sẽ được điều trị giống nhau.

HÌNH 354

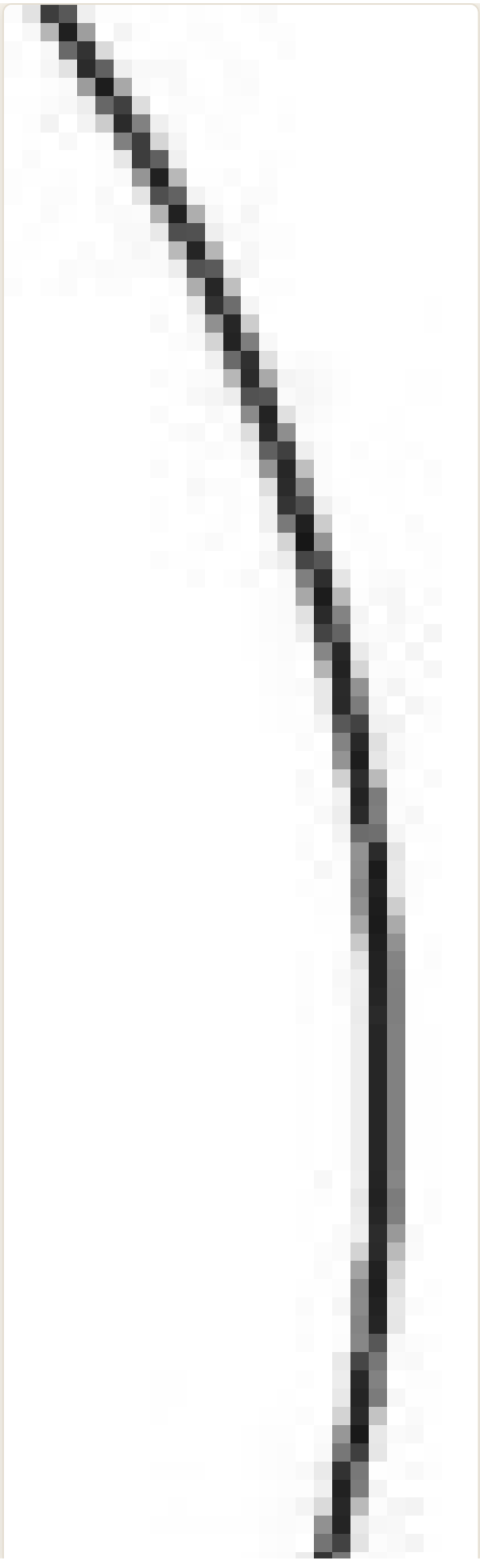
Mảnh đường viền của bong bóng hội thoại cong.

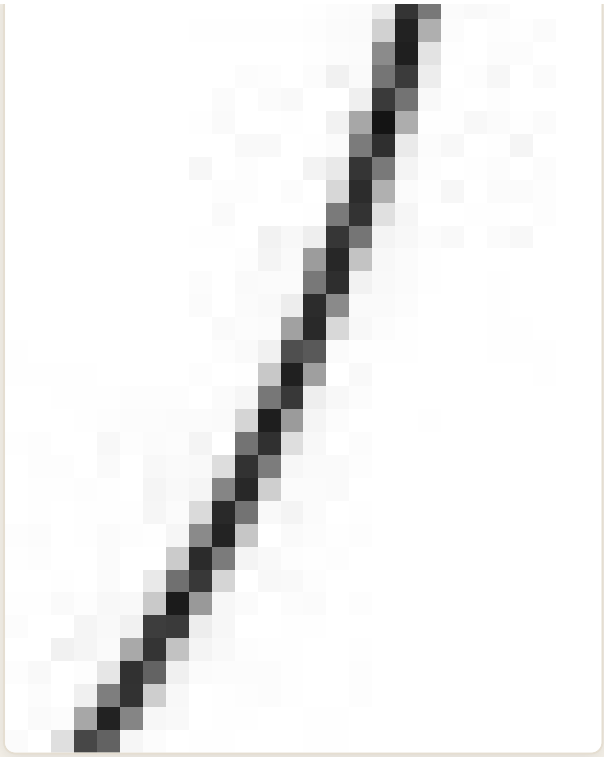
HÌNH 355



Hình hoạt họa nhân vật rồng dẫn truyện của sách, đeo đai có sọc và cầm gậy chỉ tay.

HÌNH 356





Cạnh thẳng bên hông của bong bóng hội thoại.

HÌNH 357

Cạnh cong phía dưới của bong bóng hội thoại.

Phụ lục

Phụ lục

Dịch SARS bùng phát

Vào tháng Hai năm 2003, những báo cáo bắt đầu rải rác kéo về về một đợt bùng phát chứng viêm phổi không điển hình bí ẩn tại Trung Quốc, đợt dịch này đã lây nhiễm cho 300 người và cướp đi năm sinh mạng. Chẳng bao lâu, nó lan khắp châu Á, và đến tháng Ba, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành cảnh báo toàn cầu về thứ đang dần được biết đến với tên gọi Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS).

WHO bắt đầu giám sát toàn cầu các ca viêm phổi không điển hình khi các ca bệnh liên tục xuất hiện ở những quốc gia khác tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Đến khi dịch bệnh cuối cùng kết thúc vào tháng Bảy, virus đã cướp đi 916 sinh mạng trong tổng số 8422 người nhiễm bệnh*.

Y học cổ truyền Trung Quốc và cuộc chiến chống SARS

Dù SARS là một bệnh mới, y học cổ truyền Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chống dịch bệnh và các bệnh cùng loại qua bao thế hệ, như được minh chứng bởi tác phẩm *Thương Hàn Tạp Bệnh Luận* của Trương Trọng Cảnh, được viết cách đây hơn 17 thế kỷ.

Tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh lây nhiễm với số lượng lớn nhất, y học cổ truyền Trung Quốc đã được kết hợp với các phương pháp điều trị Tây y và mang lại hiệu quả tốt. Người ta nhận thấy phương pháp này hiệu quả nhất khi bắt đầu ở giai đoạn sớm của bệnh, và trong việc giúp bệnh nhân lấy lại sức lực ở giai đoạn hồi phục.

Ở đây, ngoài việc tác động trực tiếp để chữa bệnh, y học cổ truyền Trung Quốc còn giúp làm giảm đau, buồn nôn và các tác dụng phụ khác của các phương pháp điều trị Tây y, nhất là khi một số loại thuốc Tây dùng để ức chế virus cũng ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch của cơ thể và khiến bệnh nhân trở nên dễ bị nhiễm trùng thứ phát từ các mầm bệnh khác.

*Trích từ bản tóm tắt của WHO: www.who.int/csr/sars/en/. Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng Tám năm 2003.

TRANG SÁCH 180 · SCAN P189

Phòng chống mối đe dọa từ SARS

Phòng chống mối đe dọa từ SARS

Dù hiện nay virus SARS đang tạm lắng, một số chuyên gia lo ngại rằng virus có thể quay trở lại vào những tháng mùa đông, khi khí hậu trở nên lạnh hơn. Y học cổ truyền Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng để giảm thiểu khả năng mắc bệnh của bạn.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, SARS được xếp vào loại nhiệt chứng kèm thấp trệ bên trong, hai yếu tố này cùng tác động để nhanh chóng làm tổn thương khí trong phổi và tân dịch của cơ thể. Do đó, việc điều trị tập trung vào việc giải nhiệt bên trong, trừ thấp, bồi bổ khí và thúc đẩy sự lưu thông dịch thể để giải độc cho cơ thể.

Các bài thuốc phòng SARS

Dưới đây là một số bài thuốc bổ nhằm tăng cường miễn dịch đồng thời giảm nhiệt và thấp, được lấy từ nhiều trang mạng khác nhau về y học Trung Quốc.

Bài thuốc 1

Kim ngân hoa 30g, bản lam căn 10g, thân rễ cây ráng 10g, hạnh nhân 10g, cát cánh 10g, mạch môn đông 15g, trần bì 6g, cam thảo tươi 6g, cúc hoa 6g.

Sắc với 300ml nước trong 15 phút để cô lại còn 100ml. Dùng ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối.

Bài thuốc 2

Hoàng kỳ 10-12g, *bạch truật* 9g, phòng phong 6g, kim ngân hoa 9g, liên kiều 9g, thân rễ sậy 15-20g, bạc hà 6g, cát cánh 6g, cam thảo sao 5g.

Ngày dùng một liều, uống ấm. Dùng hai lần một ngày trong năm ngày liên tiếp.

Bài thuốc 3

Thương truật 12g, *bạch truật* 15g, hoàng kỳ 15g, phòng phong 10g, kinh giới tuệ 12g, sa sâm 15g, kim ngân hoa 20g, thân rễ cây ráng 12g.

Sắc với nước. Dùng hai lần một ngày trong bảy đến 10 ngày liên tiếp.

Bài thuốc 4

Thân rễ sậy tươi 20g, kim ngân hoa 15g, liên kiều 15g, ve sầu thoái 10g, bạch cương tàm 10g, bạc hà 6g, cam thảo tươi 5g.

Sắc với nước và uống như trà. Dùng liên tục trong bảy đến 10 ngày liên tiếp.

Bài thuốc 5

Thân rễ cây quán chúng 10g, kim ngân hoa 10g, liên kiều 10g, đại thanh diệp 10g, *tô diệp* 10g, rễ sắn dây 10g, kinh giới tuệ 10g, *thương truật* 10g, cây cúc tần 10g, rễ bán hạ nam 15g.

Sắc với nước và dùng hai lần một ngày trong bảy đến 10 ngày liên tiếp.

Bài thuốc 6

Kim ngân hoa 15g, liên kiều 15g, kinh giới 15g, bản lam căn 15g, ngư tinh thảo 30g, phòng phong 12g, bạc hà 12g, hoàng cầm 12g, dã cúc hoa 15g, cam thảo 6g.

Ngâm trong 30 phút rồi đun sôi trên lửa nhỏ (cho bạc hà vào sau 10 phút) trong 15 phút. Chia làm ba lần uống trong ba ngày.

Bấm huyệt và cứu ngải

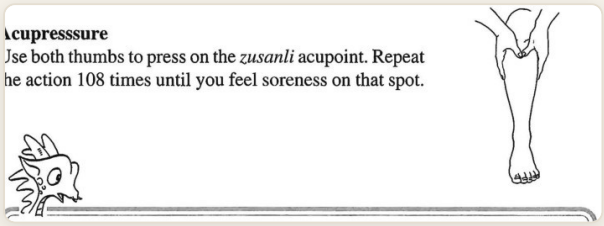
Bấm huyệt và cứu ngải

Huyệt *túc tam lý*, có thể tìm thấy ở cả hai chân, giúp làm mạnh tỳ và trừ thấp.

Cứu ngải (moxibustion)

- - Đốt ngải và đặt điếu ngải lên các huyệt *túc tam lý* ở cả hai chân trong năm đến 10 phút.
- - Thực hiện một hoặc hai lần một ngày trong năm ngày liên tiếp.

HÌNH 361



Bấm huyệt: dùng cả hai ngón cái ấn lên huyệt túc tam lý. Lặp lại động tác 108 lần cho đến khi bạn cảm thấy đau nhức tại chỗ đó.

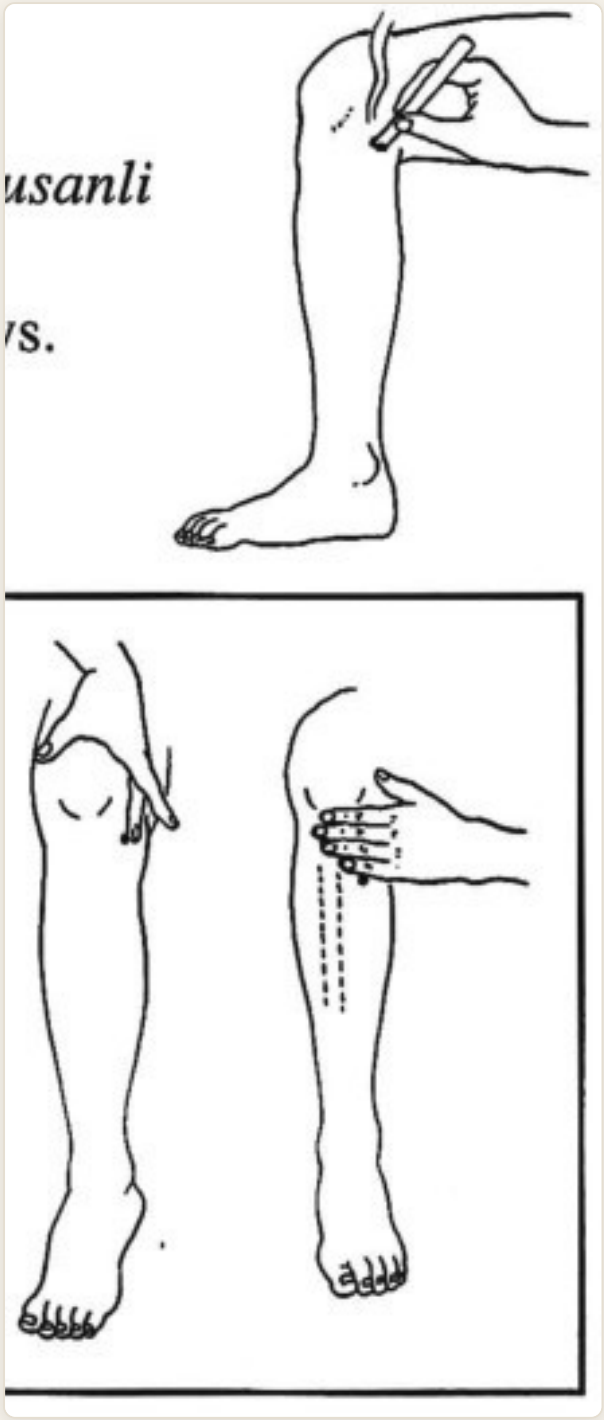
Cách tìm huyệt:

Huyệt *túc tam lý* nằm ở mặt ngoài cẳng chân, dưới xương bánh chè ba tấc. Cách mặt trước xương ống chân khoảng một bề ngang ngón tay.

Thận trọng

Trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, tốt nhất nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước để chắc chắn rằng thuốc phù hợp với thể trạng của bạn. Xin nhớ rằng, đừng dùng nhiều hơn mức cần thiết! Ngoài ra, cứu ngải chỉ nên được thực hiện bởi người có chuyên môn.

HÌNH 358

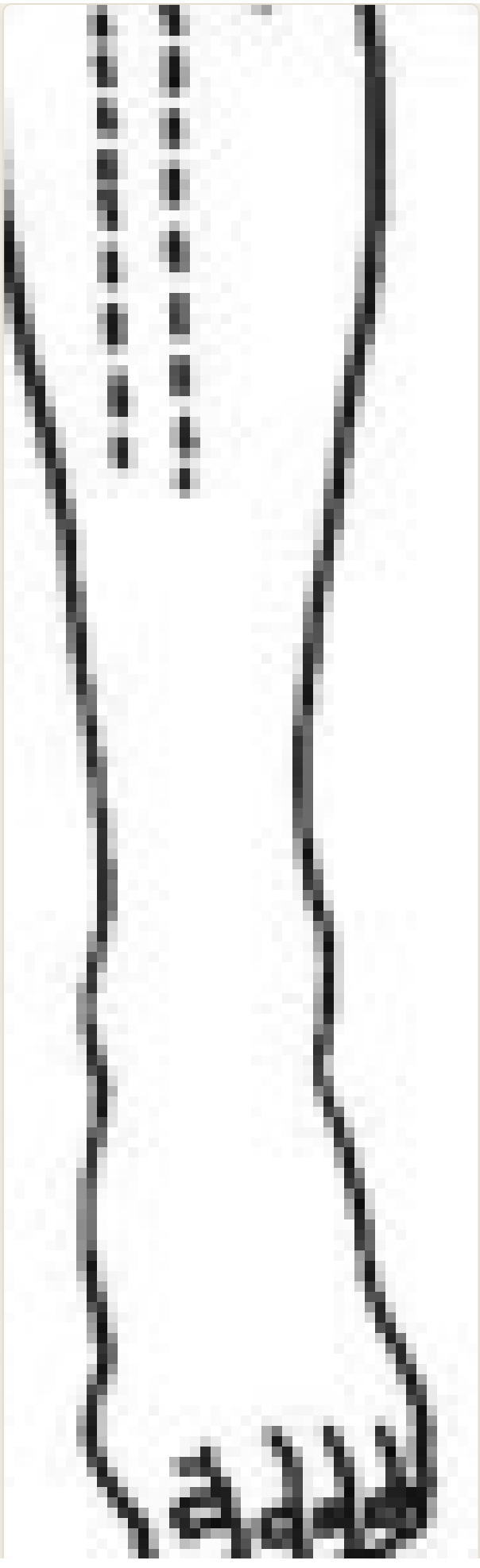


Các hình minh họa cẳng chân cho thấy cách xác định huyệt túc tam lý và cách đặt điếu ngải lên huyệt.

HÌNH 359

Hình vẽ chi tiết đánh dấu huyệt túc tam lý (足三里) ở mặt ngoài cẳng chân dưới.

HÌNH 360



Hình vẽ nét cẳng chân và bàn chân cho thấy đường đi xuống huyệt.

TRANG SÁCH 182 · SCAN P191

DANH MỤC NGUỒN LỰC Y HỌC TRUNG QUỐC

DANH MỤC NGUỒN LỰC Y HỌC TRUNG QUỐC

CÁC HIỆP HỘI Y KHOA

Hội Thầy thuốc Trung Quốc Singapore

640 Toa Payoh Lorong 4

Singapore 319522

ĐT: 65-6251 3428, 65-6251 3304

Fax: 65-6254 0037

website: en.singaporetcm.com

Hội Xúc tiến Y học Trung Quốc Singapore

10 Lorong 9 Geylang

Singapore 388758

ĐT: 65-6842 5470

Fax: 65-6741 3301

Liên đoàn Y học Trung Quốc Singapore

21 Tyrwhitt Road

#05-04, Foo Chow Building

Singapore 207530

ĐT: 65-6296 2645

Fax: 65-6536 5520

Hội Châm cứu Singapore

60 Paya Lebar Road

#05-08, Paya Lebar Square

Singapore 409051

ĐT: 65-6452 2988

website: www.acupuncture.org.sg

Hội Y học Cổ truyền Trung Quốc (Singapore)

BIK 333 Kreta Ayer Road #01–12/13

Singapore 080333

ĐT: 65-6323 0898/6225 2246

website: www.society-tcms.org

Hội Nhà sản xuất Dược phẩm Singapore

132 Neil Road

Singapore 088861

ĐT: 65-6224 5379

website: medmfg.org.sg

Hội Bào chế Đông dược Singapore

119 Tyrwhitt Road

Singapore 207547

ĐT: 65-6298 4740

Fax: 65-6299 3528

website: scda.org.sg

Nghiệp đoàn Nhà nhập khẩu & xuất khẩu Đông dược Singapore

151 Chin Swee Road

#15-02, Manhattan House

Singapore 169876

ĐT: 65-6735 2983

Hội Cựu học viên Trường Đào tạo Thầy thuốc Trung Quốc Singapore

Toa Payoh Central

P.O. Box 134

Singapore 913105

ĐT: 65-6569 3905

Fax: 65-6256 3608

Hội Thương nhân Đông dược và Sản phẩm Sức khỏe Singapore

346A King George's Avenue

Singapore 208577

ĐT: 65-6293 8019

Fax: 65-6293 5803

website: www.tcm.org.sg

CÁC HỌC VIỆN Y KHOA VÀ THẦY THUỐC

Viện Y học Thông Tế Singapore

50 Chin Swee Road

Thong Chai Building #01-01

Singapore 169874

ĐT: 65-6733 6905

Fax: 65-6733 3552

website: www.stcmi.org.sg

Viện Y học Trung Hoa Singapore

No. 640 Toa Payoh Lorong 4

Singapore 319522

ĐT: 65-6251 3304

Fax: 6254 0037

website: www.chunghwamedicalinstitution.com

Ủy ban Hành nghề Y học Cổ truyền Trung Quốc

website: www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/tcmpb/en.html

CÁC KHÓA HỌC Y HỌC TRUNG QUỐC

CÁC KHÓA HỌC Y HỌC TRUNG QUỐC

Học viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Singapore

640 Toa Payoh Lor 4

Singapore 319522

ĐT: 65-6250 3088

Fax: 6356 9901

website: www.singaporetcm.edu.sg

Các khóa học chuyên nghiệp về y học Trung Quốc.

TCM College (Singapore) Pte Ltd

371 Beach Road #02-37 Keypoint

Singapore 199597

ĐT: 65-6227 9969

Fax: 65-6299 3294

Trường đào tạo người bốc thuốc Đông dược.

Danh mục này nhằm trở thành một nguồn tham khảo cho bất kỳ ai quan tâm đến y học cổ truyền Trung Quốc. Nếu bạn muốn tổ chức hay công ty của mình được đưa vào danh mục, vui lòng gửi tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của tổ chức bạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Việc đăng danh mục là miễn phí. Xin cảm ơn!

Fax: 6392 6455

Email: asiapacbooks@pacific.net.sg

NGUỒN LỰC TRÊN WEB

Greater China Herbs

www.greaterchinaherbs.com

Bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trang cung cấp liệu pháp ăn uống, các món ăn dược liệu, mẹo chăm sóc sức khỏe, v.v.

Traditional Chinese Medicine Basics

http://www.tcmbasics.com/

Nguồn học liệu về y học cổ truyền Trung Quốc, với phần giới thiệu nhiều học thuyết nền tảng.

Comprehensive Services of Traditional Chinese Medicine

http://www.tcmtreatment.com/

Bán sách và dược liệu trực tuyến, kèm giải thích và lời khuyên điều trị cho các bệnh thường gặp cùng phần giới thiệu các loại dược liệu thường dùng.

Qi: The Journal of Traditional Eastern Health and Fitness

http://qi-journal.com/

Thông tin về y học cổ truyền Trung Quốc, bao gồm châm cứu, khí công, dược liệu, thái cực quyền. Trang còn có các mục về văn hóa và triết học Trung Quốc.

Bản dịch đã hoàn tất

Toàn bộ sách đã hoàn thành — 192 trang scan (p001–p192).

Toàn bộ 361 đồ hình trong sách đã được cắt từ bản scan và chèn đúng vị trí.

Nội dung gồm: Lý luận và học thuyết y học Trung Hoa, các phương pháp chẩn đoán, sáu phương pháp trị liệu (dược liệu, châm cứu, xoa bóp, thực liệu, tâm lý liệu pháp, khí công), các danh y lịch đại và phần hiện đại hóa y học Trung Hoa.